



Optimal  
Untuk  
Negeri



optimal

**Buku Ajar**

# **Pranikah dan Prakonsepsi**

Dr. Bdn. Nur Handayani, S.SiT, M.Kes.  
Wita Solama, SST., M.Kes.  
Ziyadatul Chusna Almabruroh Yuni Alfi, S.ST, M.KM.

**Editor:** Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



# **Buku Ajar**

# **Pranikah dan**

# **Prakonsepsi**

Dr. Bdn. Nur Handayani, S.SiT, M.Kes.

Wita Solama, SST., M.Kes.

Ziyadatul Chusna Almabruroh Yuni Alfi, S.ST, M.KM.

Editor: Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.



# Buku Ajar Pranikah dan Prakonsepsi

**Penulis:** Dr. Bdn. Nur Handayani, S.SiT, M.Kes.  
Wita Solama, SST., M.Kes.  
Ziyadatul Chusna Almabruroh Yuni Alfi, S.ST, M.KM.

**Editor :** Prof. Dr. Runjati, Bdn., M.Mid.

**Desain Sampul :** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan  
**Tata Letak :** Achmad Faisal

**ISBN :** 978-634-7294-79-1  
**Terbit :** Agustus, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang  
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
*All Right Reserved***

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine  
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88  
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan  
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram: @bimbel.optimal  
Tiktok: @maskokooo  
[www.optimaluntuknegeri.com](http://www.optimaluntuknegeri.com)  
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

# Prakata

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya buku ajar ini yang berjudul "Buku Ajar Pranikah dan Prakonsepsi". Buku ini disusun dengan tujuan memberikan panduan komprehensif bagi pasangan muda yang akan memasuki kehidupan pernikahan, serta merencanakan kehamilan dengan matang. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga Indonesia, buku ini membahas berbagai aspek penting yang mencakup persiapan fisik, psikologis, sosial, budaya, hukum, dan kesehatan reproduksi.

Penulis menyadari bahwa persiapan pranikah dan prakonsepsi tidak hanya melibatkan kesiapan individu, tetapi juga peran aktif keluarga besar, komunitas, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, buku ini secara khusus menyoroti pentingnya edukasi dan pemahaman yang tepat terkait isu-isu sensitif, seperti kesehatan seksual, pencegahan infeksi menular seksual, dan hak reproduksi pasangan muda. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya adaptasi sosial budaya dalam lingkungan keluarga besar serta memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang mungkin dihadapi pasangan muda dalam kehidupan rumah tangga.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat serta dapat membantu pasangan muda di Indonesia dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, sejahtera, dan bertanggung jawab.

Penulis



# Daftar Isi

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b> | <b>iii</b> |
|----------------------|------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Daftar Isi.....</b> | <b>iv</b> |
|------------------------|-----------|

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Bab 1 Konsep Dasar Pranikah dan Prakonsepsi .....</b> | <b>1</b> |
|----------------------------------------------------------|----------|

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Konsep dan Pentingnya Persiapan Pranikah dan Prakonsepsi .....            | 2  |
| B. Peran Bidan dalam Edukasi Pranikah dan Prakonsepsi.....                   | 5  |
| C. Tren: Kesadaran Pasangan Muda dalam Perencanaan Keluarga yang Matang..... | 7  |
| D. Isu: Rendahnya Akses Informasi Pranikah di Daerah Terpencil .....         | 8  |
| E. Latihan Soal .....                                                        | 10 |
| F. Rangkuman Materi.....                                                     | 14 |
| G. Glosarium .....                                                           | 16 |
| H. Daftar Pustaka.....                                                       | 19 |

## **Bab 2 Persiapan Pranikah dan Perencanaan Kehidupan**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Berkeluarga .....</b> | <b>21</b> |
|--------------------------|-----------|

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Konseling Pranikah: Tujuan dan Manfaatnya .....                                    | 22 |
| B. Komunikasi Efektif Pasangan.....                                                   | 23 |
| C. Perencanaan Keuangan Keluarga .....                                                | 25 |
| D. Pengelolaan Konflik dalam Pernikahan .....                                         | 28 |
| E. Tren: Konseling Pranikah secara Daring ( <i>Online Counseling</i> ) .....          | 30 |
| F. Isu: Kesiapan Psikologis Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Pernikahan ..... | 32 |
| G. Latihan Soal .....                                                                 | 34 |
| H. Rangkuman Materi.....                                                              | 39 |
| I. Glosarium .....                                                                    | 41 |
| J. Daftar Pustaka.....                                                                | 43 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bab 3 Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi .....</b> | <b>45</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Anatomi Reproduksi Pria dan Wanita.....                                   | 46 |
| B. Fisiologi Reproduksi dan Fertilitas.....                                  | 48 |
| C. Siklus Menstruasi dan Masa Subur .....                                    | 50 |
| D. Tren: Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Sosial.....             | 53 |
| E. Isu: Kesalahan Informasi tentang Siklus Kesuburan pada Pasangan Muda..... | 55 |
| F. Latihan Soal .....                                                        | 57 |
| G. Rangkuman Materi.....                                                     | 61 |
| H. Glosarium .....                                                           | 63 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                       | 66 |

## **Bab 4 Persiapan Fisik dan Kesehatan Prakonsepsi .....67**

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pemeriksaan Kesehatan Prakonsepsi ( <i>Screening</i> Kesehatan) .....      | 68 |
| B. Imunisasi dan Suplementasi Vitamin Prakonsepsi.....                        | 70 |
| C. Nutrisi Optimal untuk Fertilitas .....                                     | 72 |
| D. Olahraga dan Aktivitas Fisik Prakonsepsi .....                             | 74 |
| E. Tren: Pemeriksaan Genetik Pra-kehamilan ( <i>Genetic Screening</i> ) ..... | 76 |
| F. Isu: Rendahnya Kesadaran Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Konsepsi .....      | 78 |
| G. Latihan Soal.....                                                          | 80 |
| H. Rangkuman Materi.....                                                      | 85 |
| I. Glosarium .....                                                            | 87 |
| J. Daftar Pustaka.....                                                        | 89 |

## **Bab 5 Persiapan Psikologis dan Emosional dalam Pranikah dan Prakonsepsi.....91**

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Kesiapan Mental Pasangan dalam Menghadapi Kehamilan dan Peran sebagai Orang Tua .....   | 92  |
| B. Manajemen Stres Prakonsepsi.....                                                        | 93  |
| C. Pengelolaan Ekspektasi Pasangan terkait Kehamilan dan Pengasuhan Anak.....              | 96  |
| D. Tren: Pendekatan <i>Mindfulness</i> dan <i>Wellness</i> dalam Persiapan Kehamilan ..... | 98  |
| E. Isu: Meningkatnya Angka Kecemasan Pasangan terkait Fertilitas dan Kehamilan.....        | 100 |
| F. Latihan Soal.....                                                                       | 102 |
| G. Rangkuman Materi.....                                                                   | 107 |
| H. Glosarium .....                                                                         | 109 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                                     | 111 |

## **Bab 6 Kesehatan Seksual dan Pencegahan Risiko Prakonsepsi... 113**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Infeksi Menular Seksual (IMS) Pencegahan, Deteksi, dan Pengobatan .....  | 114 |
| B. Pencegahan HIV/AIDS dan Edukasi Pranikah.....                            | 116 |
| C. Pencegahan Penyakit Menular yang Mempengaruhi Kehamilan (TORCH) ....     | 119 |
| D. Tren: Kampanye Edukasi Seksual Pranikah Berbasis Komunitas Digital ..... | 121 |
| E. Isu: Stigma dan Tabu Terkait Pemeriksaan IMS Sebelum Menikah .....       | 123 |
| F. Latihan Soal.....                                                        | 126 |
| G. Rangkuman Materi .....                                                   | 130 |
| H. Glosarium .....                                                          | 132 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                      | 135 |

## **Bab 7 Fertilitas dan Manajemen Infertilitas..... 136**

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas Pria dan Wanita.....       | 137 |
| B. Deteksi Dini Gangguan Fertilitas .....                                | 139 |
| C. Teknologi Reproduksi Berbantu (IVF, IUI).....                         | 142 |
| D. Tren: Popularitas Teknologi Reproduksi di Kalangan Pasangan Muda..... | 145 |



|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| E. Isu: Mahalnya Biaya Teknologi Reproduksi dan Keterbatasan Aksesnya..... | 147 |
| F. Latihan Soal.....                                                       | 150 |
| G. Rangkuman Materi.....                                                   | 155 |
| H. Glosarium .....                                                         | 157 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                     | 159 |

## **Bab 8 Persiapan Sosial Budaya dan Lingkungan..... 161**

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pengaruh Budaya Lokal terhadap Persiapan Pranikah.....                   | 162 |
| B. Adaptasi Pasangan Baru dengan Lingkungan Keluarga Besar .....            | 164 |
| C. Edukasi Keluarga Besar Dalam Mendukung Pasangan Muda.....                | 166 |
| D. Tren: Perubahan Pola Dukungan Sosial dalam Masyarakat Modern .....       | 169 |
| E. Isu: Konflik Budaya dan Adat dalam Praktik Pranikah dan Prakonsepsi..... | 172 |
| F. Latihan Soal.....                                                        | 175 |
| G. Rangkuman Materi.....                                                    | 179 |
| H. Glosarium .....                                                          | 181 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                      | 183 |

## **Bab 9 Hak Reproduksi dan Aspek Hukum dalam Pernikahan..... 184**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Hak Reproduksi Pasangan Muda .....                                               | 185 |
| B. Peraturan Pernikahan di Indonesia (UU Perkawinan dan KUA).....                   | 186 |
| C. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Sejak Prakonsepsi .....                          | 188 |
| D. Tren: Awareness tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Baru .....          | 190 |
| E. Isu: Ketidaktahuan Pasangan tentang Hak Reproduksi dan Hukum<br>Pernikahan ..... | 192 |
| F. Latihan Soal.....                                                                | 195 |
| G. Rangkuman Materi.....                                                            | 199 |
| H. Glosarium .....                                                                  | 201 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                              | 203 |

## **Bab 10 Edukasi Berbasis Komunitas dan Digital dalam**

### **Persiapan Pranikah dan Prakonsepsi..... 204**

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Program Edukasi Pranikah Berbasis Komunitas .....                      | 205 |
| B. Pemanfaatan Media Digital dalam Edukasi Pranikah dan Prakonsepsi ..... | 207 |
| C. Model Program Edukasi Pranikah Efektif di Indonesia .....              | 209 |
| D. Tren: Meningkatnya Edukasi Pranikah Berbasis Aplikasi Mobile .....     | 211 |
| E. Isu: Kesulitan Akses Informasi Digital di Daerah Tertinggal .....      | 213 |
| F. Latihan Soal.....                                                      | 216 |
| G. Rangkuman Materi.....                                                  | 219 |
| H. Glosarium .....                                                        | 221 |
| I. Daftar Pustaka.....                                                    | 223 |

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bab 11 Tren Global dan Kebijakan Nasional Terkait Persiapan<br/>Pranikah dan Prakonsepsi.....</b> | <b>225</b> |
| A. Sustainable Development Goals (SDGs) terkait Kesehatan Reproduksi .....                           | 226        |
| B. Kebijakan Nasional Terkait Pendidikan Pranikah dan Prakonsepsi di<br>Indonesia .....              | 228        |
| C. Praktik Terbaik dari Berbagai Negara dalam Persiapan Pranikah .....                               | 231        |
| D. Tren: Integrasi Layanan Kesehatan Prakonsepsi dalam Layanan<br>Kesehatan Primer .....             | 233        |
| E. Isu: Gap Implementasi Kebijakan Nasional di Daerah Terpencil.....                                 | 235        |
| F. Latihan Soal.....                                                                                 | 238        |
| G. Rangkuman Materi.....                                                                             | 242        |
| H. Glosarium .....                                                                                   | 244        |
| I. Daftar Pustaka.....                                                                               | 246        |





# Bab 1

## Konsep Dasar Pranikah dan Prakonsepsi

Pernikahan merupakan fase kehidupan yang sangat penting, menandai terbentuknya keluarga baru yang menjadi unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga memiliki peranan strategis dalam mencetak generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu, persiapan pranikah dan prakonsepsi menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara matang untuk memastikan pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, serta siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan secara sehat dan aman.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Memahami secara mendalam konsep persiapan pranikah dan prakonsepsi
- Mampu memberikan edukasi yang komprehensif kepada calon pasangan
- Serta mampu berperan aktif dalam peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persiapan pranikah dan prakonsepsi.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar persiapan pranikah dan prakonsepsi secara detail.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan peran bidan dalam edukasi pranikah dan prakonsepsi.
- Menganalisis tren kesadaran pasangan muda dalam perencanaan keluarga yang matang.
- Mengidentifikasi hambatan akses informasi pranikah di daerah terpencil serta menyusun solusi strategis untuk mengatasinya.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan secara rinci aspek-aspek penting dalam persiapan pranikah seperti psikologis, fisik, finansial, dan sosial.
- Menjelaskan secara komprehensif persiapan prakonsepsi yang mencakup skrining kesehatan, gaya hidup sehat, serta imunisasi dan suplementasi.
- Menjelaskan peran bidan sebagai pendidik, konselor, tenaga kesehatan, dan fasilitator dalam edukasi pranikah dan prakonsepsi.
- Menguraikan tren positif kesadaran pasangan muda dalam perencanaan keluarga.
- Mengidentifikasi isu utama serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akses informasi di daerah terpencil.

## A. Konsep dan Pentingnya Persiapan Pranikah dan Prakonsepsi

### 1. Persiapan Pranikah

Persiapan pranikah merupakan suatu proses strategis yang bertujuan untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, finansial, maupun sosial. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa persiapan yang baik sebelum pernikahan dapat mengurangi risiko perceraian, meningkatkan kualitas komunikasi, serta memperkuat ikatan emosional pasangan (Markman, Stanley, & Blumberg, 2010).

Secara psikologis dan mental, persiapan pranikah menjadi sangat penting karena kehidupan rumah tangga pasti diwarnai berbagai dinamika dan tantangan. Pasangan yang telah melalui proses persiapan mental secara matang akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola stres yang muncul akibat tekanan kehidupan sehari-hari, serta memiliki keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana dan dewasa. Konseling ini meliputi pelatihan komunikasi efektif, pengelolaan emosi, dan pembelajaran resolusi konflik yang konstruktif (Stanley et al., 2006). Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan konstruktif akan lebih mampu menciptakan hubungan yang kuat dan harmonis.

Persiapan fisik dan kesehatan dalam konteks pranikah juga memiliki peran yang vital. Kesehatan fisik yang optimal menjadi landasan penting untuk menjalani kehidupan berkeluarga, terutama dalam menghadapi tanggung jawab reproduksi dan memiliki keturunan yang sehat. Aktivitas seperti pemeriksaan kesehatan pranikah sangat dianjurkan karena mampu mengidentifikasi kondisi medis tertentu sejak dini, termasuk risiko penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, infeksi menular seksual seperti HIV, hepatitis, dan sifilis, serta kondisi genetik tertentu yang bisa diwariskan kepada anak. WHO (2020) menekankan pentingnya deteksi dini terhadap penyakit menular seksual (PMS), kelainan genetik, dan kondisi kesehatan kronis guna menjamin keberlangsungan keluarga yang sehat. Pemeriksaan ini juga memungkinkan pasangan untuk merencanakan kehamilan dengan risiko minimal. Dengan mengetahui kondisi kesehatan secara detail sejak awal, pasangan dapat mengambil langkah pencegahan atau terapi medis yang tepat guna menghindari komplikasi kesehatan di masa depan.

Di sisi finansial, persiapan pranikah menjadi kunci penting bagi kelangsungan hidup keluarga di masa mendatang. Kesiapan finansial melibatkan kemampuan pasangan dalam membuat anggaran yang jelas dan realistis, mengelola pengeluaran dan pendapatan dengan bijaksana, serta merencanakan investasi dan tabungan untuk tujuan jangka panjang seperti pembelian rumah, pendidikan anak, dan dana pensiun. Pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan, manajemen utang, serta pemahaman terhadap prioritas finansial adalah hal yang wajib dipahami oleh pasangan yang akan menikah. Tanpa adanya stabilitas finansial yang baik, kehidupan keluarga rentan mengalami konflik yang dapat berdampak serius pada hubungan suami-istri maupun perkembangan anak-anak di masa depan.

Aspek sosial dalam persiapan pranikah juga perlu mendapat perhatian khusus. Ketika seseorang menikah, secara otomatis ia tidak hanya menjalin hubungan dengan pasangan tetapi juga berintegrasi dengan keluarga besar dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Persiapan sosial mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan nilai-nilai, norma, dan budaya keluarga masing-masing serta lingkungan sekitar yang mungkin berbeda. Kemampuan ini penting untuk memastikan pasangan dapat diterima oleh lingkungan sosial, membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan keluarga besar, serta memanfaatkan jaringan sosial secara positif dalam mendukung kehidupan berkeluarga.

## **2. Persiapan Prakonsepsi**

Persiapan prakonsepsi telah diakui sebagai intervensi kunci dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh. Menurut World Health Organization (WHO, 2013), prakonsepsi adalah serangkaian tindakan preventif dan promotif yang dilakukan sebelum kehamilan guna mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat memengaruhi hasil kehamilan, termasuk risiko pada ibu, janin, maupun bayi. Persiapan ini berperan penting dalam menciptakan kondisi fisik dan reproduksi yang optimal sebelum terjadinya konsepsi.

Persiapan ini biasanya dimulai dengan melakukan skrining kesehatan reproduksi yang komprehensif. Skrining ini mencakup pemeriksaan kadar hormon reproduksi, deteksi gangguan hormonal seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), pemeriksaan genetik untuk mengetahui potensi gangguan keturunan, serta pemeriksaan umum seperti tes darah, pengecekan tekanan darah, dan kadar gula darah. Melalui pemeriksaan ini, pasangan dapat mengidentifikasi dan

mengantisipasi risiko kesehatan yang mungkin muncul selama kehamilan, memungkinkan mereka mengambil langkah preventif atau intervensi medis yang diperlukan sebelum kehamilan terjadi.

Selanjutnya, aspek gaya hidup yang sehat sangat menentukan kesuksesannya persiapan prakonsepsi. Pasangan dianjurkan untuk menerapkan pola makan yang sehat dengan asupan nutrisi seimbang yang mencukupi kebutuhan vitamin, mineral, protein, dan serat. Aktivitas fisik rutin juga dianjurkan untuk menjaga kebugaran fisik yang optimal serta mempersiapkan tubuh dalam menghadapi perubahan fisiologis selama kehamilan. Pentingnya menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, maupun menggunakan narkoba juga sangat ditekankan karena, paparan zat berbahaya seperti nikotin, alkohol, dan narkotika dikaitkan dengan peningkatan risiko cacat lahir, gangguan tumbuh kembang, dan keguguran (CDC, 2019).

Selain itu, imunisasi prakonsepsi memiliki peranan penting dalam melindungi kesehatan ibu dan bayi yang akan dikandung. Imunisasi seperti vaksin rubella, tetanus, dan hepatitis B bertujuan memberikan perlindungan bagi ibu dari penyakit yang bisa berdampak negatif pada janin jika ibu terinfeksi selama kehamilan. Selain vaksinasi, suplementasi nutrisi seperti asam folat juga menjadi rekomendasi utama dalam persiapan prakonsepsi. Asam folat terbukti efektif mencegah kelainan tabung saraf (neural tube defect), seperti spina bifida pada janin. Zat besi juga direkomendasikan untuk membantu memastikan kadar hemoglobin dalam darah ibu tetap dalam batas normal, sehingga ibu dapat terhindar dari anemia yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan bayi.

Dengan menjalani persiapan pranikah dan prakonsepsi secara cermat dan lengkap, pasangan tidak hanya akan meningkatkan peluang untuk memiliki kehidupan rumah tangga yang bahagia, tetapi juga akan membantu memastikan bahwa proses kehamilan, kelahiran, dan tumbuh kembang anak berlangsung secara sehat dan optimal. Persiapan ini pada akhirnya berkontribusi besar terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan jangka panjang keluarga secara keseluruhan.

## **B. Peran Bidan dalam Edukasi Pranikah dan Prakonsepsi**

Bidan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memberikan edukasi pranikah dan prakonsepsi kepada calon pasangan yang akan menikah. Berdasarkan Panduan Praktik Klinis bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Kementerian Kesehatan RI, 2020), bidan tidak hanya berperan dalam pelayanan obstetri dan ginekologi, tetapi juga dalam promosi kesehatan, konseling, dan pendidikan kesehatan kepada individu maupun pasangan usia subur. Peran edukatif ini mencakup pemahaman dasar tentang fisiologi reproduksi, termasuk siklus menstruasi, masa ovulasi, dan masa subur, yang sangat penting dalam merencanakan kehamilan maupun penggunaan kontrasepsi.

Selain itu, bidan juga memberikan penjelasan mengenai berbagai jenis alat kontrasepsi yang tersedia, baik metode alami maupun metode medis seperti pil, suntikan, implan, intrauterine device (IUD), maupun penggunaan kondom. Setiap pasangan mendapatkan edukasi yang tidak hanya berorientasi pada kelebihan masing-masing metode, tetapi juga kekurangan serta pertimbangan penting yang harus diperhatikan sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu pasangan tersebut. Dengan begitu, pasangan memiliki bekal pengetahuan yang kuat dalam mengambil keputusan terkait alat kontrasepsi yang paling cocok digunakan dalam mengatur jarak kelahiran maupun mencegah kehamilannya jika belum siap.

Selanjutnya, bidan sebagai konselor memiliki peran sentral dalam mendampingi pasangan secara psikologis dan emosional. Dalam proses konseling, bidan membantu pasangan untuk mengenali tantangan-tantangan psikologis yang mungkin timbul setelah memasuki kehidupan rumah tangga. Berbagai tekanan seperti masalah ekonomi, adaptasi terhadap karakter pasangan, perbedaan latar belakang budaya, hingga komunikasi sehari-hari yang rentan menimbulkan konflik merupakan hal yang perlu dipahami dan diantisipasi. Oleh sebab itu, bidan secara aktif membimbing pasangan dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang terbuka, efektif, dan penuh empati, agar mampu mengelola konflik dengan bijak. Proses konseling ini bertujuan agar pasangan mampu menciptakan fondasi yang kokoh dalam hubungan mereka, berdasarkan rasa saling percaya, pengertian, dan komitmen kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.



Sebagai konselor, bidan memiliki kapasitas untuk mendampingi pasangan dari sisi psikologis dan emosional. WHO (2018) menyatakan bahwa dukungan emosional dan komunikasi yang baik sejak masa pranikah dapat menurunkan tingkat konflik rumah tangga dan mendukung stabilitas keluarga. Bidan membantu pasangan dalam memahami potensi tantangan rumah tangga, serta membangun keterampilan komunikasi efektif dan penyelesaian konflik berbasis empati, pengertian, dan komitmen.

Lebih jauh lagi, bidan memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan gaya hidup sehat yang sangat penting sebagai bagian integral dalam persiapan pranikah maupun prakonsepsi. Sebagai fasilitator gaya hidup sehat, bidan memberikan informasi dan motivasi kepada pasangan untuk menjalani pola hidup yang sehat melalui pola makan yang bergizi seimbang, kaya akan vitamin, mineral, dan serat, serta mengurangi asupan makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Selain itu, aktivitas fisik yang rutin seperti olahraga ringan hingga sedang juga sangat dianjurkan guna meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kebugaran fisik, dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis.

Tidak kalah penting, bidan juga berperan dalam promosi gaya hidup sehat yang merupakan pilar utama dalam prakonsepsi. Menurut Stephenson et al. (2014), penerapan pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, serta penghindaran zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan narkoba sangat berpengaruh terhadap kesuburan dan kualitas kehamilan. Edukasi gaya hidup sehat dari bidan merupakan bentuk preventif terhadap berbagai kondisi patologis yang dapat mengganggu keberhasilan konsepsi maupun kesehatan janin.

Melalui perannya yang sangat luas dan mendalam ini, bidan tidak hanya sekadar tenaga kesehatan yang memberikan layanan klinis semata, tetapi juga berfungsi sebagai figur kunci dalam proses edukasi, konseling, dan pendampingan psikologis serta sosial pasangan. Dengan begitu, bidan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi keluarga yang sehat secara fisik, emosional, dan sosial, yang pada akhirnya menjadi pondasi kuat bagi kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

### C. Tren: Kesadaran Pasangan Muda dalam Perencanaan Keluarga yang Matang

Kemajuan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara fundamental cara masyarakat, khususnya pasangan muda, memperoleh dan mengelola informasi terkait pernikahan dan kesehatan reproduksi. Menurut World Health Organization (2022), akses terhadap edukasi prakonsepsi melalui media digital dapat meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi dan membantu pasangan membuat keputusan yang lebih bijaksana sebelum menikah atau merencanakan kehamilan.

Studi oleh Ventola (2020) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi mobile kesehatan (mHealth) terus meningkat dan telah terbukti meningkatkan literasi kesehatan di kalangan generasi muda. Aplikasi ini menyediakan fitur edukasi mengenai siklus menstruasi, masa subur, pilihan kontrasepsi, hingga pengingat imunisasi pranikah dan asupan suplemen penting seperti asam folat. Dengan fitur interaktif dan real-time, pasangan dapat melakukan pemantauan dan perencanaan keluarga secara lebih terarah dan personal.

Di sisi lain, media sosial telah menjadi alat penting dalam membentuk opini dan kesadaran kolektif. Studi dari Kim & Lee (2021) mengungkapkan bahwa platform seperti Instagram dan YouTube digunakan secara luas oleh tenaga kesehatan profesional untuk menyampaikan edukasi seputar pranikah dan gaya hidup sehat dengan pendekatan visual dan naratif yang mudah dicerna. Hal ini mendorong partisipasi aktif pasangan muda dalam mengikuti kelas daring, webinar, hingga komunitas edukatif tentang pernikahan sehat.

Komunitas online juga menjadi sumber dukungan sosial yang kuat. Penelitian oleh Harville et al. (2020) menunjukkan bahwa partisipasi dalam forum digital yang membahas kesehatan keluarga dan hubungan suami-istri dapat meningkatkan kesiapan emosional serta rasa percaya diri pasangan dalam menghadapi masa transisi menuju kehidupan rumah tangga.

Dari aspek perencanaan keuangan, digitalisasi juga berperan besar. Menurut Pradana & Damanik (2021), literasi keuangan yang diperoleh pasangan melalui kanal digital seperti e-book, video edukatif, dan aplikasi pengelola keuangan dapat mendorong perencanaan anggaran rumah tangga yang lebih matang, termasuk

pemahaman tentang investasi keluarga dan manajemen risiko ekonomi dalam pernikahan.

Kesadaran pasangan muda tentang pentingnya kesehatan mental dan keterampilan komunikasi dalam pernikahan juga meningkat. Penelitian oleh Putri & Hadi (2022) di Indonesia menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti edukasi digital tentang manajemen stres, empati, dan komunikasi asertif sebelum menikah memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi setelah menikah. Mereka cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik dengan pendekatan positif dan mencegah kekerasan rumah tangga sejak dini.

Dengan meningkatnya kesadaran dan akses terhadap edukasi berbasis teknologi ini, pasangan muda menjadi lebih proaktif dan terlibat dalam proses persiapan pranikah secara menyeluruh. Mereka tidak hanya mencari informasi, tetapi juga menerapkannya dalam keputusan nyata: dari mengikuti konseling pranikah, melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, hingga menerapkan gaya hidup sehat dan strategi keuangan keluarga.

Transformasi ini pada akhirnya berdampak positif terhadap ketahanan keluarga dan kualitas generasi mendatang. Kesadaran pranikah dan prakonsepsi yang ditopang oleh teknologi informasi modern membentuk pasangan muda yang lebih siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan di tengah kompleksitas masyarakat kontemporer.

#### **D. Isu: Rendahnya Akses Informasi Pranikah di Daerah Terpencil**

Meskipun kesadaran pasangan muda di wilayah perkotaan terhadap pentingnya persiapan pranikah dan prakonsepsi semakin meningkat, kesenjangan akses informasi masih menjadi isu besar di wilayah terpencil. Studi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, termasuk bidan, berkontribusi terhadap rendahnya cakupan edukasi kesehatan reproduksi di daerah-daerah pedesaan dan terpencil.

Peran bidan sebagai tenaga kesehatan utama dalam edukasi pranikah sangat penting, namun di banyak wilayah terpencil jumlah bidan tidak mencukupi. Menurut data Badan PPSDM Kesehatan (2021), masih banyak wilayah yang memiliki rasio tenaga bidan per populasi di bawah standar minimal. Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel mengenai perencanaan keluarga, reproduksi sehat, dan prakonsepsi.

Selain itu, kendala infrastruktur komunikasi seperti ketiadaan jaringan internet menjadi hambatan signifikan. Menurut Lestari & Suharti (2022), ketidakmerataan akses internet di Indonesia memperparah kesenjangan digital antara masyarakat kota dan desa. Padahal, era digital saat ini menjadikan internet sebagai jalur utama penyebaran edukasi kesehatan melalui aplikasi, media sosial, dan webinar daring. Tanpa akses digital, masyarakat terpencil harus bergantung pada metode konvensional yang terbatas cakupannya.

Aspek sosial dan budaya juga turut menjadi penghambat. Di banyak komunitas terpencil, isu kesehatan reproduksi masih dianggap tabu. Penelitian oleh Yusriani et al. (2021) menunjukkan bahwa norma budaya lokal sering kali melarang diskusi terbuka tentang seksualitas dan perencanaan keluarga, bahkan di antara pasangan yang akan menikah. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat mereka enggan bertanya atau mencari informasi lebih lanjut.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi penyuluhan berbasis komunitas yang sensitif budaya menjadi sangat penting. Melibatkan tokoh adat, pemuka agama, atau pemimpin lokal sebagai fasilitator edukasi terbukti dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap topik-topik yang selama ini dianggap sensitif (Widyastuti & Rachmawati, 2020).

Pelatihan intensif bagi bidan yang bertugas di wilayah terpencil juga direkomendasikan, sebagaimana dinyatakan oleh WHO (2021), agar mereka tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga mampu melakukan konseling dengan pendekatan interpersonal dan budaya lokal.

Terakhir, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, LSM, dan swasta sangat diperlukan untuk memperkuat infrastruktur fisik dan digital di wilayah-wilayah terpencil. Program seperti penyediaan internet desa, penyuluhan kesehatan berbasis daring, serta peningkatan jumlah tenaga kesehatan harus dijalankan secara terintegrasi guna menjamin akses informasi yang adil dan merata.

Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup pelatihan, edukasi berbasis budaya, dan pembangunan infrastruktur, diharapkan masyarakat terpencil di Indonesia dapat menikmati manfaat persiapan pranikah dan prakonsepsi secara setara dengan masyarakat perkotaan, sehingga kualitas hidup keluarga di seluruh wilayah dapat meningkat secara merata.

## E. Latihan Soal

### **Tugas 1: Studi Kasus tentang Persiapan Pranikah**

Mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara mendalam dengan satu pasangan muda yang akan menikah dalam waktu dekat. Dalam wawancara tersebut, mahasiswa diminta menggali bagaimana pasangan tersebut mempersiapkan aspek fisik, mental, finansial, dan sosial sebelum menikah. Mahasiswa diminta menyusun hasil wawancara dalam bentuk laporan naratif yang berisi deskripsi mendetail tentang persiapan pranikah pasangan tersebut serta memberikan analisis kritis mengenai kesiapan pasangan tersebut berdasarkan konsep persiapan pranikah yang telah dipelajari.

### **Tugas 2: Membuat Rencana Edukasi Pranikah oleh Bidan**

Mahasiswa diminta menyusun rencana edukasi pranikah yang akan dilakukan oleh bidan di suatu komunitas. Dalam rencana ini, mahasiswa wajib mencantumkan materi apa saja yang perlu disampaikan oleh bidan, seperti anatomi dan fisiologi reproduksi, alat kontrasepsi, serta manajemen konflik dalam rumah tangga. Mahasiswa harus menyusun rencana tersebut secara sistematis, lengkap dengan metode penyampaian, media edukasi yang digunakan, serta bagaimana cara mengevaluasi efektivitas edukasi tersebut.

### **Tugas 3: Analisis Tren Kesadaran Pasangan Muda terhadap Perencanaan Keluarga**

Mahasiswa diminta untuk melakukan survei kecil-kecilan di lingkungan sekitar (minimal 10 responden) terkait tren kesadaran pasangan muda dalam perencanaan keluarga. Survei berisi pertanyaan seputar sumber informasi yang paling banyak digunakan, aspek-aspek yang dianggap penting oleh pasangan dalam persiapan pranikah, serta pengaruh media sosial terhadap keputusan mereka dalam merencanakan keluarga. Hasil survei tersebut disusun dalam bentuk laporan analisis yang lengkap disertai interpretasi data yang relevan dengan materi yang telah dipelajari.

### **Tugas 4: Identifikasi dan Solusi untuk Isu Rendahnya Akses Informasi Pranikah di Daerah Terpencil**

Mahasiswa diminta membuat studi literatur tentang kondisi nyata di daerah terpencil di Indonesia terkait rendahnya akses informasi mengenai persiapan pranikah dan prakonsepsi. Setelah melakukan analisis, mahasiswa harus membuat rencana aksi konkret berupa solusi komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana aksi harus mencakup pelatihan tenaga kesehatan lokal, program penyuluhan berbasis komunitas, serta strategi kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan infrastruktur komunikasi di daerah terpencil.

### **Tugas 5: Kampanye Digital tentang Pentingnya Persiapan Prakonsepsi**

Mahasiswa diminta membuat kampanye digital kreatif melalui media sosial dengan target pasangan muda yang sedang merencanakan kehamilan. Konten kampanye harus memuat informasi penting mengenai pemeriksaan kesehatan sebelum hamil (seperti skrining hormon, genetik, dan infeksi menular seksual), pola hidup sehat sebelum konsepsi, serta pentingnya imunisasi dan suplementasi nutrisi sebelum hamil. Mahasiswa diwajibkan membuat desain visual (poster atau infografis), caption edukatif, serta strategi agar kampanye ini bisa menjangkau banyak orang dan meningkatkan kesadaran pasangan muda mengenai pentingnya persiapan prakonsepsi.

#### **Pilihan Ganda**

1. Pasangan muda, Rini (24 tahun) dan Andi (26 tahun), berencana menikah 3 bulan lagi. Mereka datang kepada Anda sebagai bidan untuk mendapatkan nasihat mengenai persiapan pranikah, terutama aspek kesehatan fisik.  
Apa saran yang paling tepat untuk diberikan kepada pasangan ini terkait persiapan fisik sebelum menikah?  
A. Menyarankan tes DNA lengkap  
B. Memberikan suplemen tanpa pemeriksaan  
C. Menyarankan tes kesuburan langsung sebelum menikah  
D. Menganjurkan melakukan olahraga berat menjelang pernikahan  
E. Menyarankan pemeriksaan kesehatan pranikah yang mencakup skrining IMS, kondisi kronis, serta status imunisasi
2. Mita (27 tahun) dan Dika (30 tahun) sedang dalam tahap persiapan prakonsepsi. Mereka bertanya kepada Anda mengenai imunisasi yang penting sebelum kehamilan.  
Imunisasi manakah yang paling penting Anda rekomendasikan kepada Mita sebelum ia hamil?  
A. Rubella, tetanus, hepatitis B  
B. Campak dan cacar air  
C. Influenza musiman  
D. Polio  
E. HPV

3. Lisa (25 tahun) dan Eko (28 tahun) sedang menghadapi kesulitan mengatur keuangan menjelang pernikahan mereka. Sebagai seorang bidan yang juga memberikan edukasi pranikah, saran apakah yang paling tepat Anda berikan kepada pasangan ini?
- A. Memprioritaskan pembelian rumah dengan cicilan tinggi
  - B. Tidak perlu membuat anggaran khusus
  - C. Menyarankan mereka untuk membuat anggaran realistis dan perencanaan finansial jangka Panjang
  - D. Menyarankan pengambilan pinjaman tanpa perhitungan matang
  - E. Menyarankan pembelanjaan secara spontan menjelang pernikahan
4. Ibu Sri (48 tahun), seorang tokoh masyarakat di daerah terpencil, merasa prihatin dengan rendahnya pemahaman pasangan muda tentang kesehatan reproduksi akibat kurangnya informasi. Sebagai bidan desa yang bertanggung jawab dalam penyuluhan, langkah paling efektif apa yang harus Anda lakukan untuk meningkatkan akses informasi di daerah ini?
- A. Mengabaikan faktor budaya lokal saat menyampaikan edukasi
  - B. Melakukan penyuluhan dengan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat setempat
  - C. Hanya menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi
  - D. Menyarankan pasangan muda mencari informasi sendiri tanpa pendampingan
  - E. Tidak melakukan edukasi karena khawatir menyinggung budaya lokal
5. Putri (23 tahun) dan Rama (25 tahun) merencanakan kehamilan setelah menikah. Mereka khawatir tentang risiko kelainan bawaan pada bayi mereka. Sebagai bidan, apa suplementasi yang paling utama Anda rekomendasikan kepada Putri selama masa prakonsepsi?
- A. Vitamin C dosis tinggi
  - B. Suplementasi vitamin A dosis tinggi
  - C. Suplementasi kalsium dosis tinggi
  - D. Suplementasi asam folat untuk mencegah kelainan tabung saraf (NTD)
  - E. Suplementasi karbohidrat tinggi



## **Kunci Jawaban**

### **1. Kunci Jawaban: E**

#### **Pembahasan:**

Persiapan fisik sebelum menikah yang paling tepat adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mencakup pemeriksaan penyakit menular seksual (IMS), penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, serta imunisasi yang diperlukan sebelum. Langkah ini akan mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko kesehatan secara dini.

### **2. Kunci Jawaban: A**

#### **Pembahasan:**

Imunisasi prakonsepsi yang sangat dianjurkan sebelum kehamilan adalah rubella, tetanus, dan hepatitis B. Vaksin ini diberikan untuk mencegah infeksi yang bisa menyebabkan cacat bawaan atau komplikasi serius pada janin.

### **3. Kunci Jawaban: C**

#### **Pembahasan:**

Kesiapan finansial sebelum menikah membutuhkan anggaran yang realistis dan perencanaan keuangan yang matang, termasuk investasi jangka panjang seperti pembelian rumah, dana pendidikan anak, dan dana pensiun. Hal ini akan membantu pasangan menghindari konflik akibat ketidaksiapan finansial.

### **4. Kunci Jawaban: B**

#### **Pembahasan:**

Pendekatan penyuluhan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan akses informasi di daerah terpencil, karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar untuk menghilangkan stigma negatif dan membantu masyarakat menerima informasi dengan baik.

### **5. Kunci Jawaban: D**

#### **Pembahasan:**

Asam folat terbukti secara ilmiah sangat penting dalam mencegah kelainan tabung saraf (Neural Tube Defect), seperti spina bifida pada janin. Suplementasi asam folat sangat dianjurkan sejak sebelum konsepsi hingga awal kehamilan untuk menjamin kesehatan janin.

## F. Rangkuman Materi

Persiapan pranikah merupakan rangkaian aktivitas terstruktur yang bertujuan memastikan kesiapan menyeluruh pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, meliputi fisik, psikologis, finansial, dan sosial sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Persiapan ini bukan sekadar formalitas, melainkan investasi jangka panjang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan stabil. Kesiapan mental sangat krusial, mengingat dinamika kehidupan berumah tangga yang penuh tantangan. Pasangan yang menjalani persiapan psikologis secara matang, biasanya melalui konseling pranikah, akan lebih mampu mengelola stres, berkomunikasi secara terbuka, efektif, dan menyelesaikan konflik dengan bijak. Dalam aspek fisik dan kesehatan, pemeriksaan pranikah penting untuk mengidentifikasi sejak dini risiko penyakit kronis, infeksi menular seksual, serta gangguan genetik yang berpotensi diwariskan kepada keturunan. Kesiapan finansial juga menjadi landasan penting, di mana pasangan diajak untuk membuat anggaran realistis, pengelolaan keuangan bijaksana, serta perencanaan investasi dan tabungan untuk masa depan keluarga. Dari sisi sosial, persiapan pranikah mencakup kemampuan adaptasi terhadap lingkungan sosial dan keluarga besar pasangan, demi menciptakan hubungan yang saling menghormati dan harmonis.

Selain itu, persiapan prakonsepsi juga merupakan aspek penting yang dilakukan sebelum kehamilannya, bertujuan menciptakan kondisi optimal untuk kehamilan yang sehat. Aktivitas ini meliputi pemeriksaan kesehatan reproduksi menyeluruh, skrining hormonal, pemeriksaan genetik, serta pengendalian faktor risiko kesehatan lainnya. Gaya hidup sehat menjadi fokus utama dalam persiapan ini, mencakup pola makan seimbang, aktivitas fisik rutin, serta menghindari konsumsi zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan narkoba yang dapat menimbulkan risiko komplikasi pada janin. Imunisasi seperti rubella, tetanus, dan hepatitis B serta suplementasi nutrisi, terutama asam folat dan zat besi, sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko kelainan bawaan pada bayi.

Bidan memiliki peran sentral dalam memberikan edukasi pranikah dan prakonsepsi. Sebagai pendidik kesehatan, bidan bertanggung jawab menyampaikan informasi detail mengenai anatomi, fisiologi reproduksi, dan penggunaan alat kontrasepsi sesuai kondisi pasangan. Sebagai konselor, bidan mendampingi pasangan dalam menghadapi tantangan psikologis dan emosional, memberikan keterampilan komunikasi efektif serta teknik mengatasi konflik. Sebagai tenaga kesehatan, bidan melakukan pemeriksaan kesehatan komprehensif untuk memastikan kesiapan fisik

pasangan sebelum menikah dan memiliki anak. Bidan juga mempromosikan gaya hidup sehat, mendorong konsumsi nutrisi seimbang, aktivitas fisik rutin, serta menghindari konsumsi zat berbahaya. Melalui peran edukatif, konseling, serta pemeriksaan kesehatan, bidan turut membangun keluarga yang sehat dan harmonis secara fisik, mental, serta sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kesadaran pasangan muda akan pentingnya perencanaan keluarga secara matang, terutama dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi. Beragam platform digital memberikan akses mudah terhadap informasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keuangan keluarga, serta keterampilan komunikasi dan manajemen stres dalam rumah tangga. Dampak positifnya, pasangan muda kini lebih proaktif dalam mengambil keputusan pernikahan, melakukan persiapan menyeluruh, dan mengikuti konseling pranikah. Hal ini menciptakan generasi keluarga muda yang matang, bertanggung jawab, harmonis, dan memiliki stabilitas ekonomi lebih baik, berdampak positif pada kesejahteraan keluarga secara luas.

Namun demikian, isu rendahnya akses informasi pranikah dan prakonsepsi masih dirasakan oleh masyarakat di daerah terpencil, terutama akibat minimnya tenaga kesehatan profesional, terbatasnya infrastruktur komunikasi, dan budaya lokal yang masih menganggap tabu pembahasan kesehatan reproduksi secara terbuka. Rendahnya akses ini menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan dibandingkan masyarakat perkotaan. Solusi yang perlu diambil meliputi peningkatan pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal, pelaksanaan penyuluhan kesehatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, serta penguatan infrastruktur komunikasi melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan strategis ini, diharapkan kesenjangan informasi dapat dikurangi, sehingga seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, bisa menikmati manfaat persiapan pranikah dan prakonsepsi secara optimal, menghasilkan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera secara merata.

## G. Glosarium

### **Adaptasi Sosial:**

Proses penyesuaian diri pasangan terhadap lingkungan sosial, budaya, dan nilai-nilai keluarga besar masing-masing, yang bertujuan membangun relasi harmonis dan saling menghormati.

### **Anatomi dan Fisiologi Reproduksi:**

Pengetahuan dasar mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi manusia, yang mencakup siklus menstruasi, ovulasi, dan masa subur, sebagai landasan dalam perencanaan keluarga

### **Asam Folat:**

Vitamin B yang sangat penting dikonsumsi sebelum konsepsi hingga masa awal kehamilan untuk mencegah kelainan tabung saraf (neural tube defect) seperti spina bifida pada janin.

### **Edukasi Pranikah:**

Proses penyampaian informasi sistematis kepada pasangan yang akan menikah mengenai aspek fisik, psikologis, finansial, dan sosial yang bertujuan mempersiapkan pasangan secara menyeluruh sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

### **Gaya Hidup Sehat:**

Pola hidup yang meliputi konsumsi makanan bergizi seimbang, rutin melakukan aktivitas fisik, serta menghindari konsumsi zat-zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan narkoba untuk mendukung kesehatan optimal calon orang tua dan keturunannya.

### **Imunisasi Prakonsepsi:**

Pemberian vaksin tertentu sebelum kehamilan, seperti rubella, tetanus, dan hepatitis B, yang bertujuan melindungi ibu dari penyakit menular yang berpotensi menyebabkan komplikasi serius pada janin.

### **Konseling Pranikah:**

Proses pendampingan psikologis dan emosional pasangan sebelum menikah, yang bertujuan membantu mereka mengelola stres, menyelesaikan konflik, dan meningkatkan keterampilan komunikasi serta empati.

### **Keluarga:**

Unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan, memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berkualitas tinggi.

### **Kesiapan Finansial:**

Kondisi di mana pasangan mampu mengatur keuangan secara realistis, termasuk menyusun anggaran, pengelolaan utang, serta perencanaan investasi dan tabungan

untuk kebutuhan jangka panjang keluarga seperti rumah, pendidikan anak, dan dana pensiun.

**Kesiapan Mental:**

Kondisi psikologis pasangan yang telah matang secara emosional untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, mampu mengelola stres sehari-hari, dan memiliki keterampilan dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana.

**Kesehatan Reproduksi:**

Kondisi fisik yang optimal pada organ reproduksi, meliputi skrining hormon, pemeriksaan genetik, serta deteksi dini terhadap penyakit menular seksual, yang bertujuan memastikan kesiapan fisik sebelum kehamilan.

**Komplikasi Kehamilannya:**

Gangguan atau risiko yang muncul selama kehamilan, seperti cacat bawaan, pertumbuhan janin terhambat, atau risiko keguguran yang dapat dicegah atau dikurangi melalui persiapan prakonsepsi yang matang.

**Konsepsi:**

Proses pertemuan antara sel telur dan sperma yang menghasilkan kehamilan.

**Neural Tube Defect (NTD):**

Kelainan tabung saraf janin yang dapat menyebabkan cacat bawaan serius, dicegah dengan konsumsi asam folat sebelum konsepsi dan selama masa awal kehamilan.

**Pemeriksaan Kesehatan Pranikah:**

Rangkaian pemeriksaan medis sebelum menikah yang meliputi skrining penyakit menular seksual (IMS), penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi, serta pemeriksaan imunisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kesehatan secara dini.

**Perencanaan Keluarga:**

Proses pengambilan keputusan pasangan mengenai kapan dan bagaimana memiliki anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesehatan fisik, mental, sosial, serta kesiapan finansial.

**Persiapan Prakonsepsi:**

Aktivitas yang dilakukan sebelum terjadi kehamilan, mencakup pemeriksaan kesehatan reproduksi secara menyeluruh, gaya hidup sehat, imunisasi, serta suplementasi nutrisi tertentu untuk menciptakan kondisi optimal bagi kehamilan.

**Persiapan Pranikah:**

Aktivitas sistematis yang mencakup dimensi fisik, psikologis, finansial, dan sosial, yang bertujuan mempersiapkan pasangan secara menyeluruh sebelum menjalani kehidupan rumah tangga.

**Rubella:**

Penyakit infeksi virus yang berbahaya bagi wanita hamil karena dapat menyebabkan kecacatan bawaan pada janin, pencegahannya dilakukan melalui imunisasi sebelum hamil.

**Skrining Kesehatan Reproduksi:**

Pemeriksaan komprehensif terhadap kesehatan reproduksi pasangan sebelum kehamilan, termasuk pemeriksaan hormon, genetik, dan penyakit infeksi menular seksual, yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko komplikasi selama kehamilan.

**Suplementasi Nutrisi:**

Penambahan nutrisi tertentu seperti asam folat dan zat besi dalam diet sehari-hari sebelum dan selama kehamilan, guna memastikan kesehatan optimal ibu dan janin serta mencegah komplikasi kesehatan tertentu.

**Tantangan Psikologis:**

Tekanan emosional yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti masalah ekonomi, adaptasi terhadap pasangan, serta perbedaan budaya, yang perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik melalui proses konseling pranikah.

**Tenaga Bidan:**

Profesional kesehatan yang memiliki peran multifungsi sebagai pendidik, konselor, tenaga medis, serta fasilitator gaya hidup sehat bagi pasangan yang akan menikah maupun yang sedang merencanakan kehamilan.

**Tren Kesadaran Pasangan Muda:**

Fenomena meningkatnya kesadaran pasangan muda mengenai pentingnya persiapan matang sebelum menikah dan memiliki anak, yang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan ketersediaan akses informasi digital.

**Zat Besi:**

Mineral yang direkomendasikan dikonsumsi sebelum dan selama kehamilan untuk mencegah anemia yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan janin. Dengan glosarium ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami istilah-istilah penting dalam materi pranikah dan prakonsepsi secara mendalam.

## H. Daftar Pustaka

- Andrews, G., & Halford, W. K. (2021). *Marriage preparation and relationship education: A comprehensive guide*. Routledge.
- Badan PPSPDM Kesehatan. (2021). *Profil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Kementerian Kesehatan RI. <https://pusdatin.kemkes.go.id>
- BKKBN. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Direktorat Kesehatan Keluarga. (2019). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil (Prakonsepsi)*. Kementerian Kesehatan RI.
- Fikawati, S., & Syafiq, A. (2019). *Gizi dan Kesehatan Reproduksi*. Rajawali Pers.
- Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2019). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice* (6th ed.). Pearson Education.
- Hidayat, A. A. A., & Uliyah, M. (2020). *Kesehatan Reproduksi dan KB untuk Mahasiswa Kebidanan*. Salemba Medika.
- Jannah, N. (2020). *Psikologi Pernikahan: Persiapan Mental dan Emosi Menjelang Rumah Tangga*. Gramedia Pustaka Utama.
- KemenPPPA. (2020). *Modul Pendidikan Pranikah: Perspektif Kesetaraan Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Praktik Klinis bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Kemenkes RI.
- Lestari, D. W., & Suharti, S. (2022). Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 14(1), 22–34. <https://doi.org/10.31227/osf.io/jd4vq>
- Llewellyn-Jones, D. (2021). *Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology* (11th ed.). Elsevier.
- Mulyani, S., & Widyastuti, Y. (2019). *Asuhan Kebidanan Komprehensif dalam Kesehatan Reproduksi*. Pustaka Baru Press.
- Rahmadewi, I. P., & Wahyuni, S. (2020). *Pendidikan Kesehatan dalam Kebidanan*. Andi Offset.
- Santrock, J. W. (2020). *Life-Span Development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- WHO. (2019). *Preconception Care: Maximizing the Gains for Maternal and Child Health*. World Health Organization.
- WHO. (2021). *Strengthening midwifery education for universal health coverage 2030*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240038301>



- Widyastuti, A., & Rachmawati, P. D. (2020). Strategi komunikasi kesehatan reproduksi berbasis budaya lokal pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 15(2), 97–106. <https://doi.org/10.14710/jpki.15.2.97-106>
- Yulaikhah, L., & Fitriyah, N. (2021). *Konseling Pranikah dan Kesehatan Reproduksi*. Deepublish.
- Yusriani, N., Fitriana, D., & Syafitri, I. (2021). Tantangan edukasi kesehatan reproduksi di komunitas konservatif: Studi kasus di pedesaan NTB. *Jurnal Kesmas dan Reproduksi*, 8(1), 51–60. <https://doi.org/10.33860/jkr.v8i1.299>

# Bab 2

## Persiapan Pranikah dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga

Pernikahan adalah sebuah komitmen besar yang tidak sekadar menyatukan dua individu secara fisik, tetapi juga menyatukan aspek mental, emosional, finansial, dan sosial. Oleh karena itu, persiapan pranikah menjadi bagian integral yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Persiapan yang matang akan menjadi dasar yang kokoh untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, stabil, dan penuh kebahagiaan. Dalam bab ini, akan dibahas berbagai aspek penting terkait persiapan pranikah, mulai dari konseling, komunikasi, pengelolaan keuangan, hingga manajemen konflik, yang merupakan modal utama dalam merancang kehidupan berkeluarga yang sehat dan sejahtera.

### Capaian Pembelajaran (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami secara mendalam berbagai aspek penting persiapan pranikah serta merancang strategi untuk membantu pasangan muda menghadapi tantangan dalam kehidupan berumah tangga secara optimal.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengaplikasikan berbagai konsep persiapan pranikah dan perencanaan kehidupan berkeluarga dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan manfaat konseling pranikah.
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip komunikasi efektif bagi pasangan.
- Mahasiswa mampu menyusun perencanaan keuangan keluarga yang realistis.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi strategi pengelolaan konflik dalam rumah tangga.
- Mahasiswa mampu menjelaskan tren konseling pranikah secara daring (*online counseling*).
- Mahasiswa mampu menganalisis isu kesiapan psikologis pasangan muda menghadapi tantangan pernikahan.

## A. Konseling Pranikah: Tujuan dan Manfaatnya

Konseling pranikah merupakan salah satu pendekatan preventif yang efektif dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin menghadapi kehidupan pernikahan. Program ini tidak hanya menekankan aspek edukatif, tetapi juga pengembangan keterampilan interpersonal dan emosional. Menurut Andrews dan Halford (2021), konseling pranikah berfungsi sebagai fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat, dengan menekankan komunikasi efektif, pengelolaan konflik, dan perencanaan masa depan bersama.



**Gambar 2.1**  
**Konseling Pranikah**

Penelitian oleh Santrock (2020) menunjukkan bahwa konseling pranikah dapat membantu pasangan dalam meningkatkan kesadaran diri dan empati terhadap pasangan. Proses ini memperkuat pemahaman pasangan mengenai kebutuhan emosional masing-masing dan mendukung pembentukan relasi yang saling mendukung. Dalam konteks ini, keterampilan komunikasi menjadi elemen kunci dalam mencegah konflik yang tidak perlu, terutama jika pasangan telah terlatih dalam mendengarkan aktif, ekspresi emosi yang sehat, serta penyelesaian konflik secara asertif.

Manfaat penting lainnya dari konseling pranikah adalah kemampuan untuk mengenali potensi konflik sejak dini. Hal ini selaras dengan temuan Jannah (2020), yang menyatakan bahwa perbedaan nilai, ekspektasi, dan latar belakang budaya merupakan faktor signifikan pemicu konflik pernikahan, terutama pada tahun-tahun awal. Dengan bantuan tenaga profesional, pasangan didorong untuk membahas isu-isu sensitif tersebut dalam suasana terbimbing dan terbuka. Selain itu, Putri & Hadi (2022) menekankan bahwa pasangan yang mengikuti konseling pranikah menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih baik terhadap peran baru setelah

menikah. Hal ini karena konseling juga mengajarkan teknik pengelolaan stres dan penyesuaian diri, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika pernikahan dan perubahan peran sosial, emosional, serta ekonomi dalam keluarga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA, 2020) melalui juga menekankan pentingnya pendekatan konseling yang berperspektif gender dan berorientasi pada kesetaraan. Pendekatan ini mengajak pasangan untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga secara adil, mendorong kerja sama yang setara dalam pengambilan keputusan, serta membangun relasi yang bebas dari kekerasan dan dominasi salah satu pihak.

Dengan semakin banyaknya pasangan muda yang menghadapi tantangan pernikahan dalam masyarakat modern, konseling pranikah menjadi investasi psikososial yang sangat penting. Melalui pendekatan yang terstruktur, berbasis ilmiah, dan relevan dengan konteks budaya, konseling ini menjadi langkah awal untuk menciptakan keluarga yang tangguh, sehat secara emosional, dan harmonis dalam jangka panjang.

## **B. Komunikasi Efektif Pasangan**

Komunikasi merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas hubungan dalam kehidupan pernikahan. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara efektif akan memiliki hubungan yang cenderung lebih harmonis, saling mendukung, dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebaliknya, pasangan yang menghadapi hambatan dalam berkomunikasi sering kali menemukan diri mereka terjebak dalam konflik yang terus berulang, kesalahpahaman yang tak terselesaikan, serta hubungan emosional yang menjauh. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan komunikasi efektif merupakan salah satu aspek paling penting yang harus dimiliki pasangan dalam persiapan memasuki kehidupan berkeluarga.

Komunikasi efektif dalam hubungan pernikahan tidak hanya sebatas berbicara atau menyampaikan pesan kepada pasangan. Lebih dari itu, komunikasi efektif menuntut adanya beberapa elemen penting seperti kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat terhadap pandangan, gagasan, serta perasaan pasangan. Kejujuran dalam komunikasi merupakan fondasi penting yang memungkinkan pasangan untuk berbagi segala sesuatu secara autentik tanpa rasa takut atau ragu. Pasangan yang mampu saling terbuka satu sama lain cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, karena setiap individu dalam hubungan tersebut tahu bahwa mereka bisa mengandalkan satu sama lain untuk berbicara dengan jujur dan tulus.

Selain kejujuran, keterbukaan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Keterbukaan memungkinkan pasangan untuk berbagi perasaan, harapan, kekhawatiran, bahkan kekecewaan secara terbuka tanpa harus merasa takut dihakimi atau ditolak. Pasangan perlu menciptakan suasana yang aman secara emosional, di mana masing-masing pihak merasa nyaman dan aman untuk mengekspresikan dirinya dengan bebas. Dalam suasana yang terbuka ini, kedua belah pihak dapat memahami satu sama lain dengan lebih mendalam dan mendukung pertumbuhan hubungan secara positif.

Selanjutnya, rasa hormat terhadap pandangan dan pendapat pasangan merupakan elemen penting lain dalam komunikasi efektif. Setiap individu dalam sebuah hubungan memiliki latar belakang, pengalaman, dan sudut pandang yang unik. Menghormati pandangan pasangan berarti memberikan ruang yang cukup untuk pasangan mengungkapkan apa yang mereka rasakan atau pikirkan, meskipun pandangan tersebut mungkin berbeda dari pandangan pribadi. Rasa hormat ini ditunjukkan melalui sikap yang menghargai dan menghormati pasangan saat mereka berbicara, tidak memotong pembicaraan secara kasar, dan menunjukkan bahwa apa yang pasangan sampaikan dianggap bernilai dan penting. Pasangan yang saling menghormati akan menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif untuk diskusi yang sehat dan konstruktif, sehingga lebih mampu mencari solusi bersama ketika menghadapi berbagai masalah.

Di samping menyampaikan perasaan dan pikiran dengan cara yang tepat, aspek lain yang sangat penting dalam komunikasi efektif adalah kemampuan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif merupakan keterampilan yang melibatkan perhatian penuh terhadap apa yang sedang dikatakan oleh pasangan. Hal ini berarti tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami makna di balik kata-kata tersebut, termasuk perasaan dan emosi yang menyertainya. Mendengarkan secara aktif juga melibatkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang menunjukkan bahwa seseorang benar-benar memahami apa yang telah disampaikan oleh pasangannya. Misalnya, dengan mengulang kembali pesan yang diterima dengan kata-kata sendiri, menunjukkan empati terhadap perasaan pasangan, atau dengan memberikan tanggapan yang relevan dan mendukung terhadap apa yang disampaikan.

Kemampuan mendengarkan secara aktif sangat efektif dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman yang sering kali menjadi pemicu konflik dalam hubungan

pernikahan. Sering kali pasangan merasa tidak didengar atau dipahami, yang berujung pada frustrasi, marah, atau bahkan konflik yang lebih besar. Dengan mendengarkan secara aktif, pasangan dapat memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dengan jelas, sehingga kedua belah pihak merasa dihargai dan diperhatikan. Melalui praktik mendengarkan secara aktif, pasangan juga belajar untuk lebih memahami dan merespons kebutuhan emosional masing-masing, yang pada akhirnya memperkuat hubungan mereka secara signifikan.

Pada akhirnya, komunikasi efektif membantu pasangan untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, pasangan lebih mampu saling mengerti dan menghargai, mengurangi ketegangan yang tidak perlu, serta menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat dan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan sangat dianjurkan untuk melatih keterampilan komunikasi efektif ini dengan tekun dan konsisten, baik melalui proses konseling pranikah maupun dengan upaya pribadi sehari-hari dalam interaksi mereka.

### **C. Perencanaan Keuangan Keluarga**

Perencanaan keuangan keluarga merupakan salah satu aspek vital yang menentukan stabilitas dan kesejahteraan sebuah rumah tangga. Kehidupan berkeluarga tidak hanya tentang hubungan emosional dan cinta, tetapi juga memerlukan fondasi keuangan yang kuat agar keluarga dapat hidup dengan tenang dan harmonis. Aspek finansial yang dikelola secara bijaksana dan terencana dapat membantu pasangan dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul sepanjang kehidupan berkeluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, kesehatan, hingga rencana jangka panjang seperti membeli rumah atau merencanakan pensiun.

Langkah pertama dalam perencanaan keuangan keluarga adalah menyusun anggaran rumah tangga secara realistis dan transparan. Penyusunan anggaran ini mencakup penghitungan total pendapatan pasangan serta merinci semua jenis pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, hingga pengeluaran tambahan seperti rekreasi atau hobi. Pasangan perlu secara terbuka berdiskusi tentang prioritas masing-masing individu, menentukan kebutuhan yang esensial dan yang tidak esensial, sehingga dapat menyusun anggaran yang disepakati bersama. Dengan memiliki anggaran yang

jelas, pasangan dapat mengontrol pengeluaran mereka dan memastikan bahwa uang yang diperoleh dimanfaatkan secara efisien, efektif, serta selaras dengan tujuan bersama.



**Gambar 2.2**  
**Mengatur Keuangan Keluarga**

Selain menyusun anggaran, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran secara bijaksana juga sangat penting. Pasangan harus mampu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dalam praktiknya, mereka harus berusaha untuk mengutamakan kebutuhan yang esensial terlebih dahulu sebelum memenuhi keinginan pribadi. Mengelola pengeluaran secara bijak berarti bahwa pasangan tidak hanya sekadar membatasi konsumsi, tetapi juga berusaha agar pengeluaran yang dilakukan memang memberikan manfaat nyata bagi keluarga secara keseluruhan. Disiplin dalam pengelolaan keuangan akan melindungi keluarga dari risiko mengalami kesulitan ekonomi yang bisa mengarah pada tekanan emosional dan konflik rumah tangga.

Tidak kalah penting adalah perencanaan investasi untuk masa depan. Investasi yang direncanakan dengan matang membantu keluarga untuk mempersiapkan kebutuhan besar di masa depan seperti biaya pendidikan anak-anak, pembelian rumah, atau kebutuhan dana pensiun. Perencanaan investasi mencakup pemilihan instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko, tujuan jangka panjang keluarga, serta kemampuan finansial pasangan. Instrumen investasi ini bisa berupa tabungan berjangka, deposito, reksa dana, emas, properti, hingga saham. Dengan investasi yang terencana, keluarga bisa memiliki jaminan kestabilan finansial yang

lebih baik di masa depan, sehingga kehidupan mereka tidak hanya aman dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang.

Selain itu, pasangan juga perlu memahami dengan baik konsep manajemen utang. Utang memang tidak sepenuhnya buruk jika dikelola dengan baik, namun utang bisa menjadi sumber masalah serius apabila tidak terkontrol. Pasangan harus mampu membedakan antara utang produktif, seperti kredit rumah atau modal usaha, dengan utang konsumtif, seperti penggunaan kartu kredit secara berlebihan untuk barang-barang yang tidak terlalu penting. Memahami cara mengelola utang secara bijaksana termasuk mengetahui batas aman dalam mengambil utang, membayar utang tepat waktu, dan menghindari jebakan utang yang bisa menjerat keuangan keluarga di kemudian hari.

Di samping manajemen utang, pengelolaan dana tabungan darurat juga merupakan komponen penting dari perencanaan keuangan keluarga. Tabungan darurat adalah dana khusus yang disiapkan untuk menghadapi kondisi tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya. Idealnya, dana ini mencukupi setidaknya tiga hingga enam bulan pengeluaran rutin keluarga. Dengan adanya dana darurat, keluarga memiliki perlindungan finansial yang cukup untuk mengatasi situasi darurat tanpa harus mengganggu kestabilan finansial keluarga secara keseluruhan.

Sebagai tambahan, penting pula bagi pasangan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan berbagai sumber penghasilan tambahan. Bergantung hanya pada satu sumber penghasilan bisa sangat rentan terhadap berbagai risiko ekonomi. Dengan memiliki sumber pendapatan tambahan, keluarga menjadi lebih fleksibel dan tangguh dalam menghadapi berbagai fluktuasi ekonomi, perubahan situasi pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Penghasilan tambahan ini bisa berasal dari usaha kecil-kecilan, pekerjaan sampingan, investasi pasif, atau bahkan kegiatan kreatif yang bisa menghasilkan pendapatan tambahan.

Pada akhirnya, perencanaan keuangan keluarga yang matang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial, tetapi juga sebagai sarana penting dalam menjaga harmoni hubungan rumah tangga. Pasangan yang mampu mengelola keuangan dengan baik umumnya lebih tenang, jarang mengalami stres ekonomi, serta memiliki hubungan yang lebih stabil dan bahagia. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga, keluarga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan



lebih tenteram, fokus pada pembangunan hubungan emosional yang kuat, dan menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh dengan rasa saling mendukung dan kasih sayang.

#### **D. Pengelolaan Konflik dalam Pernikahan**

Dalam sebuah pernikahan, kehadiran konflik adalah sesuatu yang alamiah dan tidak mungkin dihindari sepenuhnya. Dua individu dengan latar belakang yang berbeda, pengalaman hidup yang unik, serta pola pikir dan perasaan yang beragam, pasti akan menghadapi perselisihan atau perbedaan pendapat dari waktu ke waktu. Konflik, pada dasarnya, tidak selalu menjadi tanda buruk dalam hubungan rumah tangga. Sebaliknya, konflik bisa menjadi kesempatan bagi pasangan untuk bertumbuh dan mengenal satu sama lain secara lebih dalam, asalkan mereka mampu mengelola konflik tersebut dengan cara yang tepat dan konstruktif.

Kualitas sebuah hubungan pernikahan tidak dinilai dari seberapa jarang konflik terjadi, tetapi justru dari kemampuan pasangan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik secara sehat dan efektif. Salah satu langkah awal dalam pengelolaan konflik yang efektif adalah kemampuan pasangan untuk memahami akar permasalahan secara jernih. Seringkali, perselisihan terjadi karena pasangan kurang mampu mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Emosi yang meluap-luap atau kekecewaan terhadap hal-hal kecil bisa saja merupakan manifestasi dari masalah yang lebih dalam, seperti ketidakamanan emosional, perasaan diabaikan, atau bahkan rasa tidak dihargai. Oleh sebab itu, penting bagi pasangan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi dan memahami secara mendalam apa yang sebenarnya menjadi penyebab konflik mereka.

Setelah akar masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yang penting adalah kemampuan pasangan dalam menyampaikan pendapat dan perasaan secara terbuka tanpa agresi. Pasangan perlu belajar untuk mengkomunikasikan kekhawatiran, ketidakpuasan, atau ketidaksetujuan mereka dengan cara yang jelas, lugas, namun tetap penuh rasa hormat. Menyampaikan perasaan secara agresif, seperti menggunakan kata-kata kasar, nada bicara tinggi, atau bahkan tindakan fisik, tidak akan menyelesaikan masalah; sebaliknya, justru akan memperbesar jarak emosional di antara pasangan. Pasangan yang efektif dalam pengelolaan konflik adalah mereka yang mampu tetap tenang, berbicara dengan jujur namun santun, serta mampu menjaga penghormatan terhadap pasangan selama berdiskusi.

Selanjutnya, pengelolaan konflik dalam pernikahan sangat membutuhkan sikap empati dari kedua belah pihak. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi pasangan, memahami perasaan dan pikirannya secara mendalam, serta mampu melihat situasi dari perspektif pasangan. Ketika masing-masing pasangan mampu menunjukkan empati dalam situasi konflik, mereka cenderung lebih terbuka terhadap solusi yang saling menguntungkan, dan lebih mudah mencapai kompromi yang sehat. Sikap empati ini juga mengurangi kemungkinan munculnya kesalahpahaman yang memperparah situasi, karena masing-masing individu merasa didengar, dipahami, dan dihargai oleh pasangannya.

Kemampuan mencapai solusi melalui negosiasi yang konstruktif juga merupakan bagian penting dari pengelolaan konflik yang efektif dalam pernikahan. Negosiasi yang konstruktif melibatkan dialog terbuka yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pasangan perlu bersikap fleksibel dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan solusi, sambil tetap fokus pada tujuan utama yaitu penyelesaian konflik secara damai dan harmonis. Dalam proses ini, sangat penting bagi pasangan untuk menghindari sikap keras kepala, tidak mau mengalah, atau memaksakan kehendak pribadi. Sebaliknya, mereka perlu belajar untuk bersikap terbuka terhadap ide-ide pasangan, serta bersedia menyesuaikan harapan masing-masing demi kebaikan bersama.

Tidak kalah pentingnya, pasangan harus menyadari nilai kompromi dan kerjasama dalam setiap konflik yang muncul. Kompromi tidak berarti bahwa salah satu pihak harus selalu mengalah atau merasa dirugikan, melainkan bahwa kedua pasangan sama-sama menemukan titik tengah yang bisa diterima oleh keduanya. Kompromi yang sehat akan menghasilkan situasi di mana kedua belah pihak merasa didengar, dihormati, dan mampu mempertahankan harga diri masing-masing. Sementara itu, kerjasama dalam konteks pengelolaan konflik berarti bahwa pasangan bekerja sama sebagai satu tim untuk menyelesaikan masalah, bukan justru saling bersaing atau mencari siapa yang paling benar. Dengan cara ini, pasangan bisa mengubah konflik menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan emosional mereka, meningkatkan rasa percaya, dan memperdalam keintiman dalam hubungan.

Dengan demikian, pengelolaan konflik yang baik dalam pernikahan tidak hanya sekadar menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertengkaran semata, melainkan juga berkontribusi pada pertumbuhan hubungan yang lebih kuat dan lebih mendalam. Pasangan yang mahir dalam mengelola konflik cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil, lebih memuaskan secara emosional, serta lebih tahan

terhadap berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Mereka mampu menjalani kehidupan bersama dengan lebih harmonis, karena setiap konflik yang muncul diubah menjadi momen pembelajaran yang memperkaya hubungan dan memperkuat fondasi cinta mereka.

#### **E. Tren: Konseling Pranikah secara Daring (*Online Counseling*)**

Perkembangan teknologi digital telah memberikan kontribusi besar dalam perluasan akses terhadap layanan kesehatan mental dan konseling, termasuk dalam ranah konseling pranikah daring (*online premarital counseling*). Model ini menjadi solusi inovatif bagi pasangan calon pengantin yang memiliki keterbatasan geografis, waktu, atau kondisi tertentu yang membuat mereka sulit mengakses layanan tatap muka konvensional. Menurut Putri dan Hadi (2022), konseling pranikah daring terbukti dapat memberikan hasil yang sebanding dengan konseling langsung apabila dijalankan oleh tenaga profesional yang kompeten.

Ada berbagai keuntungan yang membuat konseling pranikah daring semakin banyak diminati oleh pasangan modern. Salah satunya adalah fleksibilitas waktu. Pasangan yang sibuk bekerja, memiliki jadwal padat, atau sulit meluangkan waktu untuk bertemu secara langsung dengan konselor di lokasi tertentu, kini dapat mengatur jadwal sesi konseling dengan lebih bebas dan mudah. Mereka bisa mengikuti sesi dari rumah atau tempat lain yang nyaman, selama mereka memiliki perangkat yang terkoneksi dengan internet. Dengan fleksibilitas ini, pasangan bisa lebih rutin dan konsisten mengikuti sesi konseling, sehingga hasil yang diperoleh juga lebih optimal.

Selain fleksibilitas waktu, kemudahan akses juga menjadi salah satu daya tarik utama dari konseling pranikah daring. Pasangan yang tinggal di daerah terpencil, atau berada dalam hubungan jarak jauh, dapat dengan mudah mengikuti konseling tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Ini memberikan solusi yang praktis dan ekonomis bagi pasangan untuk mendapatkan dukungan profesional secara rutin. Kenyamanan yang ditawarkan oleh metode daring ini juga menjadi alasan banyak pasangan merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan secara terbuka, karena mereka bisa melakukannya dari lingkungan pribadi yang mereka anggap paling aman dan mendukung secara emosional.

Dari sisi efektivitas, konseling pranikah secara daring telah terbukti cukup efektif dalam memberikan dukungan psikologis yang diperlukan pasangan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Dalam sesi daring, pasangan dapat memperoleh

edukasi penting mengenai keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, serta strategi membangun hubungan emosional yang kuat dan sehat. Meski berbeda dengan metode tatap muka langsung, sesi daring dapat berjalan efektif apabila konselor mampu mengelola interaksi dengan baik dan memastikan bahwa pasangan tetap terlibat aktif sepanjang proses konseling.

Namun demikian, penting untuk disadari bahwa keberhasilan konseling pranikah secara daring sangat bergantung pada beberapa faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Salah satu faktor kritis adalah kualitas jaringan internet yang stabil. Koneksi internet yang buruk atau tidak stabil dapat mengganggu jalannya sesi konseling, menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi, atau bahkan menyebabkan frustrasi yang bisa mempengaruhi efektivitas konseling itu sendiri. Oleh karena itu, pasangan yang ingin mengikuti konseling pranikah daring perlu memastikan bahwa mereka memiliki akses internet yang baik, serta perangkat yang memadai untuk menjamin kelancaran sesi.

Selain jaringan internet, kompetensi dan profesionalitas konselor yang menyediakan layanan daring juga merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan konseling. Konselor yang efektif dalam sesi virtual harus mampu menggunakan teknologi dengan mahir, menjaga interaksi tetap dinamis dan interaktif meskipun dilakukan secara virtual, serta memahami cara mengelola hambatan teknis yang mungkin muncul selama sesi berlangsung. Konselor yang kompeten akan mampu menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dan produktif bagi pasangan, sehingga mereka dapat merasa seperti sedang menjalani sesi tatap muka langsung.

Terakhir, faktor yang tidak kalah penting adalah komitmen dan keterlibatan aktif dari pasangan yang mengikuti konseling daring. Pasangan harus memiliki motivasi kuat dan kesadaran bahwa keberhasilan konseling sangat tergantung pada tingkat partisipasi mereka. Keterlibatan aktif mencakup kesiapan untuk terbuka dalam berbicara tentang berbagai topik yang dibahas, disiplin dalam mengikuti jadwal yang telah disepakati, serta kesediaan untuk menerapkan berbagai strategi dan rekomendasi yang diberikan oleh konselor dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, untuk mendapatkan hasil optimal dari konseling pranikah secara daring, pasangan perlu cermat dan selektif dalam memilih layanan konseling yang benar-benar profesional, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga perlu menjaga konsistensi, disiplin, serta keterlibatan yang tinggi selama

proses konseling. Jika faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi dengan baik, konseling pranikah daring akan menjadi sarana yang sangat bermanfaat, efektif, dan bahkan revolusioner dalam mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan pernikahan yang harmonis, stabil, dan penuh kebahagiaan.

## **F. Isu: Kesiapan Psikologis Pasangan Muda dalam Menghadapi Tantangan Pernikahan**

Dalam dinamika kehidupan berkeluarga modern, salah satu isu yang semakin mendapat perhatian adalah kesiapan psikologis pasangan muda dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah komitmen besar yang membawa perubahan signifikan dalam hidup seseorang, tidak hanya dalam aspek praktis seperti tinggal bersama atau mengelola keuangan bersama, tetapi juga dalam aspek psikologis dan emosional. Sayangnya, saat ini banyak pasangan muda yang memutuskan menikah tanpa benar-benar memahami konsekuensi dan tantangan psikologis yang harus mereka hadapi setelah memasuki kehidupan berkeluarga. Ketidakmatangan psikologis ini seringkali berujung pada konflik yang berkepanjangan, stres yang tinggi, bahkan perceraian.

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesiapan psikologis pasangan muda saat ini. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah minimnya edukasi pranikah. Banyak pasangan muda yang tidak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup sebelum menikah mengenai bagaimana menghadapi perbedaan pendapat, mengelola stres, atau menghadapi perubahan peran dalam kehidupan berkeluarga. Tanpa bekal ini, mereka rentan merasa kewalahan atau frustrasi saat menghadapi tantangan rumah tangga yang sebetulnya umum dialami oleh hampir setiap pasangan.

Selain minimnya edukasi, pasangan muda juga sering memasuki pernikahan dengan ekspektasi yang tidak realistis terhadap kehidupan pernikahan maupun terhadap pasangan mereka sendiri. Mereka sering kali membayangkan kehidupan rumah tangga yang ideal, penuh kebahagiaan dan tanpa masalah. Ketika realitas menunjukkan bahwa pernikahan justru penuh dengan tantangan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis, mereka bisa menjadi kecewa, tidak puas, atau merasa bahwa pasangan mereka tidak lagi sesuai harapan. Ekspektasi yang tidak realistis ini dapat menciptakan konflik, karena pasangan sulit menerima bahwa

kehidupan pernikahan memang tidak selalu mulus, dan membutuhkan usaha terus-menerus untuk menjaga hubungan tetap harmonis.

Faktor lain yang turut memperparah situasi adalah meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi pasangan muda di era modern ini. Banyak pasangan yang harus menghadapi tekanan finansial akibat biaya hidup yang terus meningkat, kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks, dan tuntutan untuk mencapai standar kehidupan tertentu yang sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau media sosial. Tekanan ini bisa sangat memberatkan secara psikologis, terutama jika pasangan belum memiliki kemampuan komunikasi atau pengelolaan konflik yang baik. Tekanan sosial dari keluarga atau lingkungan juga turut berperan, di mana pasangan seringkali merasa perlu memenuhi ekspektasi tertentu yang belum tentu sesuai dengan kondisi atau kemampuan mereka yang sebenarnya.

Untuk mengatasi isu kesiapan psikologis ini, langkah pertama yang perlu diambil adalah dengan memastikan bahwa pasangan muda mendapatkan edukasi pranikah yang memadai. Pasangan perlu memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta atau romantisme semata, tetapi juga mencakup berbagai keterampilan praktis yang harus dipelajari, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan keluarga secara matang. Dalam hal ini, mengikuti konseling pranikah menjadi sangat penting karena proses konseling memberikan ruang yang aman bagi pasangan untuk mendiskusikan berbagai isu penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam konseling ini, pasangan diajarkan cara berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan saling menghormati, serta bagaimana menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif dan empatik.

Selain konseling pranikah, pasangan muda juga perlu dibekali dengan keterampilan komunikasi yang efektif, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran secara jernih tanpa menyebabkan konflik atau salah paham. Komunikasi yang baik akan membantu pasangan mengelola tekanan emosional yang muncul, sehingga mereka dapat lebih baik dalam menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan juga perlu mendapatkan edukasi yang komprehensif mengenai perencanaan finansial keluarga agar dapat menghadapi tekanan ekonomi secara lebih siap dan matang. Pemahaman mengenai manajemen utang, pentingnya investasi jangka panjang, serta persiapan dana darurat akan sangat membantu mereka untuk menjaga kestabilan finansial yang secara langsung mempengaruhi kestabilan emosional dan psikologis dalam hubungan.

Selain upaya dari pasangan sendiri, keterlibatan aktif keluarga besar serta dukungan masyarakat juga menjadi elemen penting dalam memperkuat kesiapan psikologis pasangan muda. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat memberikan pasangan muda sumber daya emosional dan praktis yang penting saat menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Kehadiran keluarga yang pengertian dan komunitas sosial yang mendukung dapat membantu pasangan muda merasa lebih percaya diri, nyaman, dan tidak sendirian dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Dengan adanya jaringan sosial yang kuat, pasangan muda bisa lebih mudah berbagi pengalaman, mendapatkan nasihat bijaksana, serta memperoleh motivasi untuk terus bertahan dan tumbuh bersama dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

Dengan demikian, kesiapan psikologis pasangan muda dalam menghadapi tantangan pernikahan adalah isu yang perlu diperhatikan secara serius. Melalui edukasi yang komprehensif, konseling pranikah yang berkualitas, pengembangan keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik yang matang, serta dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan masyarakat, pasangan muda bisa lebih siap secara psikologis, emosional, dan praktis dalam menghadapi kehidupan rumah tangga yang kompleks. Kesiapan ini pada akhirnya menjadi modal penting bagi pasangan untuk menciptakan kehidupan pernikahan yang bahagia, stabil, harmonis, dan penuh cinta, meski dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang selalu ada.

## **G. Latihan Soal**

### **Tugas 1: Wawancara Mendalam tentang Pengalaman Konseling Pranikah**

Mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara mendalam kepada dua pasangan yang pernah mengikuti konseling pranikah, baik secara langsung maupun daring. Hasil wawancara harus memuat alasan mereka mengikuti konseling, materi atau topik yang paling bermanfaat menurut mereka, perubahan positif yang mereka rasakan setelah konseling, serta kendala yang dialami selama proses konseling. Mahasiswa diminta membuat laporan naratif yang mencakup analisis kritis mengenai efektivitas konseling pranikah berdasarkan hasil wawancara tersebut.

### **Tugas 2: Simulasi Komunikasi Efektif Pasangan**

Mahasiswa diminta untuk membuat simulasi berupa video role-play berdurasi 10-15 menit tentang komunikasi efektif dalam kehidupan pasangan yang menghadapi konflik sehari-hari. Simulasi harus memperlihatkan bagaimana pasangan menyampaikan perasaan dan pikirannya dengan jelas dan jujur, menunjukkan sikap

empati dan aktif mendengarkan pasangan. Selain itu, mahasiswa wajib melampirkan laporan reflektif yang menjelaskan strategi komunikasi yang digunakan, tantangan yang dialami selama simulasi, serta solusi yang diambil dalam menghadapi konflik secara efektif.

### **Tugas 3: Rencana Perencanaan Keuangan Keluarga**

Mahasiswa diminta menyusun sebuah rencana keuangan keluarga secara rinci dan realistis untuk pasangan muda yang baru menikah dengan pendapatan bulanan tertentu (pendapatan dapat diasumsikan sendiri). Rencana keuangan harus mencakup anggaran bulanan, strategi pengelolaan utang, tabungan darurat, serta rencana investasi jangka panjang. Mahasiswa harus memberikan penjelasan mendalam mengenai pertimbangan yang mendasari setiap keputusan keuangan dalam rencana tersebut dan bagaimana rencana ini membantu pasangan untuk mencapai tujuan finansial dan stabilitas kehidupan rumah tangga.

### **Tugas 4: Studi Kasus Pengelolaan Konflik dalam Pernikahan**

Mahasiswa diminta menganalisis sebuah studi kasus tentang konflik dalam pernikahan yang disediakan dosen atau berdasarkan observasi mahasiswa sendiri terhadap pasangan yang telah menikah. Studi kasus harus berisi deskripsi detail mengenai latar belakang pasangan, penyebab utama konflik, bagaimana pasangan tersebut menghadapi konflik, dan dampak dari cara pengelolaan konflik tersebut. Mahasiswa harus memberikan rekomendasi solusi alternatif dengan menggunakan teori pengelolaan konflik yang konstruktif yang telah dipelajari serta menjelaskan bagaimana rekomendasi tersebut dapat membantu pasangan menyelesaikan konflik secara lebih efektif.

### **Tugas 5: Kajian Literatur tentang Tren Konseling Pranikah Daring dan Isu Kesiapan Psikologis Pasangan Muda**

Mahasiswa diminta menyusun sebuah kajian literatur yang komprehensif tentang tren konseling pranikah secara daring serta isu kesiapan psikologis pasangan muda dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan. Kajian literatur harus mencakup definisi dan karakteristik konseling daring, kelebihan dan kekurangannya, serta bagaimana tren ini mempengaruhi kesiapan psikologis pasangan muda. Mahasiswa wajib menggunakan minimal 5 jurnal ilmiah terbaru sebagai referensi utama, menyajikan hasil kajian dalam bentuk laporan analisis, serta memberikan pandangan kritis mengenai tren konseling daring sebagai solusi dalam meningkatkan kesiapan psikologis pasangan muda secara optimal.

### **Pilihan Ganda**



1. Dian (23 tahun) dan Rama (25 tahun) merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Mereka datang ke klinik kebidanan untuk mendapatkan nasihat tentang manfaat mengikuti konseling pranikah. Sebagai bidan, apa manfaat utama yang harus Anda tekankan kepada pasangan tersebut agar mereka tertarik untuk mengikuti konseling pranikah?
  - A. Dapat menjamin tidak akan pernah ada konflik dalam pernikahan
  - B. Menyelesaikan semua masalah finansial pasangan sebelum menikah
  - C. Menyediakan bekal keterampilan komunikasi efektif dan pengelolaan konflik
  - D. Memastikan pernikahan yang sempurna tanpa hambatan
  - E. Menjadikan pasangan memiliki pandangan yang seragam tanpa perbedaan
  
2. Pasangan muda, Lisa (24 tahun) dan Anton (27 tahun) sering mengalami kesalahpahaman kecil yang berujung pada konflik besar karena kurangnya komunikasi efektif. Sebagai bidan yang memberikan konseling pranikah, teknik komunikasi efektif apa yang paling penting diajarkan kepada pasangan ini?
  - A. Mendengarkan secara aktif dan penuh empati
  - B. Menyampaikan kritik secara emosional
  - C. Memotong pembicaraan pasangan agar lebih jelas
  - D. Berbicara dengan nada tinggi supaya didengar
  - E. Mengabaikan perbedaan pendapat demi menjaga kedamaian

3. Fani (25 tahun) dan Rian (27 tahun) akan segera menikah namun menghadapi tekanan ekonomi yang cukup tinggi karena biaya pernikahan. Mereka meminta nasihat Anda sebagai bidan tentang langkah terbaik yang harus diambil terkait perencanaan keuangan keluarga.
- Apa saran yang paling tepat untuk diberikan kepada pasangan ini?
- A. Mengutamakan pengeluaran keinginan agar tetap Bahagia
  - B. Menyusun anggaran realistis dan mengutamakan kebutuhan pokok
  - C. Mengabaikan tabungan darurat karena tidak penting dalam pernikahan
  - D. Tidak membuat anggaran khusus karena bisa membatasi kebebasan finansial
  - E. Mengambil pinjaman dalam jumlah besar agar pesta pernikahan berlangsung mewah
4. Rina (26 tahun) dan Adi (29 tahun) sering bertengkar karena sulit mencapai solusi saat menghadapi konflik. Sebagai bidan yang juga memberikan konseling keluarga, Anda ingin mengajarkan pasangan ini tentang cara negosiasi konstruktif. Langkah penting apakah yang perlu mereka kuasai terlebih dahulu?
- A. Menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah
  - B. Bersikap empati dan terbuka terhadap pandangan pasangan
  - C. Menggunakan bahasa yang agresif agar pendapat lebih tegas
  - D. Bersikap keras kepala untuk mempertahankan pendapat masing-masing
  - E. Menghindari pembicaraan tentang konflik sama sekali agar tidak muncul ketegangan
5. Dalam sesi konseling pranikah daring, Tika (22 tahun) dan Yudi (25 tahun) merasa sulit fokus dan mengalami gangguan komunikasi akibat koneksi internet yang buruk. Sebagai konselor, apa rekomendasi terbaik yang dapat Anda berikan kepada pasangan ini agar proses konseling tetap efektif?
- A. Melakukan sesi konseling daring pada jam-jam sibuk agar jaringan stabil
  - B. Menggunakan pesan teks saja untuk mengurangi gangguan komunikasi
  - C. Memastikan kualitas jaringan internet yang stabil sebelum sesi dimulai
  - D. Mengabaikan gangguan koneksi karena tidak berpengaruh signifikan
  - E. Menghentikan konseling daring dan tidak melanjutkan lagi

## Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Konseling pranikah memberikan pasangan bekal keterampilan komunikasi efektif dan pengelolaan konflik, sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Konseling tidak menjamin bebas konflik atau keseragaman pandangan total, tetapi membantu mengelola perbedaan dan konflik secara sehat.

2. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Mendengarkan secara aktif dan penuh empati adalah inti komunikasi efektif yang harus diajarkan kepada pasangan. Teknik ini memastikan pasangan saling memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain sehingga mengurangi kesalahpahaman.

3. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Pasangan perlu menyusun anggaran realistis dan mengutamakan kebutuhan pokok. Hal ini membantu mereka mengelola tekanan ekonomi secara bijak dan mencegah konflik akibat masalah finansial yang tidak terkendali.

4. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Sikap empati dan keterbukaan terhadap pandangan pasangan adalah langkah dasar untuk mencapai negosiasi konstruktif. Langkah ini membantu pasangan mencari solusi bersama tanpa memperbesar konflik atau menyakiti perasaan pasangan.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Keberhasilan konseling daring sangat bergantung pada kualitas jaringan internet yang stabil. Oleh karena itu, pasangan perlu memastikan koneksi internet yang baik sebelum memulai sesi konseling untuk menjaga efektivitas komunikasi dan interaksi selama konseling berlangsung.

## H. Rangkuman Materi

Konseling pranikah adalah proses pendampingan yang bertujuan membantu pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Proses ini melibatkan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang memberikan bekal pengetahuan tentang komunikasi, pengelolaan konflik, dan keterampilan interpersonal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Konseling ini bertujuan meningkatkan kesadaran diri pasangan terhadap kebutuhan emosional masing-masing, sehingga mereka lebih peka terhadap pasangan, mampu menghargai perbedaan, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam hubungan.

Salah satu manfaat utama konseling pranikah adalah penguatan hubungan emosional antar pasangan. Melalui konseling, pasangan diberikan kesempatan untuk lebih mengenal perasaan, nilai-nilai, dan harapan masing-masing mengenai pernikahan, yang pada akhirnya mempererat ikatan emosional di antara mereka. Konseling juga membantu meningkatkan keterampilan komunikasi pasangan. Komunikasi efektif dalam hubungan pernikahan menuntut kejujuran, keterbukaan, rasa hormat terhadap pandangan pasangan, serta kemampuan mendengarkan secara aktif. Dengan keterampilan komunikasi yang baik, pasangan dapat menghindari kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu konflik.

Selain aspek emosional dan komunikasi, konseling pranikah juga memberikan manfaat berupa identifikasi dini terhadap potensi konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan diajarkan mengenali isu-isu seperti perbedaan budaya, ekspektasi yang tidak realistis, atau perbedaan pola pengelolaan keuangan, sehingga mereka dapat menyusun strategi untuk mengatasi konflik secara konstruktif. Pasangan yang mengikuti konseling pranikah biasanya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola stres dan adaptasi terhadap perubahan besar dalam peran serta tanggung jawab setelah menikah. Oleh karena itu, konseling pranikah dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil.

Komunikasi efektif menjadi fondasi penting dalam kehidupan pernikahan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan kejujuran, keterbukaan, serta penghormatan terhadap pandangan pasangan. Pasangan juga dituntut untuk mampu mendengarkan secara aktif, memahami perasaan pasangan, dan memberikan tanggapan yang empati. Dengan menguasai keterampilan ini,

pasangan dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling memahami, dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Perencanaan keuangan keluarga juga merupakan aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Pasangan perlu menyusun anggaran secara realistis, mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijaksana, serta merencanakan investasi jangka panjang seperti pendidikan anak, pembelian rumah, hingga persiapan dana pensiun. Pengelolaan utang secara hati-hati dan pembentukan tabungan darurat juga sangat penting untuk memastikan stabilitas keuangan keluarga. Pasangan yang mampu mengelola keuangan secara efektif cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis dan terhindar dari konflik akibat tekanan ekonomi.

Konflik dalam pernikahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, tetapi kualitas pernikahan ditentukan oleh cara pasangan mengelola konflik tersebut. Pasangan yang efektif dalam pengelolaan konflik adalah mereka yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan, menyampaikan pendapat tanpa agresi, dan menunjukkan sikap empati. Dengan kemampuan mencapai solusi melalui negosiasi konstruktif, konflik justru bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan dan meningkatkan keintiman emosional pasangan.

Saat ini, konseling pranikah secara daring semakin populer karena menawarkan fleksibilitas waktu, akses yang mudah, dan kenyamanan. Metode ini efektif jika didukung oleh kualitas jaringan internet yang stabil, kompetensi konselor, serta keterlibatan aktif pasangan. Oleh karena itu, pasangan perlu cermat memilih layanan konseling daring yang profesional dan terpercaya.

Isu yang sering muncul adalah rendahnya kesiapan psikologis pasangan muda dalam menghadapi tantangan pernikahan. Minimnya edukasi pranikah, ekspektasi tidak realistis, serta tekanan sosial dan ekonomi membuat pasangan muda rentan terhadap konflik dan stres dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mengatasi ini, pasangan muda perlu mendapat edukasi komprehensif melalui konseling pranikah, pengembangan keterampilan komunikasi efektif, perencanaan keuangan yang matang, serta dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, pasangan muda dapat lebih siap secara emosional dan praktis dalam menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

## I. Glosarium

### **Adaptasi Peran**

Proses penyesuaian individu terhadap perubahan peran dalam kehidupan setelah menikah, seperti peran sebagai pasangan atau orang tua.

### **Anggaran Rumah Tangga**

Rencana keuangan yang disusun oleh pasangan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran secara realistis dan transparan agar mencapai tujuan finansial keluarga.

### **Dana Darurat**

Dana khusus yang disiapkan pasangan untuk menghadapi kebutuhan mendesak atau situasi tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendadak lainnya.

### **Empati**

Kemampuan pasangan untuk memahami perasaan dan sudut pandang pasangan lainnya dengan cara menempatkan diri dalam posisi pasangan.

### **Ekspektasi Tidak Realistis**

Harapan berlebihan atau idealisasi yang tidak sesuai realitas tentang kehidupan pernikahan, pasangan, atau situasi yang akan dihadapi setelah menikah.

### **Fondasi Komunikasi**

Dasar kuat yang mencakup keterampilan komunikasi efektif seperti kejujuran, keterbukaan, penghormatan terhadap pandangan pasangan, serta kemampuan mendengarkan aktif.

### **Identifikasi Potensi Konflik**

Kemampuan mengenali sejak awal berbagai isu atau perbedaan yang dapat menjadi sumber perselisihan dalam kehidupan pernikahan, seperti latar belakang budaya, ekspektasi pasangan, atau masalah keuangan.

### **Investasi Jangka Panjang**

Perencanaan keuangan yang mencakup penempatan dana pada instrumen investasi untuk kebutuhan masa depan seperti pendidikan anak, pembelian properti, atau dana pensiun.

### **Kesiapan Psikologis**

Kondisi emosional dan mental pasangan yang siap secara matang dalam menghadapi tantangan, tekanan, atau perubahan besar dalam kehidupan rumah tangga.

### **Keterampilan Interpersonal**

Kemampuan individu dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk pasangan, melalui keterampilan komunikasi, empati, negosiasi, dan resolusi konflik.

**Kompromi**

Kesepakatan yang dicapai oleh pasangan dalam menyelesaikan konflik dengan cara menemukan titik tengah yang dapat diterima kedua belah pihak tanpa merasa dirugikan.

**Komunikasi Efektif**

Proses interaksi yang ditandai oleh keterbukaan, kejujuran, sikap empati, penghormatan terhadap pendapat pasangan, serta kemampuan mendengarkan secara aktif untuk menghindari kesalahpahaman.

**Konseling Pranikah**

Bimbingan terstruktur yang dilakukan oleh tenaga profesional untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga melalui pengembangan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman tentang pernikahan.

**Konseling Daring (Online Counseling)**

Layanan konseling pranikah yang dilakukan melalui media digital atau internet, memungkinkan fleksibilitas waktu, akses mudah, serta kenyamanan bagi pasangan calon pengantin.

**Manajemen Konflik**

Kemampuan pasangan dalam menangani perbedaan atau perselisihan secara sehat, konstruktif, dan empati melalui identifikasi akar permasalahan dan negosiasi efektif.

**Manajemen Utang**

Proses pengelolaan kewajiban finansial dengan cara memahami perbedaan antara utang produktif dan konsumtif, mengatur pembayaran tepat waktu, serta menghindari utang berlebihan.

**Negosiasi Konstruktif**

Dialog terbuka yang bertujuan mencapai solusi konflik yang saling menguntungkan dengan mengedepankan sikap empati, fleksibel, dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan solusi.

**Pendapatan Tambahan**

Sumber penghasilan selain pendapatan utama yang diperoleh pasangan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan meningkatkan stabilitas finansial rumah tangga.

**Perencanaan Keuangan Keluarga**

Proses menyusun strategi keuangan, seperti anggaran, investasi, manajemen utang, serta dana darurat untuk mencapai tujuan finansial bersama pasangan.

**Stres Rumah Tangga**

Tekanan emosional atau mental yang dihadapi pasangan dalam kehidupan pernikahan, biasanya disebabkan oleh konflik, persoalan ekonomi, perubahan peran, atau tekanan sosial lainnya.

## J. Daftar Pustaka

- Andrews, G., & Halford, W. K. (2021). *Marriage preparation and relationship education: A comprehensive guide*. Routledge.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2017). *Panduan Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN.
- Corey, G. (2016). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* (10th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.
- Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2010). Marriage in the new millennium: A decade in review. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 630–649. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00722.x>
- Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). *The seven principles for making marriage work*. New York: Harmony Books.
- Harway, M. (Ed.). (2005). *Handbook of couples therapy*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Jannah, N. (2020). *Psikologi Pernikahan: Persiapan Mental dan Emosi Menjelang Rumah Tangga*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jatmika, D., & Prasetyo, E. (2019). Pengaruh konseling pranikah terhadap kesiapan menikah pasangan muda. *Jurnal Psikologi*, 46(2), 94–105. <https://doi.org/10.22146/jpsi.33074>
- Johnson, S. M. (2004). *The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection* (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.
- KemenPPPA. (2020). *Modul Pendidikan Pranikah: Perspektif Kesetaraan Gender*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Olson, D. H., DeFrain, J., & Skogrand, L. (2018). *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Owen, J., Duncan, B., Anker, M., & Sparks, J. (2012). Initial relationship goal agreement and couple therapy outcomes. *Journal of Family Psychology*, 26(2), 179–186. <https://doi.org/10.1037/a0026998>
- Papalia, D. E., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2018). *Human development* (13th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Putri, S. R., & Hadi, S. (2022). Peran konseling pranikah daring terhadap kesiapan pernikahan di kalangan pasangan usia muda. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 11(2), 101–112. <https://doi.org/10.14710/jpkkm.11.2.101-112>
- Santrock, J. W. (2020). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sari, E. K., & Apriani, S. (2021). Efektivitas konseling daring dalam persiapan pernikahan di era pandemi COVID-19. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(3), 235–242. <https://doi.org/10.29210/148900>
- Suprpto, R., & Sutanto, E. (2016). Perencanaan keuangan keluarga dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30996/jiem.v3i1.456>



- Widyarini, W., & Ramadhani, N. (2017). Hubungan antara komunikasi efektif dengan kepuasan pernikahan. *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 3(2), 121–130. <https://doi.org/10.22146/gamajop.31850>
- Young, M. E., Long, L. L., & Young, J. L. (2019). *Counseling and therapy for couples* (4th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Zahra, F., & Nasution, Z. (2019). Hubungan kesiapan psikologis dengan kepuasan pernikahan pada pasangan muda. *Psikodimensia*, 18(1), 25–33. <https://doi.org/10.24167/psiko.v18i1.1989>

# Bab 3

## Anatomi dan Fisiologi Sistem Reproduksi

Pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi adalah landasan utama bagi pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan serta merencanakan kehamilan. Pengetahuan ini membantu pasangan dalam memahami berbagai proses alami tubuh yang berkaitan dengan reproduksi dan fertilitas. Dengan memahami secara tepat tentang sistem reproduksi, pasangan dapat mengoptimalkan perencanaan kehamilan, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan menghindari berbagai kesalahan informasi yang sering terjadi.

### **Capaian Pembelajaran (CPL)**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan anatomi serta fisiologi sistem reproduksi manusia secara detail serta mampu mengidentifikasi kesalahan umum yang beredar tentang siklus kesuburan pada pasangan muda.

### **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan pengetahuan anatomi dan fisiologi reproduksi dalam konteks pranikah dan prakonsepsi serta mampu memberikan edukasi kesehatan reproduksi yang tepat dan berbasis bukti.

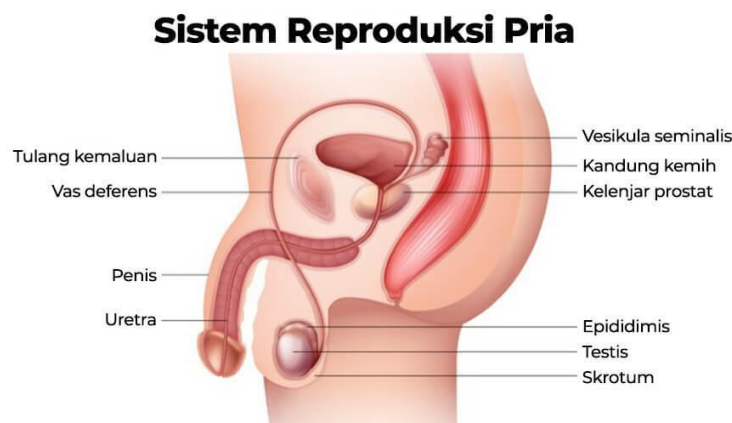
### **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

- Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi sistem reproduksi pria dan wanita secara komprehensif.
- Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fisiologi reproduksi dan fertilitas manusia.
- Mahasiswa mampu menganalisis siklus menstruasi dan masa subur pada wanita.
- Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tren edukasi kesehatan reproduksi berbasis media sosial.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kesalahan informasi mengenai siklus kesuburan.

## A. Anatomi Reproduksi Pria dan Wanita

Anatomi reproduksi pria dan wanita merupakan bagian penting dalam memahami proses reproduksi manusia secara keseluruhan. Sistem reproduksi manusia secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Kedua sistem ini memiliki struktur anatomi yang sangat khas dan berbeda satu sama lain, masing-masing dengan fungsi biologis khusus yang saling melengkapi dalam proses penciptaan kehidupan.

Pada sistem reproduksi pria, organ-organ utamanya mencakup testis, epididimis, vas deferens, vesikula seminalis, kelenjar prostat, uretra, dan penis. Testis adalah organ reproduksi primer yang berfungsi menghasilkan sel sperma sekaligus hormon testosteron yang sangat penting untuk mengatur berbagai fungsi tubuh pria seperti pertumbuhan otot, produksi sel sperma, hingga ciri seksual sekunder seperti pertumbuhan rambut wajah dan suara yang lebih dalam. Sperma yang dihasilkan oleh testis kemudian akan bergerak ke epididimis, sebuah saluran melingkar yang terletak di belakang testis, tempat sperma mengalami proses pematangan dan penyimpanan sementara sebelum ejakulasi. Setelah matang, sperma akan bergerak melalui saluran yang disebut vas deferens menuju vesikula seminalis.

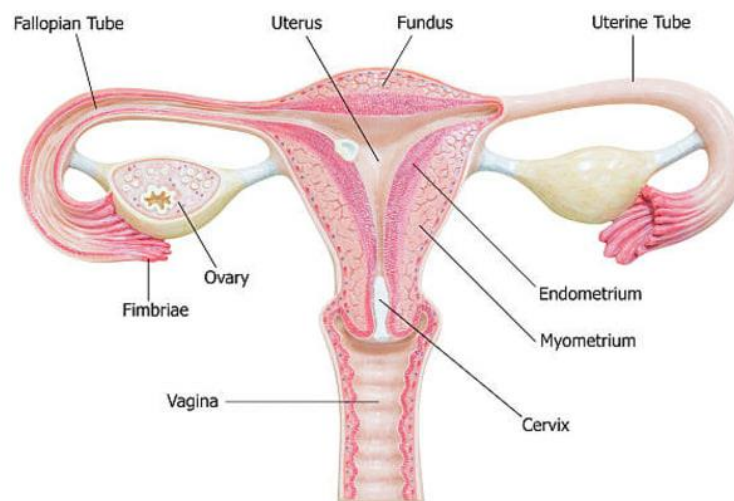


**Gambar 3.1**  
**Sistem Reproduksi Pria**

Vesikula seminalis memiliki peran penting dalam memproduksi cairan semen atau mani, yakni cairan yang memberikan nutrisi bagi sperma sekaligus melindunginya dalam perjalanan menuju sel telur wanita. Selain vesikula seminalis, kelenjar prostat juga berkontribusi pada cairan semen dengan menghasilkan cairan yang bersifat basa, membantu sperma bertahan dalam lingkungan asam yang ditemui di dalam vagina. Cairan ini bercampur dengan sperma yang datang dari vas deferens dan

membentuk semen. Ketika terjadi ejakulasi, semen ini kemudian dikeluarkan melalui uretra yang merupakan saluran bersama untuk sperma maupun urin. Penis sebagai organ seksual eksternal pada pria memiliki fungsi ganda sebagai saluran urin sekaligus organ kopulasi yang membantu dalam mengantarkan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita.

Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki anatomi yang terdiri dari organ internal dan eksternal. Organ internal meliputi ovarium, tuba fallopi, uterus atau rahim, serviks atau leher rahim, dan vagina. Ovarium merupakan organ reproduksi primer wanita yang memiliki dua fungsi utama, yakni menghasilkan sel telur (ovum) dan memproduksi hormon seks wanita, seperti estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini sangat penting untuk mengatur siklus menstruasi, perkembangan ciri-ciri seksual sekunder, dan persiapan tubuh wanita menghadapi kehamilannya nanti. Setiap bulan, secara normal, satu sel telur matang dilepaskan dari ovarium dalam proses yang disebut ovulasi, kemudian masuk ke dalam tuba fallopi.



**Gambar 3.2**  
**Sistem Reproduksi Wanita**

Tuba fallopi sendiri adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, dan berperan sebagai tempat terjadinya pembuahan, yakni pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jika terjadi pembuahan, hasil konsepsi tersebut akan bergerak menuju uterus untuk berkembang lebih lanjut. Uterus atau rahim adalah organ berbentuk seperti buah pir terbalik yang memiliki fungsi vital sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Pada bagian bawah rahim terdapat serviks, yakni pintu masuk menuju rahim dari vagina. Serviks berfungsi menjaga rahim dari infeksi sekaligus memiliki peran penting dalam proses persalinan. Vagina sendiri

merupakan saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan organ eksternal, berfungsi sebagai saluran kelahiran, jalur masuknya sperma, sekaligus saluran keluar untuk darah menstruasi.

Adapun organ eksternal pada wanita dikenal dengan sebutan vulva, terdiri dari mons pubis, labia majora, labia minora, klitoris, dan lubang vagina. Mons pubis merupakan jaringan lemak yang berfungsi melindungi tulang pubis, sedangkan labia majora dan labia minora merupakan lipatan kulit yang berfungsi melindungi organ reproduksi internal dari berbagai infeksi maupun cedera. Klitoris, sebagai organ sensitif, memiliki banyak ujung saraf dan berperan penting dalam proses rangsangan seksual wanita. Keseluruhan organ eksternal ini memiliki fungsi perlindungan sekaligus fungsi seksual yang sangat penting.

Dengan demikian, sistem reproduksi pria dan wanita memiliki struktur anatomi yang unik dan saling melengkapi. Setiap organ dalam sistem ini memiliki peran penting dalam mendukung proses reproduksi secara keseluruhan. Pemahaman mengenai anatomi ini penting bagi individu yang berencana untuk menikah atau memiliki anak agar dapat mempersiapkan diri secara optimal, memahami potensi masalah kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi, serta mengambil keputusan terbaik dalam merencanakan kehamilan maupun memilih metode kontrasepsi yang sesuai.

## **B. Fisiologi Reproduksi dan Fertilitas**

Fisiologi reproduksi adalah sebuah proses kompleks yang mencakup berbagai mekanisme biologis dan hormonal dalam tubuh manusia, baik pria maupun wanita, yang memungkinkan terjadinya reproduksi atau kemampuan fertilitas, yakni kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan. Proses ini bergantung pada interaksi yang rumit antara berbagai organ dan hormon yang memastikan bahwa sistem reproduksi berfungsi secara optimal.

Pada pria, fisiologi reproduksi difokuskan pada produksi sperma yang sehat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun pergerakan atau motilitasnya. Sel sperma diproduksi di dalam testis melalui proses yang disebut spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri merupakan proses biologis kompleks yang melibatkan berbagai tahapan pembelahan dan pematangan sel hingga menghasilkan sel sperma matang yang siap membuahi sel telur wanita. Proses ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan hormon testosteron yang diproduksi oleh sel Leydig di testis. Testosteron bertanggung jawab atas beberapa fungsi penting, termasuk

perkembangan ciri-ciri seksual sekunder pria seperti tumbuhnya rambut di wajah dan tubuh, pendalaman suara, perkembangan otot dan struktur tubuh, serta yang paling penting, produksi sperma itu sendiri.

Testosteron bekerja secara langsung di dalam testis, merangsang proses spermatogenesis sekaligus memastikan agar sperma yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan optimal. Selain testosteron, terdapat pula hormon-hormon lain seperti hormon luteinizing (LH) dan hormon perangsang folikel (FSH) yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari di otak. Kedua hormon ini memiliki peranan khusus dalam sistem reproduksi pria. LH berfungsi menstimulasi produksi testosteron oleh sel Leydig, sedangkan FSH bekerja secara langsung pada sel Sertoli di dalam testis untuk mendukung pertumbuhan dan pematangan sel sperma. Adanya keseimbangan hormon-hormon ini sangat krusial karena ketidakseimbangan atau gangguan hormonal dapat mengakibatkan penurunan produksi sperma, kualitas sperma yang buruk, bahkan dapat menyebabkan infertilitas pada pria.

Di sisi lain, pada wanita, fisiologi reproduksi berpusat pada siklus menstruasi yang merupakan manifestasi bulanan dari berbagai perubahan hormonal kompleks dalam tubuh wanita. Siklus ini diatur terutama oleh dua hormon utama yang diproduksi ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berperan dalam proses yang sangat penting, yakni perkembangan sel telur yang matang (ovulasi) serta persiapan uterus atau rahim untuk kemungkinan terjadinya kehamilan.

Pada awal siklus menstruasi, hormon FSH yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis akan merangsang folikel-folikel di ovarium untuk tumbuh dan berkembang. Folikel ini adalah struktur kecil di ovarium yang mengandung sel telur yang sedang berkembang. Ketika folikel-folikel tersebut tumbuh, mereka mulai menghasilkan hormon estrogen. Estrogen berperan penting dalam membangun lapisan dinding rahim (endometrium), mempersiapkan lingkungan rahim yang ideal untuk implantasi embrio jika terjadi pembuahan. Sekitar pertengahan siklus menstruasi, lonjakan hormon LH akan terjadi dan memicu proses ovulasi, yaitu pelepasan satu sel telur matang dari ovarium menuju tuba fallopi untuk dibuahi oleh sperma.

Setelah ovulasi terjadi, folikel yang telah melepaskan sel telur berubah menjadi struktur yang dikenal sebagai korpus luteum. Korpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang penting dalam mempertahankan dinding rahim agar

tetap siap menerima embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun secara drastis, menyebabkan lapisan dinding rahim luruh dan dikeluarkan dalam bentuk darah menstruasi. Proses ini berlangsung secara siklikal setiap bulan sepanjang masa reproduktif seorang wanita.

Fertilitas wanita sangat tergantung pada kestabilan siklus menstruasi serta keseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Gangguan hormonal seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS), gangguan tiroid, atau kelainan hormonal lainnya bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal yang signifikan. PCOS, misalnya, merupakan kondisi di mana ovarium menghasilkan kadar hormon androgen yang berlebih. Kondisi ini dapat menghambat proses ovulasi, mengganggu siklus menstruasi secara teratur, dan pada akhirnya dapat menyebabkan infertilitas atau kesulitan mendapatkan kehamilannya. Selain itu, kondisi-kondisi lain seperti stres, pola hidup tidak sehat, obesitas, serta faktor usia juga mempengaruhi regulasi hormonal sehingga dapat menurunkan kemampuan reproduksi wanita secara keseluruhan.

Dengan demikian, fisiologi reproduksi baik pada pria maupun wanita adalah proses yang sangat kompleks yang dikontrol oleh berbagai mekanisme hormonal yang saling berinteraksi secara rumit. Keseimbangan hormon yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses reproduksi berjalan optimal. Pemahaman yang mendalam mengenai fisiologi reproduksi ini sangat bermanfaat dalam membantu individu maupun pasangan yang sedang merencanakan kehamilan untuk mengetahui masa subur, mempersiapkan kesehatan reproduksi yang optimal, serta mengantisipasi atau mengatasi berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi fertilitas mereka secara keseluruhan.

### **C. Siklus Menstruasi dan Masa Subur**

Siklus menstruasi merupakan proses alami yang dialami oleh wanita yang sudah memasuki masa pubertas hingga menjelang menopause. Siklus ini melibatkan perubahan hormonal secara berkala setiap bulannya yang ditandai dengan rangkaian peristiwa kompleks yang terjadi di dalam tubuh wanita, terutama di organ reproduksi seperti ovarium dan rahim. Rata-rata, siklus menstruasi memiliki durasi sekitar 28 hari, namun dalam praktiknya, siklus ini dapat bervariasi antara wanita yang satu dengan yang lain dengan rentang waktu normal antara 21 hingga 35 hari.

Siklus menstruasi terdiri dari beberapa fase penting yang saling terkait, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Setiap fase memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai hormon reproduksi yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis (pituitari) di otak dan ovarium di dalam panggul wanita.

Fase pertama adalah fase folikuler, yang dimulai pada hari pertama menstruasi dan berakhir hingga terjadi ovulasi. Fase ini dinamakan folikuler karena melibatkan perkembangan folikel-folikel di dalam ovarium. Pada awal fase ini, kelenjar hipofisis melepaskan hormon Follicle Stimulating Hormone (FSH) yang berperan utama dalam merangsang pertumbuhan sejumlah folikel di ovarium. Folikel sendiri merupakan kantung kecil yang berisi cairan, yang di dalamnya terdapat sel telur yang sedang berkembang.

Selama pertumbuhan folikel, folikel tersebut akan mulai memproduksi hormon estrogen dalam jumlah yang semakin meningkat. Estrogen memiliki peran penting dalam fase ini, karena hormon ini berfungsi untuk mempertebal dan memperbaiki lapisan dinding rahim (endometrium), yang sebelumnya telah meluruh saat menstruasi, sehingga rahim menjadi lingkungan yang siap untuk mendukung kehamilannya jika terjadi pembuahan. Selain itu, peningkatan kadar estrogen juga mempersiapkan kondisi tubuh wanita untuk memasuki fase ovulasi.

Fase kedua dari siklus menstruasi adalah ovulasi, yang biasanya terjadi sekitar pertengahan siklus menstruasi atau sekitar hari ke-14 dalam siklus dengan panjang 28 hari. Ovulasi ditandai oleh pelepasan sel telur matang dari folikel dominan di dalam ovarium. Proses ini dipicu oleh lonjakan mendadak hormon luteinizing hormone (LH), yang dikenal sebagai LH surge. Lonjakan LH ini biasanya terjadi dalam waktu 24 hingga 36 jam sebelum ovulasi.

Pada saat ovulasi, folikel yang matang akan pecah dan melepaskan sel telur (ovum) ke dalam tuba falopi. Sel telur yang telah dilepaskan tersebut akan bergerak menuju rahim melalui tuba falopi, di mana sel telur ini dapat bertemu dengan sperma dan berpotensi dibuahi. Ovulasi adalah masa subur dalam siklus menstruasi seorang wanita, yang berarti bahwa peluang terjadinya kehamilan paling tinggi pada periode ini. Masa subur wanita tidak hanya terbatas pada hari ovulasi saja, namun juga meliputi beberapa hari sebelum dan sesudah ovulasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sperma untuk hidup hingga beberapa hari di dalam saluran reproduksi wanita. Oleh sebab itu, memahami masa subur ini sangat



penting bagi pasangan yang merencanakan kehamilan maupun bagi mereka yang ingin menghindari kehamilan dengan metode kontrasepsi alami.

Setelah ovulasi, siklus menstruasi memasuki fase ketiga, yaitu fase luteal. Fase luteal berlangsung dari pasca ovulasi hingga menjelang menstruasi berikutnya. Pada fase ini, folikel yang sudah pecah tadi berubah menjadi sebuah struktur baru yang disebut korpus luteum. Korpus luteum berfungsi menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah yang tinggi. Hormon progesteron memiliki peranan vital dalam fase luteal, yaitu mempersiapkan endometrium agar tetap dalam kondisi yang optimal untuk menerima implantasi embrio, jika terjadi pembuahan.

Jika terjadi pembuahan, maka embrio akan menempel pada dinding rahim yang telah siap tersebut, dan kehamilan pun terjadi. Sebaliknya, jika tidak ada pembuahan atau implantasi, maka korpus luteum akan mengecil dan berhenti menghasilkan progesteron. Penurunan kadar progesteron yang signifikan ini menyebabkan lapisan endometrium menjadi tidak stabil, lalu meluruh dalam bentuk menstruasi. Fase menstruasi ini kemudian menandai dimulainya siklus menstruasi yang baru.



**Gambar 3.3**  
**Siklus Menstruasi**

Pemahaman mendalam mengenai siklus menstruasi serta kemampuan untuk mengidentifikasi masa subur sangatlah penting. Pengetahuan ini dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan kehamilan maupun dalam memilih metode

kontrasepsi yang paling efektif. Bagi pasangan yang ingin memiliki keturunan, mengetahui dengan pasti kapan masa subur wanita akan meningkatkan peluang kehamilan secara signifikan. Sebaliknya, bagi mereka yang ingin menunda kehamilan, memahami pola siklus menstruasi akan membantu dalam memilih metode kontrasepsi alami dengan lebih efektif. Dengan demikian, edukasi tentang siklus menstruasi dan masa subur menjadi salah satu kunci penting dalam peningkatan kesehatan reproduksi, serta pengambilan keputusan yang bijaksana terkait keluarga berencana.

#### **D. Tren: Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Sosial**

Dalam era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi yang sangat pesat telah membuka berbagai peluang baru di berbagai bidang, termasuk dalam bidang edukasi kesehatan reproduksi. Salah satu tren terbaru yang semakin diminati, khususnya oleh generasi muda, adalah edukasi kesehatan reproduksi berbasis media sosial. Tren ini semakin populer karena media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, mampu menyediakan ruang edukasi yang lebih interaktif, menarik, informatif, dan tentunya mudah dijangkau oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.

Media sosial menawarkan kemudahan akses yang sebelumnya sulit diperoleh melalui metode edukasi konvensional. Dengan hanya berbekal perangkat seluler dan koneksi internet, generasi muda kini dapat dengan mudah mengakses informasi kesehatan reproduksi secara cepat dan real-time. Informasi yang disampaikan melalui media sosial juga sangat bervariasi, mulai dari penjelasan dasar tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, pengetahuan tentang siklus menstruasi dan fertilitas, hingga pembahasan mengenai isu-isu spesifik yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi seperti penyakit menular seksual, kontrasepsi, hingga perencanaan kehamilan.

Salah satu keunggulan utama edukasi berbasis media sosial adalah cara penyampaian informasinya yang kreatif dan atraktif. Informasi-informasi kompleks yang sebelumnya mungkin sulit dipahami, kini dapat disajikan dengan visualisasi yang menarik melalui infografis, animasi pendek, video singkat, atau bahkan sesi live interaktif yang melibatkan audiens secara langsung. Misalnya, Instagram memungkinkan penggunaan gambar yang dikombinasikan dengan keterangan singkat namun informatif, sedangkan TikTok populer dengan konten video pendek yang menyampaikan pesan secara efektif dan menghibur dalam waktu yang relatif

singkat. YouTube pun menyediakan ruang yang lebih luas bagi konten edukasi berbentuk video panjang dengan penjelasan yang lebih mendetail dan mendalam.

Karena sifatnya yang visual dan interaktif, konten-konten ini tidak hanya mampu menarik perhatian pengguna media sosial, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman serta retensi informasi mengenai topik-topik penting terkait kesehatan reproduksi. Hal ini tentu sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda yang umumnya memiliki kebiasaan konsumsi informasi yang cepat dan cenderung menyukai konten singkat namun padat informasi.

Namun demikian, popularitas tren edukasi kesehatan reproduksi melalui media sosial juga menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan yang paling besar adalah perlunya memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, akurat, dan valid secara medis. Media sosial, di sisi lain, juga berpotensi menjadi ladang subur bagi tersebarnya informasi yang tidak tepat atau bahkan menyesatkan jika tidak diawasi secara cermat. Mengingat sifat informasi yang sangat cepat menyebar di dunia maya, penyebaran informasi yang salah ini bisa memiliki dampak buruk yang serius pada pengetahuan dan perilaku kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, penyedia konten yang melibatkan diri dalam edukasi kesehatan reproduksi melalui media sosial harus memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Mereka harus selalu memastikan bahwa konten-konten yang diunggah didasarkan pada bukti ilmiah terkini, sumber terpercaya, dan pedoman medis yang berlaku. Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan, termasuk bidan, menjadi sangat krusial. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang secara profesional bertanggung jawab dalam pemberian edukasi kesehatan reproduksi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak sekadar informatif, tetapi juga secara klinis tepat, aman, dan relevan dengan kondisi masyarakat.

Keberadaan tenaga kesehatan di media sosial juga dapat memperkuat kredibilitas konten yang disampaikan, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya dan yakin terhadap informasi yang mereka terima. Para bidan, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya dapat berkontribusi dengan aktif membuat konten edukasi yang menarik sekaligus mudah dipahami, menjawab pertanyaan yang muncul dari para pengguna media sosial, serta mengklarifikasi informasi-informasi keliru yang banyak tersebar di berbagai platform.

Dengan demikian, edukasi kesehatan reproduksi berbasis media sosial bukan sekadar sebuah tren yang sementara, melainkan sebuah metode edukasi yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Media sosial telah menjadi alat edukasi yang sangat kuat dan efektif, asalkan konten yang disajikan dikelola dengan bijaksana, bertanggung jawab, dan selalu didasarkan pada bukti ilmiah yang valid. Di tengah tantangan penyebaran informasi yang semakin luas, kolaborasi aktif antara tenaga kesehatan, penyedia konten, dan masyarakat dalam mengelola konten edukasi kesehatan reproduksi di media sosial menjadi kunci penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, sadar, dan terinformasi dengan baik mengenai kesehatan reproduksi mereka.

## **E. Isu: Kesalahan Informasi tentang Siklus Kesuburan pada Pasangan Muda**

Isu kesalahan informasi tentang siklus kesuburan pada pasangan muda merupakan persoalan serius dalam bidang kesehatan reproduksi yang sering terabaikan, namun memiliki dampak besar terhadap kehidupan pasangan muda. Permasalahan ini muncul akibat kurangnya pemahaman dan edukasi yang memadai mengenai cara kerja tubuh manusia, khususnya yang terkait dengan siklus menstruasi dan masa subur seorang wanita. Akibatnya, banyak pasangan muda yang memegang teguh kepercayaan keliru atau mitos yang berkembang luas di masyarakat tentang siklus kesuburan.

Salah satu kesalahan informasi yang paling umum adalah anggapan bahwa kehamilan dapat terjadi kapan saja sepanjang siklus menstruasi. Banyak pasangan muda yang berpikir bahwa selama seorang wanita aktif secara seksual, maka risiko kehamilan selalu ada di setiap hubungan intim yang dilakukan. Keyakinan ini tentu saja tidak benar karena secara biologis, seorang wanita memiliki periode tertentu dalam siklusnya yang jauh lebih subur dibanding periode lainnya. Sebaliknya, ada pula pasangan yang percaya bahwa kehamilan hanya mungkin terjadi secara eksklusif pada hari ovulasi saja. Anggapan ini juga keliru, karena sel telur yang dilepaskan pada saat ovulasi memang hanya bertahan sekitar 12 hingga 24 jam, namun sperma dapat bertahan hidup dalam saluran reproduksi wanita hingga 3 sampai 5 hari. Oleh karena itu, hubungan seksual yang terjadi beberapa hari sebelum ovulasi juga tetap memiliki potensi untuk menghasilkan kehamilan.

Selain itu, kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah keyakinan bahwa tanda-tanda masa subur pada setiap wanita bersifat sangat jelas dan seragam. Sebagian

pasangan muda beranggapan bahwa semua wanita akan mengalami tanda-tanda yang sama secara pasti seperti rasa nyeri atau kram di perut bagian bawah, perubahan mood yang signifikan, atau peningkatan suhu tubuh yang nyata saat masa subur tiba. Padahal, dalam kenyataannya, tanda-tanda masa subur sangat bervariasi di antara wanita dan tidak semua tanda tersebut muncul dengan intensitas yang sama atau bahkan terlihat jelas pada setiap wanita. Sebagian wanita mungkin mengalami perubahan lendir serviks yang jelas dan mudah dikenali, sementara wanita lainnya mungkin hampir tidak merasakan tanda-tanda khusus sama sekali. Kondisi ini menunjukkan betapa perlunya edukasi kesehatan reproduksi yang benar-benar individual dan kontekstual, yang tidak hanya menjelaskan teori umum, tetapi juga mempertimbangkan variasi individual.

Kesalahan informasi tentang siklus kesuburan ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan pasangan muda. Dampak pertama yang sangat nyata adalah dalam kegagalan perencanaan kehamilan. Pasangan yang mempercayai informasi keliru ini mungkin mengalami kesulitan hamil karena tidak memahami dengan tepat kapan waktu optimal untuk berhubungan seksual agar peluang kehamilan meningkat. Sebaliknya, pasangan muda yang ingin menghindari kehamilan tetapi mengandalkan informasi yang keliru tentang masa subur dapat mengalami kehamilan yang tidak direncanakan karena mereka gagal menggunakan metode kontrasepsi yang tepat atau gagal menghitung dengan benar kapan periode subur tersebut terjadi.

Selain itu, pemahaman yang salah tentang siklus kesuburan juga berpengaruh besar pada pemilihan metode kontrasepsi. Jika pasangan muda beranggapan bahwa risiko kehamilan selalu sama sepanjang siklus, mereka mungkin akan merasa perlu menggunakan metode kontrasepsi yang sangat ketat atau bahkan tidak percaya diri dalam menerapkan metode kontrasepsi berbasis kalender yang membutuhkan pemahaman tentang siklus secara detail. Sebaliknya, jika pasangan percaya bahwa risiko kehamilan hanya terjadi pada hari ovulasi saja, mereka mungkin akan mengabaikan kebutuhan penggunaan kontrasepsi pada hari-hari lain, yang justru meningkatkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan.

Untuk mengatasi persoalan ini, langkah yang paling utama dan efektif adalah memberikan edukasi yang jelas, konsisten, dan tentunya berbasis bukti ilmiah yang aktual. Edukasi tersebut harus mencakup pemahaman mendetail tentang anatomi dan fisiologi reproduksi wanita, mekanisme siklus menstruasi, dan bagaimana mengenali tanda-tanda ovulasi secara akurat serta realistis. Edukasi juga harus

menegaskan bahwa masa subur wanita berlangsung beberapa hari dan tidak hanya terbatas pada satu hari tertentu saja, serta pentingnya memahami bahwa tanda-tanda masa subur bisa berbeda-beda di antara wanita.

Edukasi ini harus diberikan secara intensif oleh tenaga kesehatan profesional seperti bidan, dokter, atau konselor kesehatan reproduksi melalui berbagai media. Konseling tatap muka merupakan metode yang sangat efektif untuk memberikan pemahaman langsung dan personal, memungkinkan adanya diskusi dan klarifikasi langsung mengenai mitos atau kesalahpahaman yang dimiliki oleh pasangan muda. Selain metode tatap muka, media digital seperti media sosial, platform edukasi online, dan aplikasi kesehatan reproduksi juga perlu dimanfaatkan secara maksimal. Tentunya, konten yang disajikan melalui media digital ini harus berasal dari sumber terpercaya, dikurasi oleh tenaga kesehatan profesional, dan selalu didasarkan pada bukti ilmiah terkini agar tidak malah semakin memperluas kesalahan informasi.

Dengan pendekatan edukasi yang terpadu, komprehensif, dan berbasis bukti ini, pasangan muda akan lebih mampu memahami dengan baik dan akurat tentang bagaimana siklus kesuburan bekerja. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang signifikan, seperti tercapainya tujuan perencanaan kehamilan yang diinginkan, penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif, dan tentunya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasangan muda. Edukasi yang benar-benar akurat tentang siklus kesuburan adalah kunci utama untuk menciptakan generasi yang lebih sadar, sehat, dan mampu merencanakan kehidupan reproduksinya secara optimal.

## **F. Latihan Soal**

### **Tugas 1: Pembuatan Poster Edukatif tentang Anatomi Reproduksi**

Mahasiswa diminta membuat poster edukatif yang menarik secara visual mengenai anatomi sistem reproduksi pria dan wanita. Poster tersebut harus menjelaskan organ-organ utama beserta fungsi khusus dari masing-masing organ. Poster harus disusun secara kreatif, informatif, dan mudah dipahami oleh khalayak umum, khususnya pasangan muda yang berencana menikah atau memiliki anak. Jelaskan juga pentingnya pengetahuan ini dalam menjaga kesehatan reproduksi secara optimal.

### **Tugas 2: Video Animasi tentang Fisiologi Reproduksi dan Fertilitas**

Mahasiswa diminta membuat video animasi singkat (durasi 5-7 menit) yang menjelaskan mekanisme fisiologi reproduksi dan fertilitas, baik pada pria maupun

wanita. Video harus mencakup proses produksi sperma pada pria (spermatogenesis) dan siklus menstruasi hingga ovulasi pada wanita, disertai ilustrasi tentang bagaimana hormon-hormon seperti testosteron, estrogen, progesteron, LH, dan FSH berperan dalam proses ini. Mahasiswa juga diminta memberikan narasi yang jelas dan mudah dipahami tentang pentingnya keseimbangan hormonal dalam menjaga fertilitas.

### **Tugas 3: Observasi dan Catatan Harian Siklus Menstruasi**

Mahasiswa perempuan diminta untuk mencatat secara detail siklus menstruasi pribadi selama dua bulan, mencakup tanggal mulai menstruasi, durasi menstruasi, dan perubahan fisik maupun emosional yang dirasakan selama siklus berlangsung. Berdasarkan data yang terkumpul, mahasiswa harus membuat laporan naratif yang menjelaskan bagaimana pola siklus menstruasinya, perkiraan masa subur, serta mengidentifikasi tanda-tanda ovulasi yang dialami secara individual. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya memahami siklus pribadi dalam konteks kesehatan reproduksi.

### **Tugas 4: Analisis Konten Edukasi Reproduksi di Media Sosial**

Mahasiswa diminta untuk memilih dan menganalisis minimal tiga akun media sosial yang aktif memberikan konten edukasi kesehatan reproduksi, baik di Instagram, TikTok, atau YouTube. Mahasiswa harus mengidentifikasi konten-konten yang dianggap menarik dan efektif, serta menilai akurasi informasi yang diberikan. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menulis laporan analisis yang mencakup kekuatan dan kelemahan dari masing-masing akun dalam menyajikan informasi kesehatan reproduksi, serta memberikan rekomendasi tentang bagaimana seharusnya konten edukasi kesehatan reproduksi dikembangkan secara lebih bertanggung jawab di media sosial.

### **Tugas 5: Studi Kasus dan Solusi terhadap Kesalahan Informasi tentang Siklus Kesuburan**

Mahasiswa diminta menyusun studi kasus fiktif tentang pasangan muda yang mengalami kesulitan hamil akibat kesalahpahaman mengenai siklus kesuburan. Mahasiswa harus menggambarkan secara detail latar belakang pasangan, kesalahan informasi yang dipercaya, dampak yang timbul akibat kesalahan informasi tersebut, serta bagaimana mereka menyadari kesalahan tersebut. Selanjutnya, mahasiswa harus memberikan solusi berupa program edukasi yang jelas, konsisten, dan berbasis bukti yang dapat diterapkan untuk mengoreksi kesalahan informasi yang dialami oleh pasangan tersebut. Solusi harus mencakup metode konseling tatap muka maupun pemanfaatan media digital, dengan menjelaskan alasan mengapa metode tersebut dipilih.

### Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan berusia 26 tahun, sedang berkonsultasi di TPMB tentang keinginan memiliki anak. Ia bertanya mengenai organ reproduksi yang menjadi tempat bertemunya sperma dengan sel telur (ovum).

Organ reproduksi yang tepat sebagai tempat terjadinya pembuahan adalah:

- A. Uterus
- B. Vagina
- C. Tuba fallopi
- D. Serviks
- E. Ovarium

2. Seorang pria, Pak Adi, 30 tahun, datang ke klinik kebidanan bersama istrinya untuk konsultasi infertilitas. Hasil pemeriksaan sperma menunjukkan jumlah sperma yang sangat rendah.

Hormon utama yang bertanggung jawab untuk merangsang produksi sperma adalah:

- A. Estrogen
- B. Progesteron
- C. LH (Luteinizing hormone)
- D. FSH (Follicle-stimulating hormone)
- E. Prolaktin

3. Seorang perempuan usia 28 tahun, datang ke TPMB untuk berkonsultasi tentang siklus menstruasinya yang tidak teratur sejak 1 tahun terakhir. Setelah pemeriksaan, bidan menduga adanya gangguan hormonal berupa sindrom ovarium polikistik (PCOS).

Gangguan hormon utama pada PCOS adalah peningkatan kadar hormon:

- A. Androgen
- B. Estrogen
- C. Progesteron
- D. LH
- E. FSH

4. Seorang perempuan (24 tahun) dan suaminya ingin menunda kehamilan menggunakan metode kontrasepsi alami berdasarkan perhitungan siklus menstruasi. Jika siklus menstruasi teratur 28 hari, kapan kira-kira waktu ovulasinya terjadi?

- A. Hari ke-7
- B. Hari ke-10



- C. Hari ke-14
  - D. Hari ke-21
  - E. Hari ke-28
5. Seorang bidan, Ibu Rina, aktif memberikan edukasi kesehatan reproduksi melalui media sosial. Beliau ingin memastikan kontennya akurat dan berdasarkan bukti ilmiah. Di bawah ini, manakah langkah yang paling penting dilakukan oleh Ibu Rina untuk menjamin akurasi informasi yang disampaikan?
- A. Menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami
  - B. Memastikan konten dilengkapi dengan visualisasi menarik
  - C. Menggunakan banyak platform media social
  - D. Menghindari topik kontroversial dalam reproduksi
  - E. Melakukan pengecekan silang konten dengan sumber ilmiah terpercaya

### Kunci Jawaban

1. Kunci Jawaban: C. Tuba fallopi

Pembahasan:

Tuba fallopi merupakan tempat pertemuan sperma dan ovum (pembuahan). Setelah pembuahan terjadi, hasil konsepsi akan bergerak menuju uterus untuk implantasi. Organ lainnya tidak berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan.

2. Kunci Jawaban: D. FSH (Follicle-stimulating hormone)

Pembahasan:

FSH merupakan hormon utama yang merangsang produksi dan pematangan sperma di dalam testis (pada sel Sertoli). Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan jumlah sperma rendah, memengaruhi fertilitas pria.

3. Kunci Jawaban: A. Androgen

Pembahasan:

PCOS ditandai dengan tingginya kadar hormon androgen (seperti testosteron) yang menyebabkan gangguan ovulasi, menstruasi tidak teratur, dan infertilitas pada wanita.

4. Kunci Jawaban: C. Hari ke-14

Pembahasan:

Pada siklus menstruasi yang teratur (28 hari), ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar hari ke-14. Mengetahui waktu ini sangat penting untuk menentukan masa subur untuk perencanaan kehamilan atau kontrasepsi alami.

5. Kunci Jawaban: E. Melakukan pengecekan silang konten dengan sumber ilmiah terpercaya

Pembahasan:

Menjamin akurasi informasi edukasi kesehatan reproduksi yang disampaikan melalui media sosial harus didasarkan pada sumber ilmiah terpercaya dan bukti klinis terkini, agar tidak menyebabkan kesalahan informasi yang bisa berdampak buruk bagi pengguna media sosial yang menerima konten tersebut.

## G. Rangkuman Materi

Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki struktur anatomi dan fungsi biologis yang unik namun saling melengkapi. Pada pria, organ reproduksi terdiri dari testis sebagai penghasil sperma dan hormon testosteron yang mendukung perkembangan karakteristik seksual sekunder, epididimis untuk pematangan dan penyimpanan sperma, vas deferens untuk transportasi sperma, serta vesikula seminalis dan prostat yang memproduksi cairan semen sebagai media nutrisi dan perlindungan bagi sperma. Organ eksternal, yaitu penis, berfungsi sebagai saluran urin sekaligus organ kopulasi untuk mengantarkan sperma ke organ reproduksi wanita.

Sementara pada wanita, anatomi reproduksi terbagi atas organ internal dan eksternal. Organ internal mencakup ovarium yang menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron yang penting dalam pengaturan siklus menstruasi, tuba fallopi sebagai tempat pembuahan antara sel telur dan sperma, uterus sebagai tempat perkembangan janin, serviks sebagai pintu rahim yang melindungi dari infeksi sekaligus mendukung persalinan, serta vagina yang menjadi saluran kelahiran, jalur masuk sperma, dan tempat keluarnya darah menstruasi. Organ eksternal wanita, yang dikenal sebagai vulva, terdiri dari mons pubis, labia majora dan minora yang melindungi organ reproduksi internal, serta klitoris yang berperan dalam respons seksual.

Fisiologi reproduksi pada pria berpusat pada spermatogenesis, yaitu pembentukan sperma yang sangat bergantung pada hormon testosteron, LH, dan FSH. Keseimbangan hormon-hormon tersebut sangat menentukan kualitas dan kuantitas sperma, serta memengaruhi fertilitas pria secara keseluruhan. Sedangkan fisiologi reproduksi wanita lebih kompleks karena melibatkan siklus menstruasi yang berlangsung dalam tiga fase, yaitu fase folikuler, ovulasi, dan luteal. Pada fase folikuler, hormon FSH merangsang folikel ovarium untuk tumbuh dan menghasilkan

estrogen yang mempersiapkan endometrium untuk implantasi embrio. Ovulasi ditandai pelepasan sel telur akibat lonjakan LH, sedangkan fase luteal diatur oleh hormon progesteron yang menjaga endometrium agar siap menerima embrio. Jika tidak terjadi pembuahan, endometrium akan meluruh dalam bentuk menstruasi. Gangguan hormonal seperti PCOS dapat mengganggu siklus menstruasi dan fertilitas wanita.

Pemahaman yang baik mengenai siklus menstruasi sangat penting untuk menentukan masa subur guna merencanakan atau menunda kehamilan secara efektif. Siklus menstruasi rata-rata berlangsung sekitar 28 hari, namun variasi antara 21 hingga 35 hari masih dianggap normal. Ovulasi biasanya terjadi di tengah siklus, dan masa subur mencakup beberapa hari sebelum hingga sesudah ovulasi karena sperma mampu bertahan hidup di saluran reproduksi wanita hingga beberapa hari.

Seiring perkembangan teknologi, edukasi kesehatan reproduksi kini banyak dilakukan melalui media sosial yang sangat populer di kalangan generasi muda. Media sosial menyediakan platform yang interaktif dan menarik dalam menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang mudah dipahami melalui visualisasi yang atraktif seperti video, infografis, dan animasi. Namun, tantangan utama dari tren ini adalah memastikan informasi yang diberikan akurat dan valid secara medis. Oleh karena itu, keterlibatan aktif tenaga kesehatan profesional, seperti bidan, sangat penting dalam menciptakan konten edukasi yang benar, berbasis bukti, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Isu utama yang sering muncul di kalangan pasangan muda adalah kesalahan informasi tentang siklus kesuburan, seperti anggapan keliru bahwa kehamilan dapat terjadi kapan saja sepanjang siklus atau hanya pada hari ovulasi saja. Kesalahpahaman ini dapat berdampak serius, baik berupa kegagalan perencanaan kehamilan maupun penggunaan metode kontrasepsi yang tidak efektif. Oleh karena itu, edukasi yang intensif dan berbasis bukti sangat diperlukan untuk meluruskan kesalahan tersebut, baik melalui konseling tatap muka maupun pemanfaatan media digital yang akurat dan terpercaya. Dengan demikian, pemahaman yang tepat tentang anatomi, fisiologi, serta siklus reproduksi akan membantu pasangan muda dalam membuat keputusan yang optimal terkait kesehatan reproduksi mereka.

## H. Glosarium

### **Anatomi Reproduksi**

Struktur fisik sistem reproduksi manusia yang terdiri dari organ-organ yang saling terhubung dan memiliki fungsi spesifik dalam mendukung proses reproduksi.

### **Edukasi Kesehatan Reproduksi Berbasis Media Sosial**

Tren edukasi kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan informasi dengan cara interaktif dan menarik, terutama bagi generasi muda.

### **Epididimis**

Saluran melingkar di belakang testis tempat sperma mengalami pematangan dan penyimpanan sementara sebelum ejakulasi.

### **Estrogen**

Hormon seksual utama pada wanita yang diproduksi oleh ovarium, berperan dalam pengaturan siklus menstruasi, pengembangan ciri-ciri seksual sekunder, serta mempersiapkan lapisan endometrium untuk kehamilan.

### **Fertilitas**

Kemampuan individu atau pasangan untuk menghasilkan keturunan, yang bergantung pada kondisi anatomi dan fisiologi sistem reproduksi serta keseimbangan hormonal yang baik.

### **Folikel Ovarium**

Struktur kecil di ovarium yang berisi sel telur berkembang dan menghasilkan hormon estrogen selama fase folikuler dari siklus menstruasi.

### **Follicle Stimulating Hormone (FSH)**

Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang merangsang perkembangan folikel pada wanita serta produksi dan pematangan sperma pada pria.

### **Kesalahan Informasi Siklus Kesuburan**

Mitos atau pemahaman keliru mengenai siklus menstruasi dan masa subur wanita, yang sering menyebabkan kegagalan perencanaan kehamilan atau pemilihan metode kontrasepsi yang kurang efektif.

### **Korpus Luteum**

Struktur yang terbentuk dari folikel setelah ovulasi, menghasilkan hormon progesteron yang penting untuk menjaga ketebalan lapisan rahim selama fase luteal.

### **Labia Majora dan Minora**

Bagian eksternal organ genital wanita berupa lipatan kulit yang berfungsi melindungi organ reproduksi internal dari infeksi dan cedera.

### **Luteinizing Hormone (LH)**

Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, memicu proses ovulasi pada wanita dan merangsang produksi hormon testosteron pada pria.

### **Masa Subur**

Periode dalam siklus menstruasi wanita di mana kemungkinan terjadinya kehamilan paling tinggi, mencakup hari ovulasi serta beberapa hari sebelumnya dan sesudahnya.

### **Menstruasi**

Proses peluruhan lapisan dinding rahim (endometrium) yang terjadi jika tidak terjadi pembuahan, menandai awal siklus menstruasi baru.

### **Mons Pubis**

Bagian dari vulva berupa bantalan jaringan lemak yang berfungsi melindungi tulang pubis.

### **Ovarium**

Organ reproduksi primer wanita yang berfungsi menghasilkan sel telur (ovum) serta hormon estrogen dan progesteron.

### **Ovulasi**

Pelepasan sel telur matang dari ovarium ke tuba fallopi, yang dipicu oleh lonjakan hormon LH dan merupakan periode paling subur dalam siklus menstruasi wanita.

### **Penis**

Organ seksual eksternal pria yang berfungsi sebagai saluran urin sekaligus organ kopulasi yang mengantarkan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita.

### **Progesteron**

Hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum setelah ovulasi, berfungsi mempertahankan ketebalan dinding rahim agar siap menerima embrio jika terjadi pembuahan.

### **Prostat**

Kelenjar pada pria yang menghasilkan cairan basa untuk membantu melindungi sperma dari lingkungan asam dalam vagina.

### **Serviks**

Bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina, berfungsi menjaga rahim dari infeksi serta memainkan peran penting dalam proses persalinan.

### **Siklus Menstruasi**

Proses siklikal perubahan hormonal dan fisik yang terjadi pada tubuh wanita setiap bulan, terdiri dari fase folikuler, ovulasi, dan fase luteal.

### **Sistem Reproduksi**

Keseluruhan struktur anatomi dan fisiologis yang memungkinkan manusia melakukan reproduksi, terdiri dari organ reproduksi pria dan wanita.

**Spermatogenesis**

Proses pembentukan dan pematangan sel sperma yang terjadi di dalam testis pria dan dipengaruhi oleh hormon testosteron serta FSH.

**Testis**

Organ reproduksi primer pada pria yang menghasilkan sperma serta hormon testosteron yang mengatur perkembangan seksual sekunder.

**Testosteron**

Hormon seksual utama pria yang berperan dalam pengembangan karakteristik seksual sekunder, produksi sperma, serta mempertahankan fungsi seksual dan kesehatan umum pria.

**Tuba Fallopi**

Saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, merupakan tempat terjadinya pembuahan (pertemuan antara sel telur dan sperma).

**Uretra**

Saluran yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin pada wanita, sementara pada pria berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan semen saat ejakulasi.

**Uterus (Rahim)**

Organ berbentuk seperti buah pir terbalik pada wanita yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan.

**Vagina**

Saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan vulva, berfungsi sebagai jalur masuknya sperma, saluran kelahiran, serta tempat keluarnya darah menstruasi.

**Vas Deferens**

Saluran pada pria yang menghubungkan epididimis dengan vesikula seminalis, berfungsi sebagai tempat lewatnya sperma matang.

**Vesikula Seminalis**

Kelenjar pada pria yang menghasilkan cairan semen untuk memberikan nutrisi dan melindungi sperma selama perjalanan menuju sel telur wanita.

**Vulva**

Istilah untuk seluruh organ genital eksternal wanita yang terdiri dari mons pubis, labia majora dan minora, klitoris, serta lubang vagina, memiliki fungsi seksual dan perlindungan.

## I. Daftar Pustaka

- Berek, J. S., & Novak, E. (2020). *Berek & Novak's Gynecology* (16th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hall, J. E., & Hall, M. E. (2020). *Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology* (14th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Junqueira, L. C., & Carneiro, J. (2018). *Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kumar, V., Abbas, A. K., & Aster, J. C. (2021). *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease* (10th ed.). Elsevier Saunders.
- McCance, K. L., & Huether, S. E. (2018). *Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children* (8th ed.). Mosby Elsevier.
- Sherwood, L. (2018). *Human Physiology: From Cells to Systems* (9th ed.). Cengage Learning.
- Silverthorn, D. U. (2019). *Human Physiology: An Integrated Approach* (8th ed.). Pearson Education.
- World Health Organization. (2018). *Family Planning: A Global Handbook for Providers*. Geneva: WHO Press.
- Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., Dyer, S., Racowsky, C., de Mouzon, J., Sokol, R., & van der Poel, S. (2017). The international glossary on infertility and fertility care, 2017. *Human Reproduction*, 32(9), 1786–1801.

# Bab 4

## Persiapan Fisik dan Kesehatan Prakonsepsi

Persiapan fisik dan kesehatan prakonsepsi adalah langkah penting yang wajib dilakukan oleh pasangan sebelum memutuskan untuk memiliki keturunan. Persiapan ini tidak sekadar menjadi rutinitas medis, melainkan sebuah langkah strategis dalam menciptakan kondisi fisik yang optimal guna mendukung kehamilan yang sehat serta kelahiran bayi yang sehat pula. Persiapan fisik yang matang membantu mengidentifikasi dan mengelola berbagai risiko kesehatan yang berpotensi mempengaruhi fertilitas, kehamilan, dan kondisi janin nantinya. Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai berbagai aspek penting dalam persiapan kesehatan sebelum konsepsi, termasuk pemeriksaan kesehatan, imunisasi, nutrisi optimal, aktivitas fisik, serta tren dan isu terkini yang berkembang di masyarakat terkait kesadaran akan pentingnya persiapan kesehatan prakonsepsi.

### **Capaian Pembelajaran (CPL)**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami secara komprehensif tentang pentingnya persiapan fisik dan kesehatan sebelum konsepsi serta mampu memberikan edukasi dan konseling berbasis bukti kepada calon pasangan yang merencanakan kehamilan.

### **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis, serta menerapkan konsep pemeriksaan kesehatan, imunisasi, nutrisi, aktivitas fisik, serta memahami tren dan isu terkait persiapan kesehatan prakonsepsi secara efektif dan tepat.

### **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

- Mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan manfaat pemeriksaan kesehatan prakonsepsi.
- Mahasiswa mampu memahami pentingnya imunisasi dan suplementasi vitamin dalam masa prakonsepsi.
- Mahasiswa mampu menganalisis pentingnya nutrisi optimal untuk meningkatkan fertilitas.
- Mahasiswa mampu memberikan rekomendasi terkait olahraga dan aktivitas fisik selama masa prakonsepsi.
- Mahasiswa mampu memahami tren terbaru mengenai pemeriksaan genetik pra-kehamilan.



## A. Pemeriksaan Kesehatan Prakonsepsi (*Screening Kesehatan*)

Pemeriksaan kesehatan prakonsepsi merupakan suatu tahapan penting yang dilakukan oleh pasangan yang merencanakan kehamilan, bertujuan utama untuk menilai kondisi kesehatan secara menyeluruh sebelum terjadi konsepsi atau pembuahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tubuh calon ibu maupun calon ayah dalam kondisi yang sehat, bebas dari risiko yang dapat mengganggu proses kehamilan maupun kesehatan janin nantinya. Tahapan ini sangat penting dilakukan sebelum pasangan benar-benar menjalani masa kehamilan, karena hasil pemeriksaan dapat memberikan informasi lengkap tentang kondisi fisik, potensi masalah kesehatan, serta kesiapan reproduksi masing-masing pasangan.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan kesehatan prakonsepsi mencakup beberapa aspek yang komprehensif. Pertama adalah pemeriksaan fisik secara umum. Dalam tahap ini, tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap tanda vital seperti tekanan darah, detak jantung, dan berat badan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini berbagai kondisi seperti hipertensi atau obesitas yang dapat meningkatkan risiko komplikasi saat kehamilan berlangsung. Pemeriksaan ini juga memungkinkan pasangan untuk segera mengambil langkah preventif seperti perubahan pola makan atau aktivitas fisik secara teratur jika ditemukan adanya faktor risiko tertentu.

Selanjutnya, pemeriksaan darah secara lengkap juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses screening prakonsepsi. Pemeriksaan darah ini biasanya mencakup beberapa parameter penting, seperti kadar gula darah untuk mendeteksi kemungkinan adanya diabetes, kadar hemoglobin untuk menilai kondisi anemia, serta penentuan golongan darah dan rhesus yang sangat penting untuk mencegah komplikasi seperti ketidakcocokan rhesus antara ibu dan janin yang dapat membahayakan kehamilan. Kadar gula darah yang tinggi, misalnya, dapat menyebabkan diabetes gestasional yang berpotensi memicu berbagai komplikasi serius seperti preeklamsia, persalinan prematur, atau bahkan bayi lahir dengan berat badan berlebih.

Selain pemeriksaan darah, pemeriksaan hormonal juga dilakukan sebagai bagian integral dalam pemeriksaan prakonsepsi. Pemeriksaan hormonal bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan keseimbangan hormon yang dapat berdampak langsung terhadap kesuburan pasangan. Kondisi hormonal yang tidak seimbang,

seperti gangguan tiroid atau sindrom ovarium polikistik (PCOS), dapat menyebabkan masalah ovulasi pada wanita atau gangguan produksi sperma pada pria. Melalui pemeriksaan hormonal ini, tenaga kesehatan dapat memberikan terapi atau pengobatan yang tepat guna mengatasi permasalahan hormonal tersebut sebelum kehamilan berlangsung, sehingga peluang kehamilan yang sehat meningkat secara signifikan.

Pemeriksaan prakonsepsi juga mencakup skrining terhadap berbagai jenis infeksi menular seksual (IMS). Infeksi seperti HIV/AIDS, hepatitis B, sifilis, dan gonore dapat menimbulkan dampak serius baik pada kesuburan pasangan maupun pada kesehatan janin nantinya. Infeksi seperti hepatitis B misalnya, jika tidak terdeteksi lebih awal, dapat ditularkan dari ibu kepada janin selama proses persalinan, yang berisiko menyebabkan infeksi kronis atau bahkan gangguan fungsi hati serius pada bayi. Demikian pula HIV, jika terdeteksi lebih awal, pasangan dapat mengambil langkah preventif serta mendapatkan terapi antiretroviral guna menurunkan risiko penularan kepada janin secara signifikan.

Manfaat utama dari pemeriksaan kesehatan prakonsepsi ini adalah memungkinkan pasangan untuk mengidentifikasi berbagai kondisi kesehatan secara dini, yang jika tidak diketahui dapat berkembang menjadi masalah besar selama kehamilan dan persalinan. Misalnya saja penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, jika tidak terdeteksi sejak awal, bisa mengakibatkan komplikasi seperti preeklamsia, keguguran, kelahiran prematur, atau bahkan risiko cacat lahir pada bayi. Dengan mengetahui berbagai kondisi ini sejak dini, pasangan dapat segera mengambil langkah yang tepat seperti menjalani pengobatan, melakukan perubahan gaya hidup sehat, atau bahkan menunda kehamilan sampai kondisi kesehatan benar-benar optimal.

Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini menjadi dasar penting dalam merancang program kesehatan yang tepat bagi calon ibu. Program ini biasanya mencakup suplementasi nutrisi yang spesifik, imunisasi prakonsepsi, serta konseling pola hidup sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan berdasarkan kondisi kesehatannya. Dengan begitu, pasangan bisa secara aktif meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi mereka, serta meminimalkan risiko komplikasi selama kehamilan.

Secara keseluruhan, pemeriksaan kesehatan prakonsepsi bukan hanya sebuah formalitas medis yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga dan merencanakan keturunan. Pemeriksaan ini tidak hanya berdampak positif pada kualitas kesehatan pasangan dan calon bayi mereka, namun juga membantu pasangan dalam mempersiapkan kehidupan keluarga yang sehat, bahagia, dan harmonis secara optimal sejak awal.

## **B. Imunisasi dan Suplementasi Vitamin Prakonsepsi**

Imunisasi dan suplementasi vitamin dalam masa prakonsepsi merupakan bagian yang sangat penting dalam persiapan pasangan sebelum kehamilan terjadi. Hal ini bukan sekadar rutinitas medis semata, tetapi merupakan langkah strategis yang bertujuan melindungi kesehatan calon ibu dan janin dari berbagai risiko penyakit infeksi yang dapat berdampak serius selama masa kehamilan. Imunisasi prakonsepsi secara khusus dirancang untuk menciptakan kondisi tubuh yang optimal sehingga calon ibu memiliki kekebalan tubuh yang cukup terhadap penyakit tertentu yang berpotensi membahayakan dirinya dan janin yang dikandungnya.

Salah satu imunisasi yang sangat direkomendasikan sebelum konsepsi adalah vaksin rubella. Rubella, yang juga dikenal sebagai campak Jerman, merupakan penyakit yang jika dialami oleh wanita hamil pada trimester pertama, dapat menyebabkan risiko serius pada janin seperti kelainan kongenital, kerusakan otak, gangguan pendengaran, kelainan jantung, serta berbagai jenis kecacatan bawaan lainnya. Oleh karena itu, vaksinasi rubella sangat penting dilakukan sebelum masa kehamilan guna memastikan bahwa tubuh calon ibu telah memiliki antibodi yang memadai terhadap virus tersebut, sehingga risiko infeksi pada janin dapat diminimalkan secara signifikan.

Selain rubella, imunisasi hepatitis B juga penting untuk diberikan sebelum konsepsi. Hepatitis B merupakan penyakit yang menyerang hati dan dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sirosis hati, kanker hati, hingga kematian. Apabila seorang wanita mengalami infeksi hepatitis B selama masa kehamilan, maka virus tersebut memiliki potensi tinggi untuk ditularkan kepada janin, terutama pada saat proses persalinan. Dengan mendapatkan imunisasi hepatitis B sejak dini, calon ibu dapat terlindungi dari infeksi virus tersebut, yang pada akhirnya juga akan melindungi janin dari risiko terinfeksi penyakit berbahaya tersebut.

Selanjutnya, vaksinasi tetanus juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dari imunisasi prakonsepsi. Tetanus adalah infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kejang otot yang hebat, kesulitan bernapas, dan bahkan kematian. Dalam konteks kehamilan dan persalinan, risiko infeksi tetanus meningkat terutama jika persalinan dilakukan di tempat yang kurang steril atau tanpa fasilitas kesehatan yang memadai. Dengan vaksinasi tetanus yang tepat waktu sebelum kehamilan, risiko terjadinya infeksi tetanus pada ibu maupun bayi baru lahir bisa dihindari secara efektif.

Selain imunisasi, suplementasi vitamin prakonsepsi juga menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu vitamin esensial yang direkomendasikan secara luas sebelum kehamilan adalah asam folat. Asam folat telah terbukti secara ilmiah dapat secara signifikan menurunkan risiko terjadinya kelainan tabung saraf atau neural tube defects pada janin, seperti spina bifida, yaitu kondisi di mana tulang belakang janin tidak menutup dengan sempurna. Kelainan ini bisa berdampak serius terhadap kualitas hidup bayi yang dilahirkan, mulai dari kelumpuhan sebagian hingga gangguan perkembangan yang kompleks. Oleh karena itu, konsumsi asam folat sangat dianjurkan bahkan sejak beberapa bulan sebelum konsepsi hingga trimester pertama kehamilan guna memastikan pembentukan tabung saraf janin yang sempurna.

Selain asam folat, suplementasi zat besi juga tidak kalah pentingnya bagi wanita yang sedang mempersiapkan kehamilan. Zat besi memiliki peran vital dalam pembentukan sel darah merah dan hemoglobin yang bertugas membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh, termasuk ke janin selama kehamilan. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia yang ditandai oleh rasa lemah, letih, pusing, dan menurunnya daya tahan tubuh, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi selama masa kehamilan seperti kelahiran prematur atau berat bayi lahir rendah. Dengan mengonsumsi zat besi secara rutin sebelum konsepsi, calon ibu dapat memastikan bahwa kadar hemoglobinnnya dalam kondisi optimal, sehingga suplai oksigen dan nutrisi ke janin menjadi maksimal dan risiko komplikasi kehamilan akibat anemia dapat diminimalkan secara signifikan.

Dengan demikian, imunisasi dan suplementasi vitamin dalam masa prakonsepsi merupakan bagian integral yang tidak dapat diabaikan oleh pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Kedua hal ini memberikan perlindungan optimal bagi calon ibu dan janin dari risiko penyakit infeksi dan komplikasi serius selama masa kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya imunisasi

dan suplementasi ini perlu terus disosialisasikan secara luas oleh tenaga kesehatan melalui edukasi yang intensif agar calon pasangan dapat secara aktif mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebelum menjalani masa kehamilan, demi terwujudnya generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

### **C. Nutrisi Optimal untuk Fertilitas**

Nutrisi memiliki peran yang sangat penting dan sentral dalam mempersiapkan tubuh seorang pria maupun wanita yang sedang merencanakan kehamilan. Kualitas makanan yang dikonsumsi secara langsung berpengaruh terhadap kondisi kesehatan reproduksi dan fertilitas pasangan. Mengadopsi pola makan yang sehat, seimbang, dan kaya akan nutrisi tertentu terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan potensi kesuburan, sekaligus menciptakan lingkungan tubuh yang optimal untuk mendukung terjadinya konsepsi yang sehat dan lancar.

Salah satu kelompok nutrisi yang memiliki dampak signifikan terhadap fertilitas adalah antioksidan, yang mencakup vitamin C, vitamin E, selenium, serta seng. Antioksidan memiliki kemampuan khusus untuk melawan efek negatif dari radikal bebas yang bisa merusak sel tubuh, termasuk sel telur pada wanita dan sel sperma pada pria. Radikal bebas, yang berasal dari paparan lingkungan atau metabolisme tubuh yang kurang sehat, bisa menyebabkan kerusakan DNA sperma atau ovum, yang pada akhirnya mengurangi kualitas fertilitas. Oleh karena itu, konsumsi makanan kaya antioksidan seperti jeruk, kiwi, paprika, kacang almond, bayam, tomat, brokoli, serta biji-bijian sangat dianjurkan bagi pasangan yang ingin meningkatkan fertilitasnya.

Selain antioksidan, konsumsi asam folat juga sangat penting dalam masa prakonsepsi. Asam folat bukan hanya esensial dalam menurunkan risiko kelainan tabung saraf pada janin, tetapi juga terbukti mampu meningkatkan kualitas sel telur serta mendukung proses ovulasi yang sehat pada wanita. Asam folat juga membantu menjaga keseimbangan hormonal yang dibutuhkan untuk proses reproduksi. Makanan yang kaya akan asam folat antara lain bayam, asparagus, alpukat, kacang-kacangan, dan sereal yang diperkaya dengan asam folat. Meskipun demikian, selain makanan alami, pasangan juga disarankan untuk mengonsumsi suplemen asam folat secara rutin sebelum konsepsi demi memastikan tubuh mendapatkan kadar asam folat yang cukup.

Nutrisi lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung fertilitas adalah asam lemak omega-3. Omega-3 merupakan asam lemak sehat yang berperan besar dalam menjaga fungsi hormonal yang normal, meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi, serta menunjang kualitas sel telur dan sperma. Sumber alami omega-3 seperti ikan salmon, sarden, tuna, kacang walnut, biji chia, dan minyak zaitun sebaiknya rutin dikonsumsi oleh pasangan dalam persiapan kehamilan. Dengan mengonsumsi omega-3 secara teratur, pasangan dapat meningkatkan peluang fertilitas sekaligus mengurangi risiko terjadinya peradangan atau gangguan hormonal yang bisa menghambat terjadinya konsepsi.

Protein juga menjadi komponen nutrisi yang vital dalam mendukung fertilitas. Protein berkualitas tinggi, seperti yang terdapat dalam telur, ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan seperti almond, lentil, atau edamame, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan hormon reproduksi serta mendukung proses pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, termasuk jaringan reproduksi. Konsumsi protein yang cukup akan membantu tubuh pasangan untuk siap menghadapi proses kehamilan dengan lebih optimal.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa jenis makanan dan minuman tertentu yang sebaiknya dihindari atau dikurangi secara signifikan dalam masa persiapan konsepsi, karena memiliki dampak negatif terhadap kesuburan. Konsumsi alkohol, misalnya, diketahui dapat menurunkan kualitas sperma dan menyebabkan gangguan hormonal yang berdampak negatif pada ovulasi wanita. Demikian pula, konsumsi kafein berlebihan seperti kopi atau minuman berkafein tinggi, terbukti memiliki hubungan dengan penurunan kesuburan dan peningkatan risiko keguguran pada wanita yang sudah hamil.

Selain itu, merokok juga merupakan faktor risiko utama yang sangat berdampak negatif terhadap kesuburan. Rokok tidak hanya menyebabkan penurunan jumlah sperma pada pria, tetapi juga merusak kualitas sel telur pada wanita, yang selanjutnya bisa menyebabkan masalah fertilitas serius seperti infertilitas atau kesulitan mendapatkan keturunan. Makanan tinggi gula dan lemak jenuh, seperti makanan cepat saji, minuman manis, atau makanan ringan yang diproses, juga memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kesehatan reproduksi, karena dapat menyebabkan gangguan hormonal, obesitas, resistensi insulin, hingga peradangan kronis yang merugikan kesuburan.

Oleh karena itu, edukasi mengenai nutrisi optimal untuk fertilitas perlu disampaikan secara intensif dan rutin oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, maupun ahli gizi. Informasi yang tepat, akurat, serta berbasis bukti akan membantu pasangan dalam merancang pola makan yang lebih sehat, sehingga secara proaktif mereka mampu menciptakan kondisi tubuh yang ideal untuk konsepsi. Dengan memahami dan menerapkan prinsip nutrisi optimal ini, pasangan tidak hanya meningkatkan peluang terjadinya kehamilan, tetapi juga memastikan bahwa janin nantinya tumbuh dalam lingkungan rahim yang sehat, penuh nutrisi, dan bebas dari risiko gangguan yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin di kemudian hari.

#### **D. Olahraga dan Aktivitas Fisik Prakonsepsi**

Aktivitas fisik yang rutin dan teratur memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan kondisi tubuh pasangan, baik pria maupun wanita, menjelang terjadinya kehamilan. Dalam konteks prakonsepsi, olahraga bukan sekadar aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh semata, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan reproduksi dan fertilitas pasangan. Pasangan yang secara aktif melakukan aktivitas fisik secara teratur biasanya memiliki kondisi fisik yang lebih optimal untuk menunjang proses reproduksi yang sehat serta meningkatkan peluang kehamilan yang lancar dan tanpa hambatan.

Berbagai studi ilmiah menunjukkan bahwa olahraga ringan hingga sedang, seperti berjalan cepat, bersepeda santai, berenang secara teratur, atau melakukan latihan-latihan ringan seperti yoga dan pilates, sangat efektif dalam mendukung kesehatan reproduksi. Aktivitas ini membantu tubuh dalam menjaga berat badan yang ideal, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan hormonal tubuh. Berat badan yang ideal dan stabil memiliki hubungan erat dengan siklus menstruasi yang teratur pada wanita serta produksi sperma yang sehat pada pria. Sebaliknya, kondisi kelebihan berat badan atau obesitas maupun berat badan terlalu rendah (*underweight*) bisa menyebabkan gangguan hormonal, gangguan ovulasi, hingga penurunan kualitas sperma, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap peluang fertilitas pasangan.

Selain menjaga berat badan, aktivitas fisik yang teratur juga secara signifikan membantu memperbaiki sirkulasi darah di seluruh tubuh, termasuk meningkatkan aliran darah ke organ-organ reproduksi. Aliran darah yang baik ke organ reproduksi seperti ovarium, rahim, dan testis penting untuk menjaga fungsi organ-organ ini secara optimal. Pada wanita, aliran darah yang baik ke rahim dan ovarium

membantu menyehatkan lapisan rahim (endometrium) sehingga lebih siap menerima implantasi embrio. Demikian pula pada pria, peningkatan sirkulasi darah ke testis mendukung produksi sperma yang berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup.

Selain manfaat fisik langsung tersebut, olahraga juga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan mental dan emosional calon pasangan. Olahraga membantu mengurangi stres, kecemasan, serta memperbaiki mood, yang semuanya berhubungan erat dengan keseimbangan hormon reproduksi. Stres yang kronis diketahui secara luas dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, gangguan ovulasi pada wanita, serta penurunan kualitas sperma pada pria. Oleh sebab itu, dengan rutin berolahraga, pasangan tidak hanya mendapatkan manfaat fisik, tetapi juga manfaat psikologis berupa peningkatan suasana hati dan berkurangnya tingkat stres yang akan meningkatkan peluang fertilitas secara keseluruhan.



**Gambar 4.1**  
**Senam Aerobic Sebagai Olahraga Prakonsepsi**

Namun demikian, dalam melakukan aktivitas fisik prakonsepsi, penting untuk diperhatikan bahwa intensitas dan durasi olahraga harus dilakukan secara seimbang. Olahraga dengan intensitas yang terlalu tinggi atau ekstrem justru memiliki efek yang merugikan terhadap kesehatan reproduksi. Aktivitas fisik yang terlalu intens seperti latihan beban berat secara berlebihan, maraton, atau olahraga kompetitif lainnya dalam frekuensi yang tinggi dapat menyebabkan stres fisik pada tubuh yang berujung pada gangguan hormonal dan gangguan siklus menstruasi pada wanita. Kondisi ini disebut dengan istilah "amenore atletik", yakni berhentinya menstruasi akibat stres fisik berlebihan, yang tentu saja menurunkan kesuburan secara signifikan.



Begitu pula pada pria, olahraga dengan intensitas tinggi yang dilakukan secara ekstrem dapat mempengaruhi kualitas sperma, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun motilitas (gerakan sperma). Stres fisik yang intens dapat meningkatkan suhu testis secara signifikan, yang tidak ideal bagi produksi sperma yang sehat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dalam intensitas aktivitas fisik sangatlah penting bagi pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk konsepsi.

Dengan demikian, calon pasangan perlu memahami pentingnya keseimbangan dalam melakukan aktivitas fisik. Idealnya, mereka dianjurkan untuk memilih olahraga ringan hingga sedang, dengan durasi sekitar 30 hingga 60 menit per hari, setidaknya 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Jenis aktivitas fisik ini cukup untuk memberikan manfaat maksimal dalam menjaga berat badan ideal, keseimbangan hormon, meningkatkan sirkulasi darah, sekaligus mencegah dampak negatif dari olahraga yang terlalu intens.

Sebagai upaya preventif, edukasi rutin tentang olahraga dan aktivitas fisik prakonsepsi ini perlu disampaikan oleh tenaga kesehatan profesional seperti dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lain yang berkompeten dalam bidang kesehatan reproduksi. Edukasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesadaran pasangan tentang manfaat olahraga untuk fertilitas, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam memilih jenis aktivitas fisik yang paling sesuai untuk kondisi masing-masing individu, sehingga pasangan bisa mempersiapkan tubuh mereka dengan baik untuk konsepsi yang sehat dan optimal.

#### **E. Tren: Pemeriksaan Genetik Pra-kehamilan (*Genetic Screening*)**

Dalam beberapa tahun terakhir, pemeriksaan genetik prakonsepsi atau genetic screening telah berkembang secara pesat dan semakin populer, terutama di kalangan pasangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan atau merencanakan kehamilan. Pemeriksaan ini tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif atau terbatas pada kalangan tertentu saja, melainkan kini telah menjadi bagian dari persiapan prakonsepsi yang semakin dianjurkan oleh tenaga kesehatan profesional. Popularitas ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengetahui lebih dini berbagai risiko genetik yang mungkin dapat diturunkan kepada keturunan, serta kemajuan teknologi kedokteran yang memungkinkan deteksi berbagai kondisi genetik secara lebih akurat, cepat, dan terjangkau.

Pemeriksaan genetik prakonsepsi dilakukan dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi apakah calon orang tua membawa mutasi genetik tertentu yang dapat meningkatkan risiko penyakit atau kelainan genetik pada keturunan mereka. Kelainan-kelainan tersebut dapat berupa kelainan darah seperti thalassemia, kelainan metabolik seperti cystic fibrosis, gangguan pembekuan darah seperti hemofilia, ataupun kelainan kromosom seperti Down syndrome. Identifikasi dini terhadap kelainan genetik ini sangat penting, karena dengan mengetahui lebih awal, pasangan memiliki kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, matang, dan bijaksana mengenai kehamilan mereka.

Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan mengambil sampel darah atau jaringan dari calon pasangan yang akan dianalisis lebih lanjut di laboratorium untuk mencari kemungkinan mutasi genetik tertentu. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pasangan akan mengetahui apakah mereka merupakan carrier atau pembawa gen tertentu yang dapat meningkatkan risiko kelainan genetik pada anak. Hasil pemeriksaan ini memberikan kesempatan penting bagi pasangan untuk merencanakan kehamilan mereka dengan lebih baik dan lebih teliti. Mereka bisa berdiskusi bersama dengan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis genetika atau konselor genetik mengenai pilihan preventif yang tersedia, seperti teknik fertilisasi tertentu, terapi khusus, ataupun tindakan lain yang dapat mengurangi risiko lahirnya anak dengan kelainan genetik tertentu.

Namun demikian, meskipun memiliki berbagai manfaat penting, pemeriksaan genetik prakonsepsi juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan secara serius oleh calon pasangan maupun tenaga kesehatan yang memberikan pendampingan. Salah satu tantangan tersebut adalah dampak psikologis yang mungkin timbul setelah pasangan mengetahui hasil pemeriksaan genetik. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya risiko yang tinggi terhadap kelainan genetik tertentu, pasangan mungkin mengalami kecemasan, stres emosional, bahkan depresi yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka serta hubungan antar pasangan.

Selain dampak psikologis, ada pula dilema etis yang cukup rumit dalam mengambil keputusan mengenai kehamilan setelah mendapatkan hasil pemeriksaan genetik. Pasangan mungkin menghadapi situasi yang sulit, seperti apakah mereka tetap melanjutkan kehamilan dengan risiko kelainan genetik yang tinggi, ataukah mengambil langkah preventif seperti fertilisasi in vitro dengan seleksi embrio atau

bahkan mempertimbangkan opsi lain yang mungkin tidak mudah secara emosional. Oleh karena itu, konseling genetik menjadi komponen penting yang harus diberikan bersama pemeriksaan genetik prakonsepsi. Konseling ini dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang kompeten di bidang genetika, bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, mendukung secara emosional, serta membantu pasangan mengambil keputusan yang paling tepat dan nyaman bagi mereka berdasarkan kondisi masing-masing individu dan keluarga.

Pentingnya pendampingan psikologis yang diberikan oleh tenaga kesehatan profesional selama proses ini tidak boleh diremehkan. Pasangan harus merasa didukung dan didampingi dengan penuh empati sehingga mereka dapat menerima informasi tersebut dengan lebih tenang dan bijaksana. Tenaga kesehatan memiliki peran vital untuk menjelaskan secara rinci apa arti dari hasil pemeriksaan tersebut, serta menawarkan berbagai opsi tindakan yang dapat diambil oleh pasangan berdasarkan kondisi spesifik mereka. Dengan cara ini, pasangan akan merasa lebih siap dan mampu mengambil keputusan terbaik dengan penuh rasa percaya diri dan tanpa tekanan yang berlebihan.

Dalam keseluruhan prosesnya, pemeriksaan genetik prakonsepsi harus dipahami sebagai sebuah kesempatan berharga bagi calon orang tua untuk meningkatkan kualitas perencanaan kehamilan mereka. Meski membawa tantangan psikologis dan etis yang perlu dipertimbangkan secara matang, pemeriksaan ini tetap menjadi langkah preventif yang sangat penting guna meminimalkan risiko kelainan genetik pada keturunan. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi genetika yang semakin pesat, pemeriksaan ini diyakini akan terus berkembang dan semakin menjadi bagian integral dalam persiapan kehamilan, demi menciptakan generasi penerus yang lebih sehat, berkualitas, dan sejahtera.

## **F. Isu: Rendahnya Kesadaran Pemeriksaan Kesehatan Sebelum Konsepsi**

Salah satu tantangan utama yang masih menjadi perhatian serius dalam konteks persiapan prakonsepsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi atau pembuahan terjadi. Fenomena ini terjadi karena adanya persepsi yang keliru di tengah masyarakat, yang menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan prakonsepsi baru diperlukan apabila pasangan mengalami kesulitan memiliki anak atau setelah munculnya komplikasi tertentu dalam masa kehamilan. Akibatnya, sebagian besar pasangan masih belum menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai prioritas dalam perencanaan keluarga dan kehamilan mereka.

Padahal, pemeriksaan prakonsepsi merupakan langkah preventif yang memiliki dampak besar dalam mencegah berbagai risiko komplikasi kehamilan, gangguan fertilitas, dan bahkan risiko kelainan bawaan pada janin yang dikandung nantinya.

Rendahnya kesadaran ini secara khusus disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain kurangnya edukasi mengenai manfaat pemeriksaan prakonsepsi di kalangan pasangan muda maupun masyarakat secara umum. Informasi yang terbatas atau tidak tepat membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi dapat mengidentifikasi sejak dini berbagai kondisi yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan janin, seperti penyakit kronis (diabetes, hipertensi, gangguan tiroid), infeksi menular seksual (IMS), serta gangguan hormonal yang mempengaruhi fertilitas. Persepsi bahwa pemeriksaan kesehatan baru relevan setelah adanya gejala atau masalah tertentu menciptakan kondisi di mana pasangan cenderung menunggu hingga terjadi komplikasi, yang pada akhirnya memperkecil peluang untuk melakukan tindakan preventif yang efektif.

Selain itu, faktor budaya dan tradisi tertentu yang masih kuat di beberapa daerah turut berkontribusi pada rendahnya kesadaran ini. Di banyak komunitas, pembahasan mengenai kesehatan reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi, masih dianggap tabu atau tidak penting. Banyak pasangan merasa malu, segan, atau bahkan takut dianggap memiliki masalah kesuburan jika mereka melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum hamil, yang pada akhirnya mengurangi motivasi pasangan untuk mencari informasi yang lebih akurat mengenai manfaat pemeriksaan prakonsepsi. Ditambah lagi dengan akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, kondisi ini semakin memperparah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi.

Untuk mengatasi isu rendahnya kesadaran ini, diperlukan upaya yang terintegrasi, komprehensif, dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan prakonsepsi secara intensif dan masif. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga penyuluh kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan informasi akurat, jelas, dan berbasis bukti tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi kepada masyarakat. Edukasi ini perlu disampaikan secara rutin melalui berbagai bentuk media yang mudah dijangkau oleh

masyarakat, seperti media sosial yang kini menjadi platform paling efektif untuk menjangkau pasangan muda, seminar kesehatan, talkshow, serta konseling pranikah yang diberikan secara langsung kepada pasangan yang akan menikah.

Di samping itu, materi edukasi yang diberikan juga harus dikemas secara menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Informasi ini sebaiknya tidak hanya terbatas pada manfaat pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, tetapi juga menjelaskan secara rinci jenis pemeriksaan yang perlu dilakukan, manfaatnya dalam mencegah risiko komplikasi, serta langkah-langkah praktis yang perlu dilakukan oleh pasangan dalam mempersiapkan konsepsi yang sehat. Pendekatan yang ramah, empati, serta sensitif terhadap budaya lokal akan sangat membantu masyarakat menerima informasi dengan lebih positif dan bersedia menerapkan langkah-langkah preventif tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Selain edukasi oleh tenaga kesehatan, peran aktif pemerintah juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap pemeriksaan prakonsepsi. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang lebih mendukung akses pemeriksaan kesehatan prakonsepsi yang terjangkau dan tersedia secara luas, khususnya di daerah terpencil atau pedesaan. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperkuat infrastruktur pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik desa yang menyediakan layanan pemeriksaan prakonsepsi, serta mengadakan program-program khusus seperti pemeriksaan kesehatan gratis atau subsidi bagi pasangan yang melakukan pemeriksaan prakonsepsi.

Kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi pendidikan, serta komunitas lokal juga sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan jangkauan dan dampak edukasi kesehatan prakonsepsi ini. Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta gerakan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi. Hasil akhirnya, pasangan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat besar pemeriksaan prakonsepsi, sehingga mampu secara proaktif mencegah risiko komplikasi kehamilan dan memastikan kondisi kesehatan yang optimal untuk menyambut kehamilan yang sehat, aman, serta berkualitas di masa depan.

## **G. Latihan Soal**

### **Tugas 1: Studi Kasus Pemeriksaan Kesehatan Prakonsepsi**

Mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara mendalam dengan minimal satu pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Dalam wawancara ini, mahasiswa menggali informasi apakah pasangan tersebut telah melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi yang komprehensif. Mahasiswa harus mengidentifikasi apa saja pemeriksaan yang telah atau belum dilakukan, memahami alasan pasangan dalam melakukan atau tidak melakukan pemeriksaan, serta menjelaskan dampak yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Hasil wawancara dikemas dalam bentuk laporan tertulis lengkap yang disertai analisis kritis berdasarkan teori yang dipelajari dalam materi.

### **Tugas 2: Penyusunan Rencana Edukasi Imunisasi dan Suplementasi Vitamin Prakonsepsi**

Mahasiswa diminta untuk menyusun rencana edukasi yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan (bidan/dokter) terkait pentingnya imunisasi prakonsepsi (Rubella, Hepatitis B, dan Tetanus) serta suplementasi vitamin (Asam folat dan Zat besi). Rencana ini harus mencakup materi edukasi secara rinci, metode edukasi yang dipilih (seminar, diskusi kelompok, konseling pribadi, media sosial), media yang digunakan (brosur, infografis, video edukatif), serta evaluasi efektivitas kegiatan edukasi yang dirancang. Mahasiswa wajib menjelaskan alasan pemilihan metode dan media berdasarkan target sasaran (calon pasangan usia reproduktif).

### **Tugas 3: Pembuatan Menu Nutrisi Optimal untuk Fertilitas**

Mahasiswa diminta untuk menyusun menu makanan selama satu minggu untuk pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Menu tersebut harus memenuhi standar nutrisi optimal yang mendukung fertilitas seperti kandungan antioksidan (vitamin C, E, selenium, seng), asam folat, omega-3, dan protein berkualitas tinggi. Mahasiswa harus menjelaskan secara terperinci manfaat dari masing-masing jenis makanan yang dipilih dan alasan mengapa makanan tertentu dihindari (misalnya alkohol, kafein berlebihan, rokok, gula, dan lemak jenuh). Hasil tugas berupa menu mingguan lengkap dengan penjelasan rasionalnya.

### **Tugas 4: Program Aktivitas Fisik dan Olahraga untuk Pasangan Prakonsepsi**

Mahasiswa diminta menyusun panduan lengkap aktivitas fisik atau olahraga yang ideal untuk pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Panduan ini mencakup rekomendasi jenis olahraga (jalan cepat, yoga, pilates, berenang, bersepeda ringan), durasi olahraga per hari, intensitas yang dianjurkan, serta hal-hal yang perlu dihindari (olahraga intensitas tinggi/ekstrem). Mahasiswa juga diminta membuat penjelasan tentang manfaat dari masing-masing jenis aktivitas fisik terhadap fertilitas, serta potensi dampak negatif jika tidak mematuhi rekomendasi yang diberikan.

## **Tugas 5: Analisis Tren Pemeriksaan Genetik dan Solusi untuk Rendahnya Kesadaran Masyarakat**

Mahasiswa diminta melakukan studi literatur tentang tren pemeriksaan genetik prakonsepsi (genetic screening) serta isu rendahnya kesadaran pemeriksaan kesehatan prakonsepsi di Indonesia. Mahasiswa kemudian diminta menyusun sebuah analisis yang mencakup identifikasi tren tersebut, manfaat dan tantangan pemeriksaan genetik, serta penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi. Di bagian akhir, mahasiswa wajib merancang sebuah rencana aksi konkrit berupa strategi edukasi terpadu melalui kolaborasi pemerintah, lembaga kesehatan, komunitas lokal, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pasangan muda mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan prakonsepsi dan pemeriksaan genetik secara efektif.

Melalui kelima tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara mendalam sekaligus mengimplementasikan pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan prakonsepsi, imunisasi dan suplementasi, nutrisi optimal, aktivitas fisik prakonsepsi, pemeriksaan genetik, serta upaya mengatasi isu rendahnya kesadaran masyarakat dalam persiapan kehamilan yang sehat dan optimal.

### **Pilihan Ganda**

1. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik bersama suaminya dengan tujuan melakukan pemeriksaan kesehatan prakonsepsi. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 150/95 mmHg dan berat badan 78 kg dengan tinggi badan 160 cm. Pemeriksaan darah menunjukkan kadar gula darah sewaktu 220 mg/dL.  
Apa langkah yang paling tepat dilakukan bidan?
  - A. Merujuk ke dokter spesialis kebidanan untuk langsung program hamil.
  - B. Menyarankan segera kehamilan karena usia optimal untuk hamil.
  - C. Melakukan terapi antihipertensi dan antidiabetes sendiri tanpa rujukan.
  - D. Memberikan suplementasi zat besi dan asam folat secara rutin tanpa intervensi lain.
  - E. Memberikan edukasi tentang pola hidup sehat, menurunkan berat badan, dan konsultasi ke dokter spesialis.
2. Pasangan suami-istri berusia 30 tahun berencana memiliki anak pertama. Mereka melakukan pemeriksaan darah lengkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa istri memiliki golongan darah O dengan rhesus negatif, sementara suami golongan darah AB rhesus positif.

- Apakah kemungkinan komplikasi yang perlu diwaspadai pada kehamilan nanti?
- A. Diabetes gestasional
  - B. Preeklamsia berat
  - C. Anemia defisiensi besi
  - D. Infeksi Hepatitis B
  - E. Ketidakcocokan rhesus (Rh incompatibility)
3. Seorang calon ibu berusia 26 tahun datang untuk konsultasi prakonsepsi. Ia belum pernah menerima imunisasi apapun selama dewasa. Imunisasi apa yang wajib diberikan sebelum ia hamil?
- A. Influenza, varisela, polio
  - B. Rubella, hepatitis B, tetanus
  - C. Difteri, pertusis, tifoid
  - D. MMR, HPV, meningitis
  - E. Pneumokokus, rotavirus, malaria
4. Seorang wanita usia 27 tahun datang ke klinik untuk pemeriksaan prakonsepsi. Ia memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, berat badan berlebih, serta wajah berjerawat dan tumbuh rambut di wajah yang berlebihan (hirsutisme). Pemeriksaan hormonal apakah yang paling relevan dilakukan?
- A. Tes fungsi tiroid
  - B. Pemeriksaan hormon prolactin
  - C. Pemeriksaan hormon insulin dan glukosa
  - D. Pemeriksaan hormon reproduksi (FSH, LH, estrogen, testosteron)
  - E. Tes hormon pertumbuhan (GH)
5. Pasangan usia 32 tahun melakukan pemeriksaan prakonsepsi. Hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa istri positif hepatitis B. Langkah penting apa yang harus segera dilakukan terkait temuan ini dalam persiapan kehamilan?
- A. Menghentikan rencana kehamilan
  - B. Menggunakan metode fertilisasi in vitro
  - C. Pemberian imunisasi hepatitis B pada calon ayah dan edukasi mengenai pencegahan penularan pada janin
  - D. Mengonsumsi obat antivirus tanpa pengawasan
  - E. Melakukan diet ketat untuk menghilangkan virus hepatitis B secara alami

### Kunci Jawaban



1. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Tekanan darah tinggi (hipertensi) dan gula darah tinggi (diabetes) yang ditemukan pada pemeriksaan prakonsepsi merupakan risiko tinggi komplikasi kehamilan seperti preeklamsia dan diabetes gestasional. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah memberikan edukasi pola hidup sehat terlebih dahulu, menurunkan berat badan, dan merujuk untuk konsultasi ke dokter spesialis agar kondisi tersebut dapat terkontrol optimal sebelum kehamilan terjadi.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Perbedaan rhesus antara ibu (negatif) dan janin (positif) dapat menyebabkan komplikasi berupa ketidakcocokan rhesus (Rh incompatibility). Kondisi ini bisa memicu pembentukan antibodi dalam tubuh ibu yang menyerang janin pada kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, pasangan ini perlu pemantauan dan profilaksis khusus selama kehamilan.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Imunisasi yang direkomendasikan secara khusus untuk wanita usia reproduktif sebelum kehamilan adalah rubella, hepatitis B, dan tetanus. Rubella mencegah kecacatan janin, hepatitis B mencegah penularan infeksi ke janin saat persalinan, dan tetanus melindungi ibu serta bayi dari risiko infeksi pada saat persalinan.

4. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Gejala menstruasi tidak teratur, berat badan berlebih, hirsutisme, dan jerawat menunjukkan kemungkinan PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome). PCOS dikonfirmasi dengan pemeriksaan hormonal berupa FSH, LH, estrogen, dan testosteron untuk melihat adanya ketidakseimbangan hormon yang mengganggu ovulasi.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Jika calon ibu positif hepatitis B, langkah penting berikutnya adalah memastikan pasangan (calon ayah) telah diimunisasi agar tidak tertular. Selain itu, ibu harus mendapatkan edukasi mengenai cara pencegahan penularan infeksi ini kepada janin selama kehamilan dan persalinan. Dengan demikian, risiko infeksi hepatitis B pada bayi dapat dikurangi secara signifikan.

## H. Rangkuman Materi

Pemeriksaan kesehatan prakonsepsi adalah langkah strategis yang penting bagi pasangan yang merencanakan kehamilan untuk menilai kesehatan calon orang tua sebelum terjadinya konsepsi. Melalui pemeriksaan ini, pasangan dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing, mulai dari pemeriksaan fisik umum seperti tekanan darah, detak jantung, hingga berat badan, guna mendeteksi dini kondisi yang berisiko tinggi terhadap kehamilan seperti hipertensi atau obesitas. Pemeriksaan darah juga dilakukan secara komprehensif, termasuk pengukuran gula darah, kadar hemoglobin, serta penentuan golongan darah dan rhesus. Hal ini bertujuan untuk menghindari komplikasi seperti diabetes gestasional, preeklamsia, anemia, atau ketidakcocokan rhesus antara ibu dan janin yang dapat membahayakan kehamilan. Pemeriksaan hormonal menjadi bagian integral dari screening ini untuk mendeteksi gangguan hormon seperti PCOS atau gangguan tiroid yang mempengaruhi kesuburan pasangan. Skrining infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, hepatitis B, sifilis, dan gonore juga sangat penting dilakukan karena infeksi tersebut berpotensi mempengaruhi kesuburan dan kesehatan janin nantinya. Secara keseluruhan, pemeriksaan ini adalah investasi jangka panjang yang berperan besar dalam memastikan kesiapan fisik dan kesehatan reproduksi pasangan, sekaligus membantu mereka mengambil tindakan preventif maupun terapi dini sebelum menjalani kehamilan.

Selain pemeriksaan kesehatan, imunisasi dan suplementasi vitamin dalam masa prakonsepsi juga memiliki peran krusial. Imunisasi rubella, hepatitis B, dan tetanus direkomendasikan sebelum kehamilan guna melindungi ibu dan janin dari risiko infeksi yang dapat menimbulkan kecacatan atau komplikasi serius saat kehamilan dan persalinan. Suplementasi vitamin, khususnya asam folat dan zat besi, merupakan langkah preventif penting untuk menghindari kelainan tabung saraf janin serta anemia pada ibu hamil. Dengan imunisasi dan suplementasi vitamin yang tepat, calon ibu akan memiliki kondisi kesehatan yang optimal, sehingga dapat meminimalkan risiko komplikasi selama kehamilan.

Dalam mempersiapkan kehamilan, nutrisi optimal menjadi elemen esensial untuk mendukung fertilitas pasangan. Diet yang kaya akan antioksidan, vitamin C dan E, selenium, seng, asam folat, omega-3, dan protein berkualitas tinggi akan meningkatkan kesehatan reproduksi serta menciptakan kondisi tubuh yang ideal untuk konsepsi. Pasangan juga disarankan untuk menghindari makanan dan minuman yang dapat menurunkan kesuburan, seperti alkohol, kafein berlebihan,

rokok, serta makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Edukasi mengenai pola makan sehat perlu terus disosialisasikan secara rutin oleh tenaga kesehatan demi tercapainya kehamilan yang sehat dan optimal.

Aktivitas fisik dan olahraga yang rutin dan seimbang juga sangat dianjurkan dalam masa persiapan prakonsepsi. Olahraga ringan hingga sedang, seperti jalan cepat, yoga, pilates, berenang, dan bersepeda ringan membantu pasangan menjaga berat badan ideal, meningkatkan keseimbangan hormonal, serta memperbaiki sirkulasi darah ke organ reproduksi, yang semuanya penting untuk fertilitas. Namun, olahraga dengan intensitas tinggi atau ekstrem harus dihindari karena justru dapat berdampak negatif terhadap kesuburan, mengganggu siklus menstruasi, serta menurunkan kualitas sperma.

Tren pemeriksaan genetik sebelum kehamilan kini semakin berkembang dan menjadi bagian integral dalam persiapan konsepsi. Pemeriksaan genetik bertujuan mendeteksi adanya risiko penyakit atau kelainan genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, hemofilia, dan Down syndrome. Meski memiliki manfaat besar, pemeriksaan ini membawa tantangan psikologis dan dilema etis tersendiri bagi pasangan. Oleh karena itu, konseling genetik secara mendalam oleh tenaga kesehatan sangat diperlukan agar pasangan dapat membuat keputusan secara matang dan terinformasi dengan baik.

Namun, masih terdapat isu rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum konsepsi. Kurangnya edukasi, persepsi keliru, faktor budaya, serta terbatasnya akses pelayanan kesehatan menjadi penyebab rendahnya kesadaran ini. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan edukasi intensif yang melibatkan tenaga kesehatan, pemerintah, dan komunitas lokal melalui berbagai media, seperti media sosial dan seminar kesehatan. Strategi kolaborasi antar lembaga juga perlu dilakukan agar edukasi ini efektif dan menjangkau lebih banyak pasangan, sehingga mereka dapat memahami manfaat besar dari pemeriksaan prakonsepsi untuk mencapai kehamilan yang sehat, aman, dan berkualitas di masa depan.

## I. Glosarium

### **Amenore Atletik**

Kondisi berhentinya menstruasi akibat stres fisik yang tinggi, umumnya dialami wanita yang melakukan aktivitas fisik atau olahraga ekstrem.

### **Anemia**

Kondisi medis akibat kurangnya sel darah merah atau hemoglobin, menyebabkan kelelahan, pucat, dan pusing.

### **Antibodi**

Protein dalam tubuh yang berfungsi melawan infeksi atau penyakit.

### **Antioksidan**

Zat yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, contohnya vitamin C, vitamin E, selenium, dan seng.

### **Asam Folat**

Vitamin B kompleks yang penting untuk perkembangan janin, khususnya dalam mencegah kelainan tabung saraf seperti spina bifida.

### **Diabetes Gestasional**

Diabetes yang muncul pertama kali saat kehamilan, ditandai dengan peningkatan kadar gula darah.

### **Gangguan Hormonal**

Ketidakseimbangan hormon dalam tubuh yang memengaruhi kesuburan dan siklus reproduksi.

### **Genetic Screening (Pemeriksaan Genetik)**

Pemeriksaan medis untuk mendeteksi risiko kelainan genetik pada calon keturunan sebelum konsepsi terjadi.

### **Golongan Darah dan Rhesus**

Klasifikasi darah berdasarkan antigen tertentu, di mana ketidakcocokan antara ibu dan janin dapat menimbulkan komplikasi kehamilan.

### **Hepatitis B**

Infeksi virus serius yang menyerang hati, dapat ditularkan dari ibu ke janin saat persalinan jika tidak diimunisasi.

### **Hipertensi**

Kondisi tekanan darah tinggi yang berisiko menyebabkan komplikasi serius selama kehamilan seperti preeklamsia.

### **Imunisasi Prakonsepsi**

Vaksinasi yang diberikan sebelum kehamilan, seperti rubella, hepatitis B, dan tetanus, untuk melindungi ibu dan janin dari infeksi serius.

**Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, seperti HIV/AIDS, hepatitis B, sifilis, dan gonore.

**Kesehatan Prakonsepsi**

Upaya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum pasangan merencanakan kehamilan untuk menghindari komplikasi selama masa kehamilan.

**Konseling Genetik**

Proses diskusi antara tenaga kesehatan dan pasangan mengenai hasil pemeriksaan genetik untuk mengambil keputusan terkait risiko genetik.

**Neural Tube Defects**

Kelainan bawaan akibat gangguan pada penutupan tabung saraf janin, contohnya spina bifida.

**Nutrisi Optimal**

Pola makan sehat yang mencakup asupan antioksidan, asam folat, omega-3, protein berkualitas tinggi untuk meningkatkan fertilitas.

**Obesitas**

Kondisi kelebihan berat badan secara signifikan yang dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan.

**Omega-3**

Asam lemak sehat yang membantu menjaga keseimbangan hormonal, meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi, serta kualitas sperma dan sel telur.

**Ovarium Polikistik (PCOS)**

Kondisi hormonal pada wanita yang menyebabkan gangguan ovulasi, ditandai dengan siklus menstruasi tidak teratur dan gejala hirsutisme.

**Preeklamsia**

Komplikasi kehamilan ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam urin, yang bisa menyebabkan kerusakan organ dan kelahiran prematur.

**Radikal Bebas**

Molekul tidak stabil yang dapat merusak sel tubuh termasuk DNA sel reproduksi, berdampak negatif pada kesuburan.

**Skrining Kesehatan**

Proses pemeriksaan kesehatan awal untuk mengidentifikasi potensi risiko kesehatan sebelum kehamilan terjadi.

**Spina Bifida**

Kelainan bawaan akibat tidak sempurnanya penutupan tulang belakang janin, dapat menyebabkan kelumpuhan sebagian atau gangguan perkembangan lainnya.

### **Suplementasi Vitamin**

Penambahan vitamin seperti asam folat dan zat besi yang dianjurkan sebelum konsepsi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan janin.

### **Tetanus**

Infeksi bakteri serius yang menyebabkan kejang otot, berisiko terjadi pada ibu dan bayi saat persalinan jika tidak divaksinasi sebelumnya.

### **Zat Besi**

Mineral esensial untuk produksi hemoglobin dalam sel darah merah, penting dalam pencegahan anemia selama kehamilan.

## **J. Daftar Pustaka**

- Departemen Kesehatan RI. (2020). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Prekonsepsi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Dorney, E., & Black, K. I. (2018). Preconception care. *Australian Journal of General Practice*, 47(7), 424–429. <https://doi.org/10.31128/AJGP-01-18-4473>
- Evenson, K. R., & Mottola, M. F. (2018). Physical activity guidelines for pregnant women: Current evidence and future directions. *Current Sports Medicine Reports*, 17(10), 308–318. <https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000510>
- Fleming, T. P., Watkins, A. J., Velazquez, M. A., Mathers, J. C., Prentice, A. M., Stephenson, J., Barker, M., ... & Hanson, M. A. (2018). Origins of lifetime health around the time of conception: Causes and consequences. *The Lancet*, 391(10132), 1842–1852. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30312-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30312-X)
- Frayne, D. J., Verbiest, S., Chelmow, D., Clarke, H., Dunlop, A., Hosmer, J., Menard, M. K., & Moos, M.-K. (2016). Health care system measures to advance preconception wellness. *Obstetrics & Gynecology*, 127(5), 863–872. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001379>
- Greenberg, J. A., Bell, S. J., Guan, Y., & Yu, Y. (2020). Folic Acid supplementation and pregnancy: More than just neural tube defect prevention. *Reviews in Obstetrics & Gynecology*, 13(3), 233–241.
- Hanson, M., Barker, M., Dodd, J. M., Kumanyika, S., Norris, S., Steegers, E., Stephenson, J., & Thangaratinam, S. (2017). Interventions to prevent maternal obesity before conception, during pregnancy, and post-partum. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 5(1), 65–76. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(16\)30108-5](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(16)30108-5)
- Homan, G. F., Davies, M., & Norman, R. (2007). The impact of lifestyle factors on reproductive performance in the general population and those undergoing infertility treatment: A review. *Human Reproduction Update*, 13(3), 209–223. <https://doi.org/10.1093/humupd/dml056>
- Johnson, K., Posner, S. F., Biermann, J., Cordero, J. F., Atrash, H. K., Parker, C. S., ... & Curtis, M. G. (2006). Recommendations to improve preconception health and health care—United States. *Morbidity and Mortality Weekly Report: Recommendations and Reports*, 55(RR-6), 1–23.

- Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2015). Optimizing natural fertility: A committee opinion. *Fertility and Sterility*, 103(3), e18–e25. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.12.128>
- Stephenson, J., Heslehurst, N., Hall, J., Schoenaker, D. A., Hutchinson, J., Cade, J. E., Poston, L., ... & Mishra, G. D. (2018). Before the beginning: Nutrition and lifestyle in the preconception period and its importance for future health. *The Lancet*, 391(10132), 1830–1841. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30311-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30311-8)
- The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2019). ACOG Committee Opinion No. 762: Prepregnancy counseling. *Obstetrics & Gynecology*, 133(1), e78–e89. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003013>
- World Health Organization. (2013). Meeting to develop a global consensus on preconception care to reduce maternal and childhood mortality and morbidity. WHO Headquarters.
- World Health Organization. (2020). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO Press.
- Yao, R., & Goetzinger, K. R. (2016). Genetic carrier screening in the twenty-first century. *Clinics in Laboratory Medicine*, 36(2), 277–288. <https://doi.org/10.1016/j.cll.2016.01.003>

# Bab 5

## Persiapan Psikologis dan Emosional dalam Pranikah dan Prakonsepsi

Persiapan pranikah dan prakonsepsi tidak hanya melibatkan kesiapan fisik dan finansial, tetapi juga sangat membutuhkan kesiapan psikologis dan emosional. Aspek ini sering kali terabaikan meskipun sangat penting, mengingat kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak merupakan tahapan hidup yang penuh tantangan dan dinamika emosional. Persiapan psikologis yang baik akan membantu pasangan mengelola ekspektasi dan stres, serta menjalani masa kehamilan dan pengasuhan anak dengan lebih optimal.

### **Capaian Pembelajaran (CPL)**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami konsep kesiapan psikologis dan emosional dalam konteks pranikah dan prakonsepsi, serta mampu menerapkannya untuk membantu pasangan dalam persiapan kehamilan yang sehat secara mental dan emosional.

### **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Mahasiswa mampu menganalisis aspek psikologis dan emosional yang penting dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi, serta mampu mengaplikasikan strategi pengelolaan stres, ekspektasi, dan pendekatan mindfulness untuk mendukung kesehatan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi proses kehamilan dan pengasuhan anak.

### **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

- Mahasiswa mampu menjelaskan kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehamilan dan peran sebagai orang tua secara komprehensif.
- Mahasiswa mampu menerapkan teknik manajemen stres prakonsepsi secara efektif.
- Mahasiswa mampu menganalisis dan mengelola ekspektasi pasangan terkait kehamilan dan pengasuhan anak.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi isu kecemasan terkait fertilitas dan kehamilan serta memberikan solusi praktis berbasis bukti untuk mengatasi kecemasan tersebut.



## **A. Kesiapan Mental Pasangan dalam Menghadapi Kehamilan dan Peran sebagai Orang Tua**

Kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehamilan dan peran sebagai orang tua adalah aspek penting yang membutuhkan perhatian serius, namun sering kali terlupakan dalam persiapan pranikah maupun prakonsepsi. Menjadi orang tua bukan hanya soal kemampuan fisik atau biologis untuk memiliki keturunan, tetapi melibatkan kesiapan emosional yang mendalam serta kesiapan mental untuk menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Persiapan mental yang matang akan membantu pasangan untuk tidak hanya menikmati momen-momen bahagia selama kehamilan tetapi juga menghadapi berbagai dinamika emosional yang sering muncul seiring perkembangan kehamilan dan lahirnya seorang anak.

Pasangan yang tengah mempersiapkan kehamilan perlu memahami bahwa peran sebagai orang tua membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan peran mereka sebelumnya. Hal ini mencakup tanggung jawab emosional, fisik, hingga finansial yang harus dihadapi secara bersama-sama. Sering kali, pasangan menganggap bahwa menjadi orang tua adalah sebuah proses alami yang akan berjalan dengan sendirinya tanpa perlu persiapan khusus. Anggapan ini berisiko menimbulkan perasaan kaget dan stres ketika menghadapi situasi-situasi baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya.

Kesiapan mental pasangan mencakup kesadaran tentang berbagai perubahan gaya hidup yang pasti akan terjadi. Misalnya, perubahan pola tidur yang signifikan karena kebutuhan bayi baru lahir yang membutuhkan perhatian hampir setiap waktu. Pasangan juga harus menyadari bahwa dinamika hubungan mereka akan mengalami perubahan drastis, dimana waktu berdua menjadi sangat terbatas karena perhatian dan energi mereka kini terbagi dengan hadirnya anak. Hal ini bisa memicu perasaan terasing, frustrasi, bahkan konflik jika pasangan tidak memiliki persiapan mental yang baik sejak awal.

Selain perubahan pola hidup, kesiapan mental juga mencakup kesiapan menghadapi berbagai jenis tekanan psikologis baru. Tekanan ini bisa datang dari internal pasangan itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga besar yang mungkin memiliki harapan dan standar tersendiri tentang bagaimana seharusnya pasangan tersebut menjalani kehamilan dan pengasuhan anak. Tanpa

kesiapan mental yang cukup, pasangan akan mudah merasa kewalahan, cemas, atau bahkan depresi akibat tekanan yang datang dari berbagai arah ini.

Oleh karena itu, komunikasi terbuka dan saling pengertian antar pasangan menjadi kunci utama dalam kesiapan mental ini. Dengan komunikasi terbuka, pasangan dapat secara jujur mengungkapkan ketakutan, harapan, serta ekspektasi masing-masing terkait kehamilan dan peran sebagai orang tua. Komunikasi ini menciptakan fondasi kuat bagi hubungan pasangan, sehingga mereka dapat lebih siap dan tangguh secara mental saat menghadapi tantangan-tantangan yang muncul.

Selain komunikasi, pasangan juga sebaiknya mencari edukasi atau pelatihan yang relevan tentang kehamilannya maupun pola pengasuhan yang positif. Edukasi ini bisa didapatkan melalui buku, seminar, konseling pranikah, maupun berbagai forum edukasi kesehatan reproduksi dan parenting yang kredibel. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, pasangan bisa lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi serta mampu mengelola emosinya secara lebih efektif dan sehat.

Dengan persiapan mental yang matang seperti ini, pasangan tidak hanya akan mampu menghadapi masa kehamilan dengan lebih tenang dan positif, tetapi juga bisa menjalani peran sebagai orang tua dengan penuh percaya diri, kebijaksanaan, serta kesiapan emosional yang tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak positif, tidak hanya terhadap hubungan antar pasangan tetapi juga terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkan kelak, menciptakan lingkungan yang sehat secara mental dan emosional bagi seluruh keluarga.

## **B. Manajemen Stres Prakonsepsi**

Manajemen stres prakonsepsi merupakan sebuah aspek krusial dalam persiapan pasangan yang tengah merencanakan kehamilan. Meskipun umumnya pasangan fokus pada kesiapan fisik dan finansial, kesiapan emosional berupa pengelolaan stres justru sering terabaikan. Padahal, stres yang tidak terkelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental, termasuk menurunkan potensi fertilitas pasangan. Hal ini menjadikan manajemen stres prakonsepsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian persiapan menuju kehamilan yang sehat.

Secara umum, stres prakonsepsi muncul dari berbagai tekanan, baik yang berasal dari internal pasangan itu sendiri maupun dari eksternal. Tekanan internal sering kali berupa kekhawatiran tentang kemampuan memiliki keturunan, kecemasan menghadapi proses kehamilan dan persalinan, serta rasa takut akan ketidaksiapan menjalankan peran baru sebagai orang tua. Sementara itu, tekanan eksternal biasanya berasal dari lingkungan sosial, termasuk harapan tinggi dari keluarga besar, tekanan dari teman sebaya yang sudah lebih dulu memiliki anak, serta berbagai norma sosial yang menuntut pasangan untuk segera memiliki keturunan setelah menikah. Semua tekanan ini secara akumulatif dapat menyebabkan stres yang cukup besar dan kompleks.

Pasangan harus mampu mengenali berbagai gejala stres prakonsepsi yang mungkin dialami. Gejala-gejala tersebut dapat mencakup gangguan tidur, kecemasan yang berlebihan atau terus-menerus, perasaan mudah marah atau tersinggung, serta perubahan pola makan, baik kehilangan nafsu makan maupun makan berlebihan sebagai kompensasi emosional. Gejala-gejala ini bukan sekadar gangguan sementara, tetapi merupakan sinyal bahwa tubuh dan pikiran pasangan sedang mengalami ketegangan yang harus segera diatasi agar tidak semakin memperburuk kondisi kesehatan secara menyeluruh.

Dalam mengelola stres prakonsepsi, pasangan perlu menerapkan strategi yang holistik dan efektif. Salah satu strategi paling populer dan terbukti secara ilmiah adalah aktivitas relaksasi yang dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi gejala stres yang muncul. Aktivitas relaksasi seperti yoga dan meditasi terbukti efektif karena membantu pasangan fokus pada kesadaran diri serta pernapasan yang dalam dan teratur, yang dapat menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Yoga, misalnya, tidak hanya meningkatkan fleksibilitas dan kesehatan fisik tetapi juga memberikan efek ketenangan emosional yang signifikan melalui gerakan-gerakan yang lambat dan terkontrol.

Selain yoga dan meditasi, olahraga teratur juga sangat dianjurkan sebagai metode manajemen stres prakonsepsi. Aktivitas fisik yang teratur seperti berjalan kaki, berlari ringan, atau berenang dapat merangsang produksi hormon endorfin, yang sering disebut hormon kebahagiaan, sehingga meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Pola tidur yang sehat juga merupakan faktor penting lainnya. Pasangan yang memiliki tidur cukup dan berkualitas cenderung lebih mampu mengelola stres dibandingkan mereka yang mengalami gangguan tidur kronis.

Oleh karena itu, menciptakan rutinitas tidur yang konsisten dan nyaman menjadi sangat esensial.

Konsultasi dengan profesional psikologi juga merupakan langkah penting dalam pengelolaan stres prakonsepsi, khususnya jika stres yang dirasakan sudah mulai mengganggu fungsi sehari-hari atau memicu konflik dalam hubungan pasangan. Konseling psikologi dapat membantu pasangan untuk mengeksplorasi sumber stres mereka, memberikan keterampilan koping yang efektif, serta membantu pasangan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik dalam menghadapi tekanan. Proses konseling ini juga memungkinkan pasangan untuk mendapatkan perspektif baru tentang berbagai tantangan yang mereka hadapi, sehingga mampu merespons situasi dengan lebih bijaksana dan terkendali.

Tidak kalah penting adalah dukungan emosional dari pasangan itu sendiri maupun keluarga dan lingkungan sosial yang positif. Pasangan perlu saling memberikan perhatian, pengertian, serta kesediaan mendengar dan mendiskusikan berbagai kecemasan yang dirasakan oleh masing-masing. Dukungan emosional seperti ini menciptakan rasa aman dan nyaman, yang secara langsung akan mengurangi intensitas stres yang dirasakan. Lingkungan keluarga yang suportif juga dapat berkontribusi positif terhadap pengurangan stres dengan memberikan dukungan psikologis, emosional, serta praktis dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, manajemen stres prakonsepsi bukanlah sekadar upaya sampingan, melainkan sebuah prioritas dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat dan harmonis. Pasangan yang mampu mengenali tanda-tanda stres, memahami sumbernya, serta menerapkan berbagai strategi efektif untuk mengelola stres, akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalani masa kehamilan dengan tenang, positif, dan penuh harapan. Hal ini pada akhirnya menciptakan fondasi mental dan emosional yang kuat bagi pasangan dalam menyambut kehadiran buah hati mereka dengan kebahagiaan serta kesiapan yang optimal.

### C. Pengelolaan Ekspektasi Pasangan terkait Kehamilan dan Pengasuhan Anak

Dalam proses persiapan pranikah dan prakonsepsi, salah satu aspek psikologis penting yang perlu diperhatikan pasangan adalah pengelolaan ekspektasi. Ekspektasi, atau harapan yang dimiliki pasangan mengenai kehamilan dan peran mereka sebagai orang tua, memainkan peran krusial dalam menentukan kualitas pengalaman emosional yang mereka alami sepanjang masa ini. Sayangnya, banyak pasangan memiliki gambaran yang tidak realistis tentang bagaimana proses kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak akan berlangsung. Gambaran ideal ini sering dibentuk oleh berbagai narasi populer, media sosial, pengalaman orang lain yang hanya menampilkan sisi positif, serta tekanan dari norma budaya yang berlaku.

Ketika realita yang dialami tidak sejalan dengan ekspektasi yang telah dibangun, pasangan berisiko mengalami rasa kecewa, frustrasi, stres, bahkan konflik yang berkelanjutan. Sebagai contoh, beberapa pasangan mungkin mengharapkan kehamilan berjalan lancar tanpa gangguan kesehatan, sementara kenyataannya kehamilan sering kali disertai berbagai kondisi tidak nyaman seperti mual, muntah, dan kelelahan ekstrem. Kondisi ini jika tidak diantisipasi sejak awal, dapat menyebabkan pasangan merasa gagal atau tidak mampu mengelola situasi secara baik. Demikian juga dengan ekspektasi tentang pengasuhan anak; banyak pasangan berharap bahwa setelah memiliki anak, kehidupan keluarga akan selalu dipenuhi momen-momen bahagia, tanpa menyadari bahwa proses pengasuhan anak juga dipenuhi tantangan seperti kurang tidur, kesulitan dalam mengatur waktu, hingga dinamika hubungan pasangan yang berubah secara signifikan.

Oleh sebab itu, pasangan perlu secara aktif berdiskusi mengenai harapan dan ekspektasi masing-masing secara terbuka dan jujur sejak awal, bahkan sebelum kehamilan terjadi. Dalam diskusi ini, pasangan harus mampu mengidentifikasi sejauh mana ekspektasi mereka bersifat realistis, atau sebaliknya, terlalu ideal dan tidak sesuai dengan kondisi nyata. Pasangan yang mampu menyadari potensi tantangan sejak dini akan lebih siap secara mental ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Diskusi mengenai ekspektasi ini tidak cukup hanya dilakukan sekali, melainkan harus menjadi bagian rutin dari komunikasi pasangan, terutama dalam masa-masa transisi penting seperti kehamilan, menjelang persalinan, dan awal pengasuhan anak.

Selain komunikasi yang terbuka antar pasangan, penting juga bagi mereka untuk mencari informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kehamilan dan pengasuhan anak. Dengan memiliki sumber informasi yang kredibel, pasangan bisa mendapatkan gambaran realistis tentang apa yang bisa mereka harapkan dalam perjalanan menuju peran baru sebagai orang tua. Informasi akurat akan membantu pasangan membuat keputusan yang lebih bijaksana serta membantu mereka mengantisipasi berbagai kemungkinan tantangan yang dapat muncul. Pasangan juga perlu belajar tentang variasi pengalaman yang mungkin terjadi pada setiap individu, sehingga mereka memahami bahwa pengalaman satu pasangan tidak selalu sama dengan pasangan lainnya.

Tidak kalah penting, pasangan perlu mempersiapkan berbagai skenario alternatif yang mungkin dihadapi dalam kehamilan dan pengasuhan anak. Persiapan skenario alternatif ini membantu pasangan mengembangkan fleksibilitas psikologis dalam menghadapi berbagai situasi tak terduga. Misalnya, jika pasangan mengharapkan kelahiran normal tetapi dihadapkan pada kemungkinan operasi caesar, persiapan mental dan emosional yang sudah dipikirkan sebelumnya akan membantu mereka menerima situasi tersebut dengan lebih tenang dan penuh penerimaan. Demikian juga dengan situasi lainnya, seperti kesulitan menyusui atau adanya kebutuhan khusus pada anak. Pasangan yang telah memikirkan berbagai kemungkinan situasi ini akan lebih mampu merespon secara adaptif dan positif.

Lebih jauh lagi, pengelolaan ekspektasi juga terkait erat dengan kemampuan pasangan dalam memberikan dukungan emosional satu sama lain. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, pasangan yang saling mendukung akan lebih mampu menjaga stabilitas emosional dan hubungan mereka. Dukungan emosional ini mencakup sikap saling pengertian, empati, serta penerimaan atas keterbatasan dan tantangan yang muncul. Pasangan yang mampu saling memberi dukungan ini akan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat, yang pada akhirnya membantu mereka menjalani masa kehamilan dan pengasuhan anak dengan rasa percaya diri yang tinggi.

Dalam konteks yang lebih luas, pengelolaan ekspektasi yang baik juga akan membantu pasangan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang sehat secara emosional. Ketika pasangan mampu menerima kenyataan dengan baik, mereka secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak-anak mereka tentang bagaimana menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan bijaksana dan penuh ketenangan. Pasangan yang secara aktif mengelola ekspektasi mereka juga

cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesehatan fisik dan emosional seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, pengelolaan ekspektasi dalam konteks kehamilan dan pengasuhan anak bukanlah sebuah hal yang boleh disepelekan. Sebaliknya, hal ini harus menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan psikologis pranikah dan prakonsepsi. Melalui komunikasi terbuka, informasi akurat, persiapan berbagai skenario alternatif, serta dukungan emosional yang kuat antar pasangan, ekspektasi yang realistis dapat dibangun. Ini memungkinkan pasangan untuk menjalani masa kehamilan dan pengasuhan anak dengan lebih optimal, penuh ketenangan, dan kebahagiaan yang sejati.

#### **D. Tren: Pendekatan *Mindfulness* dan *Wellness* dalam Persiapan Kehamilan**

Pendekatan mindfulness dan wellness kini semakin populer di kalangan pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk kehamilannya. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah suatu praktik yang mengajak individu untuk secara sadar dan penuh perhatian terhadap apa yang terjadi dalam diri dan sekitarnya, tanpa adanya penilaian atau penghakiman. Praktik ini bertujuan menciptakan ketenangan batin dan keseimbangan emosional dengan cara menerima segala perasaan, sensasi fisik, dan pikiran secara sadar pada momen sekarang. Dalam konteks pranikah dan prakonsepsi, mindfulness membantu pasangan menghadapi berbagai tekanan psikologis dengan lebih baik, seperti kecemasan tentang fertilitas, ketidakpastian proses kehamilannya, hingga kekhawatiran akan kemampuan mereka sebagai calon orang tua.

Aktivitas mindfulness yang paling sering diterapkan pasangan mencakup meditasi, latihan pernapasan dalam, refleksi harian, dan berbagai latihan yang menekankan kesadaran terhadap tubuh dan emosi. Meditasi, misalnya, adalah salah satu teknik mindfulness yang populer karena membantu pasangan untuk fokus pada pernapasan mereka sambil menenangkan pikiran dari berbagai gangguan eksternal. Praktik meditasi yang rutin terbukti secara ilmiah mampu menurunkan hormon stres, memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan konsentrasi, dan pada akhirnya menciptakan ketenangan emosional yang bermanfaat bagi kesehatan reproduksi. Latihan pernapasan dalam juga sering digunakan sebagai metode cepat untuk meredakan kecemasan atau stres yang tiba-tiba muncul, karena pernapasan yang teratur dan dalam mampu secara efektif menenangkan sistem saraf.

Di samping mindfulness, konsep wellness atau kesejahteraan holistik juga menjadi tren yang sangat relevan dalam persiapan kehamilan. Wellness bukan hanya tentang ketiadaan penyakit, melainkan tentang pencapaian kondisi kesehatan optimal secara fisik, mental, dan emosional yang saling terhubung secara erat. Dalam konteks prakonsepsi, wellness mendorong pasangan untuk memperhatikan berbagai aspek kehidupan yang dapat menunjang kesehatan reproduksi mereka secara menyeluruh. Hal ini mencakup pola makan yang sehat dan bergizi, aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, pola tidur yang cukup, hingga menjaga hubungan sosial yang positif dan suportif.

Pola makan sehat memainkan peran penting dalam wellness karena nutrisi yang cukup dan tepat sangat diperlukan dalam mendukung kesehatan reproduksi dan mental. Nutrisi yang seimbang membantu menjaga keseimbangan hormonal, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kemampuan fertilitas pasangan. Selain itu, olahraga rutin seperti yoga, pilates, atau latihan aerobik yang teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik tetapi juga secara signifikan meningkatkan mood, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Tidur yang berkualitas sendiri merupakan elemen penting dalam wellness, mengingat kurang tidur sering kali menjadi penyebab utama meningkatnya stres dan berbagai gangguan emosional yang dapat memengaruhi fertilitas secara negatif.

Kombinasi dari praktik mindfulness dan wellness ini menciptakan kondisi psikologis dan emosional yang lebih stabil dan kuat bagi pasangan. Mereka akan menjadi lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul sebelum maupun selama kehamilan. Selain itu, tren ini juga sejalan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental dalam konteks reproduksi, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian serius.

Namun, meskipun tren mindfulness dan wellness semakin populer, pasangan perlu menyadari bahwa praktik ini bukanlah solusi instan. Mindfulness dan wellness memerlukan konsistensi dan komitmen untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dukungan yang berkelanjutan dari pasangan itu sendiri maupun lingkungan sosial mereka. Sebagai tambahan, penting juga bagi pasangan untuk mengikuti panduan yang tepat dari tenaga profesional terlatih dalam bidang ini, seperti psikolog, konselor, atau pelatih mindfulness bersertifikasi, untuk memastikan bahwa pendekatan ini memberikan manfaat optimal bagi persiapan kehamilan mereka.



Dengan demikian, pendekatan mindfulness dan wellness dalam persiapan kehamilan menjadi bagian integral dari persiapan psikologis dan emosional pasangan di era modern ini. Pasangan yang secara aktif menerapkan pendekatan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah, hubungan yang lebih harmonis, serta kesiapan emosional yang lebih baik dalam menghadapi segala dinamika dan tantangan yang muncul selama proses prakonsepsi, kehamilan, hingga tahap pengasuhan anak.

### **E. Isu: Meningkatnya Angka Kecemasan Pasangan terkait Fertilitas dan Kehamilan**

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam angka kecemasan yang dialami pasangan, khususnya pasangan muda, terkait dengan fertilitas dan proses kehamilan. Fenomena ini mencerminkan adanya kekhawatiran yang mendalam, yang tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis pasangan tetapi juga dapat berimplikasi negatif terhadap kesehatan fisik dan hubungan interpersonal mereka. Kecemasan ini semakin nyata karena munculnya berbagai tekanan eksternal maupun internal yang dirasakan pasangan sejak awal pernikahan hingga menjelang kehamilan.

Salah satu penyebab utama kecemasan ini adalah tekanan sosial yang kuat agar pasangan segera memiliki anak setelah menikah. Di banyak budaya, memiliki anak masih dipandang sebagai tanda keberhasilan dalam berkeluarga. Kondisi ini memicu kecemasan yang cukup besar, terutama jika pasangan tersebut menghadapi kesulitan dalam merencanakan kehamilan atau belum berhasil memiliki keturunan dalam waktu yang dianggap ideal oleh masyarakat. Tekanan tersebut menjadi semakin nyata dengan ekspektasi tinggi yang datang dari keluarga, orang tua, dan lingkungan sosial terdekat. Akibatnya, pasangan merasa terjebak dalam situasi emosional yang penuh ketegangan, memicu kecemasan, rasa malu, atau bahkan perasaan bersalah jika kehamilan tidak segera terwujud.

Selain tekanan dari lingkungan sosial, kecemasan juga dipicu oleh eksposur terhadap informasi yang tidak akurat atau kurang kredibel yang banyak ditemukan di media sosial dan platform digital lainnya. Informasi-informasi tersebut sering kali menampilkan gambaran ideal yang tidak realistis tentang kehamilan atau kisah-kisah dramatis yang tidak representatif. Hal ini menyebabkan banyak pasangan mengalami ketakutan yang berlebihan mengenai potensi masalah fertilitas, risiko komplikasi kehamilan, atau tantangan dalam pengasuhan anak. Kondisi ini semakin

parah ketika pasangan tidak mendapatkan informasi yang tepat dari sumber terpercaya atau tidak mampu melakukan verifikasi atas informasi yang diterimanya, sehingga mereka terus terperangkap dalam lingkaran kekhawatiran yang tidak berdasar.

Jika tidak segera ditangani, kecemasan yang terus-menerus dan berlebihan ini dapat menciptakan konflik serius dalam hubungan pasangan. Hubungan yang tadinya harmonis bisa berubah menjadi penuh ketegangan akibat saling menyalahkan atau ketidakmampuan dalam mengelola tekanan emosional yang terus muncul. Selain itu, kecemasan kronis juga terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, seperti terganggunya siklus menstruasi pada wanita, gangguan kesuburan pada pria dan wanita, bahkan menurunnya kualitas hubungan seksual yang pada akhirnya memperberat kondisi sulit mendapatkan keturunan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Pertama-tama, pasangan perlu didorong untuk mendapatkan edukasi yang benar-benar ilmiah mengenai fertilitas dan kehamilan. Edukasi tersebut sebaiknya diberikan oleh tenaga profesional, seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bidan, psikolog, atau konselor pernikahan yang memiliki kredibilitas. Melalui edukasi yang tepat, pasangan akan memiliki pemahaman yang realistis mengenai berbagai aspek kehamilan, termasuk kondisi normal dan potensi tantangan yang mungkin muncul, sehingga kecemasan yang tidak berdasar dapat dikurangi secara signifikan.

Selain edukasi, konseling pranikah juga menjadi solusi penting dalam membantu pasangan mengelola kecemasan. Konseling yang profesional akan menciptakan ruang aman bagi pasangan untuk secara terbuka mengungkapkan ketakutan, kecemasan, dan harapan masing-masing. Dengan demikian, pasangan bisa saling memahami perspektif masing-masing dan menemukan solusi bersama. Diskusi terbuka ini akan membantu pasangan untuk menyusun strategi konkret dalam menghadapi berbagai skenario kehamilan maupun pengasuhan anak, serta memperkuat hubungan emosional dan komunikasi pasangan.

Lebih lanjut, membangun sistem dukungan sosial yang kuat juga terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan pasangan. Dukungan sosial ini bisa berasal dari keluarga terdekat, sahabat, komunitas sosial, atau bahkan kelompok dukungan yang khusus menangani isu fertilitas dan kehamilan. Berbagi pengalaman dengan pasangan lain yang mengalami hal serupa sering kali memberikan kelegaan

emosional, mengurangi rasa kesendirian, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan kehamilan.

Dengan pendekatan edukasi yang tepat, konseling profesional, serta dukungan sosial yang baik, pasangan bisa secara signifikan mengurangi tingkat kecemasan mereka. Akibatnya, mereka akan lebih siap secara emosional dalam menjalani proses prakonsepsi hingga masa kehamilan, serta mampu mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat dan harmonis. Hal ini menjadi dasar yang kokoh bagi terbentuknya lingkungan keluarga yang positif dan kondusif untuk perkembangan emosional dan fisik calon anak mereka di masa depan.

## F. Latihan Soal

### **Tugas 1: Wawancara tentang Kesiapan Mental Pasangan**

Mahasiswa diminta melakukan wawancara mendalam dengan satu pasangan yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang menanti kelahiran anak pertama. Dalam wawancara ini, mahasiswa harus:

- Mengidentifikasi tingkat kesiapan mental dan emosional pasangan.
- Menggali sejauh mana pasangan memahami tanggung jawab emosional, fisik, dan finansial terkait kehamilan dan menjadi orang tua.
- Mengidentifikasi apakah pasangan pernah mendapatkan edukasi formal atau informal mengenai kesiapan mental menghadapi kehamilan.
- Menanyakan bentuk komunikasi dan strategi pasangan dalam menghadapi tantangan emosional yang muncul selama persiapan kehamilan.

Mahasiswa wajib menuliskan hasil wawancara dalam laporan yang disertai analisis kritis berdasarkan teori kesiapan mental dalam materi kuliah.

### **Tugas 2: Penyusunan Program Manajemen Stres Prakonsepsi**

Mahasiswa diminta untuk membuat proposal program manajemen stres bagi pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Proposal harus mencakup:

- Penjelasan rinci mengenai pentingnya manajemen stres dalam persiapan prakonsepsi.
- Strategi praktis yang akan diterapkan (meditasi, yoga, olahraga rutin, konsultasi psikologi).
- Penjadwalan kegiatan secara mingguan atau bulanan yang jelas.
- Evaluasi yang terukur untuk menilai efektivitas program yang dirancang.

Proposal harus menjelaskan secara terperinci manfaat masing-masing metode yang dipilih serta alasan mengapa metode tersebut dipilih berdasarkan kondisi psikologis pasangan.

### **Tugas 3: Studi Literatur tentang Pengelolaan Ekspektasi Pasangan**

Mahasiswa diminta melakukan studi literatur tentang pentingnya pengelolaan ekspektasi pasangan terkait kehamilan dan pengasuhan anak. Mahasiswa kemudian harus menyusun laporan yang mencakup:

- Penjelasan tentang risiko dan dampak ekspektasi yang tidak realistis terhadap pasangan.
- Strategi efektif untuk mengelola ekspektasi (komunikasi terbuka, edukasi, persiapan skenario alternatif).
- Contoh-contoh nyata atau studi kasus tentang pasangan yang berhasil atau gagal mengelola ekspektasi mereka.
- Rekomendasi konkret yang bisa diterapkan oleh pasangan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga ekspektasi tetap realistis.

Laporan ini harus didukung oleh minimal 5 referensi akademik terbaru.

### **Tugas 4: Implementasi Pendekatan Mindfulness dan Wellness**

Mahasiswa diminta menyusun modul pelatihan pendekatan mindfulness dan wellness bagi pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Modul ini mencakup:

- Penjelasan mengenai konsep mindfulness dan wellness secara sederhana dan jelas.
- Panduan aktivitas mindfulness sehari-hari (meditasi, latihan pernapasan, refleksi harian).
- Panduan aktivitas wellness yang mencakup nutrisi, olahraga ringan hingga sedang, dan pola tidur sehat.
- Teknik evaluasi sederhana untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan.

Modul harus disusun dalam format yang mudah dipahami dan dapat langsung dipraktikkan oleh pasangan dalam kehidupan sehari-hari.

### **Tugas 5: Analisis Isu Kecemasan Pasangan tentang Fertilitas dan Kehamilan**

Mahasiswa diminta untuk melakukan penelitian kecil berupa survei singkat kepada minimal 10 pasangan usia reproduktif tentang kecemasan mereka terkait fertilitas dan kehamilan. Survei harus mencakup:

- Jenis kecemasan yang paling umum dirasakan oleh pasangan.
- Sumber utama kecemasan pasangan (tekanan sosial, informasi tidak akurat, ekspektasi tinggi).
- Dampak yang dirasakan pasangan akibat kecemasan tersebut (hubungan interpersonal, kondisi fisik, kesehatan mental).
- Strategi atau langkah yang sudah diambil pasangan dalam mengatasi kecemasan mereka.

Mahasiswa wajib menganalisis hasil survei tersebut dan menyusun rekomendasi praktis berupa strategi edukasi dan konseling yang efektif untuk mengurangi kecemasan pasangan berdasarkan hasil temuan di lapangan.

### **Pilihan Ganda**

1. Wulan (28 tahun) datang ke klinik bidan bersama suaminya (30 tahun) dalam rangka merencanakan kehamilan pertama mereka. Wulan terlihat cemas dan bertanya banyak tentang kesiapan menjadi orang tua. Ia mengatakan khawatir tentang perubahan pola tidur dan waktu yang harus dibagi setelah kehadiran bayi.

Sebagai bidan, langkah terbaik apa yang sebaiknya Anda lakukan?

- A. Memberikan edukasi tentang perubahan pola hidup yang realistis dan mendorong komunikasi terbuka antar pasangan
  - B. Memberikan edukasi tentang pentingnya menabung uang sejak dini
  - C. Menyarankan agar menunda kehamilan sampai kecemasan hilang
  - D. Menyarankan segera ke dokter untuk pemeriksaan fertilitas
  - E. Memberikan resep obat penenang ringan untuk mengurangi kecemasan
- 
2. Fitri (27 tahun) dan suaminya (29 tahun) sering mengalami konflik setelah menikah, terutama terkait ekspektasi masing-masing tentang kehamilan. Fitri ingin segera memiliki anak, sementara suaminya merasa belum siap.  
Apa intervensi terbaik yang dapat dilakukan oleh bidan?
    - A. Menyarankan suami untuk mengikuti kemauan istri
    - B. Menyarankan agar pasangan segera merencanakan kehamilan untuk menghindari konflik
    - C. Memberikan konseling untuk membangun komunikasi terbuka dan membantu pasangan mengelola ekspektasi yang realistis
    - D. Memberikan suplemen kesuburan kepada pasangan agar cepat hamil
    - E. Menyarankan suami untuk konsultasi sendiri ke psikolog
  3. Nina (30 tahun) merasa sangat tertekan karena terus-menerus ditanya keluarganya mengenai kehamilan yang belum juga terjadi setelah menikah selama satu tahun. Akibat tekanan ini, ia mulai mengalami gangguan tidur, sering cemas, dan mudah marah.  
Apa rekomendasi terbaik yang sebaiknya diberikan oleh bidan?
    - A. Meminta Nina segera menjalani program inseminasi buatan
    - B. Menyarankan Nina untuk memutuskan komunikasi dengan keluarganya sementara waktu

- C. Memberikan edukasi dan konseling tentang manajemen stres prakonsepsi seperti meditasi, yoga, atau aktivitas relaksasi lainnya
  - D. Merujuk Nina ke psikiater untuk mendapatkan obat-obatan penenang
  - E. Memberikan vitamin tambahan agar tubuh Nina lebih sehat
4. Rini (32 tahun) dan suaminya (35 tahun) mempersiapkan kehamilan pertama mereka. Mereka sangat tertarik dengan tren mindfulness dan wellness sebagai bagian persiapan mental menghadapi kehamilan. Sebagai bidan, rekomendasi terbaik yang dapat diberikan kepada pasangan ini adalah:
- A. Mendorong pasangan untuk melakukan olahraga intensitas tinggi agar lebih siap fisik
  - B. Menyarankan pasangan untuk rutin melakukan meditasi, latihan pernapasan, serta menjaga pola makan sehat dan tidur teratur
  - C. Mengarahkan pasangan agar hanya fokus pada aspek fisik saja
  - D. Mengusulkan pasangan agar tidak memikirkan aspek psikologis terlebih dahulu
  - E. Menyarankan agar pasangan melakukan diet ketat agar lebih sehat sebelum hamil
5. Pasangan muda, Dita (26 tahun) dan suaminya (28 tahun), mengungkapkan bahwa mereka sering merasa takut gagal dalam menjadi orang tua. Mereka mengaku sering mencari informasi tentang kehamilan dan parenting melalui media sosial, namun justru semakin cemas setelah melihat berbagai informasi negatif dan dramatis. Sebagai bidan, langkah paling tepat yang harus dilakukan untuk pasangan ini adalah:
- A. Menyarankan pasangan berhenti total menggunakan media social
  - B. Menyarankan pasangan untuk mengikuti semua saran di media social
  - C. Menyarankan pasangan untuk segera berkonsultasi ke dokter kandungan
  - D. Memberikan vitamin penambah stamina agar pasangan lebih percaya diri
  - E. Memberikan edukasi berbasis bukti mengenai fertilitas, kehamilan, dan pengasuhan anak

## Kunci Jawaban

1. Jawaban: A

Pembahasan:

Dalam menghadapi kecemasan terkait perubahan pola hidup, pasangan membutuhkan edukasi yang realistis mengenai tantangan yang akan dihadapi dan pentingnya komunikasi terbuka agar lebih siap mental dan emosional dalam menjalani kehamilan dan peran sebagai orang tua.

2. Jawaban: C

Pembahasan:

Konflik karena ekspektasi yang tidak sejalan harus diatasi melalui komunikasi terbuka dan realistis. Konseling membantu pasangan untuk mengelola ekspektasi masing-masing dan mencapai kesepakatan bersama dalam merencanakan kehamilan.

3. Jawaban: C

Pembahasan:

Gejala stres prakonsepsi seperti gangguan tidur, cemas, dan mudah marah harus dikelola melalui metode relaksasi dan manajemen stres seperti meditasi dan yoga. Hal ini lebih efektif dibandingkan langsung menggunakan pendekatan medis atau farmakologis.

4. Jawaban: B

Pembahasan:

Mindfulness dan wellness mencakup latihan meditasi, pernapasan, serta pola hidup sehat seperti pola makan seimbang dan tidur yang cukup. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi kehamilan.

5. Jawaban: E

Pembahasan:

Kecemasan yang timbul dari informasi yang tidak akurat atau dramatis di media sosial dapat dikurangi dengan memberikan edukasi yang akurat, berbasis bukti, serta terpercaya mengenai berbagai aspek kehamilan dan pengasuhan anak. Ini membantu pasangan memahami situasi secara realistis, sehingga lebih tenang dan siap menghadapi tantangan.

## G. Rangkuman Materi

Kesiapan mental pasangan dalam menghadapi kehamilan dan peran sebagai orang tua merupakan aspek penting yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam proses persiapan pranikah maupun prakonsepsi. Menjadi orang tua bukan sekadar kemampuan biologis untuk memiliki keturunan, tetapi juga melibatkan kesiapan emosional dan mental untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang kompleks. Pasangan perlu menyadari bahwa tanggung jawab sebagai orang tua mencakup berbagai aspek emosional, fisik, dan finansial yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka harus memahami perubahan gaya hidup yang akan terjadi, seperti pola tidur yang berubah drastis dan keterbatasan waktu berdua, yang dapat memicu perasaan stres, frustrasi, hingga konflik. Selain itu, tekanan psikologis dari internal maupun eksternal, seperti harapan keluarga atau standar sosial, juga perlu diantisipasi. Dalam hal ini, komunikasi terbuka, edukasi tentang kehamilan dan parenting, serta pelatihan khusus menjadi sangat penting untuk mempersiapkan pasangan secara mental. Dengan persiapan mental yang matang, pasangan dapat menjalani kehamilan secara positif serta siap dalam menjalankan peran sebagai orang tua dengan penuh percaya diri, kebijaksanaan, dan stabilitas emosional.

Dalam persiapan menuju kehamilan yang sehat, manajemen stres prakonsepsi juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan secara serius oleh pasangan. Stres yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental, bahkan berpotensi menurunkan fertilitas pasangan. Stres ini biasanya berasal dari tekanan internal berupa kecemasan akan ketidakmampuan memiliki anak atau ketidaksiapan menjadi orang tua, serta tekanan eksternal dari lingkungan sosial seperti harapan keluarga maupun tekanan norma budaya yang menuntut pasangan segera memiliki keturunan. Gejala stres prakonsepsi seperti gangguan tidur, kecemasan berlebih, atau perubahan pola makan, perlu dikenali secara dini. Strategi efektif dalam mengelola stres ini antara lain meditasi, yoga, olahraga rutin, serta menjaga pola tidur yang teratur. Konsultasi psikologi juga dianjurkan, terutama jika stres mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari pasangan. Selain itu, dukungan emosional dari pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial yang positif sangat membantu dalam mengurangi intensitas stres, sehingga pasangan lebih siap menjalani masa kehamilan dengan tenang dan penuh harapan.



Pengelolaan ekspektasi pasangan tentang kehamilan dan pengasuhan anak juga menjadi aspek penting dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi. Sering kali pasangan memiliki gambaran ideal yang tidak realistis mengenai proses kehamilan maupun pengasuhan, yang bersumber dari narasi media sosial, pengalaman orang lain, atau tekanan budaya. Ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi tersebut, pasangan berisiko mengalami kekecewaan, frustrasi, dan konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pasangan harus aktif berdiskusi secara terbuka tentang ekspektasi mereka sejak dini, bahkan sebelum kehamilan terjadi. Diskusi ini akan membantu mereka membangun harapan yang realistis serta menyiapkan berbagai skenario alternatif yang mungkin terjadi. Selain komunikasi, pasangan juga disarankan mencari informasi dari sumber terpercaya agar mereka mampu mengantisipasi tantangan-tantangan realistis yang mungkin dihadapi. Pengelolaan ekspektasi yang efektif, ditambah dukungan emosional yang saling diberikan, akan menciptakan stabilitas emosional dalam keluarga, mengurangi stres, serta meningkatkan kemampuan pasangan dalam menghadapi berbagai dinamika kehamilan dan pengasuhan anak dengan percaya diri dan kebijaksanaan.

Pendekatan *mindfulness* dan *wellness* kini semakin diminati dalam konteks persiapan kehamilan. *Mindfulness* mengajarkan pasangan untuk fokus secara sadar dan penuh perhatian terhadap kondisi emosional dan fisik mereka tanpa penilaian, membantu menciptakan ketenangan dan keseimbangan emosional. Praktik seperti meditasi, latihan pernapasan, dan refleksi harian terbukti mampu menurunkan stres, memperbaiki kualitas tidur, dan mendukung kesehatan reproduksi. *Wellness*, sebagai kesejahteraan holistik, mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling terhubung, termasuk pola makan sehat, olahraga rutin, pola tidur teratur, serta hubungan sosial yang positif. Kedua pendekatan ini, jika dilakukan secara konsisten dan didukung oleh panduan profesional, akan memberikan kesiapan psikologis dan emosional yang lebih baik bagi pasangan dalam menghadapi kehamilan serta membantu mereka mengatasi berbagai tantangan emosional dan fisik selama masa prakonsepsi hingga pengasuhan anak.

Namun, di sisi lain terdapat isu yang semakin meningkat, yaitu kecemasan pasangan terkait fertilitas dan kehamilan. Kecemasan ini muncul akibat tekanan sosial yang kuat agar pasangan segera memiliki anak setelah menikah, serta informasi yang tidak akurat atau dramatis dari media sosial dan berbagai sumber yang kurang kredibel. Akibatnya, pasangan terjebak dalam kondisi emosional yang penuh ketegangan, yang dapat merusak hubungan interpersonal, menurunkan kesehatan fisik dan mental, serta memperberat kondisi sulit mendapatkan keturunan. Untuk

mengatasi kecemasan ini, pasangan perlu mendapat edukasi berbasis bukti tentang kehamilan dan fertilitas, mengikuti konseling pranikah untuk mengelola kecemasan secara terbuka dan jujur, serta membangun sistem dukungan sosial yang kuat. Dengan pendekatan tersebut, kecemasan dapat dikurangi secara signifikan, memungkinkan pasangan menjalani proses prakonsepsi hingga masa kehamilan dengan lebih stabil, harmonis, dan percaya diri.

## H. Glosarium

### **Aktivitas relaksasi**

Metode seperti meditasi dan yoga yang digunakan pasangan untuk mengurangi ketegangan mental dan emosional, membantu menciptakan kondisi psikologis yang lebih tenang dan positif dalam menghadapi proses prakonsepsi hingga kehamilan.

### **Dukungan emosional**

Bantuan berupa perhatian, pengertian, dan sikap saling mendukung antar pasangan serta dari keluarga dan lingkungan sosial, yang membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesiapan mental.

### **Ekspektasi**

Harapan atau bayangan pasangan mengenai kehamilan dan peran sebagai orang tua, yang jika tidak realistis dapat menyebabkan kekecewaan atau stres ketika kenyataan berbeda dengan yang diharapkan.

### **Fleksibilitas psikologis**

Kemampuan pasangan untuk menyesuaikan diri secara mental dan emosional terhadap perubahan situasi yang terjadi selama kehamilan dan pengasuhan anak, sehingga dapat merespons tantangan secara adaptif dan positif.

### **Gangguan tidur kronis**

Kondisi di mana pasangan mengalami kesulitan tidur dalam jangka panjang, yang dapat memperburuk kondisi emosional, meningkatkan stres, serta mempengaruhi kesehatan fisik secara keseluruhan.

### **Kecemasan fertilitas**

Kekhawatiran pasangan mengenai kemampuan untuk memiliki keturunan, yang sering kali diperparah oleh tekanan sosial, ekspektasi tinggi dari lingkungan, atau paparan informasi yang kurang kredibel.

### **Kesiapan mental**

Kondisi di mana pasangan telah mempersiapkan diri secara emosional dan psikologis untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang terjadi selama kehamilan hingga pengasuhan anak.

**Komunikasi terbuka**

Interaksi yang jujur dan transparan antara pasangan, yang mencakup diskusi mengenai ketakutan, harapan, ekspektasi, dan tantangan yang mungkin muncul selama kehamilan dan peran sebagai orang tua.

**Konseling pranikah**

Proses konsultasi yang dilakukan pasangan sebelum menikah atau sebelum kehamilan, bertujuan untuk mengatasi perbedaan ekspektasi, meningkatkan komunikasi, dan mengelola kecemasan yang mungkin muncul terkait pernikahan dan persiapan menjadi orang tua.

**Manajemen stres prakonsepsi**

Strategi yang digunakan oleh pasangan dalam mengelola stres sebelum terjadinya kehamilannya, seperti meditasi, yoga, aktivitas fisik rutin, dan konsultasi psikologis, guna mengurangi dampak negatif stres pada kesehatan fisik dan mental, serta fertilitas.

**Mindfulness**

Praktik kesadaran penuh yang membantu individu untuk menerima perasaan, pikiran, dan sensasi fisik tanpa penghakiman, dengan tujuan mencapai ketenangan emosional dan mental selama persiapan kehamilan.

**Skenario alternatif**

Rencana atau kemungkinan lain yang dipersiapkan pasangan jika situasi yang diharapkan tidak terjadi, seperti perubahan metode persalinan, masalah menyusui, atau kebutuhan khusus pada anak, guna meningkatkan fleksibilitas mental pasangan dalam menghadapi ketidakpastian.

**Tekanan psikologis eksternal**

Tekanan yang berasal dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, teman sebaya, norma budaya, serta informasi dari media sosial yang sering kali tidak akurat atau realistis.

**Tekanan psikologis internal**

Tekanan emosional yang berasal dari diri pasangan sendiri, seperti rasa takut tidak siap menjadi orang tua, kekhawatiran akan fertilitas, atau ketidakpastian mengenai proses kehamilan.

**Wellness**

Konsep kesejahteraan holistik yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, dan emosional, dengan tujuan menciptakan kondisi kesehatan optimal dalam persiapan menghadapi kehamilan.

## I. Daftar Pustaka

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association.
- Britton, J. R. (2008). Maternal anxiety: Course and antecedents during the early postpartum period. *Depression and Anxiety*, 25(9), 793–800. <https://doi.org/10.1002/da.20325>
- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(4), 822–848. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822>
- Duncan, L. G., & Bardacke, N. (2010). Mindfulness-based childbirth and parenting education: Promoting family mindfulness during the perinatal period. *Journal of Child and Family Studies*, 19(2), 190–202. <https://doi.org/10.1007/s10826-009-9313-7>
- Fletcher, R., Silberberg, S., & Galloway, D. (2004). New fathers' postbirth views of antenatal classes: Satisfaction, benefits, and knowledge of family services. *The Journal of Perinatal Education*, 13(3), 18–26. <https://doi.org/10.1624/105812404X1762>
- Green, J. M., & Baston, H. A. (2003). Feeling in control during labor: Concepts, correlates, and consequences. *Birth*, 30(4), 235–247. <https://doi.org/10.1046/j.1523-536X.2003.00253.x>
- Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144–156. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016>
- Lothian, J. A. (2008). Safe, healthy birth: What every pregnant woman needs to know. *The Journal of Perinatal Education*, 17(3), 48–54. <https://doi.org/10.1624/105812408X329593>
- Maleki, A., Faghihzadeh, S., & Dehdari, T. (2019). The effectiveness of stress management training on perceived stress and coping strategies of pregnant women. *Journal of Education and Health Promotion*, 8(1), 130–135. [https://doi.org/10.4103/jehp.jehp\\_104\\_19](https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_104_19)
- Mercer, R. T. (2004). Becoming a mother versus maternal role attainment. *Journal of Nursing Scholarship*, 36(3), 226–232. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.2004.04042.x>
- O'Hara, M. W., & Swain, A. M. (1996). Rates and risk of postpartum depression—a meta-analysis. *International Review of Psychiatry*, 8(1), 37–54. <https://doi.org/10.3109/09540269609037816>
- Parfitt, Y., & Ayers, S. (2014). Transition to parenthood and mental health in first-time parents. *Infant Mental Health Journal*, 35(3), 263–273. <https://doi.org/10.1002/imhj.21443>
- Shapiro, S. L., Astin, J. A., Bishop, S. R., & Cordova, M. (2005). Mindfulness-based stress reduction for health care professionals: Results from a randomized trial. *International Journal of Stress Management*, 12(2), 164–176. <https://doi.org/10.1037/1072-5245.12.2.164>

- Van den Bergh, B. R. H., Mulder, E. J. H., Mennes, M., & Glover, V. (2005). Antenatal maternal anxiety and stress and the neurobehavioural development of the fetus and child: Links and possible mechanisms. A review. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 29(2), 237–258. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2004.10.007>
- Vieten, C., & Astin, J. (2008). Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on prenatal stress and mood: Results of a pilot study. *Archives of Women's Mental Health*, 11(1), 67–74. <https://doi.org/10.1007/s00737-008-0214-3>
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. World Health Organization

# Bab 6

## Kesehatan Seksual dan Pencegahan Risiko Prakonsepsi

Persiapan pranikah dan prakonsepsi mencakup banyak aspek penting, termasuk kesehatan seksual dan pencegahan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan pasangan maupun calon anak. Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan seksual serta pencegahan risiko penyakit menular seksual dan infeksi lain yang mempengaruhi kehamilan sangat penting dalam memastikan kondisi kesehatan optimal bagi pasangan yang merencanakan kehamilan. Edukasi dan pemahaman yang tepat mengenai isu ini membantu pasangan menghindari komplikasi kehamilan serta meningkatkan kualitas kehidupan seksual dan reproduksi mereka.

### Capaian Pembelajaran (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan seksual dan pencegahan risiko prakonsepsi secara menyeluruh serta mampu mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membantu pasangan mempersiapkan kehamilan yang sehat dan aman.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisis isu kesehatan seksual dan risiko prakonsepsi, serta mengaplikasikan metode pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan penyakit menular seksual untuk mendukung pasangan dalam persiapan kehamilan yang aman.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan secara detail mengenai infeksi menular seksual (IMS), termasuk pencegahan, deteksi, dan pengobatan.
- Mahasiswa mampu menjelaskan strategi pencegahan HIV/AIDS serta edukasi pranikah yang efektif.
- Mahasiswa mampu memahami pentingnya pencegahan penyakit menular yang dapat mempengaruhi kehamilan (TORCH).
- Mahasiswa mampu menganalisis tren kampanye edukasi seksual pranikah berbasis komunitas digital.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap stigma dan tabu terkait pemeriksaan IMS sebelum menikah.

## **A. Infeksi Menular Seksual (IMS) Pencegahan, Deteksi, dan Pengobatan**

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan kelompok penyakit yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman. Hubungan seksual tidak aman ini meliputi hubungan seksual secara vaginal, anal, maupun oral tanpa menggunakan pelindung atau metode pengaman seperti kondom. Berbagai jenis IMS yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari antara lain klamidia, gonore, sifilis, herpes genital, serta human papillomavirus (HPV). Setiap jenis infeksi tersebut memiliki gejala, tingkat keparahan, dan metode pengobatan yang berbeda. Meskipun banyak IMS bisa diobati, ada juga beberapa jenis yang bersifat kronis atau menetap dalam tubuh manusia, seperti infeksi herpes genital atau beberapa tipe HPV yang bisa memicu risiko kanker.

IMS tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan individu yang terinfeksi, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap pasangan seksualnya. Risiko ini meningkat secara signifikan jika individu yang terinfeksi tidak mengetahui kondisinya karena beberapa IMS memang sering kali tidak menampilkan gejala yang jelas di tahap awal. Hal ini membuat penularan kepada pasangan menjadi semakin tidak terkendali, yang pada akhirnya meningkatkan risiko munculnya komplikasi kesehatan dalam jangka panjang.

Selain dampak langsung kepada pasangan, IMS juga memiliki implikasi serius pada kehamilan. Seorang ibu yang mengidap IMS bisa menularkan infeksi tersebut kepada janin selama proses kehamilan atau saat persalinan berlangsung. Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang serius bagi bayi, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, cacat bawaan, kebutaan, gangguan pendengaran, atau bahkan kematian bayi baru lahir dalam kasus-kasus yang parah. Oleh sebab itu, pasangan yang tengah merencanakan pernikahan dan kehamilan sangat dianjurkan untuk secara serius memahami dan melakukan tindakan pencegahan terhadap IMS sejak dini.

Salah satu upaya terpenting dalam mencegah IMS adalah praktik seksual yang aman dan bertanggung jawab. Praktik seksual aman ini antara lain dengan penggunaan kondom secara konsisten dan benar pada setiap kali melakukan hubungan seksual, terutama bila seseorang atau pasangannya memiliki riwayat seksual dengan lebih dari satu pasangan atau bila riwayat kesehatan seksual pasangan tidak jelas. Kondom efektif mencegah penularan karena mampu

menghalangi cairan tubuh yang mengandung bakteri atau virus penyebab IMS berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Selain itu, membatasi jumlah pasangan seksual juga terbukti efektif dalam mengurangi risiko tertular IMS, karena semakin banyak pasangan seksual yang dimiliki, semakin tinggi pula risiko paparan terhadap berbagai jenis infeksi.

Dalam konteks persiapan pranikah dan prakonsepsi, komunikasi terbuka antara pasangan tentang riwayat seksual masing-masing merupakan langkah preventif yang sangat penting. Pasangan yang secara jujur berdiskusi mengenai sejarah seksual mereka akan mampu memahami risiko yang dihadapi, sehingga dapat menentukan langkah-langkah konkret yang perlu diambil bersama untuk mencegah IMS. Salah satu tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah menjalani pemeriksaan atau skrining kesehatan seksual secara rutin sebelum menikah.

Deteksi dini melalui pemeriksaan rutin ini merupakan aspek vital dalam pengelolaan IMS karena sebagian besar infeksi seksual tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas pada tahap awal. Tanpa adanya pemeriksaan rutin, seseorang dapat mengidap IMS tanpa disadari selama bertahun-tahun, meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke pasangan seksualnya, dan memperparah kondisi kesehatan reproduksi. Pemeriksaan IMS biasanya mencakup beberapa prosedur standar, seperti wawancara medis menyeluruh yang mencakup riwayat seksual, pemeriksaan fisik, serta tes laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah, urin, atau pengambilan sampel usapan dari area genital. Tes-tes tersebut bertujuan mengidentifikasi bakteri atau virus spesifik yang menyebabkan IMS, seperti klamidia, gonore, sifilis, herpes genital, dan HPV.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya IMS, pengobatan perlu segera dilakukan untuk mencegah timbulnya komplikasi lebih lanjut. Pengobatan IMS disesuaikan dengan jenis infeksi yang ditemukan. Pada infeksi bakteri seperti klamidia, gonore, dan sifilis, terapi antibiotik akan menjadi pilihan utama. Antibiotik harus diminum secara lengkap sesuai petunjuk dokter untuk memastikan infeksi telah hilang sepenuhnya. Jika pengobatan antibiotik tidak dijalani secara tuntas, maka risiko resistensi antibiotik atau kegagalan pengobatan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi kesehatan.

Untuk IMS yang disebabkan oleh virus seperti herpes genital atau HPV, umumnya akan diberikan pengobatan antivirus yang bertujuan mengurangi gejala dan mengontrol frekuensi kekambuhan penyakit. Meski antivirus tidak mampu



sepenuhnya menghilangkan virus dari tubuh, penggunaannya sangat penting untuk menjaga kualitas hidup pasien dan menurunkan risiko penularan lebih lanjut. Selain pengobatan medis, pasien juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bagaimana menjaga kebersihan genital serta cara mengelola kehidupan seksual secara sehat.

Edukasi seksual yang akurat, jelas, dan berbasis bukti menjadi faktor penentu dalam mengatasi IMS. Pasangan yang akan menikah atau berencana memiliki anak sebaiknya mendapatkan edukasi yang memadai mengenai IMS, baik dari tenaga kesehatan profesional seperti dokter atau bidan maupun melalui sumber-sumber informasi yang kredibel. Edukasi ini meliputi penjelasan tentang jenis-jenis IMS, cara penularannya, dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, serta langkah-langkah konkret dalam pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan yang efektif.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini mencakup pencegahan melalui praktik seksual yang aman, pemeriksaan rutin untuk deteksi dini, pengobatan yang tepat sesuai jenis infeksi, serta edukasi seksual yang akurat, pasangan dapat secara optimal menjaga kesehatan seksualnya. Pendekatan yang holistik tersebut sangat penting, bukan hanya untuk kesehatan masing-masing individu, tetapi juga dalam menciptakan dasar yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang sehat serta kehamilan yang aman dan bebas dari komplikasi akibat IMS. Melalui kesadaran, pengetahuan yang cukup, serta tanggung jawab bersama, pasangan dapat memasuki tahap kehidupan baru mereka dengan kesiapan fisik dan mental yang matang, harmonis, dan sehat secara seksual dan reproduktif.

## **B. Pencegahan HIV/AIDS dan Edukasi Pranikah**

HIV/AIDS merupakan isu kesehatan global yang sangat kompleks dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam bidang kesehatan reproduksi hingga saat ini. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, menyebabkan melemahnya kemampuan tubuh dalam melawan berbagai infeksi dan penyakit lainnya. Seiring berjalannya waktu, infeksi HIV bisa berkembang menjadi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), sebuah kondisi di mana sistem imun mengalami penurunan fungsi yang parah sehingga tubuh rentan terhadap berbagai penyakit oportunistik yang bisa mengancam nyawa. Hingga kini, belum ditemukan obat yang sepenuhnya dapat menyembuhkan HIV/AIDS, sehingga fokus utama kesehatan global adalah pada langkah-langkah pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan yang efektif untuk mengontrol penyebaran penyakit ini.

Dalam konteks pranikah, isu HIV/AIDS perlu menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap kesehatan pasangan serta calon anak yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi calon pasangan yang merencanakan pernikahan untuk memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai penyakit ini, termasuk bagaimana cara penularannya, metode pencegahan yang efektif, serta pentingnya melakukan skrining atau pemeriksaan rutin sebelum menikah. Edukasi pranikah mengenai HIV/AIDS harus diberikan secara komprehensif dan berbasis bukti, mencakup informasi mendalam tentang bagaimana HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa kondom, melalui darah yang terkontaminasi, serta dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayinya selama proses kehamilan, persalinan, ataupun menyusui.

Salah satu strategi pencegahan paling efektif yang wajib ditekankan dalam edukasi pranikah adalah penggunaan kondom secara konsisten dan benar setiap kali melakukan hubungan seksual, terutama jika status HIV pasangan belum diketahui secara pasti. Penggunaan kondom telah terbukti secara ilmiah efektif mencegah transmisi HIV karena kondom mampu menjadi penghalang yang menghalangi cairan tubuh, seperti cairan semen, cairan vagina, dan darah, yang mengandung virus HIV berpindah dari satu individu ke individu lainnya. Meski demikian, penggunaan kondom tidak akan efektif jika tidak dilakukan secara konsisten. Oleh karena itu, konsistensi dalam penggunaan kondom harus menjadi bagian penting dari edukasi pranikah untuk pasangan yang hendak menikah.

Selain metode pencegahan berbasis penggunaan kondom, salah satu pendekatan pencegahan yang dianjurkan secara luas adalah tes HIV pra-nikah atau skrining HIV secara rutin. Skrining ini bertujuan mendeteksi secara dini apakah salah satu atau kedua pasangan telah terinfeksi HIV. Skrining pra-nikah sangat penting, mengingat banyak kasus HIV yang tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas pada tahap awal infeksi. Ketidaktahuan terhadap status HIV ini berpotensi meningkatkan risiko penularan kepada pasangan seksual serta kepada calon anak selama masa kehamilan. Dengan mengetahui status HIV sejak awal, pasangan dapat membuat keputusan dan merencanakan keluarga secara lebih matang, aman, dan tepat.

Bagi individu yang memiliki risiko tinggi untuk tertular HIV, misalnya karena memiliki pasangan yang positif HIV atau terlibat dalam perilaku seksual berisiko tinggi, terapi profilaksis pra-pajanan atau pre-exposure prophylaxis (PrEP) menjadi pilihan pencegahan yang efektif. PrEP merupakan pendekatan medis berupa pemberian obat antivirus tertentu sebelum paparan terhadap HIV terjadi, yang

tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus tersebut. Terapi ini telah terbukti sangat efektif dalam menurunkan risiko penularan HIV secara signifikan jika digunakan secara teratur dan konsisten sesuai petunjuk medis. Edukasi pranikah perlu menyertakan informasi yang jelas tentang manfaat serta cara penggunaan PrEP bagi pasangan yang berisiko tinggi, agar mereka memahami opsi yang tersedia untuk menjaga kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Sementara itu, bagi individu yang telah dinyatakan positif HIV, sangat penting untuk segera memulai terapi antiretroviral (ARV). Terapi ARV adalah pengobatan yang bertujuan mengontrol perkembangan virus HIV dalam tubuh sehingga jumlah virus (viral load) dapat ditekan ke tingkat yang sangat rendah atau bahkan tidak terdeteksi. Ketika viral load berhasil ditekan hingga sangat rendah, maka risiko penularan HIV kepada pasangan seksual atau dari ibu kepada anak saat kehamilan dan persalinan menjadi sangat rendah pula. Kondisi ini dikenal sebagai undetectable = untransmittable (U=U), artinya bahwa jika virus HIV dalam darah tidak terdeteksi berkat terapi ARV yang efektif, maka risiko transmisi HIV menjadi hampir nol. Oleh karena itu, edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi ARV juga perlu ditekankan dalam program edukasi pranikah.

Selain aspek medis dan pencegahan, edukasi pranikah juga perlu secara aktif mengupayakan pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Salah satu hambatan terbesar dalam pengendalian HIV/AIDS adalah stigma sosial yang masih melekat, yang membuat individu enggan melakukan pemeriksaan rutin, takut untuk mencari pengobatan, atau merasa terisolasi secara sosial. Dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai HIV/AIDS, pasangan dapat memahami bahwa HIV bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, melainkan kondisi kesehatan yang dapat dikendalikan dengan pengobatan yang tepat serta sikap saling mendukung antara pasangan.

Melalui edukasi pranikah yang komprehensif dan berbasis bukti, pasangan akan memahami bahwa HIV/AIDS adalah kondisi kesehatan yang bisa dicegah melalui berbagai langkah strategis, mulai dari praktik seksual yang aman, skrining rutin sebelum menikah, hingga terapi medis yang tepat. Dengan meningkatnya kesadaran, pengetahuan, dan empati terhadap isu HIV/AIDS, pasangan bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih sehat dan aman, serta mampu melindungi kesehatan generasi selanjutnya dengan cara yang lebih efektif dan bijaksana. Edukasi yang menyeluruh ini tidak hanya melindungi pasangan dari risiko

HIV, tetapi juga secara luas membantu upaya global dalam mengendalikan epidemi HIV/AIDS secara efektif dan berkelanjutan.

### **C. Pencegahan Penyakit Menular yang Mempengaruhi Kehamilan (TORCH)**

Penyakit menular yang dikenal dengan istilah TORCH merupakan gabungan dari beberapa jenis infeksi yang meliputi Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes Simplex Virus. Penyakit ini sangat penting diperhatikan terutama oleh pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan atau pasangan yang sedang dalam tahap awal kehamilan, karena dapat menyebabkan komplikasi serius terhadap janin maupun ibu hamil. Komplikasi tersebut dapat berupa keguguran, kelainan bawaan pada janin (kelainan kongenital), gangguan tumbuh kembang bayi setelah lahir, hingga kematian janin dalam kandungan.

Toxoplasmosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit *Toxoplasma gondii*, yang umumnya menyebar melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, daging mentah atau setengah matang, atau melalui kontak langsung dengan feses kucing yang terinfeksi. Infeksi ini menjadi sangat berbahaya jika terjadi selama kehamilannya karena parasit dapat menembus plasenta, menginfeksi janin, dan menyebabkan gangguan serius pada sistem saraf pusat bayi. Oleh karena itu, calon ibu dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan secara teratur, memastikan makanan benar-benar matang sebelum dikonsumsi, serta menghindari kontak langsung dengan kotoran hewan peliharaan seperti kucing atau hewan liar yang berisiko tinggi membawa parasit tersebut. Jika memiliki hewan peliharaan, sebaiknya pasangan yang tidak hamil yang bertugas untuk membersihkan kotak kotoran hewan agar dapat meminimalkan risiko paparan.

Rubella atau campak Jerman merupakan infeksi virus yang sangat berbahaya bila terjadi pada trimester pertama kehamilan. Infeksi ini bisa menyebabkan Sindrom Rubella Kongenital (Congenital Rubella Syndrome - CRS), suatu kondisi di mana janin mengalami kelainan bawaan berat, seperti gangguan pendengaran, kelainan jantung, gangguan penglihatan (seperti katarak), retardasi mental, hingga gangguan tumbuh kembang lainnya. Cara paling efektif untuk mencegah rubella adalah melalui imunisasi sebelum masa kehamilan. Vaksinasi rubella ini biasanya diberikan setidaknya satu bulan sebelum kehamilan direncanakan. Oleh sebab itu, penting bagi setiap wanita usia subur, khususnya yang hendak menikah, untuk

memastikan telah mendapatkan imunisasi rubella serta memeriksakan status kekebalan tubuhnya melalui pemeriksaan darah sebelum memulai kehamilan.

Cytomegalovirus (CMV) adalah virus yang termasuk dalam keluarga virus herpes dan merupakan penyebab umum infeksi kongenital. CMV biasanya menyebar melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seseorang yang terinfeksi, seperti air liur, darah, urin, atau air susu ibu. Kebanyakan infeksi CMV pada orang dewasa tidak menunjukkan gejala spesifik, sehingga sering kali tidak disadari. Namun, bila infeksi ini terjadi pada ibu hamil, terutama yang pertama kali terpapar virus tersebut, risiko penularan ke janin sangat besar dan bisa menyebabkan berbagai gangguan serius seperti gangguan pendengaran, retardasi mental, hingga gangguan tumbuh kembang anak yang bersifat permanen. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menjalani skrining CMV sebelum kehamilan serta menerapkan kebersihan pribadi dengan ketat, seperti mencuci tangan dengan sabun secara teratur dan menghindari kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain, terutama dari anak kecil atau orang dengan gejala flu atau demam.

Herpes Simplex Virus (HSV), khususnya HSV tipe 2, merupakan virus penyebab herpes genital yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Pada ibu hamil yang terinfeksi HSV, risiko terbesar terjadi ketika ibu mengalami infeksi primer (pertama kali) saat kehamilannya. Infeksi HSV ini dapat ditransmisikan kepada janin selama proses persalinan, menyebabkan infeksi neonatal yang berat, termasuk gangguan neurologis hingga kematian. Pencegahan infeksi HSV dilakukan dengan praktik seksual yang aman, seperti penggunaan kondom secara konsisten serta pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin sebelum kehamilan. Jika calon ibu diketahui positif terinfeksi HSV, dokter dapat merencanakan persalinan melalui operasi caesar untuk meminimalisir transmisi kepada bayi.

Mengingat risiko komplikasi yang sangat serius dari penyakit TORCH, deteksi dini melalui skrining sebelum kehamilan menjadi langkah yang amat penting. Pemeriksaan laboratorium yang biasanya berupa tes darah untuk mendeteksi antibodi terhadap Toxoplasma, Rubella, CMV, dan HSV perlu dilakukan sejak masa persiapan pranikah. Skrining ini membantu pasangan mengetahui secara jelas status imun mereka terhadap berbagai infeksi ini. Dengan informasi ini, pasangan dan tenaga kesehatan bisa merancang strategi pencegahan atau pengobatan dini bila diperlukan.

Selain langkah-langkah pencegahan secara fisik dan medis, edukasi pranikah yang mendalam mengenai penyakit TORCH juga sangat dibutuhkan. Edukasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang akurat dan komprehensif kepada pasangan mengenai risiko dari setiap jenis infeksi TORCH, cara-cara pencegahan yang efektif, pentingnya imunisasi sebelum kehamilan (terutama rubella), serta perlunya menjalani skrining kesehatan secara rutin dan teratur. Melalui edukasi yang baik, pasangan akan lebih siap menghadapi masa kehamilan secara aman dan sehat, dengan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya. Dengan demikian, edukasi pranikah mengenai TORCH menjadi bagian integral dari persiapan menuju kehamilan yang sehat dan aman, serta menjadi pondasi kuat untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

#### **D. Tren: Kampanye Edukasi Seksual Pranikah Berbasis Komunitas Digital**

Tren edukasi seksual pranikah berbasis komunitas digital merupakan fenomena yang semakin berkembang luas dan mendapat perhatian besar, terutama seiring kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini menjadi sangat signifikan karena hadirnya kebutuhan yang tinggi di kalangan generasi muda untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Saat ini, generasi muda, khususnya pasangan yang tengah mempersiapkan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, sering menghadapi tantangan terkait keterbatasan akses informasi yang jelas dan benar mengenai berbagai aspek kesehatan seksual dan reproduksi. Keterbatasan ini bisa diakibatkan oleh kurangnya edukasi formal di sekolah, adanya stigma budaya, maupun kurangnya komunikasi terbuka di keluarga atau komunitas terdekat.

Dalam konteks inilah komunitas digital hadir sebagai solusi alternatif yang efektif dan efisien. Komunitas digital merupakan wadah atau ruang online yang memungkinkan para penggunanya, terutama generasi muda, untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan memperoleh pengetahuan secara luas, terbuka, dan interaktif. Platform digital seperti media sosial yang sangat populer seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, serta berbagai aplikasi kesehatan reproduksi khusus yang kini tersedia, telah menjadi sarana utama dalam mendukung kampanye edukasi seksual pranikah ini. Penggunaan platform-platform tersebut memiliki daya tarik tersendiri karena karakteristiknya yang

dinamis, interaktif, dan sangat sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda yang lebih visual, singkat, tetapi kaya informasi.

Salah satu format konten yang paling banyak digunakan dalam kampanye edukasi seksual digital adalah infografis. Infografis merupakan kombinasi gambar dan teks singkat yang disusun secara visual sehingga pesan-pesan mengenai topik-topik sensitif seperti pencegahan infeksi menular seksual, penggunaan alat kontrasepsi, persiapan kehamilannya, serta berbagai tips persiapan fisik dan mental dalam menghadapi pernikahan dapat disampaikan secara efektif dan menarik. Kekuatan infografis terletak pada desain visualnya yang menarik perhatian, singkat namun padat, serta kemudahan untuk dibagikan secara luas melalui media sosial, sehingga memungkinkan informasi kesehatan seksual menjangkau audiens secara luas dalam waktu singkat.

Selain infografis, format konten lain yang juga sangat diminati adalah video pendek atau konten audiovisual. Video pendek biasanya dikemas dengan durasi singkat sekitar satu hingga tiga menit, namun penuh dengan informasi penting, disajikan dalam gaya komunikasi yang santai, mudah dipahami, tetapi tetap didasarkan pada sumber ilmiah dan terpercaya. Format video ini memiliki kemampuan menarik perhatian audiens muda karena kehadiran narator yang ramah, animasi yang kreatif, maupun influencer atau tokoh publik yang diidolakan oleh generasi muda. Kehadiran pakar kesehatan reproduksi atau influencer di bidang kesehatan dalam konten video ini meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan, sehingga generasi muda lebih mudah menerima dan mempercayainya.

Webinar atau seminar online juga menjadi format penting lainnya yang kerap dimanfaatkan dalam kampanye berbasis komunitas digital. Webinar menyediakan ruang interaktif yang memungkinkan peserta untuk berinteraksi secara langsung dengan ahli seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan, psikolog keluarga, konselor pernikahan, hingga edukator seksual yang profesional dan berpengalaman. Melalui sesi webinar ini, peserta dapat bertanya secara langsung mengenai berbagai isu atau permasalahan seksual yang mereka hadapi, tanpa rasa malu atau canggung yang biasanya muncul dalam interaksi langsung tatap muka. Format ini sangat efektif dalam mengatasi hambatan psikologis maupun sosial yang masih ada dalam masyarakat terkait pembahasan isu-isu seksual.

Lebih lanjut, diskusi online yang bersifat terbuka namun anonim juga menjadi kekuatan utama komunitas digital dalam edukasi seksual pranikah. Platform diskusi seperti grup komunitas online, forum digital, atau fitur komentar dalam media sosial

memungkinkan generasi muda berbagi pengalaman, bertanya, atau mengungkapkan berbagai kekhawatiran secara jujur dan terbuka tanpa merasa takut dinilai atau dihakimi oleh orang lain. Diskusi-diskusi ini biasanya dimoderasi oleh para ahli atau edukator seksual yang memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan tetap positif, konstruktif, serta didasarkan pada fakta ilmiah yang dapat dipercaya.

Pemanfaatan komunitas digital dalam kampanye edukasi seksual pranikah ini terbukti mampu membawa perubahan positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, melakukan deteksi dini penyakit seksual, serta mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Kampanye digital ini juga berhasil mengurangi stigma negatif serta tabu yang selama ini melekat kuat dalam pembahasan isu-isu seksual, sehingga generasi muda kini dapat berbicara lebih terbuka dan percaya diri mengenai topik-topik tersebut.

Dengan berkembangnya edukasi seksual pranikah berbasis komunitas digital ini, maka generasi muda dapat memperoleh akses informasi yang lebih akurat, terpercaya, dan mudah dipahami, yang pada akhirnya akan membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab dan matang mengenai kesehatan reproduksi serta kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani. Tren ini tidak hanya mengubah cara informasi kesehatan reproduksi disampaikan, tetapi juga menciptakan budaya baru yang lebih terbuka dan positif dalam membahas isu-isu seksual, berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan generasi muda yang lebih sehat, lebih bijaksana, serta lebih siap menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga secara holistik.

#### **E. Isu: Stigma dan Tabu Terkait Pemeriksaan IMS Sebelum Menikah**

Stigma dan tabu yang melekat pada pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS) sebelum menikah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di lingkungan yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai konservatif atau norma budaya yang cenderung menganggap pembahasan tentang seksualitas sebagai sesuatu yang sensitif atau bahkan terlarang. Hal ini berkontribusi pada munculnya persepsi negatif terhadap pasangan yang memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seksual sebelum menikah, seolah-olah pemeriksaan tersebut mencerminkan perilaku seksual yang menyimpang atau tidak bermoral.



Fenomena ini mengakibatkan banyak pasangan merasa terhambat oleh rasa malu, ketidaknyamanan, hingga rasa takut akan pandangan negatif dan penilaian buruk dari keluarga, teman, tetangga, maupun masyarakat secara umum. Situasi ini menyebabkan banyak calon pengantin akhirnya memilih untuk tidak menjalani pemeriksaan IMS, meskipun secara medis dan ilmiah telah terbukti bahwa skrining tersebut sangat penting untuk mencegah berbagai komplikasi kesehatan serius. Akibatnya, keputusan tersebut justru membuka risiko besar terhadap dampak jangka panjang yang berbahaya, baik untuk kesehatan seksual pasangan maupun kesehatan reproduksi, termasuk masalah infertilitas, komplikasi kehamilannya seperti keguguran, kelahiran prematur, cacat bawaan pada bayi, hingga gangguan psikologis dan emosional yang berkepanjangan akibat stres atau rasa bersalah.

Perlu dipahami bahwa stigma ini pada dasarnya berakar dari kurangnya pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pemeriksaan IMS sebagai langkah pencegahan dan persiapan kehidupan seksual yang sehat. Banyak masyarakat masih menganggap bahwa melakukan skrining IMS sebelum menikah sama halnya dengan mengakui bahwa seseorang telah menjalani perilaku seksual yang buruk. Padahal, pemeriksaan IMS sama sekali tidak berkaitan dengan penilaian moral seseorang. Pemeriksaan tersebut justru merupakan wujud tanggung jawab individu terhadap kesehatan diri sendiri, pasangan, serta calon keturunan. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi adanya infeksi menular seksual secara dini, karena beberapa jenis IMS bahkan dapat terjadi tanpa gejala yang jelas, sehingga seseorang tidak menyadari bahwa dirinya telah terinfeksi.

Menjalani pemeriksaan IMS sebelum menikah sejatinya merupakan langkah bijaksana, positif, dan bertanggung jawab, karena tindakan ini memastikan bahwa kedua calon pasangan telah benar-benar siap secara fisik, mental, dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Pemeriksaan kesehatan seksual yang dilakukan sebelum menikah bukan semata-mata terkait dengan status seksual masa lalu, tetapi lebih berorientasi pada masa depan, yaitu untuk menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan kualitas hubungan, dan memastikan kehidupan seksual yang aman dan bertanggung jawab.

Untuk mengatasi stigma dan tabu tersebut, upaya edukasi secara luas dan konsisten sangat dibutuhkan. Edukasi yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat sporadis atau sekali waktu, tetapi harus menjadi bagian integral dari pendidikan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Edukasi ini harus menitikberatkan pada penyampaian informasi yang berbasis bukti, jelas, lugas, serta dapat diterima oleh

masyarakat dari berbagai kalangan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pemeriksaan IMS adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan pribadi dalam menjaga kesehatan, bukan sesuatu yang harus dirahasiakan atau dianggap memalukan.

Selain edukasi secara formal, penting pula untuk menjalankan kampanye advokasi melalui media massa, media sosial, dan platform digital lainnya yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih luas. Kampanye ini dapat melibatkan figur-figur publik, tokoh masyarakat yang dihormati, pemuka agama, dokter, bidan, tenaga kesehatan, dan influencer yang memiliki pengaruh kuat dalam menyampaikan pesan-pesan positif tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan seksual sebelum menikah. Ketika tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati secara terbuka memberikan dukungan terhadap pemeriksaan IMS, stigma negatif yang selama ini melekat secara perlahan akan terkikis dan digantikan oleh persepsi yang lebih positif, realistis, dan bertanggung jawab.

Selain itu, untuk mendukung upaya ini, perlu adanya lingkungan layanan kesehatan yang terbuka, ramah, dan non-diskriminatif terhadap pasangan yang hendak menjalani pemeriksaan kesehatan seksual. Klinik-klinik kesehatan, rumah sakit, atau fasilitas layanan kesehatan lainnya harus menjamin privasi dan kerahasiaan pasien serta memberikan pelayanan yang penuh empati dan tidak menghakimi. Dengan menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka, pasangan akan merasa lebih aman dan percaya diri untuk datang serta menjalani pemeriksaan kesehatan seksual tanpa khawatir akan dicap negatif atau dipandang sebelah mata.

Pada akhirnya, upaya terpadu yang meliputi edukasi publik yang berkelanjutan, kampanye advokasi yang melibatkan berbagai pihak berpengaruh, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan seksual secara keseluruhan, akan secara signifikan membantu mengurangi stigma dan tabu yang selama ini menghalangi pemeriksaan IMS sebelum menikah. Jika masyarakat mulai memahami bahwa pemeriksaan IMS bukan hanya tentang perilaku seksual masa lalu, tetapi merupakan investasi penting untuk kesehatan masa depan, maka kesadaran akan pentingnya pemeriksaan ini akan meningkat. Pasangan akan menjadi lebih terbuka, bertanggung jawab, dan siap menghadapi kehidupan pernikahan dengan kondisi kesehatan yang optimal, menciptakan generasi yang lebih sehat, sejahtera, dan harmonis secara fisik maupun emosional.

## F. Latihan Soal

### **Tugas 1: Studi Kasus tentang Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Mahasiswa diminta untuk memilih satu jenis IMS yang umum (misalnya klamidia, gonore, atau herpes genital), kemudian menulis studi kasus secara rinci. Dalam tugas ini, mahasiswa harus menjelaskan secara detail:

- Gejala klinis yang umum dijumpai pada infeksi tersebut.
- Metode deteksi dini yang tepat (jenis tes dan prosedur pemeriksaannya).
- Metode pengobatan yang efektif, termasuk nama obat, dosis, lama terapi, serta efek samping potensial.
- Strategi pencegahan yang dapat dilakukan oleh pasangan yang berencana menikah.

Mahasiswa diminta menyajikan kasus ini dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis.

### **Tugas 2: Merancang Program Edukasi Pencegahan HIV/AIDS untuk Pasangan Pranikah**

Mahasiswa diminta membuat proposal program edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran calon pasangan mengenai HIV/AIDS. Program ini harus mencakup:

- Latar belakang pentingnya edukasi HIV/AIDS dalam persiapan pernikahan.
- Informasi rinci tentang metode penularan HIV serta metode pencegahannya (penggunaan kondom, tes HIV rutin, terapi ARV dan PrEP).
- Strategi penyampaian materi (media sosial, webinar, video pendek, diskusi komunitas digital).
- Indikator evaluasi keberhasilan program edukasi yang diusulkan.

Proposal dibuat dalam format profesional dengan penjelasan rinci dan didukung oleh referensi akademik terbaru.

### **Tugas 3: Analisis Risiko Penyakit TORCH dan Strategi Pencegahannya**

Mahasiswa diminta membuat analisis mendalam mengenai risiko penyakit TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes) bagi pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Dalam analisis ini, mahasiswa harus:

- Menjelaskan secara rinci risiko dari masing-masing infeksi terhadap ibu hamil dan janin.
- Menguraikan langkah-langkah pencegahan yang efektif (imunisasi, praktik kebersihan, skrining laboratorium sebelum kehamilan).
- Menyusun rekomendasi langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan pasangan pranikah dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah infeksi TORCH.

Analisis dibuat dalam bentuk esai ilmiah minimal 5 halaman disertai referensi terbaru dari jurnal kesehatan reproduksi.

#### **Tugas 4: Pembuatan Konten Edukasi Seksual Berbasis Komunitas Digital**

Mahasiswa diminta untuk merancang konten edukasi seksual pranikah yang dapat digunakan dalam kampanye berbasis komunitas digital. Dalam tugas ini, mahasiswa harus:

- Menentukan platform digital yang akan digunakan (misalnya Instagram, YouTube, TikTok).
- Membuat storyboard dan rancangan konten dalam bentuk infografis atau video pendek.
- Memastikan bahwa konten yang dibuat informatif, kreatif, interaktif, serta relevan dengan target audiens (generasi muda pranikah).
- Memberikan penjelasan tentang strategi promosi konten agar dapat menjangkau audiens secara luas dan efektif.

Tugas ini diserahkan dalam bentuk dokumen lengkap, termasuk storyboard atau desain visual yang jelas dan menarik.

#### **Tugas 5: Wawancara dan Analisis Mengenai Stigma Pemeriksaan IMS Sebelum Menikah**

Mahasiswa diminta untuk melakukan wawancara mendalam dengan minimal 2 pasangan calon pengantin terkait pandangan mereka tentang pemeriksaan IMS sebelum menikah. Dalam wawancara ini, mahasiswa harus menggali:

- Persepsi pasangan terhadap stigma dan tabu dalam pemeriksaan IMS.
- Faktor-faktor yang menyebabkan keengganan atau motivasi pasangan untuk melakukan pemeriksaan IMS.
- Dampak potensial stigma terhadap keputusan pasangan untuk memeriksakan diri.

Hasil wawancara kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan teori stigma dan perilaku kesehatan, lalu dituliskan dalam bentuk laporan yang sistematis dan didukung referensi ilmiah. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi stigma dalam masyarakat.

#### **Pilihan Ganda**

1. Pasien perempuan usia 25 tahun datang ke klinik bidan dengan keluhan nyeri perut bawah, keputihan berwarna kekuningan, serta nyeri saat buang air kecil. Pasien memiliki riwayat berganti pasangan seksual lebih dari satu kali dalam setahun terakhir tanpa menggunakan kondom. Pemeriksaan usap vagina ditemukan bakteri Gram negatif.

Apa diagnosis IMS yang paling mungkin dialami pasien ini?

- A. Gonore
- B. Herpes genital
- C. HPV

- D. Sifilis
- E. Kandidiasis vagina

2. Seorang ibu hamil usia 28 tahun datang ke klinik kebidanan dengan hasil skrining positif terhadap virus herpes simplex tipe 2 (HSV-2). Ibu khawatir tentang risiko penularan pada bayinya. Apa rekomendasi tindakan paling tepat untuk persalinan ibu ini?
  - A. Persalinan normal dengan pemberian antibiotic
  - B. Persalinan normal dengan penggunaan antiseptik vagina
  - C. Persalinan melalui operasi caesar terencana
  - D. Persalinan normal dengan imunisasi neonatal segera setelah lahir
  - E. Persalinan normal tanpa tindakan khusus
3. Pasangan muda usia reproduktif datang untuk konsultasi pranikah. Mereka belum pernah melakukan pemeriksaan IMS sebelumnya karena merasa malu dan takut dengan stigma negatif dari lingkungan. Sebagai bidan, edukasi apa yang paling tepat diberikan kepada pasangan ini?
  - A. Menyarankan pasangan untuk tidak melakukan pemeriksaan jika merasa tidak nyaman
  - B. Mengedukasi pasangan tentang pentingnya pemeriksaan IMS sebagai tanggung jawab kesehatan reproduksi
  - C. Menyarankan penggunaan antibiotik profilaksis rutin sebelum menikah
  - D. Menyarankan pemeriksaan IMS hanya jika mengalami gejala
  - E. Menyarankan pasangan agar melakukan vaksinasi HPV tanpa pemeriksaan IMS lainnya
4. Seorang wanita usia 30 tahun positif HIV dan rutin minum obat ARV dengan hasil viral load tidak terdeteksi selama 1 tahun terakhir. Ia kini berencana hamil. Apa edukasi yang tepat diberikan mengenai risiko penularan HIV pada bayinya?
  - A. Risiko transmisi HIV masih tinggi walau viral load tidak terdeteksi
  - B. Risiko transmisi HIV sangat rendah hingga hampir tidak ada jika viral load tetap tidak terdeteksi selama kehamilan
  - C. Obat ARV harus dihentikan saat kehamilan karena berbahaya bagi bayi
  - D. Persalinan normal tanpa obat ARV sudah aman
  - E. Bayi wajib diisolasi setelah lahir agar tidak tertular HIV

5. Seorang wanita usia 27 tahun datang ke klinik dengan keluhan lesi kecil, bergerombol, terasa perih, gatal, dan nyeri pada area genital. Lesi ini muncul berulang terutama saat pasien stres atau kelelahan. Berdasarkan gejala klinis ini, diagnosis IMS yang paling mungkin adalah?
- A. Gonore
  - B. Herpes genital
  - C. Klamidia
  - D. Sifilis
  - E. HPV

**Kunci Jawaban:**

**1. Jawaban: A**

Pembahasan:

Gejala khas gonore adalah keputihan bernanah, nyeri perut bawah, nyeri saat buang air kecil, dan disebabkan oleh bakteri Gram negatif *Neisseria gonorrhoeae*. Riwayat berganti pasangan seksual tanpa kondom meningkatkan risiko IMS, khususnya gonore.

**2. Jawaban: C**

Pembahasan:

HSV-2 berisiko tinggi menular pada bayi selama proses persalinan per vaginam, terutama jika ibu mengalami infeksi primer atau lesi aktif. Operasi caesar terencana adalah metode terbaik untuk mencegah penularan virus herpes genital kepada bayi.

**3. Jawaban: B**

Pembahasan:

Edukasi yang tepat harus menekankan bahwa pemeriksaan IMS sebelum menikah adalah tindakan bertanggung jawab untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap kesehatan reproduksi dan bukan sesuatu yang memalukan atau negatif secara moral.

**4. Jawaban: B**

Pembahasan:

Kondisi undetectable = untransmittable (U=U) berarti jika ibu secara rutin minum ARV dan viral load tidak terdeteksi, risiko penularan HIV pada bayi sangat rendah bahkan hampir tidak ada.

**5. Jawaban: B**

Pembahasan:

Herpes genital ditandai dengan lesi yang terasa nyeri, gatal, perih, berbentuk vesikel kecil bergerombol yang muncul berulang kali saat tubuh mengalami stres atau kondisi kelelahan. Hal ini khas untuk infeksi virus HSV yang bersifat kronis dan kambuhan.

## G. Rangkuman Materi

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan penyakit yang menyebar melalui aktivitas seksual yang tidak terlindungi, termasuk hubungan vaginal, anal, maupun oral. IMS seperti klamidia, gonore, sifilis, herpes genital, dan HPV memiliki dampak serius terhadap kesehatan individu maupun pasangan seksual, terutama karena sering kali tidak menunjukkan gejala yang jelas di tahap awal sehingga penularannya menjadi tidak terkendali. IMS juga menimbulkan komplikasi serius dalam kehamilan seperti kelahiran prematur, cacat bawaan, hingga kematian bayi baru lahir. Pencegahan IMS yang efektif melibatkan praktik seksual aman, termasuk penggunaan kondom secara konsisten, membatasi jumlah pasangan seksual, dan komunikasi terbuka antara pasangan tentang riwayat seksual masing-masing. Deteksi dini IMS melalui pemeriksaan rutin sebelum menikah sangat penting untuk mengidentifikasi infeksi secara awal. Pengobatan IMS disesuaikan dengan penyebabnya, misalnya antibiotik untuk infeksi bakteri seperti gonore dan klamidia, serta antivirus untuk infeksi virus seperti herpes genital atau HPV. Edukasi seksual yang komprehensif merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan, deteksi, dan pengobatan IMS.

Dalam konteks pranikah, HIV/AIDS menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang serius terhadap pasangan maupun calon keturunan. HIV, virus penyebab AIDS, melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit oportunistik yang mengancam nyawa. Hingga kini belum ada obat yang menyembuhkan HIV, sehingga fokus utama adalah pada pencegahan melalui penggunaan kondom secara konsisten, skrining rutin sebelum menikah, serta penggunaan terapi profilaksis pra-pajanan (PrEP) bagi pasangan berisiko tinggi. Terapi antiretroviral (ARV) penting bagi individu HIV-positif untuk mengendalikan jumlah virus dalam tubuh, yang dapat mengurangi risiko transmisi secara signifikan bahkan mencapai kondisi undetectable = untransmittable (U=U). Edukasi pranikah juga harus melibatkan upaya mengurangi stigma terhadap individu HIV-positif agar mereka lebih terbuka melakukan pemeriksaan serta menjalani pengobatan secara rutin.

Penyakit menular kelompok TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus) juga perlu diwaspadai sebelum kehamilan karena infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi berat seperti keguguran, kelainan kongenital, hingga gangguan tumbuh kembang bayi. Pencegahan TORCH dilakukan dengan menjaga kebersihan pribadi, konsumsi makanan yang dimasak matang, vaksinasi rubella

sebelum kehamilan, serta skrining rutin. Edukasi mengenai penyakit TORCH sebelum menikah penting untuk meminimalkan risiko infeksi selama kehamilan.

Saat ini, terdapat tren edukasi seksual pranikah melalui komunitas digital yang berkembang pesat berkat kemajuan teknologi. Melalui media sosial dan aplikasi khusus, generasi muda dapat mengakses informasi akurat mengenai kesehatan seksual dalam format seperti infografis, video pendek, webinar interaktif, serta forum diskusi anonim. Edukasi berbasis komunitas digital ini membantu mengatasi keterbatasan akses informasi, stigma, serta tabu dalam membahas isu-isu seksual, sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya kesehatan seksual dan reproduksi.

Namun, isu stigma dan tabu terkait pemeriksaan IMS sebelum menikah masih menjadi tantangan serius. Banyak pasangan merasa malu atau takut dipandang negatif oleh masyarakat sehingga enggan melakukan pemeriksaan kesehatan seksual secara dini. Situasi ini meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang bagi kesehatan reproduksi dan seksual pasangan tersebut. Untuk mengatasi stigma ini, perlu edukasi berkelanjutan melalui kampanye media, melibatkan tokoh publik serta penyedia layanan kesehatan yang ramah, terbuka, dan menjaga kerahasiaan pasien. Dengan pendekatan komprehensif ini, pemeriksaan IMS akan dipandang sebagai tindakan bertanggung jawab untuk masa depan kesehatan pasangan dan generasi selanjutnya.



## H. Glosarium

### **Antibiotik**

Obat-obatan yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri, termasuk klamidia, gonore, dan sifilis dalam konteks IMS.

### **Antivirus**

Obat yang digunakan untuk mengurangi gejala serta frekuensi kekambuhan pada infeksi virus, seperti herpes genital dan Human Papillomavirus (HPV).

### **Cytomegalovirus (CMV)**

Virus dari kelompok herpes yang menyebabkan infeksi serius terutama jika terjadi pada ibu hamil, berisiko tinggi menyebabkan kelainan kongenital pada janin.

### **Deteksi Dini**

Proses identifikasi penyakit atau infeksi di tahap awal, sebelum gejala menjadi jelas atau sebelum kondisi semakin parah, melalui skrining rutin seperti tes darah, urin, atau usapan genital.

### **Edukasi Seksual**

Proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan berbasis bukti tentang kesehatan seksual dan reproduksi, bertujuan meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku, dan mengurangi risiko kesehatan seksual.

### **Herpes Genital**

Infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Herpes Simplex Virus (HSV) tipe 2, ditandai dengan munculnya lesi vesikular pada area genital, bersifat kronis dengan periode kekambuhan.

### **Human Immunodeficiency Virus (HIV)**

Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan kondisi AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), melemahkan tubuh terhadap infeksi oportunistik.

### **Human Papillomavirus (HPV)**

Virus penyebab infeksi menular seksual yang berpotensi kronis dan bisa menyebabkan kanker serviks serta kutil kelamin.

### **Imunisasi Rubella**

Vaksinasi untuk mencegah infeksi virus Rubella (campak Jerman), terutama direkomendasikan sebelum kehamilan untuk mencegah Sindrom Rubella Kongenital.

### **Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman (vaginal, anal, oral), mencakup infeksi seperti klamidia, gonore, sifilis, herpes genital, dan HPV.

### **Infografis**

Bentuk penyajian informasi berupa gabungan teks dan gambar yang disusun secara visual, sering digunakan dalam edukasi seksual digital untuk menyampaikan pesan secara jelas dan efektif.

**Klamidia**

Infeksi bakteri yang umum pada IMS, sering tanpa gejala, tetapi bisa menyebabkan infertilitas dan komplikasi kehamilan jika tidak diobati.

**Komplikasi Kongenital**

Kelainan atau gangguan bawaan pada janin yang terjadi selama masa kehamilan, sering disebabkan oleh infeksi seperti TORCH.

**Komunitas Digital**

Platform online seperti media sosial, forum, dan aplikasi khusus yang memungkinkan pertukaran informasi secara luas, interaktif, dan anonim.

**Kondom**

Alat kontrasepsi berbentuk pelindung yang efektif dalam mencegah penularan IMS, termasuk HIV, ketika digunakan secara konsisten dan benar selama aktivitas seksual.

**Pencegahan**

Tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko terjadinya penyakit atau infeksi melalui praktik yang aman, skrining rutin, imunisasi, dan edukasi.

**Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP)**

Terapi pencegahan dengan obat antivirus yang diminum oleh individu dengan risiko tinggi terinfeksi HIV, bertujuan mengurangi kemungkinan penularan virus.

**Profilaksis**

Tindakan pencegahan medis berupa pemberian obat-obatan tertentu sebelum paparan penyakit, seperti penggunaan PrEP untuk HIV.

**Rubella (Campak Jerman)**

Infeksi virus yang sangat berbahaya pada trimester pertama kehamilannya, berisiko menyebabkan kelainan kongenital serius pada janin.

**Sifilis**

Infeksi bakteri menular seksual yang memiliki beberapa tahap, ditandai dengan lesi awal (chancre) dan berisiko menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati.

**Sindrom Rubella Kongenital (Congenital Rubella Syndrome)**

Kelainan kongenital serius pada janin akibat infeksi virus Rubella saat kehamilan, yang meliputi gangguan jantung, pendengaran, penglihatan, serta retardasi mental.

**Skrining**

Pemeriksaan medis rutin yang bertujuan untuk deteksi dini penyakit sebelum gejala klinis muncul, seperti pemeriksaan IMS pra-nikah atau skrining TORCH sebelum kehamilan.

**Stigma dan Tabu**

Persepsi atau penilaian negatif oleh masyarakat terhadap individu atau pasangan yang melakukan pemeriksaan IMS, sering menghambat upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit seksual.

**Terapi Antiretroviral (ARV)**

Pengobatan medis yang digunakan untuk mengontrol perkembangan virus HIV dalam tubuh, dengan tujuan mengurangi viral load hingga tidak terdeteksi dan mencegah transmisi virus.

**Toksoplasmosis**

Infeksi parasit yang disebabkan oleh *Toxoplasma gondii*, yang berbahaya bagi ibu hamil karena dapat menimbulkan komplikasi serius pada janin.

**TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus)**

Kelompok infeksi yang sangat penting diperhatikan dalam kehamilan karena berisiko menyebabkan komplikasi serius pada janin dan ibu hamil.

**Undetectable = Untransmittable (U=U)**

Kondisi ketika jumlah virus HIV dalam darah tidak terdeteksi berkat terapi ARV, yang secara signifikan mengurangi risiko penularan virus HIV kepada pasangan atau bayi.

**Viral Load**

Jumlah virus HIV dalam darah seseorang yang positif HIV, digunakan untuk mengukur efektivitas terapi ARV.

**Webinar**

Seminar atau diskusi interaktif yang dilakukan secara daring, memungkinkan peserta berkomunikasi langsung dengan tenaga ahli tentang isu kesehatan seksual secara nyaman dan anonim.

## I. Daftar Pustaka

- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. U.S. Department of Health & Human Services. <https://www.cdc.gov/std/treatment-guidelines>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Summary of CDC STI treatment guidelines, wall chart. U.S. Department of Health & Human Services.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Update to CDC's treatment guidelines for gonococcal infection, 2020. MMWR, 69(50).
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Chlamydial infections – STI treatment guidelines. U.S. Department of Health & Human Services.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Clinical treatment of gonorrhea. U.S. Department of Health & Human Services.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2009). Condom effectiveness – male latex condoms and sexually transmitted diseases. U.S. Department of Health & Human Services.
- Manhart, L. E., & Koutsky, L. A. (2002). Condom use in prevention of human papillomavirus infections and associated cervical neoplasia: A systematic review. *Journal of Women's Health & Gender-Based Medicine*, 11(5), 515–520.
- Villa, L. L., Costa, R. L., Petta, C. A., Andrade, R. P., Ault, K. A., Giuliano, A. R., ... Barr, E. (2005). Prophylactic quadrivalent human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) L1 virus-like-particle vaccine in young women: A randomized double-blind placebo-controlled multicentre phase II efficacy trial. *The Lancet Oncology*, 6(5), 271–278.
- Vardas, E., Giuliano, A. R., Goldstone, S., Palefsky, J. M., Moreira, E. D., Penny, M., ... Seth, R. (2011). Use of condoms and the risk of genital human papillomavirus infection in men: A meta-analysis. *Clinical Infectious Diseases*, 52, 399–407.
- CDC STI Guidelines (2021) memberikan pedoman deteksi, pengobatan infeksi bakteri dan virus, termasuk gonore, klamidia, sifilis, herpes genital, dan HPV [cdc.gov](https://www.cdc.gov).
- CDC gonorrhea update (2020) menegaskan regimen tunggal ceftriaxone 500 mg IM sebagai terapi lini pertama untuk gonore [cdc.gov+9cdc.gov+9medicine.medscape.com+9](https://www.cdc.gov+9cdc.gov+9medicine.medscape.com+9).
- CDC chlamydia guidelines (2021) merekomendasikan doxycycline sebagai terapi utama, dengan azithromycin sebagai alternatif untuk pasien khusus .
- Condom effectiveness CDC (2009) menunjukkan kondom mengurangi penularan HPV, meski mungkin tidak sepenuhnya mencegahnya [frontiersin.org+4nitag-resource.org+4self.com+4](https://frontiersin.org+4nitag-resource.org+4self.com+4).
- Studi-sudi meta-analisis dan percobaan klinis (Manhart & Koutsky, 2002; Villa et al., 2005; Vardas et al., 2011) mendemonstrasikan pentingnya kondom dan vaksin HPV dalam pencegahan IMS

# Bab 7

## Fertilitas dan Manajemen Infertilitas

Fertilitas atau kesuburan adalah kemampuan alami seseorang atau pasangan untuk bereproduksi melalui hubungan seksual. Kesuburan adalah aspek vital yang harus dipahami pasangan dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi, karena menjadi kunci utama dalam keberhasilan memiliki keturunan. Namun, tidak semua pasangan memiliki kesuburan optimal. Sebagian pasangan menghadapi gangguan fertilitas atau infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk hamil setelah satu tahun berhubungan seksual secara teratur tanpa alat kontrasepsi. Pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor fertilitas, deteksi dini infertilitas, serta teknologi reproduksi sangat diperlukan untuk menyiapkan pasangan secara mental, fisik, dan sosial dalam menghadapi tantangan ini.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas pada pria dan wanita.
- Melakukan edukasi dan konseling deteksi dini gangguan fertilitas.
- Menjelaskan berbagai teknologi reproduksi berbantu seperti IVF dan IUI.
- Menganalisis tren penggunaan teknologi reproduksi di kalangan pasangan muda.
- Mengidentifikasi isu sosial-ekonomi yang terkait biaya dan akses teknologi reproduksi.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan dengan rinci berbagai faktor penyebab gangguan fertilitas pada pria dan wanita.
- Mengidentifikasi metode deteksi dini infertilitas.
- Menguraikan prosedur teknologi reproduksi berbantu dan implikasinya.
- Mengevaluasi tren popularitas penggunaan teknologi reproduksi pada generasi muda.
- Mengkaji secara kritis permasalahan mahal biaya dan keterbatasan akses teknologi reproduksi serta solusi praktis untuk mengatasinya.

### Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menguraikan faktor biologis, gaya hidup, lingkungan, dan psikologis yang mempengaruhi fertilitas pria dan wanita.
- Menguasai metode deteksi dini infertilitas melalui anamnesis dan pemeriksaan medis.
- Menjelaskan secara rinci proses IVF dan IUI serta kelebihan dan kekurangannya.
- Mengidentifikasi alasan meningkatnya popularitas teknologi reproduksi pada pasangan muda.
- Menganalisis dampak sosial dan ekonomi akibat tingginya biaya dan keterbatasan akses teknologi reproduksi.

## A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas Pria dan Wanita

Fertilitas atau kesuburan merupakan suatu kondisi biologis yang sangat esensial bagi pasangan yang menginginkan kehadiran anak dalam keluarga mereka. Namun, fertilitas manusia tidaklah sederhana dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berhubungan. Faktor-faktor ini mencakup aspek biologis, gaya hidup, lingkungan, dan psikologis, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap potensi reproduksi pria maupun wanita.

Dalam aspek biologis, wanita seringkali menghadapi berbagai kondisi yang bisa mengganggu proses alami reproduksi. Salah satu gangguan yang sering terjadi adalah masalah ovulasi, di mana sel telur tidak matang atau tidak dilepaskan secara rutin, mengakibatkan ketidaksuburan. Selain itu, kondisi seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS) juga menjadi penyebab umum infertilitas pada wanita. PCOS merupakan gangguan hormonal yang menyebabkan pembentukan banyak kista kecil di ovarium, mengganggu siklus menstruasi, dan menghambat proses ovulasi normal. Gangguan lain yang juga umum terjadi adalah endometriosis, yaitu kondisi ketika jaringan endometrium tumbuh di luar rongga rahim, yang dapat menyebabkan nyeri hebat dan hambatan signifikan dalam proses fertilisasi. Selain itu, masalah anatomi seperti gangguan pada saluran tuba fallopi, seperti penyumbatan atau perlengketan, juga secara langsung menghalangi bertemunya sperma dan ovum sehingga fertilisasi tidak dapat terjadi.

Pada pria, kesuburan sangat erat kaitannya dengan kondisi kualitas dan jumlah sperma yang dihasilkan. Jumlah sperma rendah atau oligospermia menjadi salah satu penyebab utama infertilitas pria, di mana jumlah sperma yang diproduksi kurang dari ambang normal untuk mendukung fertilisasi. Demikian juga, kualitas sperma yang buruk atau asthenospermia, di mana sperma memiliki motilitas (kemampuan bergerak) yang rendah, turut berkontribusi besar dalam menurunkan peluang pembuahan. Varikokel, yaitu kondisi pelebaran pembuluh darah vena pada skrotum, juga menjadi faktor penyebab infertilitas pria yang umum. Kondisi ini menyebabkan peningkatan suhu di testis yang dapat menurunkan produksi dan kualitas sperma. Gangguan hormonal seperti hipogonadisme, di mana tubuh pria menghasilkan hormon testosteron dalam jumlah yang rendah, juga dapat menyebabkan infertilitas.

Selain aspek biologis, gaya hidup yang tidak sehat juga secara signifikan mempengaruhi kesuburan pada pria dan wanita. Kebiasaan merokok diketahui secara luas memiliki dampak negatif pada fertilitas, karena bahan-bahan kimia dalam rokok dapat merusak kualitas sperma serta mengganggu fungsi ovarium pada wanita. Konsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan hormonal yang signifikan, serta menurunkan jumlah dan kualitas sperma secara drastis. Penggunaan narkoba, bahkan dalam dosis kecil sekalipun, terbukti merusak sistem reproduksi dan menyebabkan infertilitas yang serius. Pola makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi tinggi lemak jenuh, gula, dan makanan olahan, dapat menyebabkan obesitas, resistensi insulin, serta ketidakseimbangan hormon reproduksi.

Obesitas sendiri merupakan masalah serius yang sering dihubungkan dengan infertilitas, baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, obesitas bisa menyebabkan resistensi insulin yang memicu gangguan hormonal seperti PCOS. Sedangkan pada pria, kelebihan berat badan berhubungan erat dengan penurunan produksi hormon testosteron serta kualitas sperma yang rendah. Sebaliknya, aktivitas fisik yang terlalu rendah juga dapat memperparah kondisi ini, karena gaya hidup sedentari berkontribusi pada peningkatan berat badan dan penurunan kesehatan reproduksi secara keseluruhan.

Stres kronis juga menjadi bagian penting yang mempengaruhi fertilitas manusia. Dalam kondisi stres yang berkepanjangan, tubuh memproduksi hormon kortisol secara berlebihan yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi seperti estrogen dan testosteron. Stres yang tidak terkendali ini dapat mengganggu siklus menstruasi pada wanita dan menurunkan kualitas sperma pada pria, sehingga semakin memperkecil peluang kehamilannya.

Faktor lingkungan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesuburan. Di era modern ini, manusia sering terpapar oleh berbagai bahan kimia berbahaya, seperti pestisida yang terkandung dalam makanan, logam berat dari limbah industri, serta polutan di udara perkotaan. Semua ini terbukti mempengaruhi kualitas sperma serta fungsi ovarium. Selain bahan kimia, radiasi dari alat-alat elektronik seperti komputer, telepon genggam, atau peralatan rumah tangga lainnya, secara perlahan dapat mengganggu produksi sperma maupun proses ovulasi. Lingkungan kerja tertentu seperti pekerja pabrik kimia, tenaga kesehatan radiologi, atau pekerja pertanian juga memiliki risiko tinggi terpapar bahan-bahan toksik yang dapat menurunkan fertilitas secara signifikan.



Tidak kalah pentingnya adalah faktor psikologis. Tekanan sosial yang kuat, seperti tuntutan keluarga dan masyarakat untuk segera memiliki anak setelah menikah, seringkali menimbulkan beban psikologis yang besar bagi pasangan. Tekanan ini dapat menyebabkan kecemasan dan stres berkepanjangan, yang secara tidak langsung mengganggu keseimbangan hormon reproduksi. Kondisi psikologis seperti kecemasan dan depresi juga terbukti berhubungan dengan gangguan hormonal, siklus menstruasi yang tidak teratur, serta penurunan libido, yang semuanya berdampak negatif terhadap kesuburan.

Secara keseluruhan, fertilitas bukanlah suatu kondisi yang berdiri sendiri, melainkan hasil interaksi dari berbagai aspek kehidupan. Memahami dengan baik faktor-faktor tersebut merupakan langkah awal penting yang harus dilakukan pasangan dalam persiapan menuju kehidupan pernikahan dan kehamilan yang sehat. Dengan memiliki pemahaman yang lengkap dan tepat tentang berbagai faktor yang mempengaruhi fertilitas ini, maka setiap pasangan akan lebih mampu mengantisipasi serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, sehingga harapan memiliki keturunan yang sehat dapat lebih mudah tercapai.

## **B. Deteksi Dini Gangguan Fertilitas**

Deteksi dini gangguan fertilitas adalah langkah penting yang harus diperhatikan oleh setiap pasangan yang berencana memiliki keturunan. Proses ini sangat menentukan peluang keberhasilan intervensi medis yang akan diambil selanjutnya. Dengan melakukan deteksi sedini mungkin, pasangan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengatasi masalah yang ada sebelum kondisinya semakin kompleks atau bahkan irreversible. Deteksi dini yang dilakukan secara menyeluruh dan akurat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kesehatan reproduksi pasangan, sehingga penanganan yang spesifik dan tepat sasaran dapat diberikan oleh tenaga kesehatan.

Salah satu tahap awal yang sangat penting dalam proses deteksi dini adalah anamnesis medis yang menyeluruh. Anamnesis medis merupakan proses wawancara terstruktur oleh tenaga medis terhadap pasangan untuk menggali secara mendalam berbagai informasi yang relevan terkait kesehatan reproduksi mereka. Dalam anamnesis ini, salah satu aspek yang dikaji pada wanita adalah riwayat menstruasi dan siklus ovulasi. Pola menstruasi yang tidak teratur, nyeri hebat selama menstruasi, siklus yang terlalu pendek atau terlalu panjang, serta gejala-gejala lain yang menyertai seperti spotting atau perdarahan tidak normal,



dapat menjadi indikasi awal adanya gangguan fertilitas seperti endometriosis, sindrom ovarium polikistik (PCOS), ataupun gangguan hormonal lainnya.

Selain itu, dalam wawancara medis ini juga digali riwayat kesehatan seksual, termasuk adanya infeksi menular seksual di masa lalu, riwayat operasi ginekologi, atau riwayat penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau kelainan tiroid yang diketahui dapat berpengaruh signifikan pada fertilitas wanita. Riwayat keluarga juga penting untuk diidentifikasi, sebab beberapa gangguan reproduksi seperti endometriosis, PCOS, atau infertilitas yang disebabkan kelainan genetik memiliki kecenderungan menurun dalam keluarga.

Tak kalah pentingnya adalah mengkaji pola hubungan seksual pasangan, karena frekuensi, waktu, dan metode hubungan seksual yang tidak tepat juga dapat menjadi hambatan bagi kehamilan. Anamnesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kesehatan reproduksi pasangan serta untuk menentukan strategi diagnostik berikutnya.

Setelah tahap anamnesis selesai, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan medis yang terarah untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor penyebab infertilitas. Pemeriksaan medis pada wanita biasanya mencakup berbagai jenis tes laboratorium serta prosedur pencitraan. Salah satu tes laboratorium yang umum dilakukan adalah pemeriksaan hormon reproduksi, antara lain Follicle Stimulating Hormone (FSH), Luteinizing Hormone (LH), estrogen, progesteron, dan Anti-Mullerian Hormone (AMH). Hormon-hormon ini sangat penting karena masing-masing memiliki peran dalam proses ovulasi, maturasi folikel, serta fungsi ovarium secara keseluruhan. Misalnya, kadar FSH yang tinggi dapat mengindikasikan penurunan cadangan ovarium atau menopause dini, sementara kadar AMH membantu mengevaluasi cadangan ovarium dan potensi ovarium untuk menghasilkan sel telur yang sehat.

Selain tes hormonal, pemeriksaan ultrasonografi (USG) ovarium juga merupakan komponen diagnostik yang penting untuk wanita. USG ovarium dapat mendeteksi adanya kista, folikel yang abnormal, atau kelainan struktural seperti fibroid rahim yang mungkin menghambat proses kehamilan. Pemeriksaan pencitraan lainnya yang lazim dilakukan adalah histerosalpingografi (HSG), yakni sebuah prosedur diagnostik yang menggunakan sinar-X dan cairan kontras khusus yang disuntikkan ke dalam rahim dan saluran tuba. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat

mengevaluasi apakah saluran tuba terbuka dan normal atau justru mengalami sumbatan akibat perlengketan, endometriosis, atau infeksi.

Untuk pria, deteksi dini gangguan fertilitas umumnya dilakukan melalui analisis sperma yang menjadi dasar dalam evaluasi fertilitas pria. Analisis sperma ini mencakup pemeriksaan jumlah sperma, motilitas (kemampuan bergerak), serta morfologi atau bentuk sperma. Jumlah sperma yang terlalu sedikit (oligospermia), motilitas sperma yang rendah (asthenospermia), dan bentuk sperma yang tidak normal (teratozoospermia) dapat secara signifikan mengurangi peluang fertilisasi alami. Dari hasil analisis sperma ini, dokter dapat mengidentifikasi apakah infertilitas yang dialami pasangan berasal dari faktor pria atau wanita, atau bahkan keduanya.

Selain analisis sperma, pemeriksaan hormonal juga dilakukan pada pria, khususnya testosteron, LH, dan FSH. Pemeriksaan ini membantu untuk mengidentifikasi gangguan hormonal yang mungkin menjadi penyebab infertilitas pria, seperti hipogonadisme, yakni kondisi ketika tubuh pria tidak mampu memproduksi testosteron dalam jumlah cukup. Pemeriksaan ini memberikan gambaran tentang kesehatan sistem reproduksi pria secara keseluruhan, membantu dokter dalam menentukan terapi hormon yang diperlukan bila ditemukan ketidakseimbangan hormon.

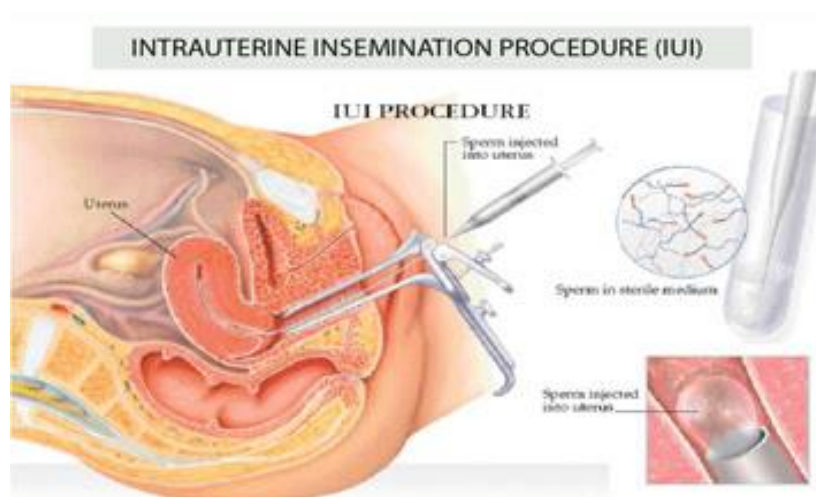
Pemeriksaan tambahan yang sering dilakukan adalah ultrasonografi testis yang berguna untuk mendeteksi kelainan struktural seperti varikokel, tumor, atau sumbatan pada saluran sperma. Varikokel adalah salah satu penyebab infertilitas pria yang paling umum dan sering terabaikan karena gejalanya tidak selalu jelas. Melalui ultrasonografi ini, varikokel dapat diidentifikasi secara jelas sehingga penanganan tepat bisa diberikan.

Dengan melakukan serangkaian prosedur deteksi dini ini, pasangan akan mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi fertilitas mereka. Ini memungkinkan dokter untuk membuat diagnosis yang akurat serta menyusun rencana pengobatan yang tepat dan personal. Intervensi dini yang didasarkan pada diagnosis yang akurat sangat berperan dalam meningkatkan peluang keberhasilan terapi infertilitas. Oleh karena itu, setiap pasangan yang merencanakan kehamilan sangat dianjurkan untuk secara rutin melakukan pemeriksaan fertilitas sedini mungkin sebagai bagian dari persiapan prakonsepsi mereka.

### C. Teknologi Reproduksi Berbantu (IVF, IUI)

Dalam perjalanan medis modern untuk mengatasi tantangan infertilitas, berbagai inovasi telah dikembangkan, salah satunya adalah Teknologi Reproduksi Berbantu atau Assisted Reproductive Technology (ART). ART merupakan kumpulan prosedur medis yang secara khusus dirancang untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan secara alami. Di antara banyak metode yang tersedia, dua metode yang paling umum dikenal dan banyak digunakan adalah Intrauterine Insemination (IUI) dan In Vitro Fertilization (IVF). Kedua metode ini memiliki karakteristik, tahapan, indikasi, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, serta peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai jenis gangguan infertilitas.

Salah satu metode ART yang lebih sederhana dan relatif kurang invasif adalah Intrauterine Insemination atau dikenal sebagai IUI. Prosedur ini melibatkan langkah memasukkan sperma yang telah diproses secara khusus ke dalam rongga rahim wanita secara langsung, mendekatkan sperma ke sel telur untuk meningkatkan peluang pembuahan alami. Sebelum dimasukkan, sperma melalui proses persiapan laboratorium untuk memilih sperma yang paling sehat dan paling aktif, sehingga mampu meningkatkan potensi fertilisasi secara signifikan.

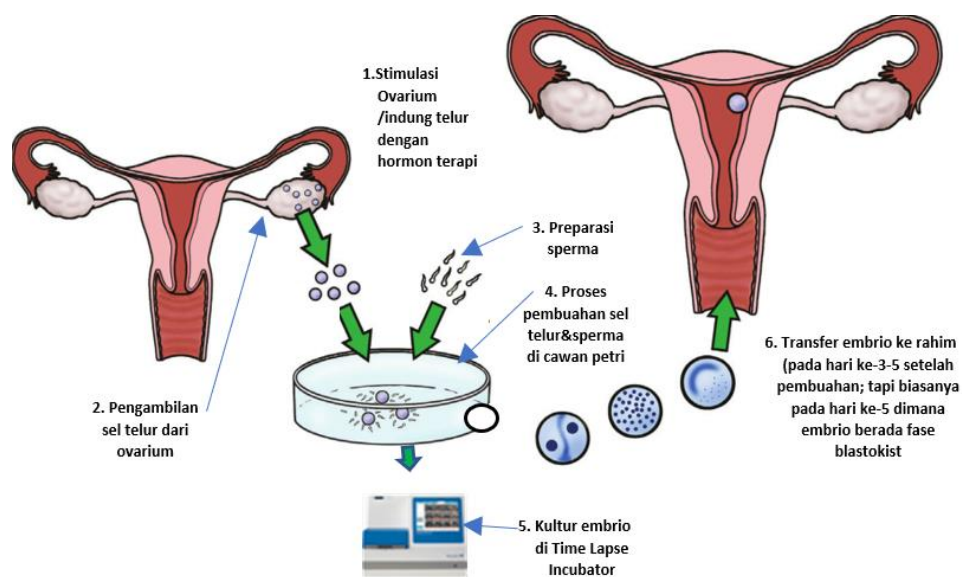


**Gambar 7.1**  
**Intrauterine Insemination (IUI)**

IUI umumnya direkomendasikan kepada pasangan yang mengalami gangguan fertilitas ringan hingga sedang, misalnya gangguan ringan kualitas sperma, gangguan lendir serviks yang menyulitkan perjalanan sperma menuju rahim, atau infertilitas yang tidak jelas penyebabnya (unexplained infertility). Teknik ini relatif sederhana dan nyaman bagi pasien karena tidak membutuhkan prosedur

pembedahan, sehingga pasangan sering kali lebih nyaman secara fisik maupun psikologis dalam menjalani metode ini.

Sebaliknya, metode lain yang lebih kompleks dan invasif namun memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi adalah In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung. IVF adalah prosedur fertilisasi yang dilakukan sepenuhnya di luar tubuh manusia, dalam lingkungan laboratorium yang terkendali dan steril. Metode ini melalui beberapa tahapan penting yang membutuhkan keterampilan medis dan teknologi yang sangat presisi.



**Gambar 7.2**  
**In Vitro Fertilization (IVF)**

Tahapan pertama dalam IVF adalah stimulasi ovarium, di mana wanita akan diberikan hormon tertentu untuk merangsang ovarium agar menghasilkan sejumlah besar folikel matang. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sel telur yang diperoleh cukup jumlahnya dan berkualitas tinggi. Setelah proses stimulasi, langkah berikutnya adalah pengambilan sel telur (ovum pick-up) yang biasanya dilakukan melalui prosedur bedah kecil menggunakan panduan ultrasonografi.

Sel telur yang diambil kemudian dipertemukan dengan sperma dalam sebuah medium khusus di laboratorium, di mana proses fertilisasi berlangsung di luar tubuh (in vitro). Setelah terjadi fertilisasi, embrio yang terbentuk dibiakkan di laboratorium selama beberapa hari, diawasi secara ketat untuk memastikan embrio berkembang dengan normal. Setelah mencapai tahap perkembangan tertentu, embrio yang

memiliki kualitas terbaik akan ditransfer kembali ke dalam rahim wanita melalui prosedur yang dikenal sebagai transfer embrio. Prosedur transfer embrio ini dilakukan secara sederhana tanpa anestesi, di mana embrio diletakkan secara hati-hati di dalam rahim untuk memungkinkan proses implantasi secara alami.

Metode IVF memiliki indikasi medis yang luas dan sering menjadi pilihan utama bagi pasangan dengan gangguan fertilitas berat, seperti jumlah atau kualitas sperma yang sangat rendah, sumbatan pada saluran tuba falopi, wanita dengan usia lanjut yang cadangan sel telurnya terbatas, serta pasangan yang telah mengalami kegagalan berulang dengan metode reproduksi berbantu lainnya. IVF merupakan metode yang memberikan peluang terbaik bagi pasangan yang menghadapi infertilitas kompleks, terutama ketika metode lainnya seperti IUI tidak berhasil.

Setiap metode ART memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kelebihan utama ART secara umum, baik IUI maupun IVF, adalah efektivitasnya yang tinggi dalam membantu pasangan memperoleh kehamilan, khususnya bagi mereka yang mengalami berbagai hambatan fertilitas yang sulit diatasi secara alami. Metode IVF bahkan mampu memberikan peluang kehamilan bagi pasangan dengan kondisi infertilitas yang sangat berat yang sebelumnya dianggap hampir mustahil mendapatkan keturunan secara alami.

Namun demikian, di balik efektivitas tersebut, terdapat beberapa kekurangan atau tantangan yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh pasangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya yang sangat mahal. IVF khususnya, melibatkan proses medis yang rumit, peralatan laboratorium yang canggih, serta tenaga medis terlatih khusus, yang menjadikan biaya prosedur ini relatif tinggi. Hal ini membuat IVF masih sulit diakses oleh semua lapisan masyarakat, terutama pasangan dengan keterbatasan finansial.

Selain aspek ekonomi, ART juga memiliki risiko medis tertentu yang perlu dipahami oleh pasien. Pada IVF, misalnya, prosedur stimulasi ovarium dapat menimbulkan risiko kondisi seperti sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS), yang walaupun jarang terjadi, namun dapat berakibat serius jika tidak ditangani dengan tepat. Ada pula risiko kehamilan ganda, yang dapat meningkatkan potensi komplikasi baik selama kehamilan maupun persalinan.

Aspek psikologis juga merupakan salah satu tantangan dalam penggunaan ART. Prosedur ART yang kompleks dan memakan waktu bisa menimbulkan beban

emosional yang signifikan bagi pasangan, seperti kecemasan, stres, perasaan bersalah, atau bahkan depresi, terutama jika upaya awal tidak berhasil. Meskipun demikian, dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan infertilitas, semakin banyak pasangan yang memilih metode ART ini sebagai solusi. Dengan pemahaman yang baik mengenai kelebihan, kekurangan, indikasi, dan risiko dari masing-masing metode ART, pasangan dapat membuat keputusan yang bijaksana dan tepat mengenai langkah yang akan mereka tempuh untuk memperoleh keturunan.

Dalam praktiknya, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi secara mendalam kepada pasangan yang menjalani ART, mengenai seluruh proses yang akan dilalui, potensi manfaat, kemungkinan risiko, serta beban biaya dan psikologis yang akan dihadapi. Pendekatan yang komprehensif ini membantu pasangan untuk tidak hanya siap secara medis, tetapi juga secara mental, emosional, dan finansial dalam menghadapi proses ART, sehingga dapat menjalani perjalanan menuju kehamilan yang lebih positif, sehat, dan penuh harapan.

#### **D. Tren: Popularitas Teknologi Reproduksi di Kalangan Pasangan Muda**

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi reproduksi berbantu atau Assisted Reproductive Technology (ART) seperti In Vitro Fertilization (IVF) dan Intrauterine Insemination (IUI) semakin populer di kalangan pasangan muda. Tren ini menunjukkan perubahan signifikan dalam cara pandang masyarakat, terutama kaum muda yang kini lebih terbuka terhadap berbagai opsi medis untuk memperoleh keturunan. Berbagai alasan mendasari meningkatnya minat pasangan muda dalam memanfaatkan teknologi reproduksi ini, yang mencakup faktor kesadaran kesehatan, perubahan gaya hidup, perkembangan sosial budaya, dan pengaruh kuat dari media sosial.

Salah satu alasan utama yang mendukung meningkatnya popularitas teknologi reproduksi di kalangan pasangan muda adalah semakin tingginya kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi sejak dini. Saat ini, pasangan muda jauh lebih teredukasi tentang isu-isu fertilitas dibanding generasi sebelumnya. Edukasi formal maupun informal melalui sekolah, seminar, webinar, dan berbagai platform digital semakin banyak tersedia, memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas dan pentingnya perencanaan prakonsepsi. Pasangan muda kini lebih menyadari bahwa menjaga kesehatan

reproduksi sejak awal sangat penting, dan bahwa kesuburan merupakan aspek kehidupan yang perlu direncanakan dengan matang, layaknya aspek kehidupan lainnya.

Selain meningkatnya kesadaran kesehatan reproduksi, pola kehidupan pasangan muda juga mengalami pergeseran yang cukup drastis dibanding generasi sebelumnya. Banyak pasangan muda kini memilih untuk menunda usia pernikahan dan kehamilan akibat tuntutan karir atau pendidikan. Mereka umumnya lebih fokus untuk mencapai stabilitas finansial, mengejar pendidikan tinggi, atau mengembangkan karir terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk memiliki anak. Penundaan ini menyebabkan sebagian pasangan akhirnya menghadapi tantangan fertilitas yang meningkat seiring bertambahnya usia. Sebagaimana diketahui, usia adalah faktor penting yang mempengaruhi kesuburan, terutama bagi wanita, di mana peluang kehamilan alami cenderung menurun secara signifikan setelah usia 35 tahun. Oleh karena itu, pasangan yang menunda memiliki anak sering kali memutuskan untuk memanfaatkan teknologi reproduksi sebagai solusi praktis dan efektif untuk mengatasi tantangan fertilitas yang muncul akibat faktor usia ini.

Selain itu, persepsi masyarakat yang semakin positif terhadap penggunaan teknologi reproduksi berbantu turut memengaruhi popularitas ART di kalangan pasangan muda. Pada masa lalu, penggunaan teknologi reproduksi sering kali dikaitkan dengan stigma negatif atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak alami. Kini, pandangan ini telah banyak berubah. Penggunaan teknologi seperti IVF dan IUI tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan. Sebaliknya, masyarakat, terutama kaum muda di perkotaan, cenderung melihat teknologi ini sebagai bentuk kemajuan medis yang perlu dimanfaatkan secara positif untuk membantu pasangan yang kesulitan memiliki keturunan. Terlebih lagi, banyak pasangan muda saat ini dengan terbuka dan percaya diri berbicara tentang pengalaman mereka menjalani ART, sehingga semakin mengikis stigma yang dulu ada di sekitar teknologi ini.

Perkembangan teknologi digital, terutama media sosial, juga berperan sangat besar dalam meningkatkan popularitas IVF dan IUI di kalangan pasangan muda. Media sosial telah menjadi platform utama di mana berbagai informasi kesehatan, termasuk informasi tentang teknologi reproduksi, dapat diakses secara cepat dan luas. Melalui media sosial, pasangan muda dengan mudah menemukan cerita sukses, testimoni, dan pengalaman nyata pasangan lain yang berhasil mendapatkan



keturunan melalui teknologi reproduksi berbantu. Kehadiran influencer, selebriti, dan tokoh publik yang secara terbuka membagikan perjalanan mereka menjalani IVF atau IUI turut menciptakan tren positif dan rasa penasaran yang besar di kalangan pasangan muda. Informasi yang terbuka dan jujur dari orang-orang yang mereka kagumi atau idolakan ini telah membantu mengubah persepsi masyarakat secara signifikan, menjadikan teknologi reproduksi tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga dianggap sebagai pilihan modern yang menarik dan inspiratif.

Tidak dapat dipungkiri, media sosial telah memberikan pengaruh besar dalam membangun komunitas digital di mana pasangan muda merasa didukung, dimotivasi, dan diberikan informasi yang diperlukan tentang langkah-langkah medis yang dapat mereka ambil dalam mengatasi tantangan fertilitas. Banyak pasangan muda sekarang aktif bergabung dalam forum-forum daring atau grup komunitas digital yang membahas secara terbuka tentang isu fertilitas dan teknologi reproduksi, di mana mereka bisa berbagi pengalaman, mendukung satu sama lain, serta mendapatkan wawasan dari tenaga medis profesional. Komunitas digital ini memberikan rasa nyaman, solidaritas, dan semangat positif, yang secara psikologis sangat membantu pasangan muda dalam mengambil keputusan untuk menjalani prosedur IVF atau IUI dengan lebih yakin dan percaya diri.

Secara keseluruhan, tren meningkatnya popularitas teknologi reproduksi di kalangan pasangan muda mencerminkan perubahan positif dalam cara masyarakat melihat infertilitas dan opsi medis yang tersedia untuk mengatasinya. Pasangan muda kini lebih siap secara mental, emosional, dan finansial dalam menghadapi proses ART. Tren ini merupakan indikator jelas bahwa teknologi reproduksi berbantu telah menjadi bagian integral dari gaya hidup modern yang semakin terbuka terhadap kemajuan medis, sekaligus menjadi harapan besar bagi pasangan muda yang menginginkan keturunan namun menghadapi berbagai tantangan fertilitas.

## **E. Isu: Mahalnya Biaya Teknologi Reproduksi dan Keterbatasan Aksesnya**

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi reproduksi berbantu atau yang dikenal dengan Assisted Reproductive Technology (ART), seperti In Vitro Fertilization (IVF) dan Intrauterine Insemination (IUI), memang semakin populer di kalangan pasangan yang mengalami gangguan fertilitas. Meski popularitasnya meningkat signifikan, penggunaan teknologi ini masih menghadapi tantangan besar berupa



biaya yang tinggi serta akses terbatas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tingginya biaya ART dan terbatasnya akses menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga penyedia layanan kesehatan.

Salah satu hambatan utama yang dialami pasangan dalam mengakses teknologi reproduksi berbantu adalah biaya prosedur yang sangat mahal. Biaya untuk menjalani satu siklus IVF di Indonesia bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, prosedur yang relatif lebih sederhana seperti IUI pun dapat mencapai belasan juta rupiah per siklusnya. Harga tersebut belum termasuk biaya tambahan untuk obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, konsultasi dokter spesialis, hingga biaya rawat inap jika diperlukan. Akibatnya, pasangan dari golongan ekonomi menengah ke bawah sering kali kesulitan atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk mengakses layanan ART ini.

Tingginya biaya tersebut menjadi semakin kompleks karena mayoritas program asuransi kesehatan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi biaya terkait prosedur teknologi reproduksi. Banyak perusahaan asuransi baik pemerintah maupun swasta yang mengecualikan atau hanya sedikit memberikan cakupan terhadap prosedur IVF maupun IUI, karena prosedur-prosedur ini masih sering dianggap sebagai layanan kesehatan tambahan (non-esensial). Kondisi ini mengakibatkan pasangan yang membutuhkan ART harus menanggung hampir seluruh biaya secara pribadi atau mandiri, sehingga meningkatkan beban finansial mereka secara signifikan. Tidak jarang pula pasangan yang akhirnya harus menjual aset pribadi, mengambil pinjaman besar, atau menguras tabungan hidup mereka demi mendapatkan kesempatan memiliki keturunan melalui teknologi reproduksi berbantu ini.

Selain persoalan biaya yang mahal, keterbatasan akses terhadap fasilitas dan tenaga medis yang menyediakan layanan ART juga menjadi tantangan serius, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis kepulauan. Sebagian besar klinik atau rumah sakit yang menyediakan layanan IVF maupun IUI masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan beberapa ibu kota provinsi lainnya. Pasangan yang tinggal di daerah terpencil atau kota-kota kecil umumnya tidak memiliki akses langsung ke fasilitas tersebut. Mereka sering kali harus melakukan perjalanan jauh yang memakan waktu, tenaga, dan biaya tambahan yang tidak sedikit, sekadar untuk mendapatkan konsultasi awal maupun pemeriksaan lanjutan. Kondisi ini sangat

membatasi kesempatan pasangan di daerah terpencil untuk mendapatkan pengobatan infertilitas yang efektif.

Selain keterbatasan fasilitas, minimnya jumlah spesialis reproduksi dan tenaga medis terlatih yang merata di seluruh Indonesia juga menjadi persoalan yang cukup kompleks. Spesialis reproduksi umumnya hanya tersedia di rumah sakit atau klinik tertentu, dan kebanyakan dari mereka berpraktik di pusat-pusat kota besar yang memiliki infrastruktur medis yang lengkap. Akibatnya, pasangan yang tinggal jauh dari pusat kota harus rela menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya membuat janji temu dengan spesialis, antrean panjang, hingga terbatasnya konsultasi langsung dengan dokter ahli. Situasi ini dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan yang sedang menjalani pengobatan infertilitas karena mereka harus menghadapi stres tambahan yang disebabkan oleh berbagai hambatan akses tersebut.

Untuk mengatasi persoalan mahal biaya dan keterbatasan akses layanan ART, dibutuhkan berbagai solusi strategis dan kebijakan yang holistik dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan lembaganya. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah melalui implementasi program subsidi atau bantuan keuangan khusus dari pemerintah bagi pasangan infertil yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Program subsidi semacam ini dapat membantu meringankan beban finansial pasangan, sekaligus meningkatkan aksesibilitas ART bagi masyarakat yang lebih luas. Beberapa negara maju telah sukses menerapkan program semacam ini, yang terbukti meningkatkan angka kelahiran dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Selain pemberian subsidi, langkah penting lainnya adalah mengintegrasikan layanan teknologi reproduksi ke dalam cakupan asuransi kesehatan yang lebih luas dan inklusif. Dengan demikian, pasangan tidak perlu lagi menanggung seluruh biaya ART secara pribadi. Pemerintah bersama dengan penyedia asuransi baik swasta maupun publik perlu bekerja sama dalam menciptakan skema asuransi reproduksi khusus yang mampu menjangkau lebih banyak kalangan. Dengan cakupan asuransi yang lebih luas dan jelas, pasangan infertil dari berbagai kalangan dapat memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan layanan ART tanpa harus merasa khawatir dengan besarnya beban keuangan yang harus mereka tanggung.

Di sisi lain, upaya untuk memperluas akses layanan ART ke seluruh wilayah Indonesia juga perlu dilakukan secara serius. Pemerintah dapat melakukan pemerataan fasilitas kesehatan khusus untuk infertilitas dengan cara membangun

dan meningkatkan kapasitas klinik atau rumah sakit yang mampu menyediakan layanan teknologi reproduksi di berbagai daerah di luar kota-kota besar. Selain itu, program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia seperti spesialis fertilitas, embriolog, perawat spesialis reproduksi, serta konselor fertilitas perlu ditingkatkan dan didistribusikan secara merata ke seluruh Indonesia. Dengan demikian, pasangan di daerah terpencil atau kota-kota kecil tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan reproduksi yang berkualitas tinggi.

Kampanye edukasi secara nasional juga menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi reproduksi berbantu ini. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak terkait harus terus melakukan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media tentang pentingnya pengobatan infertilitas dan opsi teknologi reproduksi yang tersedia. Edukasi ini perlu menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga informasi yang akurat mengenai ART, manfaatnya, risiko yang mungkin terjadi, serta cara-cara untuk mendapatkan layanan tersebut dapat diterima dengan baik dan merata.

Dengan penerapan solusi terpadu ini mulai dari program subsidi, peningkatan cakupan asuransi, pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah spesialis reproduksi, hingga kampanye edukasi secara luas, maka persoalan mahal biaya dan keterbatasan akses teknologi reproduksi di Indonesia dapat perlahan-lahan diatasi. Melalui langkah-langkah konkret ini, diharapkan semua pasangan infertil dari berbagai latar belakang ekonomi maupun geografis memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan bantuan medis yang mereka butuhkan dalam mewujudkan harapan memiliki keturunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia secara keseluruhan.

## **F. Latihan Soal**

### **Tugas 1: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas**

Mahasiswa diminta untuk membuat makalah mendalam mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi fertilitas pada pria dan wanita.

Makalah ini harus mencakup:

- Penjelasan rinci mengenai faktor biologis, gaya hidup, lingkungan, dan psikologis yang mempengaruhi fertilitas.
- Analisis kasus yang relevan mengenai gangguan fertilitas akibat faktor-faktor tersebut (minimal satu kasus untuk setiap faktor).

- Rekomendasi konkret tentang gaya hidup yang sebaiknya diterapkan oleh pasangan dalam menjaga kesehatan reproduksi sebelum pernikahan dan kehamilan.

Makalah disusun minimal 8 halaman, menggunakan referensi ilmiah terbaru dan terpercaya.

### **Tugas 2: Studi Kasus Deteksi Dini Gangguan Fertilitas**

Mahasiswa diminta membuat laporan studi kasus mengenai pentingnya deteksi dini gangguan fertilitas pada pasangan usia subur.

Dalam tugas ini, mahasiswa harus:

- Mendeskripsikan secara rinci prosedur deteksi dini gangguan fertilitas pada wanita (anamnesis medis, pemeriksaan hormon, ultrasonografi ovarium, dan HSG).
- Mendeskripsikan secara rinci prosedur deteksi dini gangguan fertilitas pada pria (analisis sperma, pemeriksaan hormon, ultrasonografi testis).
- Menjelaskan pentingnya deteksi dini untuk intervensi medis yang efektif melalui kasus nyata atau simulasi (fiktif) yang jelas.

Laporan studi kasus dibuat minimal 5 halaman dengan penyajian yang terstruktur dan didukung oleh referensi medis terbaru.

### **Tugas 3: Poster Edukatif tentang Teknologi Reproduksi Berbantu (IVF dan IUI)**

Mahasiswa diminta merancang poster edukasi untuk masyarakat awam yang menjelaskan teknologi reproduksi berbantu, khususnya IVF dan IUI.

Poster ini harus memuat:

- Penjelasan sederhana namun akurat mengenai prosedur IVF dan IUI, termasuk tahapannya.
- Indikasi medis kapan IVF atau IUI sebaiknya digunakan.
- Informasi tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing metode.
- Pesan edukasi tentang pentingnya konsultasi medis sebelum menjalani prosedur ART.

Poster harus menarik secara visual, informatif, jelas, serta mudah dipahami oleh masyarakat awam.

### **Tugas 4: Esai tentang Tren Popularitas Teknologi Reproduksi di Kalangan Pasangan Muda**

Mahasiswa diminta menulis esai kritis tentang meningkatnya popularitas teknologi reproduksi berbantu di kalangan pasangan muda.

Esai harus mencakup:

- Analisis mendalam mengenai perubahan persepsi masyarakat dan peran media sosial dalam popularitas ART.

- Dampak dari tren menunda pernikahan dan kehamilan terhadap peningkatan kebutuhan ART.
- Implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis dari meningkatnya penggunaan ART di kalangan pasangan muda.

Esai disusun minimal 6 halaman, menggunakan pendekatan analisis kritis yang didukung referensi jurnal kesehatan reproduksi terbaru.

### **Tugas 5: Proposal Program Mengatasi Mahalnya Biaya dan Keterbatasan Akses Teknologi Reproduksi di Indonesia**

Mahasiswa diminta menyusun proposal terperinci yang berisi usulan program atau kebijakan konkret untuk mengatasi mahal biaya dan keterbatasan akses terhadap teknologi reproduksi berbantu di Indonesia.

Proposal tersebut harus mencakup:

- Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pentingnya akses ART yang lebih merata.
- Gambaran detail kondisi biaya dan distribusi fasilitas ART saat ini di Indonesia.
- Rekomendasi spesifik yang meliputi subsidi pemerintah, pengembangan asuransi reproduksi khusus, dan pemerataan fasilitas ART.
- Strategi kampanye edukasi nasional mengenai ART.
- Indikator keberhasilan implementasi program atau kebijakan yang diusulkan.

Proposal dibuat minimal 10 halaman dalam format profesional, dilengkapi referensi ilmiah terbaru dan relevan.

### Pilihan Ganda

1. Seorang wanita usia 30 tahun datang ke klinik kebidanan mengeluhkan sulit hamil setelah 2 tahun menikah tanpa kontrasepsi. Pasien mengalami menstruasi tidak teratur sejak remaja, obesitas, serta ditemukan rambut halus tumbuh berlebihan pada wajah. Berdasarkan gejala klinis, kondisi yang paling mungkin dialami pasien adalah:
  - A. Endometriosis
  - B. Sindrom ovarium polikistik (PCOS)
  - C. Mioma uteri
  - D. Hipogonadisme
  - E. Salpingitis kronis
2. Seorang pria usia 35 tahun bersama istrinya datang ke klinik karena sulit mendapatkan keturunan selama 3 tahun menikah. Hasil analisis sperma menunjukkan jumlah sperma rendah (oligospermia). Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya pelebaran pembuluh darah di skrotum. Kondisi apakah yang paling mungkin dialami oleh pria ini?
  - A. Asthenospermia
  - B. Hipogonadisme
  - C. Varikokel
  - D. Teratozoospermia
  - E. Epididimitis kronis
3. Pasangan suami-istri usia 28 tahun datang berkonsultasi karena belum memiliki anak setelah 1,5 tahun menikah. Dari anamnesis didapatkan riwayat bahwa suami adalah perokok berat dan sering mengonsumsi alkohol. Faktor gaya hidup manakah yang paling berpengaruh negatif terhadap fertilitas pria ini?
  - A. Konsumsi makanan olahan
  - B. Aktivitas fisik rendah
  - C. Merokok dan konsumsi alkohol
  - D. Penggunaan obat hipertensi
  - E. Konsumsi tinggi gula
4. Seorang wanita usia 34 tahun datang ke bidan mengeluhkan nyeri hebat saat menstruasi dan sulit hamil setelah 3 tahun menikah. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan adanya jaringan endometrium di luar rahim. Apakah diagnosis yang paling tepat?

- A. Sindrom ovarium polikistik (PCOS)
- B. Endometriosis
- C. Mioma uteri
- D. Hidrosalping
- E. Hipogonadisme

5. Seorang pasangan muda usia 27 tahun datang berkonsultasi ingin menjalani pemeriksaan fertilitas. Dari wawancara awal, diketahui wanita tersebut mengalami menstruasi tidak teratur dan nyeri panggul. Pemeriksaan apakah yang paling tepat dilakukan pertama kali untuk mendeteksi adanya kelainan pada wanita ini?

- A. Pemeriksaan analisis sperma suami
- B. Ultrasonografi testis
- C. Pemeriksaan hormon FSH, LH, dan AMH serta ultrasonografi ovarium
- D. Pemeriksaan hormonal testosterone
- E. Pemeriksaan tekanan darah dan gula darah puasa

**Kunci Jawaban:**

1. **Jawaban: B**

Pembahasan:

PCOS ditandai dengan menstruasi yang tidak teratur, hirsutisme (rambut berlebih di wajah), dan obesitas. PCOS merupakan gangguan hormonal yang menyebabkan gangguan ovulasi, sehingga menyebabkan infertilitas.

2. **Jawaban: C**

Pembahasan:

Varikokel adalah pelebaran vena di skrotum yang menyebabkan peningkatan suhu testis, yang berakibat pada penurunan produksi dan kualitas sperma, terutama oligospermia.

3. **Jawaban: C**

Pembahasan:

Rokok dan alkohol secara signifikan menurunkan kualitas sperma, menurunkan jumlah sperma, serta mengganggu keseimbangan hormon reproduksi pria, menyebabkan infertilitas.

4. **Jawaban: B**

Pembahasan:

Endometriosis merupakan kondisi dimana jaringan endometrium tumbuh di luar rongga rahim, menyebabkan nyeri menstruasi hebat dan infertilitas akibat perlengketan dan gangguan tuba.

## 5. Jawaban: C

Pembahasan:

Untuk wanita dengan gangguan siklus menstruasi dan nyeri panggul, pemeriksaan hormonal (FSH, LH, AMH) serta ultrasonografi ovarium adalah pemeriksaan awal paling relevan untuk menilai fungsi ovarium dan kondisi patologis seperti PCOS atau endometriosis.

## G. Rangkuman Materi

Fertilitas atau kesuburan manusia merupakan hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait, seperti faktor biologis, gaya hidup, lingkungan, dan psikologis. Faktor biologis mencakup kondisi medis tertentu, seperti gangguan ovulasi pada wanita yang menyebabkan ketidakmatangan atau ketidaklepasan sel telur secara rutin. Sindrom ovarium polikistik (PCOS) juga menjadi penyebab umum infertilitas pada wanita, ditandai dengan adanya kista kecil pada ovarium yang mengganggu proses ovulasi. Gangguan lainnya adalah endometriosis, yaitu tumbuhnya jaringan endometrium di luar rahim yang menyebabkan nyeri hebat dan gangguan fertilisasi. Masalah anatomis seperti penyumbatan atau perlengketan saluran tuba falopi juga sering menghambat proses fertilisasi.

Pada pria, kondisi yang sangat berpengaruh terhadap fertilitas adalah kualitas dan jumlah sperma. Kondisi seperti oligospermia (jumlah sperma rendah) atau asthenospermia (motilitas sperma yang rendah) sangat mengurangi peluang fertilisasi. Varikokel, yaitu pelebaran vena pada skrotum, juga merupakan penyebab infertilitas yang umum pada pria karena meningkatkan suhu testis dan mengganggu kualitas sperma. Gangguan hormonal seperti hipogonadisme, di mana produksi hormon testosteron rendah, juga berkontribusi besar terhadap masalah infertilitas.

Selain faktor biologis, gaya hidup yang tidak sehat juga memberikan dampak negatif terhadap fertilitas. Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol secara berlebihan, serta penggunaan narkoba terbukti merusak sistem reproduksi. Pola makan yang buruk, seperti konsumsi tinggi lemak jenuh dan gula, serta kurangnya aktivitas fisik menyebabkan obesitas yang erat kaitannya dengan infertilitas. Obesitas pada wanita dapat memicu gangguan hormonal seperti PCOS, sementara pada pria menyebabkan penurunan produksi testosteron dan kualitas sperma. Selain itu, stres kronis juga memiliki dampak negatif karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi dan menurunkan peluang kehamilan.



Faktor lingkungan turut memainkan peran penting, di mana paparan bahan kimia seperti pestisida, logam berat, serta polutan udara secara signifikan dapat menurunkan kualitas sperma dan fungsi ovarium. Radiasi dari alat-alat elektronik seperti komputer dan ponsel juga dapat mempengaruhi kesuburan secara perlahan. Lingkungan kerja tertentu seperti pabrik kimia, bidang radiologi, dan pertanian memiliki risiko lebih tinggi dalam mempengaruhi fertilitas karena paparan bahan toksik.

Selain itu, faktor psikologis seperti tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat untuk segera memiliki keturunan dapat menyebabkan kecemasan dan stres yang berkepanjangan. Kondisi psikologis tersebut terbukti mengganggu keseimbangan hormon, menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur pada wanita, serta menurunkan libido, yang semuanya berdampak negatif terhadap kesuburan pasangan.

Deteksi dini gangguan fertilitas menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi masalah sejak awal. Langkah awal dalam deteksi ini adalah anamnesis medis secara menyeluruh, meliputi riwayat menstruasi, siklus ovulasi, riwayat kesehatan seksual, operasi sebelumnya, riwayat keluarga, serta pola hubungan seksual pasangan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan medis terarah seperti tes hormon reproduksi, ultrasonografi ovarium, dan histerosalpingografi (HSG) pada wanita. Pada pria, pemeriksaan utamanya berupa analisis sperma, pemeriksaan hormonal (testosteron, LH, FSH), serta ultrasonografi testis untuk mendeteksi kelainan struktural seperti varikokel.

Teknologi reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology - ART) seperti intrauterine insemination (IUI) dan in vitro fertilization (IVF) menjadi pilihan medis yang efektif dalam mengatasi infertilitas. IUI relatif sederhana dan digunakan pada kasus infertilitas ringan hingga sedang dengan menyuntikkan sperma langsung ke dalam rahim. IVF merupakan metode lebih kompleks yang melibatkan fertilisasi sel telur dan sperma di laboratorium. Proses IVF meliputi stimulasi ovarium, pengambilan sel telur, fertilisasi di luar tubuh, serta transfer embrio kembali ke rahim. Meski efektif, metode ini memiliki tantangan, seperti biaya tinggi, risiko medis tertentu (misalnya sindrom hiperstimulasi ovarium), serta beban emosional yang signifikan bagi pasangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi reproduksi ini semakin populer di kalangan pasangan muda akibat meningkatnya kesadaran kesehatan reproduksi, pola hidup yang berubah dengan menunda pernikahan serta kehamilan demi karir atau pendidikan, serta pengaruh positif media sosial. Kini, teknologi reproduksi tidak lagi dianggap tabu, melainkan sebagai solusi modern yang diterima secara sosial.

Namun, isu besar terkait teknologi reproduksi ini adalah biaya yang sangat mahal dan akses yang terbatas, terutama bagi masyarakat di luar kota besar dan dengan ekonomi menengah ke bawah. Kebanyakan asuransi kesehatan juga belum sepenuhnya mengakomodasi biaya prosedur ini. Oleh karena itu, penting adanya upaya strategis seperti subsidi pemerintah, cakupan asuransi reproduksi yang lebih inklusif, pemerataan fasilitas kesehatan, peningkatan sumber daya manusia di bidang reproduksi, serta kampanye edukasi nasional. Dengan solusi tersebut, harapan memiliki keturunan yang sehat bisa diwujudkan secara lebih merata oleh seluruh pasangan di Indonesia.

## H. Glosarium

### **Anamnesis medis**

Proses wawancara terstruktur antara tenaga kesehatan dan pasien untuk menggali riwayat kesehatan, terutama terkait kesehatan reproduksi.

### **Anti-Mullerian Hormone (AMH)**

Hormon yang digunakan untuk menilai cadangan ovarium wanita dan kemampuannya menghasilkan sel telur yang sehat.

### **Asthenospermia**

Kondisi di mana sperma memiliki motilitas (kemampuan gerak) yang rendah, mengurangi potensi fertilisasi.

### **Endometriosis**

Penyakit di mana jaringan endometrium tumbuh di luar rahim, menyebabkan nyeri haid hebat dan infertilitas.

### **Fertilitas**

Kemampuan alami individu atau pasangan untuk bereproduksi atau memiliki keturunan.

### **Follicle Stimulating Hormone (FSH)**

Hormon yang merangsang pertumbuhan folikel ovarium pada wanita, penting dalam proses ovulasi dan penanda cadangan ovarium.

### **Hirsutisme**

Pertumbuhan rambut berlebihan di tubuh wanita, biasanya akibat ketidakseimbangan hormon seperti pada sindrom ovarium polikistik (PCOS).

Histerosalpingografi (HSG)

Pemeriksaan diagnostik menggunakan sinar-X dan cairan kontras untuk mengevaluasi kondisi rahim dan saluran tuba falopi.

### **Hipogonadisme**

Kondisi rendahnya produksi hormon seks seperti testosteron pada pria yang menyebabkan gangguan fertilitas.

### **Infertilitas**

Ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah setahun atau lebih melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi.

### **Intrauterine Insemination (IUI)**

Prosedur reproduksi berbantu sederhana yang melibatkan penyuntikan sperma yang telah diproses ke dalam rahim secara langsung.

### **In Vitro Fertilization (IVF)**

Prosedur reproduksi berbantu di mana fertilisasi antara sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh (di laboratorium), kemudian embrio ditransfer kembali ke dalam rahim.

### **Motilitas sperma**

Kemampuan sperma bergerak secara aktif, menentukan kemampuan sperma mencapai sel telur untuk fertilisasi.

### **Oligospermia**

Kondisi jumlah sperma yang lebih rendah dari normal, yang menyebabkan penurunan peluang fertilisasi.

### **Ovulasi**

Proses pelepasan sel telur yang matang dari ovarium ke saluran tuba falopi, tahap penting dalam reproduksi.

### **Ovum pick-up**

Prosedur pengambilan sel telur dari ovarium pada proses IVF menggunakan panduan ultrasonografi.

### **Pestisida**

Zat kimia yang digunakan dalam pertanian untuk mengendalikan hama, namun berpotensi merusak kesuburan jika terpapar secara terus-menerus.

### **Polutan**

Bahan pencemar lingkungan yang berasal dari aktivitas industri, kendaraan bermotor, atau limbah rumah tangga, dapat memengaruhi kualitas sperma dan fungsi ovarium.

### **Progesteron**

Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan, penting untuk mempertahankan kehamilan.

### **Resistensi insulin**

Kondisi di mana tubuh tidak merespons insulin secara efektif, sering terkait dengan obesitas dan gangguan hormonal seperti PCOS.

**Sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS)**

Komplikasi potensial pada IVF di mana ovarium bereaksi secara berlebihan terhadap stimulasi hormon, dapat menyebabkan nyeri, pembengkakan ovarium, dan komplikasi serius lainnya.

**Sindrom ovarium polikistik (PCOS)**

Gangguan hormonal umum pada wanita yang ditandai oleh pembentukan banyak kista kecil di ovarium, menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur dan infertilitas.

**Stres kronis**

Kondisi stres berkepanjangan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi, gangguan menstruasi, dan penurunan kualitas sperma.

**Teratozoospermia**

Kondisi di mana sperma memiliki bentuk abnormal, mengurangi kemampuan sperma dalam fertilisasi alami.

**Testosteron**

Hormon seks utama pada pria yang penting dalam produksi sperma serta fungsi seksual dan reproduksi.

**Ultrasonografi (USG)**

Metode pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk memvisualisasi organ tubuh, termasuk ovarium dan testis.

**Varikokel**

Kondisi pelebaran pembuluh darah vena di skrotum, menyebabkan peningkatan suhu testis dan menurunkan kualitas sperma.

## I. Daftar Pustaka

- Anderson, K., Nisenblatt, V., & Norman, R. (2010). Lifestyle factors in people seeking infertility treatment - a review. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 50(1), 8–20. <https://doi.org/10.1111/j.1479-828X.2009.01119.x>
- Chavarro, J. E., Rich-Edwards, J. W., Rosner, B. A., & Willett, W. C. (2007). Diet and lifestyle in the prevention of ovulatory disorder infertility. *Obstetrics & Gynecology*, 110(5), 1050–1058. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000287293.25465.e1>
- Eisenberg, M. L., & Lipshultz, L. I. (2015). Varicocele-induced infertility: Newer insights into its pathophysiology. *Indian Journal of Urology*, 31(1), 58–64. <https://doi.org/10.4103/0970-1591.145294>
- Homan, G. F., Davies, M., & Norman, R. (2007). The impact of lifestyle factors on reproductive performance in the general population and those undergoing infertility treatment: A review. *Human Reproduction Update*, 13(3), 209–223. <https://doi.org/10.1093/humupd/dml056>
- Mascarenhas, M. N., Flaxman, S. R., Boerma, T., Vanderpoel, S., & Stevens, G. A. (2012). National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: A systematic

analysis of 277 health surveys. *PLOS Medicine*, 9(12), e1001356.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001356>

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2015). Diagnostic evaluation of the infertile female: A committee opinion. *Fertility and Sterility*, 103(6), e44–e50. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.03.019>

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2015). Diagnostic evaluation of the infertile male: A committee opinion. *Fertility and Sterility*, 103(3), e18–e25. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.12.103>

Rossi, B. V., Abusief, M., & Missmer, S. A. (2016). Modifiable risk factors and infertility: What are the connections? *American Journal of Lifestyle Medicine*, 10(4), 220–231. <https://doi.org/10.1177/1559827614558020>

Schenker, J. G. (2011). Ethical dilemmas in assisted reproductive technologies. *De Gruyter*, 45–58. <https://doi.org/10.1515/9783110240214.45>

Seli, E., & Arici, A. (Eds.). (2011). Recurrent implantation failure: Etiologies and clinical management. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1782-9>

Sharma, R., Biedenharn, K. R., Fedor, J. M., & Agarwal, A. (2013). Lifestyle factors and reproductive health: Taking control of your fertility. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 11(1), 66. <https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-66>

Sunderam, S., Kissin, D. M., Crawford, S. B., Folger, S. G., Boulet, S. L., Warner, L., & Barfield, W. D. (2015). Assisted reproductive technology surveillance—United States, 2013. *MMWR Surveillance Summaries*, 64(11), 1–25. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss6411a1>

Vander Borcht, M., & Wyns, C. (2018). Fertility and infertility: Definition and epidemiology. *Clinical Biochemistry*, 62, 2–10. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2018.03.012>

Zegers-Hochschild, F., Adamson, G. D., de Mouzon, J., Ishihara, O., Mansour, R., Nygren, K., ... Van der Poel, S. (2009). The international committee for monitoring assisted reproductive technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossary on ART terminology, 2009. *Human Reproduction*, 24(11), 2683–2687. <https://doi.org/10.1093/humrep/dep343>

# Bab 8

## Persiapan Sosial Budaya dan Lingkungan

Persiapan pranikah dan prakonsepsi tidak hanya mencakup aspek biologis dan medis, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial budaya dan lingkungan yang kompleks. Setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan membawa serta latar belakang budaya, tradisi, nilai-nilai keluarga, serta ekspektasi sosial yang berbeda-beda. Interaksi antara nilai-nilai ini dengan lingkungan keluarga besar dan komunitas sekitar sering kali menimbulkan tantangan tersendiri yang perlu dipahami dan dikelola dengan bijaksana. Pemahaman yang baik tentang dinamika sosial budaya dan lingkungan ini akan membantu pasangan dalam menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, sehingga mampu membangun fondasi keluarga yang kokoh, harmonis, dan sehat secara mental dan emosional.

### **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):**

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami dinamika sosial budaya dan lingkungan dalam konteks persiapan pranikah dan prakonsepsi, mengelola adaptasi sosial budaya dengan efektif, serta merancang edukasi dan strategi advokasi untuk mendukung pasangan dalam menghadapi tantangan sosial budaya dan lingkungan.

### **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):**

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh budaya lokal dalam persiapan pranikah, mendukung adaptasi pasangan baru di lingkungan keluarga besar, merancang edukasi keluarga besar untuk mendukung pasangan muda, menganalisis tren perubahan pola dukungan sosial dalam masyarakat modern, serta mengevaluasi isu konflik budaya dan adat dalam praktik pranikah dan prakonsepsi.

### **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK):**

- Mahasiswa mampu menjelaskan secara detail pengaruh budaya lokal terhadap persiapan pranikah dan implikasinya dalam kehidupan keluarga.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan proses adaptasi pasangan baru dengan lingkungan keluarga besar.
- Mahasiswa mampu merancang program edukasi keluarga besar dalam mendukung pasangan muda.
- Mahasiswa mampu menganalisis tren perubahan pola dukungan sosial dalam masyarakat modern dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga.
- Mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu konflik budaya dan adat yang timbul dalam praktik pranikah dan prakonsepsi serta merumuskan strategi penyelesaian yang efektif.

## A. Pengaruh Budaya Lokal terhadap Persiapan Pranikah

Pengaruh budaya lokal terhadap persiapan pranikah merupakan aspek penting yang harus dipahami secara mendalam oleh setiap pasangan yang berencana memasuki kehidupan rumah tangga. Indonesia, dengan keragaman budaya yang begitu luas, menghadirkan berbagai tradisi unik yang diwariskan secara turun-temurun melalui generasi, membentuk cara pandang, persepsi, serta tindakan individu dan keluarga dalam mempersiapkan pernikahan. Tradisi-tradisi ini bukan semata-mata rangkaian formalitas, melainkan sarat akan nilai simbolis yang berperan besar dalam membangun hubungan interpersonal antara kedua pasangan dan keluarga besar masing-masing.

Salah satu tahapan awal dalam budaya lokal Indonesia adalah prosesi lamaran. Adat lamaran ini tidak sekadar menjadi momen simbolis untuk menyatakan niat serius pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, namun juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua dan keluarga besar calon pasangan. Proses lamaran biasanya melibatkan lebih dari sekadar pasangan calon pengantin, tetapi juga seluruh keluarga besar dan bahkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam komunitas lokal. Setiap tahapan dalam proses ini memiliki makna filosofis yang mendalam, seperti penyerahan seserahan sebagai simbol kesiapan mempelai pria untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pasangan di masa depan. Selain itu, kehadiran keluarga besar serta tokoh masyarakat menandai pentingnya pengakuan sosial dan restu kolektif dalam ikatan pernikahan yang akan dibentuk, menciptakan pondasi yang kuat untuk kehidupan keluarga yang harmonis.

Selain lamaran, prosesi tunangan juga memegang peranan penting dalam budaya lokal. Tunangan dalam banyak budaya Indonesia dipandang sebagai suatu tahap formal yang mempererat hubungan kedua keluarga dan menjadi jembatan menuju kehidupan pernikahan yang lebih solid. Prosesi pertunangan biasanya ditandai dengan ritual-ritual simbolis seperti pertukaran cincin, pemberian hadiah-hadiah yang memiliki arti khusus, serta pertemuan resmi antara keluarga besar kedua calon mempelai. Tradisi pertunangan ini, selain mempererat hubungan keluarga besar, juga bertujuan menciptakan kesepahaman awal mengenai berbagai aspek kehidupan setelah pernikahan, seperti tanggung jawab finansial, pengaturan tempat tinggal, serta peran masing-masing anggota keluarga yang baru. Ritual ini secara tidak langsung membantu calon pasangan mengenali ekspektasi keluarga, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tuntutan kehidupan keluarga di masa depan.



Tradisi mas kawin atau mahar juga merupakan unsur penting dalam budaya lokal yang sangat diperhatikan oleh keluarga calon mempelai. Mas kawin memiliki variasi bentuk yang sangat beragam tergantung pada adat istiadat daerah dan suku. Di beberapa budaya, mas kawin berupa barang berharga seperti emas atau sejumlah uang tunai, sementara di daerah lainnya mas kawin bisa berupa barang simbolis seperti seperangkat alat ibadah, perlengkapan rumah tangga, atau bahkan hewan ternak. Setiap bentuk mas kawin ini memiliki makna yang mendalam, yakni sebagai penghormatan terhadap perempuan, sebagai tanda keseriusan pihak laki-laki dalam menafkahi keluarga, sekaligus sebagai simbol tanggung jawab sosial yang akan diemban dalam kehidupan keluarga. Pemahaman yang jelas mengenai makna dan tujuan dari mas kawin ini penting agar kedua calon mempelai bisa memaknai tradisi ini secara positif dan konstruktif, bukan sebagai beban yang memberatkan.

Di samping prosesi dan ritual adat tersebut, pengaruh budaya lokal juga secara signifikan membentuk ekspektasi keluarga besar terhadap pasangan yang akan menikah, khususnya mengenai peran gender dalam rumah tangga. Dalam banyak budaya lokal di Indonesia, peran tradisional yang sangat jelas masih dominan, yakni laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengelola rumah tangga serta pengasuh anak. Meskipun demikian, seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin modern, peran gender tradisional tersebut kini mulai bergeser, dan banyak pasangan muda mulai mengadopsi pandangan kesetaraan gender. Situasi ini seringkali menimbulkan gesekan antara nilai-nilai lama yang dipegang keluarga besar dengan pandangan baru yang dibawa oleh pasangan muda. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami ekspektasi tersebut secara mendalam, serta membuka ruang dialog dan negosiasi yang positif bersama keluarga besar agar tercapai kesepakatan peran yang sesuai dengan kebutuhan pasangan namun tetap menghargai nilai-nilai budaya setempat.

Selain itu, budaya lokal juga menuntut adanya kewajiban sosial yang cukup besar terhadap komunitas tempat tinggal. Pasangan yang baru menikah di beberapa daerah Indonesia seringkali diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti acara gotong royong, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas komunitas lainnya. Kewajiban sosial ini bertujuan menjaga ikatan sosial yang kuat dan memastikan integrasi pasangan baru ke dalam komunitas secara baik. Meski demikian, pasangan muda yang belum terbiasa dengan tuntutan sosial ini mungkin merasa kewalahan, sehingga penting untuk melakukan persiapan pranikah yang matang, termasuk diskusi tentang cara memenuhi ekspektasi



tersebut tanpa harus mengorbankan waktu pribadi atau keharmonisan rumah tangga mereka.

Dalam konteks persiapan pranikah yang komprehensif, pemahaman mendalam mengenai pengaruh budaya lokal sangatlah penting. Ketika pasangan mampu memahami dan menghormati nilai-nilai serta tradisi lokal, mereka akan lebih siap dalam menjalani berbagai tahapan pernikahan secara harmonis. Mereka juga lebih siap menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik budaya yang mungkin muncul di masa depan. Persiapan pranikah yang matang dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal tidak hanya akan memperkuat hubungan pasangan dengan keluarga besar dan komunitas, tetapi juga memastikan bahwa kehidupan keluarga yang dibangun nantinya mampu bertahan kuat di tengah dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengaruh budaya lokal terhadap persiapan pranikah merupakan aspek esensial yang harus diintegrasikan secara mendalam dalam setiap program edukasi pranikah dan prakonsepsi.

## **B. Adaptasi Pasangan Baru dengan Lingkungan Keluarga Besar**

Adaptasi pasangan baru dengan lingkungan keluarga besar merupakan suatu proses yang tidak sederhana dan sering kali menjadi tantangan yang cukup rumit serta membutuhkan kesadaran penuh dari setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berkeluarga. Proses adaptasi ini mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aspek sosial, emosional, budaya, hingga psikologis. Pasangan baru diharapkan untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh keluarga besar, baik dari sisi nilai-nilai, norma, kebiasaan, serta pola interaksi yang selama ini telah terbentuk dalam lingkungan keluarga besar tersebut.

Setiap keluarga besar pada hakikatnya memiliki karakteristik unik yang mencerminkan sejarah, latar belakang budaya, serta pola asuh yang diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Karakteristik unik ini sering kali berwujud dalam bentuk berbagai tradisi yang khas, seperti ritual keluarga, perayaan hari-hari besar, kebiasaan sehari-hari, hingga kebiasaan khusus yang muncul dalam situasi tertentu seperti kelahiran, pernikahan, atau kematian. Oleh karena itu, pasangan baru yang bergabung ke dalam lingkungan keluarga besar dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik terhadap tradisi-tradisi tersebut. Mereka perlu belajar dan menghormati setiap nilai serta kebiasaan yang berlaku dalam keluarga besar agar bisa diterima secara harmonis. Pasangan yang tidak memahami atau bahkan

mengabaikan tradisi tersebut, biasanya akan menghadapi berbagai kesulitan yang berpotensi memicu konflik antar anggota keluarga.

Selain dari tradisi keluarga, pasangan baru juga perlu menghadapi ekspektasi sosial yang sering kali sangat kuat dipegang oleh keluarga besar. Ekspektasi sosial ini bisa mencakup banyak hal seperti cara mengelola keuangan rumah tangga, pembagian peran antara suami dan istri, cara mendidik anak, hingga kewajiban sosial yang harus mereka jalankan dalam komunitas lokal. Misalnya, dalam keluarga yang lebih konservatif atau tradisional, suami diharapkan menjadi tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kondisi finansial, sementara istri lebih diharapkan untuk menjalankan peran domestik seperti mengurus anak-anak dan rumah tangga. Ekspektasi seperti ini, bila tidak dikomunikasikan dengan baik sejak awal, dapat menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga yang baru terbentuk.

Di sisi lain, pola komunikasi antar generasi di dalam keluarga besar juga sering menjadi tantangan tersendiri. Pasangan baru harus memahami bahwa setiap generasi dalam keluarga besar kemungkinan besar memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Generasi yang lebih tua mungkin terbiasa dengan komunikasi yang lebih formal, penuh penghormatan, dan mengedepankan hierarki sosial, sementara generasi yang lebih muda cenderung lebih terbuka, egaliter, dan santai dalam menyampaikan pendapat atau berdiskusi tentang berbagai hal. Pasangan baru dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap perbedaan pola komunikasi tersebut agar mereka dapat berinteraksi secara harmonis dengan semua anggota keluarga besar. Tanpa adanya kemampuan adaptasi komunikasi yang baik, konflik yang muncul akibat kesalahpahaman atau ketidakpekaan terhadap gaya komunikasi antar generasi dapat dengan mudah terjadi.

Dalam menghadapi tantangan adaptasi dengan lingkungan keluarga besar, peran pasangan sebagai tim yang solid sangat dibutuhkan. Dukungan emosional antar pasangan merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan proses adaptasi tersebut. Pasangan perlu memberikan dukungan satu sama lain, saling memahami kesulitan dan tantangan yang dialami, serta saling memperkuat dalam situasi sulit yang mungkin timbul akibat tekanan sosial atau harapan yang tidak sesuai dengan nilai pribadi mereka. Ketika pasangan dapat saling mendukung secara emosional, mereka akan lebih mudah menghadapi tantangan sosial yang muncul dari keluarga besar. Sebaliknya, kurangnya dukungan emosional antar pasangan akan

memperbesar risiko konflik internal yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga.

Selain dukungan emosional, komunikasi yang terbuka antara pasangan juga menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan adaptasi ini. Komunikasi terbuka ini mencakup kemampuan untuk saling berbicara secara jujur mengenai perasaan masing-masing, kekhawatiran, harapan, hingga rencana-rencana yang berkaitan dengan keluarga besar. Pasangan yang mampu menjalin komunikasi terbuka cenderung lebih berhasil dalam mengatasi berbagai perbedaan yang muncul, karena mereka mampu menyusun strategi bersama dan bernegosiasi dengan baik untuk menemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sekaligus juga dihormati oleh keluarga besar.

Dengan demikian, adaptasi pasangan baru dengan lingkungan keluarga besar memang merupakan suatu proses yang kompleks, tetapi juga merupakan proses penting yang harus dilewati dengan kesadaran penuh, saling pengertian, dan komunikasi yang efektif. Adaptasi yang berhasil akan membawa banyak manfaat bagi pasangan baru, tidak hanya dalam bentuk penerimaan yang hangat dari keluarga besar, tetapi juga dalam membangun fondasi rumah tangga yang harmonis dan kokoh. Oleh karena itu, setiap pasangan harus mempersiapkan diri secara matang dan menyeluruh, agar mampu menghadapi proses adaptasi ini dengan penuh kesiapan, bijaksana, dan optimisme dalam membangun kehidupan pernikahan yang langgeng dan bahagia.

### **C. Edukasi Keluarga Besar Dalam Mendukung Pasangan Muda**

Edukasi keluarga besar dalam mendukung pasangan muda adalah proses yang memiliki arti strategis dalam memastikan terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis, sehat, dan saling menghargai. Dalam budaya Indonesia, keluarga besar sering kali memiliki pengaruh besar dalam kehidupan rumah tangga pasangan baru. Keterlibatan keluarga besar ini bukan hanya mencakup hal-hal yang bersifat simbolis atau ritual semata, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan muda, seperti keputusan terkait keuangan, pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, hingga masalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, edukasi terhadap keluarga besar sangat penting untuk memastikan bahwa keterlibatan tersebut bersifat positif, mendukung, dan tidak menciptakan tekanan yang dapat merugikan pasangan muda.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam edukasi keluarga besar adalah pentingnya komunikasi yang efektif antar generasi. Perbedaan generasi biasanya membawa perbedaan cara pandang, nilai-nilai, norma, bahkan gaya komunikasi. Generasi yang lebih tua umumnya memiliki pola komunikasi yang lebih formal dan hierarkis, sementara generasi muda cenderung lebih terbuka, egaliter, dan informal dalam mengekspresikan diri. Tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai perbedaan ini, komunikasi antar generasi bisa dengan mudah berubah menjadi sumber ketegangan dan kesalahpahaman. Oleh sebab itu, keluarga besar perlu dididik tentang bagaimana menjalin komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh penghormatan terhadap generasi yang lebih muda. Edukasi ini mencakup keterampilan mendengarkan secara aktif, empati terhadap situasi pasangan muda, serta cara menyampaikan nasihat atau masukan dengan cara yang konstruktif, bukan dengan kritik atau intervensi yang dapat menekan pasangan muda.

Selain komunikasi yang efektif, edukasi keluarga besar juga perlu mencakup pemahaman tentang dinamika hubungan pasangan muda. Pasangan muda yang baru menikah umumnya masih dalam proses mencari keseimbangan dalam hubungan mereka, termasuk dalam menentukan peran masing-masing di dalam keluarga. Masa-masa awal pernikahan ini sangat krusial, di mana pasangan masih saling menyesuaikan diri, mencoba memahami kebutuhan satu sama lain, serta mulai merumuskan nilai-nilai keluarga yang baru. Dalam kondisi ini, keluarga besar harus memahami bahwa intervensi yang berlebihan justru bisa mengganggu proses adaptasi tersebut. Keluarga besar perlu diberikan pemahaman bahwa proses adaptasi tersebut memerlukan waktu, kesabaran, serta ruang yang cukup bagi pasangan muda untuk menyelesaikan berbagai perbedaan mereka secara mandiri. Dengan demikian, pasangan muda dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan rumah tangga mereka sendiri.

Hal lain yang perlu ditekankan dalam edukasi kepada keluarga besar adalah pentingnya menghormati keputusan pasangan muda dalam berbagai aspek kehidupan. Keluarga besar perlu memahami bahwa setiap pasangan muda memiliki hak penuh untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga mereka, mulai dari keputusan tentang keuangan, cara pengelolaan rumah tangga, hingga isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi. Dalam budaya yang cenderung kolektif, sering kali keputusan pasangan muda diintervensi atau bahkan didikte oleh keluarga besar yang merasa memiliki otoritas lebih besar dalam menentukan arah kehidupan keluarga. Edukasi dalam konteks ini bertujuan untuk mengubah paradigma keluarga besar agar lebih menghargai otonomi pasangan

muda, memberikan kebebasan untuk menentukan arah hidup mereka sendiri, dan mendukung pilihan mereka walaupun berbeda dengan pandangan generasi yang lebih tua. Dengan begitu, keluarga besar tidak hanya menjadi sumber nasihat atau dukungan emosional, tetapi juga menjadi fasilitator dalam membangun lingkungan yang positif dan mendukung.

Program edukasi kepada keluarga besar dapat dilaksanakan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan konteks keluarga serta karakteristik budaya lokal. Salah satu metode yang paling efektif adalah melalui pertemuan keluarga yang bersifat informal namun terarah. Pertemuan semacam ini memberikan ruang bagi semua anggota keluarga untuk berbicara secara terbuka, saling mendengarkan pendapat, serta mendiskusikan berbagai isu yang mungkin dihadapi pasangan muda. Pertemuan keluarga ini juga dapat difasilitasi oleh tenaga profesional, seperti konselor atau psikolog keluarga, untuk memastikan bahwa diskusi berlangsung secara sehat, konstruktif, dan fokus pada solusi yang terbaik bagi pasangan muda.

Selain pertemuan keluarga, workshop atau pelatihan khusus juga bisa menjadi pilihan yang efektif. Workshop ini bisa dirancang untuk menyampaikan informasi penting tentang cara-cara mendukung pasangan muda dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Workshop tersebut dapat mencakup berbagai topik, seperti komunikasi efektif antar generasi, manajemen konflik keluarga, cara menghormati otonomi pasangan muda, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak yang modern. Dengan melibatkan tenaga profesional yang kompeten, workshop ini tidak hanya mampu memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membantu keluarga besar untuk mempraktikkan keterampilan-keterampilan tersebut secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, konseling keluarga juga merupakan salah satu metode edukasi yang bisa dipilih. Konseling keluarga memberikan ruang aman bagi keluarga besar untuk mendiskusikan berbagai masalah atau konflik yang mungkin muncul dalam proses adaptasi dengan pasangan muda. Dengan pendekatan yang profesional, konseling keluarga dapat membantu keluarga besar memahami akar masalah, mengeksplorasi berbagai solusi alternatif, serta membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan harmonis bagi pasangan muda. Konseling keluarga juga berfungsi sebagai media untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga besar, sehingga mampu menciptakan iklim keluarga yang positif, penuh dukungan, dan jauh dari konflik yang merugikan pasangan muda.

Secara keseluruhan, edukasi keluarga besar tentang pentingnya mendukung pasangan muda adalah upaya yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis. Dengan edukasi ini, keluarga besar diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan dan dukungan positif bagi pasangan muda, bukan sebaliknya menjadi sumber tekanan atau konflik. Dalam jangka panjang, edukasi ini akan membantu pasangan muda dalam membangun kehidupan rumah tangga yang kuat, harmonis, bahagia, serta mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam perjalanan hidup mereka bersama.

#### **D. Tren: Perubahan Pola Dukungan Sosial dalam Masyarakat Modern**

Perubahan pola dukungan sosial dalam masyarakat modern merupakan fenomena yang sangat menarik dan penting untuk dipahami secara mendalam, terutama dalam konteks persiapan pranikah dan prakonsepsi. Dalam sejarahnya, pola dukungan sosial di Indonesia dan banyak negara lain biasanya sangat bergantung pada keluarga besar sebagai sumber utama informasi, dukungan emosional, dan bantuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan keluarga baru. Keluarga besar secara tradisional memainkan peran sentral dalam memberikan nasihat, panduan moral, serta bantuan praktis seperti merawat anak, mengelola rumah tangga, dan memberikan dukungan finansial dalam situasi tertentu. Namun, seiring dengan perubahan sosial ekonomi, perkembangan teknologi, serta dinamika demografis dan mobilitas masyarakat, pola ini mengalami transformasi signifikan menuju bentuk dukungan sosial yang lebih kompleks dan beragam.

Salah satu perubahan utama dalam pola dukungan sosial adalah pergeseran dari pola berbasis keluarga besar menuju pola yang semakin berbasis komunitas dan media digital. Tren ini didorong oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah meningkatnya mobilitas pasangan muda, di mana semakin banyak pasangan yang berpindah tempat tinggal karena tuntutan pendidikan, pekerjaan, atau mencari lingkungan yang dianggap lebih sesuai dengan gaya hidup mereka. Akibat mobilitas tinggi ini, banyak pasangan muda terpisah secara fisik dari keluarga besar mereka, yang sebelumnya merupakan sumber dukungan utama. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak bagi pasangan muda untuk mencari alternatif dukungan sosial yang tidak lagi bergantung pada kedekatan fisik atau geografis dengan keluarga besar mereka.

Selain faktor mobilitas, tuntutan pekerjaan yang tinggi dan perubahan gaya hidup masyarakat urban modern juga memiliki dampak signifikan terhadap pola dukungan sosial yang terbentuk. Dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin sibuk, pasangan muda biasanya menghadapi keterbatasan waktu untuk secara rutin bertemu atau berkomunikasi secara intens dengan anggota keluarga besar mereka. Akibatnya, mereka cenderung mencari bentuk dukungan sosial yang lebih fleksibel, mudah diakses, dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Dalam konteks ini, media digital muncul sebagai solusi yang paling efektif karena menawarkan akses cepat, mudah, serta tanpa batas geografis untuk mendapatkan informasi, nasihat, maupun dukungan emosional dari berbagai pihak yang relevan.

Fenomena ini semakin diperkuat oleh perubahan pola komunikasi dalam keluarga besar itu sendiri, di mana banyak generasi yang lebih tua kurang fasih atau kurang nyaman menggunakan teknologi komunikasi modern seperti media sosial, aplikasi chat, atau platform digital lainnya. Sebaliknya, generasi muda tumbuh dengan keakraban terhadap teknologi digital, yang membuat mereka lebih nyaman mencari dan berbagi informasi melalui media digital dibandingkan melalui komunikasi tradisional. Pola komunikasi digital yang terbuka, anonim, dan informal juga memberikan kenyamanan psikologis tersendiri bagi pasangan muda, terutama dalam mendiskusikan topik-topik sensitif yang mungkin sulit dibicarakan secara terbuka dengan keluarga besar.

Dalam pola dukungan sosial modern ini, komunitas digital memainkan peran yang sangat signifikan. Komunitas digital yang terbentuk melalui forum online, grup media sosial, atau platform khusus lainnya menyediakan ruang bagi pasangan muda untuk saling berbagi pengalaman, bertukar pikiran, serta saling memberikan dukungan emosional tanpa tekanan atau ekspektasi sosial yang kadang muncul dalam interaksi keluarga besar. Dalam komunitas digital, pasangan muda juga dapat mengakses pendapat dan perspektif yang lebih beragam dari orang-orang yang mungkin memiliki latar belakang berbeda, pengalaman hidup yang bervariasi, serta pemahaman yang lebih luas tentang berbagai isu kehidupan keluarga modern. Dengan demikian, komunitas digital menawarkan dukungan sosial yang lebih inklusif, fleksibel, dan beragam dibandingkan dukungan yang lebih tradisional dari keluarga besar.

Di sisi lain, komunitas berbasis lingkungan tempat tinggal atau komunitas yang terbentuk berdasarkan kesamaan minat, hobi, atau pekerjaan juga semakin berkembang sebagai sumber dukungan sosial yang signifikan. Pasangan muda

sering kali terlibat aktif dalam komunitas lokal, seperti kelompok parenting, komunitas hobi, atau kelompok profesional yang memberikan rasa solidaritas, pengakuan sosial, serta dukungan praktis dalam kehidupan sehari-hari mereka. Komunitas-komunitas ini juga cenderung memiliki dinamika yang lebih egaliter, di mana anggota saling mendukung secara setara tanpa adanya hierarki sosial yang kuat seperti dalam keluarga besar tradisional.

Perubahan pola dukungan sosial ini membawa implikasi penting bagi para tenaga pendidik, konselor pernikahan, bidan, dan profesional lainnya yang bergerak di bidang pelayanan keluarga dan kesehatan reproduksi. Mengetahui dan memahami tren ini memungkinkan mereka untuk merancang berbagai program dukungan sosial yang lebih relevan dan efektif bagi pasangan muda. Program-program tersebut harus mampu memanfaatkan keunggulan media digital serta komunitas berbasis minat untuk menyediakan informasi yang valid, dukungan emosional yang tepat, serta panduan praktis yang bermanfaat bagi pasangan muda. Misalnya, tenaga profesional dapat mengembangkan konten edukasi digital yang interaktif seperti webinar, video edukatif, atau infografis yang menarik di media sosial, sehingga pasangan muda dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja.

Selain itu, profesional juga perlu memperhatikan bahwa dalam pola dukungan sosial modern, privasi dan anonimitas sering kali menjadi faktor penting yang dicari oleh pasangan muda. Oleh karena itu, layanan konsultasi daring, konseling jarak jauh, atau platform konsultasi digital yang menjamin privasi dan kerahasiaan pengguna menjadi semakin relevan dan diminati. Dengan demikian, pasangan muda akan merasa lebih nyaman, aman, serta percaya diri dalam mencari bantuan profesional tanpa rasa khawatir akan penilaian atau intervensi sosial yang tidak diinginkan.

Secara keseluruhan, tren perubahan pola dukungan sosial dari yang berbasis keluarga besar menuju komunitas digital dan lokal merupakan fenomena kompleks yang perlu dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak terkait. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tren ini, berbagai bentuk dukungan sosial yang lebih efektif, relevan, serta adaptif terhadap kebutuhan pasangan muda dapat dikembangkan. Pada akhirnya, dukungan sosial yang tepat akan membantu pasangan muda menjalani kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan modern dengan lebih baik dan percaya diri.



## **E. Isu: Konflik Budaya dan Adat dalam Praktik Pranikah dan Prakonsepsi**

Konflik budaya dan adat dalam praktik pranikah dan prakonsepsi merupakan fenomena yang umum dijumpai, terutama dalam masyarakat yang kaya akan keragaman budaya seperti Indonesia. Konflik ini muncul terutama ketika pasangan calon pengantin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda atau ketika pasangan muda memiliki nilai-nilai, pemahaman, serta pandangan modern yang berbeda dengan generasi yang lebih tua dalam keluarga besar mereka. Hal ini menjadikan konflik budaya dan adat bukan sekadar tantangan sederhana, melainkan sesuatu yang kompleks, sensitif, dan memerlukan perhatian khusus agar tidak berkembang menjadi hambatan serius dalam kehidupan rumah tangga yang baru akan dibentuk.

Salah satu bentuk konflik yang sering muncul adalah perbedaan persepsi tentang konsep pernikahan itu sendiri. Di dalam masyarakat tradisional, pernikahan umumnya dianggap sebagai sebuah ikatan sosial yang tidak hanya melibatkan pasangan itu sendiri tetapi juga dua keluarga besar yang harus dipersatukan melalui berbagai upacara adat dan tradisi yang rumit dan panjang. Sebaliknya, pasangan muda yang tumbuh dalam lingkungan yang lebih modern sering kali memiliki pandangan bahwa pernikahan merupakan ikatan personal antara dua individu, di mana keputusan-keputusan penting terkait kehidupan rumah tangga mereka merupakan hak eksklusif pasangan tersebut. Perbedaan persepsi semacam ini bisa memunculkan kesalahpahaman, ketegangan, dan bahkan konflik terbuka ketika pasangan mencoba menjalani prosesi pranikah, karena keluarga besar mungkin akan merasa diabaikan atau tidak dihormati jika tradisi yang selama ini dipandang penting tidak diikuti oleh pasangan muda.

Selain perbedaan persepsi mengenai makna pernikahannya, konflik juga dapat muncul dari tradisi keluarga yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi pasangan muda. Dalam berbagai budaya lokal, ada tradisi tertentu yang dianggap penting oleh generasi sebelumnya namun dinilai tidak relevan, bahkan bertentangan dengan prinsip pasangan muda yang lebih modern atau memiliki wawasan global. Tradisi seperti penentuan tanggal pernikahan yang wajib melalui perhitungan khusus oleh sesepuh keluarga, ritual adat yang kompleks, hingga pemberian mas kawin yang harus mengikuti standar tertentu, dapat menjadi pemicu konflik serius jika pasangan muda merasa dipaksa untuk mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan keyakinan atau keinginan mereka. Dalam situasi ini,

pasangan muda sering kali menghadapi dilema antara menghormati keinginan keluarga besar mereka atau mempertahankan nilai-nilai pribadi dan integritas prinsip mereka sendiri.

Tekanan sosial yang datang dari keluarga besar dan komunitas sekitar juga sering memperburuk konflik ini. Di dalam masyarakat tradisional yang erat dengan komunitasnya, keluarga besar biasanya sangat terpengaruh oleh pandangan komunitas mengenai bagaimana sebuah pernikahan harus dilaksanakan. Pasangan muda mungkin merasakan tekanan besar untuk mematuhi norma-norma komunitas karena khawatir akan menghadapi stigma, kritik, atau bahkan pengucilan sosial jika mereka tidak mengikuti tradisi atau adat yang berlaku secara ketat di masyarakat mereka. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis yang signifikan bagi pasangan, karena mereka harus menyeimbangkan keinginan pribadi dengan ekspektasi sosial yang kadang bertentangan secara tajam.

Untuk mengelola dan menyelesaikan konflik budaya dan adat ini, diperlukan pendekatan yang sangat hati-hati, empatik, dan penuh kebijaksanaan. Salah satu strategi terpenting adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara pasangan dengan keluarga besar mereka. Pasangan harus mampu menyampaikan keinginan, pandangan, dan prinsip mereka secara jelas dan terbuka kepada keluarga besar, namun tetap menjaga rasa hormat dan pengertian terhadap nilai-nilai yang dianut keluarga. Sebaliknya, keluarga besar pun harus dibantu untuk memahami perspektif pasangan muda, sehingga mereka bisa melihat bahwa perbedaan pandangan bukanlah sebuah ancaman melainkan sebuah peluang untuk saling memahami dan memperkaya pemahaman antar generasi.

Dalam kasus-kasus tertentu, mediasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan dihormati oleh semua pihak dapat menjadi solusi yang efektif. Mediator ini bisa berupa tokoh agama, tokoh adat, atau tenaga profesional seperti konselor pernikahan dan keluarga. Mediator akan membantu kedua pihak untuk menyuarakan pandangan mereka secara lebih jelas dan saling mendengarkan secara aktif tanpa prasangka atau emosi negatif yang berlebihan. Dalam proses mediasi ini, mediator juga memiliki peran strategis untuk membantu merancang kompromi atau solusi bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dengan tetap menghormati nilai-nilai inti yang dipegang oleh masing-masing pihak yang terlibat.

Selain komunikasi terbuka dan mediasi yang baik, pendekatan edukasi dan advokasi juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik budaya dan adat ini. Edukasi bertujuan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada semua pihak, baik kepada pasangan muda maupun keluarga besar, mengenai nilai-nilai budaya masing-masing serta pentingnya penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Edukasi ini bisa diselenggarakan dalam berbagai bentuk, mulai dari seminar keluarga, workshop khusus pranikah, hingga sesi konseling keluarga yang difasilitasi oleh tenaga profesional. Tujuan dari edukasi ini adalah agar setiap pihak mampu melihat bahwa perbedaan budaya bukan merupakan ancaman, tetapi justru bisa menjadi kekayaan yang memperkuat hubungan antar keluarga jika dikelola dengan baik.

Advokasi juga merupakan elemen penting yang harus disertakan dalam penyelesaian konflik ini. Advokasi berfokus pada mendorong penghargaan terhadap hak-hak pasangan muda dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Melalui advokasi, pasangan muda diharapkan bisa lebih berdaya dalam menyampaikan pandangan mereka tanpa rasa takut terhadap tekanan sosial atau stigma negatif dari komunitas. Di sisi lain, advokasi juga mengajak komunitas dan keluarga besar untuk menghormati dan mendukung pilihan pasangan muda, terutama dalam hal-hal yang bersifat prinsipil seperti keputusan terkait kesehatan reproduksi, pengelolaan ekonomi keluarga, maupun pilihan gaya hidup yang sehat dan seimbang.

Dengan pendekatan komunikasi yang terbuka, mediasi yang efektif, serta edukasi dan advokasi yang intensif, konflik budaya dan adat dalam praktik pranikah dan prakonsepsi diharapkan bisa dikelola dengan baik. Pemahaman yang mendalam tentang konflik ini memungkinkan mahasiswa dan tenaga profesional untuk memberikan pendampingan yang efektif dan strategis kepada pasangan, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan sosial budaya dan lingkungan dengan lebih percaya diri. Pada akhirnya, pendekatan ini bertujuan menciptakan fondasi yang kokoh bagi kehidupan keluarga yang sehat, harmonis, serta menghormati nilai-nilai budaya masing-masing, sehingga pasangan dapat memasuki kehidupan rumah tangga dengan kesiapan emosional, sosial, dan budaya yang matang.

## F. Latihan Soal

### **Tugas 1: Analisis Komparatif Tradisi Pranikah**

Mahasiswa diminta untuk memilih dua budaya lokal yang berbeda di Indonesia dan melakukan analisis komparatif mengenai tradisi pranikah dalam kedua budaya tersebut. Analisis harus meliputi makna filosofis di balik tradisi seperti prosesi lamaran, tunangan, dan mas kawin. Mahasiswa juga harus membahas implikasi sosial budaya tradisi tersebut bagi pasangan muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

### **Tugas 2: Studi Kasus Adaptasi Pasangan dengan Keluarga Besar**

Mahasiswa diharuskan untuk melakukan wawancara mendalam dengan satu pasangan yang baru menikah mengenai pengalaman mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan keluarga besar. Mahasiswa kemudian harus membuat laporan terperinci mengenai tantangan yang dihadapi pasangan tersebut, strategi adaptasi yang mereka gunakan, serta rekomendasi praktis yang dapat diberikan bagi pasangan lain dalam situasi serupa.

### **Tugas 3: Rancangan Program Edukasi Keluarga Besar**

Mahasiswa diminta untuk merancang sebuah program edukasi keluarga besar untuk mendukung pasangan muda secara efektif. Dalam rancangan program ini, mahasiswa harus menjelaskan tujuan program, metode yang digunakan (pertemuan keluarga, workshop, konseling), materi yang disampaikan (komunikasi antar generasi, pemahaman dinamika pasangan muda, penghormatan terhadap keputusan pasangan muda), serta indikator keberhasilan program tersebut.

### **Tugas 4: Kajian Tren Dukungan Sosial Berbasis Digital**

Mahasiswa diminta untuk menyusun esai ilmiah tentang perubahan pola dukungan sosial di masyarakat modern, khususnya dalam konteks persiapan pranikah. Esai harus mencakup analisis faktor-faktor yang menyebabkan tren pergeseran dari dukungan keluarga besar ke komunitas digital, dampak tren tersebut terhadap kehidupan pasangan muda, serta rekomendasi bagaimana tenaga profesional bisa memanfaatkan tren ini dalam memberikan layanan edukasi pranikah yang efektif.

### **Tugas 5: Strategi Penyelesaian Konflik Budaya dalam Praktik Pranikah**

Mahasiswa harus membuat laporan studi kasus yang mendalam tentang konflik budaya yang terjadi pada satu pasangan pranikah yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Laporan ini harus menjelaskan akar masalah konflik budaya tersebut, dampaknya terhadap pasangan, serta pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik (komunikasi terbuka, mediasi, edukasi, dan advokasi). Mahasiswa juga diminta memberikan rekomendasi praktis yang bisa digunakan pasangan lain dalam menghadapi tantangan serupa.

### Pilihan Ganda

1. Seorang perempuan berusia 24 tahun, berasal dari daerah Jawa, akan menikah dengan pasangannya yang berasal dari suku Minangkabau. Ia mengalami kesulitan menerima tradisi "uang jemputan" yang wajib diberikan keluarga calon mempelai pria dalam budaya Minang. Sebagai bidan yang memberikan konseling pranikah, apa tindakan paling tepat yang dapat Anda lakukan?
  - A. Menyarankan pasangan tersebut untuk menolak secara tegas tradisi tersebut
  - B. Menyarankan pasangan agar mengikuti saja tanpa diskusi agar tidak menimbulkan konflik
  - C. Mengajak pasangan untuk memahami makna filosofis di balik tradisi tersebut dan mendorong dialog terbuka
  - D. Meminta keluarga perempuan agar menyesuaikan dengan budaya pria
  - E. Mengabaikan masalah ini karena bukan masalah kesehatan
  
2. Pasangan muda yang akan menikah berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Mereka mengeluhkan tekanan sosial yang besar dari keluarga besar dalam menentukan tempat tinggal setelah menikah. Sebagai tenaga kesehatan yang mendampingi persiapan pranikah, langkah terbaik apa yang Anda rekomendasikan untuk mengatasi masalah ini?
  - A. Menyarankan pasangan agar mengikuti saja keputusan keluarga besar
  - B. Memberikan dukungan agar pasangan menjauh dari keluarga besar untuk menghindari tekanan
  - C. Menyarankan pasangan agar menolak semua bentuk campur tangan keluarga
  - D. Memfasilitasi mediasi antara pasangan dan keluarga besar agar tercapai kesepakatan Bersama
  - E. Menyarankan pasangan untuk memilih budaya dominan salah satu pihak agar konflik mereda
  
3. Seorang perempuan berusia 26 tahun merasa tertekan dengan ekspektasi keluarga besar calon suaminya yang berasal dari daerah tradisional. Keluarga tersebut memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peran perempuan dalam urusan rumah tangga. Sebagai bidan yang memberikan edukasi pranikah, edukasi seperti apakah yang paling tepat diberikan kepada keluarga besar?
  - A. Meminta keluarga besar untuk sepenuhnya mengubah tradisi dan nilai budaya mereka
  - B. Mengedukasi keluarga besar tentang pentingnya menghormati keputusan dan peran yang telah disepakati pasangan muda

- C. Menginstruksikan pasangan muda untuk menghindari komunikasi langsung dengan keluarga besar
  - D. Menyarankan keluarga besar untuk tidak terlibat sama sekali dalam kehidupan rumah tangga pasangan
  - E. Mengarahkan pasangan untuk mengikuti semua ekspektasi keluarga agar harmonis
4. Seorang laki-laki 27 tahun berasal dari budaya Batak dan calon istrinya berasal dari budaya Sunda. Mereka kesulitan menyesuaikan adat mas kawin yang sangat berbeda. Sebagai seorang bidan yang memberikan edukasi pranikah, apa pendekatan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut?
- A. Menyarankan mereka untuk tidak menggunakan adat mas kawin
  - B. Mengarahkan pasangan untuk memilih mas kawin sesuai budaya dominan calon suami saja
  - C. Meminta kedua keluarga untuk menentukan mas kawin tanpa melibatkan pasangan
  - D. Mengedukasi pasangan dan keluarga mengenai pentingnya dialog terbuka dan kompromi yang menghormati kedua budaya
  - E. Menyarankan pasangan menggunakan tradisi budaya Sunda saja untuk menyederhanakan masalah
5. Pasangan muda mengalami konflik dengan keluarga besar karena keinginan mereka untuk melaksanakan pernikahan secara sederhana tanpa mengikuti tradisi adat yang rumit dan mahal. Mereka mengalami stres dan kebingungan. Sebagai tenaga kesehatan, intervensi apa yang paling tepat dilakukan untuk membantu pasangan ini?
- A. Menyarankan pasangan agar mengikuti saja tradisi keluarga besar untuk menghindari konflik
  - B. Meminta pasangan untuk menjauh dari keluarga besar agar tidak mendapat tekanan lebih lanjut
  - C. Memfasilitasi edukasi dan mediasi bersama keluarga besar tentang pentingnya menghargai pilihan pasangan muda
  - D. Menginstruksikan pasangan untuk mengadakan pernikahan secara diam-diam agar tidak diketahui keluarga
  - E. Mengarahkan keluarga besar agar membatalkan semua tradisi yang sudah turun-temurun

## **Kunci Jawaban**

### **1. Kunci Jawaban: C**

#### **Pembahasan:**

Dalam menghadapi perbedaan tradisi budaya antar pasangan, pendekatan terbaik adalah mengajak pasangan untuk memahami makna filosofis tradisi tersebut dan membuka dialog terbuka. Pemahaman yang mendalam akan makna adat membantu mereka menerima dan menghargai tradisi tanpa merasa terpaksa.

### **2. Kunci Jawaban: D**

#### **Pembahasan:**

Mediasi merupakan solusi paling tepat dalam mengatasi konflik budaya yang melibatkan keluarga besar. Melalui mediasi, pasangan dan keluarga dapat saling mendengarkan, memahami pandangan masing-masing, serta menemukan solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa mengorbankan hubungan baik.

### **3. Kunci Jawaban: B**

#### **Pembahasan:**

Edukasi yang tepat adalah membantu keluarga besar memahami pentingnya menghormati otonomi pasangan muda dalam menentukan peran dan keputusan rumah tangga mereka. Cara ini dapat mengurangi tekanan terhadap pasangan muda sambil tetap menghargai nilai budaya keluarga besar.

### **4. Kunci Jawaban: D**

#### **Pembahasan:**

Pendekatan terbaik dalam menyelesaikan perbedaan terkait adat mas kawin adalah melalui edukasi mengenai pentingnya dialog terbuka dan kompromi yang menghormati kedua budaya. Dengan demikian, pasangan dan keluarga besar bisa menemukan solusi bersama yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi masing-masing pihak.

### **5. Kunci Jawaban: C**

#### **Pembahasan:**

Intervensi terbaik adalah memfasilitasi edukasi dan mediasi bersama keluarga besar agar memahami pentingnya menghormati pilihan pasangan muda, terutama dalam konteks keuangan dan psikologis. Cara ini membantu menciptakan solusi kompromi yang mengakomodasi keinginan pasangan muda tanpa mengabaikan sepenuhnya tradisi keluarga besar.

## G. Rangkuman Materi

Pengaruh budaya lokal sangat penting dalam persiapan pranikah karena setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi unik dengan makna simbolis mendalam yang diwariskan secara turun-temurun. Prosesi lamaran, misalnya, merupakan bentuk penghormatan serius dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan, melibatkan keluarga besar serta tokoh masyarakat, dan mencerminkan kesiapan calon mempelai dalam memikul tanggung jawab. Demikian pula dengan prosesi tunangan yang menjadi sarana mempererat hubungan antar keluarga besar dan menciptakan kesepahaman awal terkait kehidupan pasca pernikahan. Mas kawin atau mahar juga merupakan unsur penting dalam budaya lokal dengan beragam bentuk simbolis yang menunjukkan penghargaan dan tanggung jawab calon mempelai pria. Budaya lokal juga sangat berpengaruh dalam menentukan ekspektasi keluarga besar terhadap peran gender di dalam rumah tangga dan partisipasi pasangan dalam kehidupan komunitas. Pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan ekspektasi ini membantu pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial budaya serta menghindari konflik yang mungkin muncul, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan keluarga yang harmonis.

Adaptasi pasangan baru dengan lingkungan keluarga besar merupakan proses kompleks yang mencakup berbagai aspek sosial, emosional, budaya, dan psikologis. Setiap keluarga besar memiliki karakteristik unik yang terwujud dalam berbagai tradisi dan pola interaksi, sehingga pasangan baru dituntut untuk memahami dan menghormati nilai-nilai tersebut agar diterima secara harmonis. Selain tradisi, ekspektasi sosial yang kuat dari keluarga besar terkait pengelolaan rumah tangga, peran gender, dan tanggung jawab sosial juga sering menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan pola komunikasi antar generasi, antara yang lebih formal dengan yang informal, juga bisa memicu kesalahpahaman jika tidak diatasi dengan baik. Untuk berhasil melewati tantangan ini, pasangan harus mampu membangun komunikasi terbuka serta saling memberikan dukungan emosional secara penuh. Dengan demikian, proses adaptasi ini tidak hanya memudahkan integrasi pasangan ke dalam keluarga besar, tetapi juga memperkuat fondasi kehidupan rumah tangga mereka.

Edukasi keluarga besar dalam mendukung pasangan muda memegang peranan strategis dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Dalam budaya kolektif di Indonesia, keluarga besar sering memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pasangan muda dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengelolaan



keuangan, pengasuhan anak, dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada keluarga besar tentang komunikasi efektif antar generasi, dinamika hubungan pasangan muda, serta pentingnya menghormati keputusan dan otonomi pasangan muda. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pertemuan keluarga informal, workshop, atau konseling keluarga yang difasilitasi oleh tenaga profesional. Dengan edukasi yang baik, keluarga besar dapat menjadi sumber dukungan positif yang membantu pasangan muda dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.

Tren perubahan pola dukungan sosial dalam masyarakat modern menunjukkan pergeseran signifikan dari dukungan yang berbasis keluarga besar ke dukungan berbasis komunitas dan media digital. Hal ini terjadi karena meningkatnya mobilitas pasangan muda yang berpindah tempat tinggal akibat tuntutan pekerjaan atau pendidikan, serta keterbatasan waktu dalam berkomunikasi intensif dengan keluarga besar. Sebagai alternatif, pasangan muda kini lebih sering mencari informasi dan dukungan emosional melalui media digital seperti forum online dan komunitas digital yang dianggap lebih fleksibel, nyaman, serta anonim. Perubahan pola komunikasi dalam keluarga besar, di mana generasi tua kurang akrab dengan teknologi digital, turut memperkuat tren ini. Komunitas lokal berbasis minat, hobi, atau pekerjaan juga berkembang sebagai sumber dukungan sosial yang efektif dan egaliter. Pemahaman akan tren ini sangat penting bagi tenaga profesional dalam merancang program edukasi dan konsultasi yang relevan, memanfaatkan media digital dan komunitas lokal, serta menyediakan layanan yang menjaga privasi pengguna untuk memberikan dukungan maksimal bagi pasangan muda.

Konflik budaya dan adat dalam praktik pranikah dan prakonsepsi merupakan isu kompleks yang kerap terjadi di Indonesia, terutama pada pasangan dengan latar belakang budaya berbeda atau pasangan dengan pandangan modern yang bertentangan dengan nilai tradisional keluarga besar. Konflik ini sering muncul dari perbedaan persepsi tentang konsep pernikahan, tradisi keluarga yang tidak sejalan dengan nilai pribadi pasangan muda, serta tekanan sosial dari komunitas yang kuat dalam menjaga tradisi. Untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati melalui komunikasi yang terbuka, mediasi oleh pihak netral, serta edukasi dan advokasi untuk menghormati perbedaan pandangan. Dengan pendekatan ini, pasangan muda dan keluarga besar bisa mencapai kompromi dan saling memahami sehingga terbentuk fondasi kuat bagi kehidupan keluarga yang sehat, harmonis, serta menghormati keragaman budaya.

## H. Glosarium

### **Adaptasi Sosial**

Proses penyesuaian diri pasangan baru terhadap norma-norma, tradisi, dan pola interaksi keluarga besar agar dapat diterima secara harmonis.

### **Advokasi**

Upaya aktif untuk mendukung dan memperjuangkan hak pasangan muda dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga mereka, terutama dalam menghadapi tekanan sosial atau budaya.

### **Budaya Lokal**

Sistem nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas tertentu yang memengaruhi cara pandang dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

### **Ekspektasi Sosial**

Harapan atau tuntutan dari keluarga besar atau komunitas terhadap pasangan muda mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti peran gender, pengelolaan rumah tangga, atau partisipasi dalam aktivitas sosial.

### **Edukasi Keluarga Besar**

Program atau kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada keluarga besar tentang pentingnya komunikasi yang efektif, menghormati keputusan pasangan muda, serta mendukung adaptasi pasangan baru ke dalam keluarga.

### **Ikatan Sosial**

Hubungan interpersonal yang kuat antara pasangan baru dengan keluarga besar serta komunitas lokal, biasanya diperkuat melalui keterlibatan dalam tradisi dan kegiatan sosial bersama.

### **Komunikasi Antar Generasi**

Proses pertukaran informasi, ide, nilai, dan perasaan antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda dalam keluarga besar yang dapat membantu menghindari konflik atau kesalahpahaman.

### **Komunitas Digital**

Kelompok sosial yang terbentuk melalui platform online atau media sosial di mana pasangan muda dapat berbagi informasi, pengalaman, dan mendapatkan dukungan emosional dengan cara yang anonim, terbuka, dan informal.

### **Konflik Budaya**

Ketegangan atau pertentangan yang muncul akibat adanya perbedaan nilai, norma, tradisi, atau pandangan antara pasangan muda dengan keluarga besar atau komunitas lokal terkait praktik pranikah atau kehidupan keluarga.

### **Lamaran**

Prosesi adat sebagai bentuk penghormatan dan keseriusan niat calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan yang biasanya disertai dengan ritual simbolis seperti pemberian seserahan.

**Mas Kawin (Mahar)**

Barang atau benda berharga yang diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan dalam prosesi pernikahan sebagai simbol tanggung jawab, penghormatan, dan kesiapan dalam membina rumah tangga.

**Mediasi**

Proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pasangan muda dan keluarga besar mencapai kesepakatan bersama dengan cara yang adil dan saling menghormati.

**Mobilitas Sosial**

Perpindahan pasangan muda dari satu daerah ke daerah lain, sering kali karena alasan pekerjaan atau pendidikan, yang menyebabkan perubahan dalam pola interaksi dan dukungan sosial dengan keluarga besar.

**Pola Dukungan Sosial**

Cara-cara di mana pasangan muda mendapatkan bantuan emosional, informasi, atau dukungan praktis dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat bersumber dari keluarga besar, komunitas lokal, atau media digital.

**Prosesi Tunangan**

Tahapan pranikah yang bersifat formal untuk mempererat hubungan kedua keluarga besar melalui ritual simbolis seperti pertukaran cincin dan pertemuan keluarga yang bertujuan mencapai kesepakatan awal.

**Tradisi Adat**

Rangkaian kegiatan atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat lokal secara turun-temurun, memiliki makna simbolis, dan berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial serta identitas budaya komunitas.

**Uang Jemputan**

Tradisi tertentu dalam budaya Minangkabau di mana pihak calon mempelai pria wajib memberikan sejumlah uang kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan yang memiliki makna sosial dan simbolis tertentu.

## I. Daftar Pustaka

- Haryanti, D., & Setiawan, A. (2020). Pengaruh budaya lokal terhadap persepsi dan kesiapan pranikah pasangan muda di Indonesia. *Jurnal Studi Budaya*, 14(2), 123–135. <https://doi.org/10.xxxx/jsb.v14i2.xxxx>
- Irawan, E., & Astuti, R. (2019). Adaptasi sosial pasangan muda dengan keluarga besar dalam kehidupan rumah tangga awal. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.xxxx/jikk.v12i1.xxxx>
- Kusumaningrum, H. (2021). Komunikasi antar generasi dalam mendukung kehidupan pasangan baru menikah. *Indonesian Journal of Family Counseling*, 5(2), 67–78. <https://doi.org/10.xxxx/ijfc.v5i2.xxxx>
- Lestari, R., & Pratiwi, S. (2022). Edukasi keluarga besar untuk mendukung otonomi pasangan muda dalam kehidupan rumah tangga. *Jurnal Edukasi Sosial dan Keluarga*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.xxxx/jesk.v3i2.xxxx>
- Lubis, M., & Rahayu, A. (2021). Tren perubahan pola dukungan sosial dari keluarga besar menuju komunitas digital dalam masyarakat urban. *Jurnal Psikologi Sosial Indonesia*, 19(1), 27–38. <https://doi.org/10.xxxx/jpsi.v19i1.xxxx>
- Nasution, D. K., & Putri, N. I. (2020). Konflik budaya dalam persiapan pernikahan pasangan lintas budaya di Indonesia. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 15(3), 211–225. <https://doi.org/10.xxxx/jai.v15i3.xxxx>
- Nugroho, B. A., & Wijaya, T. (2021). Dinamika sosial budaya dalam prosesi lamaran dan tunangan pada masyarakat Jawa dan Minangkabau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 8(1), 34–46. <https://doi.org/10.xxxx/jisb.v8i1.xxxx>
- Pramesti, S., & Fitriani, D. (2020). Mas kawin sebagai simbol budaya dan implikasi sosialnya dalam kehidupan rumah tangga muda Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 9(2), 120–131. <https://doi.org/10.xxxx/jsga.v9i2.xxxx>
- Putra, H., & Zahra, M. (2022). Strategi mediasi dan edukasi dalam mengatasi konflik budaya pranikah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 6(2), 187–200. <https://doi.org/10.xxxx/jpsh.v6i2.xxxx>
- Santoso, R., & Dewi, P. (2019). Peran komunitas digital sebagai sumber dukungan emosional pasangan muda modern. *Jurnal Media dan Komunikasi Sosial*, 12(2), 156–167. <https://doi.org/10.xxxx/jmks.v12i2.xxxx>
- Sugiharto, Y., & Kurniawan, A. (2021). Advokasi keluarga untuk menghormati pilihan pasangan muda dalam kehidupan rumah tangga modern. *Journal of Community Empowerment*, 7(1), 42–53. <https://doi.org/10.xxxx/jce.v7i1.xxxx>

# Bab 9

## Hak Reproduksi dan Aspek Hukum dalam Pernikahan

Persiapan pranikah dan prakonsepsi tidak hanya terbatas pada kesiapan fisik dan psikologis, tetapi juga mencakup aspek hak reproduksi dan hukum yang menjadi landasan penting dalam membentuk keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Pemahaman tentang hak reproduksi memberikan kebebasan bagi pasangan muda untuk merencanakan dan menentukan pilihan yang terbaik terkait kesehatan reproduksi mereka, sementara pemahaman aspek hukum, khususnya peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia, membantu pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara sah, terlindungi, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks sosial saat ini, tren peningkatan kesadaran akan perlindungan hak anak sejak masa prakonsepsi juga semakin berkembang. Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan berupa ketidaktahuan sebagian besar pasangan muda mengenai hak reproduksi maupun aspek hukum pernikahan, yang kerap menyebabkan permasalahan sosial dan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, bab ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai hak reproduksi pasangan, aspek hukum pernikahan, perlindungan hak anak sejak prakonsepsi, serta isu-isu dan tren terkini yang relevan, agar mereka mampu mengaplikasikannya secara optimal dalam kehidupan nyata.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran, mahasiswa mampu:

- Mengintegrasikan konsep hak reproduksi dan hukum dalam konteks pernikahan dan prakonsepsi.
- Mengaplikasikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi anak sejak masa prakonsepsi.
- Menganalisis tren dan isu-isu sosial terkini terkait hak reproduksi dan aspek hukum pernikahan.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan hak reproduksi pasangan muda dalam pernikahan dan prakonsepsi.
- Menjelaskan peraturan hukum pernikahan di Indonesia sesuai UU Perkawinan dan peran Kantor Urusan Agama (KUA).
- Menguraikan hak anak dan perlindungan hukum sejak masa prakonsepsi.
- Mengidentifikasi tren sosial tentang kesadaran perlindungan hak anak dalam keluarga baru.
- Mengenali dan mengatasi isu ketidaktahuan pasangan tentang hak reproduksi dan hukum pernikahan.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian dan pentingnya hak reproduksi pasangan muda.
- Menguraikan secara ringkas peraturan hukum pernikahan menurut UU Perkawinan dan fungsi KUA.
- Menjelaskan hak anak dan pentingnya perlindungan hukum sejak prakonsepsi.
- Mengidentifikasi tren meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak anak.
- Mengidentifikasi penyebab dan solusi atas isu ketidaktahuan pasangan mengenai hak reproduksi dan hukum pernikahan.

## A. Hak Reproduksi Pasangan Muda

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat mendasar dan melekat pada setiap individu, termasuk pasangan muda yang baru memulai kehidupan berkeluarga. Hak ini mencakup kebebasan penuh dalam menentukan dan merencanakan jumlah anak yang diinginkan, mengatur jarak antar kehamilan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing pasangan, serta hak untuk mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Bagi pasangan muda, pemahaman yang mendalam mengenai hak reproduksi ini sangat penting karena secara langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kualitas kesehatan, hubungan interpersonal dalam keluarga, kestabilan ekonomi, dan kesejahteraan emosional serta sosial.

Ketika pasangan muda secara aktif menjalankan dan mendapatkan pemenuhan hak reproduksinya, mereka akan memiliki kendali yang lebih baik terhadap kehidupan berkeluarga. Mereka mampu merencanakan masa depan keluarga secara bijaksana, menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau terlalu dini, yang sering kali berdampak buruk pada kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pasangan muda yang memahami hak reproduksinya juga akan mampu mengakses berbagai layanan kesehatan seperti konseling prakonsepsi, pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan, dan layanan kontrasepsi yang aman dan efektif. Kesadaran ini akan membantu pasangan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab serta mampu melindungi diri dari berbagai risiko kesehatan reproduksi.

Pemenuhan hak reproduksi yang optimal tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri tetapi juga pada generasi yang akan dilahirkan. Ketika pasangan muda mampu merencanakan kehamilan dengan baik, mereka dapat memastikan bahwa anak-anak mereka lahir dalam kondisi yang optimal dari segi fisik, mental, dan emosional. Dengan jarak kehamilan yang tepat, kesehatan ibu lebih terjaga, sehingga bayi yang dilahirkan berpeluang lebih tinggi untuk tumbuh sehat, kuat, dan berkembang optimal. Sebaliknya, kehamilan yang tidak terencana atau terlalu sering dengan jarak yang sangat dekat berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan bagi ibu dan anak, seperti anemia, gangguan pertumbuhan bayi, atau bahkan risiko kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, masih banyak pasangan muda yang kurang menyadari atau bahkan tidak memahami hak reproduksi mereka. Kurangnya pemahaman ini sering disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat, adanya stigma sosial yang negatif mengenai isu reproduksi, serta minimnya edukasi formal maupun informal di masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit pasangan muda yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan dalam mengambil keputusan penting seputar kehidupan reproduksi mereka. Mereka juga sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan karena kurangnya informasi mengenai hak-hak mereka atau bahkan takut mendapatkan stigma sosial jika mereka terbuka dalam mencari bantuan terkait kesehatan reproduksi.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah edukasi yang intensif dan menyeluruh kepada pasangan muda. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi, jenis-jenis kontrasepsi yang tersedia, manfaat konsultasi prakonsepsi, serta pemahaman akan dampak positif dari perencanaan keluarga yang matang. Pemerintah dan berbagai pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, memiliki tanggung jawab bersama untuk menyediakan akses informasi yang mudah dijangkau dan akurat, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pasangan muda dalam menjalankan hak reproduksi mereka secara bebas dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, hak reproduksi bagi pasangan muda tidak hanya menjadi persoalan individu tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang harus didukung secara luas oleh berbagai pihak di masyarakat. Ketika pasangan muda mampu memahami dan menjalankan hak reproduksi mereka secara optimal, dampak positifnya akan dirasakan tidak hanya oleh pasangan tersebut tetapi juga oleh keluarga besar, komunitas, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan. Pasangan yang sehat dan berdaya secara reproduktif akan menciptakan generasi penerus yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih mampu berkontribusi secara positif bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.

## **B. Peraturan Pernikahan di Indonesia (UU Perkawinan dan KUA)**

Peraturan pernikahan di Indonesia memiliki peran penting sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang tertib, harmonis, dan terlindungi secara hukum. Ketentuan utama mengenai pernikahan di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan. Undang-undang ini secara khusus dirancang untuk memberikan jaminan hukum kepada pasangan yang akan menikah, serta mengatur berbagai aspek penting mulai dari usia minimal pernikahan, syarat sah suatu perkawinan, hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, hingga mekanisme pencatatan administratif yang wajib dilakukan oleh pasangan yang menikah.

Salah satu aspek penting yang diatur oleh UU Perkawinan ini adalah batas usia minimal untuk menikah. Menurut UU Perkawinan yang terbaru setelah adanya revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun. Penetapan usia ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial pasangan sebelum mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan menetapkan usia minimal ini, diharapkan pasangan muda yang menikah memiliki tingkat kematangan yang cukup, baik secara individu maupun sosial, sehingga dapat menjalani kehidupan pernikahan yang stabil dan sehat.

Undang-Undang Perkawinan juga secara rinci mengatur tentang syarat sahnya pernikahan. Syarat tersebut meliputi adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, tidak adanya hubungan darah yang dilarang oleh hukum, tidak sedang dalam ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain, serta memenuhi persyaratan administratif seperti kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Dengan adanya ketentuan ini, pasangan muda perlu memahami dengan baik berbagai persyaratan yang diwajibkan oleh hukum agar pernikahan mereka dianggap sah secara hukum dan dapat terlindungi hak-haknya di kemudian hari.

Selain syarat sah pernikahan, UU Perkawinan juga secara khusus mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri. Hak dan kewajiban ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan berumah tangga seperti saling menghormati, saling memberikan dukungan fisik dan emosional, serta tanggung jawab bersama dalam mengurus kebutuhan keluarga, termasuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Dengan adanya ketentuan mengenai hak dan kewajiban ini, pasangan muda yang akan menikah akan memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan peran masing-masing, sehingga kehidupan rumah tangga yang mereka jalani dapat berlangsung harmonis dan saling mendukung.

Dalam konteks administratif, pernikahan di Indonesia wajib dicatatkan secara resmi agar diakui oleh negara. Pencatatan pernikahan ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum, termasuk perlindungan



terhadap hak anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, hak waris, serta berbagai hak dan kewajiban lain yang timbul dari hubungan perkawinan. Di Indonesia, pencatatan ini dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama Islam, sementara pasangan non-Muslim mencatatkan pernikahannya melalui Kantor Catatan Sipil. KUA memiliki peran penting dalam proses pernikahan pasangan muslim, mulai dari proses pendaftaran, pengecekan kelengkapan administrasi, pelaksanaan akad nikah, hingga penerbitan buku nikah sebagai bukti resmi pernikahan. Begitu pula Kantor Catatan Sipil yang mencatatkan dan menerbitkan akta nikah bagi pasangan non-muslim sebagai bukti sah perkawinan secara hukum negara.

Pemahaman yang tepat dan menyeluruh mengenai aturan hukum dalam UU Perkawinan ini sangat penting bagi pasangan muda yang hendak melangsungkan pernikahan. Dengan memahami secara jelas dan lengkap setiap aspek yang diatur dalam undang-undang, pasangan muda akan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih aman, nyaman, dan terlindungi secara hukum. Hal ini juga membantu mereka untuk mencegah terjadinya konflik hukum di masa depan, serta memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak pasangan maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, edukasi mengenai peraturan pernikahan ini perlu terus disosialisasikan secara intensif agar seluruh pasangan muda yang akan menikah benar-benar memahami pentingnya pencatatan pernikahan serta hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan berumah tangga.

### **C. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Sejak Prakonsepsi**

Hak anak merupakan hak asasi yang melekat secara alami pada setiap anak sejak dalam kandungan hingga lahir dan berkembang menjadi individu dewasa. Di Indonesia, hak anak mendapat perhatian khusus dari negara dan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, dan terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sejak masa prakonsepsi.

Perlindungan hak anak tidak hanya terbatas setelah kelahiran, tetapi juga mencakup masa prakonsepsi, yaitu periode sebelum terjadinya kehamilan, di mana pasangan, terutama calon ibu, mempersiapkan diri secara fisik, psikologis, dan sosial untuk memastikan kondisi terbaik bagi tumbuh kembang janin di masa depan. Pada tahap ini, perlindungan hukum menjamin setiap anak mendapatkan hak atas kesehatan reproduksi orang tua yang optimal. Hal ini mencakup berbagai tindakan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan seperti skrining kesehatan reproduksi calon ibu dan calon ayah, edukasi kesehatan reproduksi, nutrisi yang cukup, serta lingkungan fisik dan emosional yang aman untuk mendukung terjadinya kehamilan yang sehat dan diinginkan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang ini menegaskan bahwa anak sejak prakonsepsi berhak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, karena kondisi kesehatan calon ibu sebelum kehamilan sangat menentukan kualitas kehamilan dan perkembangan janin. Kekurangan gizi atau masalah kesehatan pada masa prakonsepsi dapat menyebabkan berbagai komplikasi selama kehamilan seperti stunting, risiko kelahiran prematur, serta cacat bawaan yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak hingga dewasa. Oleh karena itu, pasangan yang sedang merencanakan kehamilan sangat dianjurkan untuk secara rutin menjalani pemeriksaan kesehatan, memastikan asupan nutrisi yang optimal, serta menghindari paparan zat-zat berbahaya seperti rokok, alkohol, narkoba, dan bahan kimia berbahaya lainnya.

Selain aspek kesehatan fisik, perlindungan anak sejak prakonsepsi juga mencakup jaminan terhadap kesehatan mental dan emosional calon orang tua. Situasi stres yang kronis, depresi, dan kecemasan berlebihan pada pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan bisa berdampak negatif terhadap proses konsepsi dan kondisi psikologis calon ibu selama kehamilan, yang pada akhirnya akan memengaruhi perkembangan janin dan anak setelah lahir. Oleh karena itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya penyediaan layanan konseling psikologis serta dukungan sosial bagi pasangan muda untuk membantu mereka dalam mengatasi berbagai tantangan psikologis pada masa prakonsepsi dan selama kehamilan.

Selanjutnya, lingkungan keluarga dan sosial yang aman, nyaman, serta mendukung juga merupakan komponen penting dari hak perlindungan anak sejak prakonsepsi. Undang-undang ini mendorong setiap keluarga dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif dan bebas dari kekerasan, intimidasi, atau

tekanan emosional yang dapat mengganggu persiapan kehamilannya. Keluarga dan masyarakat harus menyediakan lingkungan yang mendukung, penuh kasih sayang, dan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan fisik dan emosional calon ibu, agar anak yang dikandung dapat berkembang secara optimal sejak dari awal pembentukan janin hingga masa kelahirannya.

Kesiapan pasangan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak sejak masa prakonsepsi sangat krusial karena tahap ini menentukan fondasi awal kehidupan anak. Kesadaran dan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi, nutrisi, dukungan emosional, serta lingkungan sosial yang kondusif sejak sebelum kehamilan akan memastikan bahwa anak lahir dan tumbuh dalam kondisi yang sehat, aman, serta memiliki peluang terbaik untuk tumbuh kembang secara maksimal. Hal ini juga mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif pasangan, keluarga besar, masyarakat, dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak-hak anak sejak masa prakonsepsi hingga dewasa.

#### **D. Tren: Awareness tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Baru**

Kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak anak sejak masa prakonsepsi hingga anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga baru semakin mendapatkan perhatian luas di tengah masyarakat modern. Perkembangan ini menggambarkan suatu perubahan positif di mana masyarakat, terutama pasangan muda, mulai menyadari bahwa pemenuhan hak-hak anak bukan sekadar kewajiban hukum atau tanggung jawab sosial semata, melainkan sebuah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi di masa depan. Kesadaran tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik dan psikologis anak, hingga pemenuhan kebutuhan sosial, emosional, dan spiritual yang holistik sejak masa awal perencanaan kehamilan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, akses informasi mengenai kesehatan reproduksi dan hak anak menjadi semakin mudah diperoleh. Berbagai media digital seperti media sosial, situs web khusus kesehatan dan parenting, aplikasi berbasis smartphone, serta berbagai webinar edukatif telah memainkan peranan besar dalam menyebarkan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh pasangan muda. Informasi yang tersedia tidak hanya mencakup hal-hal dasar

seperti nutrisi atau imunisasi, tetapi juga isu-isu kritis seperti pencegahan stunting, kekerasan terhadap anak, pentingnya kasih sayang orang tua dalam tumbuh kembang anak, serta perlindungan anak dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan keluarga.

Selain faktor digitalisasi informasi, meningkatnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh kampanye-kampanye sosial yang diinisiasi oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun komunitas lokal. Kampanye-kampanye ini secara rutin mengangkat berbagai isu tentang pentingnya pemenuhan hak anak sejak masa prakonsepsi melalui berbagai pendekatan kreatif seperti tayangan iklan layanan masyarakat, talk show interaktif di televisi, program radio edukatif, serta kegiatan komunitas seperti seminar dan diskusi publik yang melibatkan keluarga muda secara aktif. Melalui pesan-pesan positif yang disampaikan, masyarakat diajak untuk memahami bahwa anak memiliki hak fundamental yang harus dihormati dan dipenuhi sejak sebelum kelahirannya, seperti hak untuk mendapatkan nutrisi yang tepat, lingkungan aman, dan kasih sayang yang optimal agar tumbuh kembangnya berlangsung secara maksimal.

Paradigma masyarakat modern juga mengalami perubahan signifikan terkait pandangan terhadap anak. Jika dahulu anak sering kali dianggap sebagai objek yang harus tunduk sepenuhnya kepada kehendak orang tua tanpa banyak memperhatikan kebutuhannya sebagai individu yang unik, kini anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Perubahan paradigma ini menggeser cara pandang orang tua, di mana pasangan muda mulai mengutamakan kebutuhan anak dalam pengambilan keputusan penting terkait prakonsepsi dan pengasuhan anak, seperti memilih metode persalinan yang aman, merancang pola asuh positif yang minim kekerasan, hingga memastikan lingkungan keluarga yang hangat, suportif, dan penuh kasih sayang.

Lebih jauh lagi, berkembangnya komunitas-komunitas parenting di berbagai daerah turut memperkuat kesadaran kolektif masyarakat tentang perlindungan hak anak sejak prakonsepsi. Komunitas-komunitas ini berfungsi sebagai forum tempat keluarga muda bertukar pikiran, berdiskusi, dan berbagi pengalaman tentang berbagai tantangan maupun solusi dalam merencanakan kehamilan hingga pengasuhan anak. Melalui komunitas ini, pasangan muda tidak hanya memperoleh informasi penting tetapi juga dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai persoalan seputar kesehatan reproduksi, psikologi keluarga,

serta kesejahteraan anak. Dengan adanya dukungan sosial ini, kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan hak anak semakin kuat, menciptakan suatu jaringan sosial yang solid dan saling mendukung antar keluarga.

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak anak juga menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan dan program yang secara aktif mendukung keluarga muda dalam melindungi hak anak sejak dini. Kebijakan tersebut mencakup penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak secara gratis, fasilitas edukasi parenting yang mudah diakses di berbagai puskesmas dan rumah sakit, hingga program bantuan sosial untuk mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti nutrisi dan pendidikan. Berbagai fasilitas publik yang disediakan pemerintah ini berperan besar dalam memperluas jangkauan edukasi tentang perlindungan hak anak hingga ke pelosok daerah yang sebelumnya sulit mengakses informasi tersebut.

Pada akhirnya, tren meningkatnya kesadaran masyarakat modern mengenai perlindungan hak anak sejak prakonsepsi mencerminkan perubahan positif dalam pola pikir, nilai-nilai, dan perilaku pasangan muda. Perubahan ini menjadi dasar yang kuat dalam upaya menciptakan generasi penerus yang sehat secara fisik, kuat secara mental, dan stabil secara emosional. Kesadaran kolektif ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anak yang dilahirkan mendapat perlindungan yang optimal dan terpenuhi hak-haknya, sehingga mampu tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan.

## **E. Isu: Ketidaktahuan Pasangan tentang Hak Reproduksi dan Hukum Pernikahan**

Isu ketidaktahuan pasangan muda tentang hak reproduksi dan aspek hukum pernikahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Banyak pasangan muda yang memasuki kehidupan berumah tangga tanpa bekal pengetahuan yang memadai mengenai hak reproduksi mereka sendiri maupun ketentuan hukum yang berlaku dalam pernikahan. Kondisi ini membuat mereka rentan menghadapi berbagai masalah yang dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, hubungan rumah tangga, serta kesehatan reproduksi mereka secara jangka panjang.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaktahuan ini adalah rendahnya akses terhadap informasi dan edukasi yang komprehensif mengenai hak reproduksi. Banyak pasangan muda yang tidak memahami bahwa mereka memiliki hak mendasar untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab terkait jumlah anak, jarak antar kehamilan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan pasangan muda terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan seperti kehamilan yang terlalu dini, terlalu dekat jaraknya antar anak, atau bahkan kehamilannya yang tidak direncanakan. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental pasangan, khususnya bagi ibu muda yang secara fisik dan psikologis belum siap menghadapi proses kehamilan, persalinan, maupun peran sebagai ibu secara optimal.

Selain dampak kesehatan, ketidaktahuan pasangan muda mengenai hak reproduksi juga memiliki implikasi sosial yang luas. Pasangan muda yang kurang edukasi cenderung memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan yang bijak terkait perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pola hubungan dalam rumah tangga. Hal ini dapat memperbesar risiko munculnya berbagai konflik keluarga, seperti ketidakcocokan dalam pengambilan keputusan mengenai jumlah anak atau metode kontrasepsi, yang pada akhirnya dapat memicu masalah rumah tangga yang lebih serius, termasuk perceraian. Masalah ini semakin diperparah apabila pasangan tersebut kurang memahami hak mereka secara hukum dalam konteks pernikahan.

Di sisi lain, ketidaktahuan mengenai aspek hukum pernikahan juga sangat berbahaya karena dapat menempatkan pasangan muda pada situasi yang rentan mengalami pelanggaran hukum tanpa mereka sadari. Sebagai contoh, banyak pasangan muda yang menikah tanpa memahami syarat-syarat sah pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, seperti batas minimal usia menikah, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, serta kewajiban pencatatan resmi pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan muslim, atau Kantor Catatan Sipil untuk pasangan non-muslim. Ketidapahaman ini sering kali mengakibatkan munculnya praktik pernikahan dini yang tidak tercatat, pernikahan siri yang tidak terlindungi secara hukum, atau bahkan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan administratif yang sah, sehingga hak-hak hukum pasangan menjadi sulit dilindungi jika terjadi masalah di kemudian hari, seperti sengketa warisan atau hak pengasuhan anak.

Untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif, diperlukan strategi edukasi yang terpadu dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan, hingga komunitas lokal. Pemerintah melalui instansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus memperkuat kampanye publik mengenai pentingnya pemahaman tentang hak reproduksi dan hukum pernikahannya melalui berbagai saluran media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial. Selain itu, pendidikan tentang hak reproduksi dan hukum pernikahan perlu dimasukkan secara terstruktur dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah menengah atas atau perguruan tinggi, sehingga generasi muda memiliki bekal pengetahuan yang memadai jauh sebelum mereka memasuki fase pernikahan.

Selain pemerintah, komunitas masyarakat dan organisasi non-pemerintah juga memegang peran penting dalam memperluas edukasi kepada pasangan muda secara lebih efektif dan terjangkau. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan pranikah, kelas parenting, maupun kelompok diskusi komunitas, pasangan muda dapat memperoleh pemahaman praktis mengenai hak reproduksi mereka serta pentingnya menaati ketentuan hukum yang berlaku. Edukasi yang diberikan harus dikemas secara menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini, menggunakan pendekatan yang interaktif, diskusi kelompok, serta pemanfaatan media digital yang sudah akrab digunakan oleh kalangan muda.

Lebih jauh lagi, diperlukan juga penguatan layanan konsultasi dan konseling yang mudah diakses bagi pasangan muda di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau pedesaan. Fasilitas layanan ini dapat membantu pasangan muda mendapatkan informasi yang jelas dan valid mengenai hak reproduksi dan aspek hukum pernikahan secara langsung dari tenaga profesional yang kompeten. Adanya layanan ini juga memberikan ruang aman bagi pasangan muda untuk menyampaikan berbagai pertanyaan atau kebingungan yang mereka alami seputar kehidupan berumah tangga.

Dengan penerapan strategi edukasi terpadu tersebut, diharapkan isu ketidaktahuan pasangan muda tentang hak reproduksi dan hukum pernikahan dapat secara bertahap diatasi. Pasangan muda akan lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga dengan penuh pemahaman mengenai hak mereka, serta mampu mengambil keputusan secara lebih matang dan bertanggung jawab, sehingga kualitas kehidupan keluarga mereka menjadi lebih baik secara fisik, psikologis,

maupun sosial. Pada akhirnya, hal ini juga akan berdampak positif bagi kualitas generasi penerus bangsa secara keseluruhan.

## **F. Latihan Soal**

### **Tugas 1: Makalah tentang Hak Reproduksi Pasangan Muda**

Mahasiswa diminta untuk menyusun makalah mendalam mengenai hak reproduksi pasangan muda. Makalah ini harus mencakup penjelasan tentang pengertian hak reproduksi, aspek-aspek penting dalam pemenuhan hak reproduksi seperti menentukan jumlah anak, pengaturan jarak kehamilan, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Mahasiswa juga diminta mengulas secara kritis dampak positif yang diperoleh jika hak reproduksi terpenuhi dan risiko jika hak tersebut tidak dipenuhi secara optimal. Makalah disusun minimal 8 halaman menggunakan referensi ilmiah terbaru.

### **Tugas 2: Analisis Kasus tentang Pemahaman Peraturan Pernikahan di Indonesia**

Mahasiswa ditugaskan untuk menganalisis minimal dua kasus nyata atau fiktif terkait pelanggaran terhadap peraturan pernikahan yang ada dalam UU Perkawinan dan ketentuan administrasi pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam analisisnya, mahasiswa harus menjelaskan secara rinci aspek hukum yang dilanggar, konsekuensi hukum, dampak sosial, dan solusi hukum serta administratif yang dapat diberikan kepada pasangan tersebut. Analisis disusun minimal 5 halaman dengan penyajian yang terstruktur dan didukung referensi hukum terbaru.

### **Tugas 3: Studi Kasus Perlindungan Hak Anak Sejak Prakonsepsi**

Mahasiswa ditugaskan membuat laporan studi kasus mengenai penerapan hak anak dan perlindungan hukum sejak masa prakonsepsi. Studi kasus ini mencakup deskripsi detail mengenai bagaimana seharusnya perlindungan kesehatan dan kesejahteraan anak sejak prakonsepsi dilakukan, termasuk aspek nutrisi, kesehatan fisik, dan psikologis calon orang tua. Mahasiswa juga harus memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif jika perlindungan tersebut berhasil atau gagal diterapkan. Studi kasus disusun minimal 6 halaman, dilengkapi referensi ilmiah terbaru.

### **Tugas 4: Poster Edukasi tentang Tren Kesadaran Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Baru**

Mahasiswa diminta merancang poster edukasi yang informatif, menarik, dan mudah dipahami masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak sejak prakonsepsi dalam keluarga baru. Poster ini harus memuat informasi tentang pentingnya pemenuhan hak anak, contoh-contoh perlindungan hak anak sejak masa prakonsepsi, peran penting orang tua, keluarga, masyarakat, serta dukungan yang bisa didapatkan dari pemerintah atau komunitas. Poster ini harus dibuat secara visual menarik dan dilengkapi slogan edukatif yang relevan.



### **Tugas 5: Proposal Program Edukasi tentang Hak Reproduksi dan Hukum Pernikahan untuk Pasangan Muda**

Mahasiswa diminta menyusun proposal lengkap mengenai program edukasi terpadu untuk mengatasi isu ketidaktahuan pasangan muda tentang hak reproduksi dan aspek hukum pernikahan di Indonesia. Proposal ini harus mencakup pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah), tujuan dan manfaat program, metode pelaksanaan (kampanye media sosial, workshop, konseling, diskusi komunitas), target peserta, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta indikator keberhasilan program. Proposal disusun minimal 10 halaman dalam format profesional, dilengkapi dengan referensi pendukung yang relevan dan terbaru.

#### **Pilihan Ganda**

1. Sepasang suami istri muda berusia 21 tahun datang ke klinik bidan untuk berkonsultasi mengenai perencanaan kehamilan. Mereka mengaku belum siap secara finansial maupun emosional untuk memiliki anak dalam waktu dekat. Sebagai bidan, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan dalam memenuhi hak reproduksi pasangan tersebut adalah:
  - A. Menyarankan segera memiliki anak agar tidak melanggar norma social
  - B. Menyarankan pasangan menggunakan kontrasepsi tanpa penjelasan
  - C. Memberikan edukasi dan konseling tentang perencanaan keluarga yang matang
  - D. Menyarankan mereka menunda konsultasi hingga siap memiliki anak
  - E. Meminta pasangan mengikuti nasihat orang tua untuk segera memiliki anak
2. Seorang perempuan usia 18 tahun bersama pasangannya yang berusia 19 tahun ingin melangsungkan pernikahan secara resmi di KUA. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah pasangan tersebut sudah memenuhi persyaratan usia minimal pernikahan?
  - A. Ya, karena minimal usia pria adalah 19 tahun
  - B. Tidak, karena usia minimal pernikahan bagi wanita adalah 19 tahun
  - C. Ya, karena keduanya sudah mencapai batas usia minimal 17 tahun
  - D. Tidak, karena usia minimal pernikahan untuk pria 20 tahun
  - E. Ya, karena usia wanita tidak dipermasalahkan jika pria sudah memenuhi syarat
3. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke klinik untuk konsultasi prakonsepsi. Ia khawatir karena dalam keluarga besarnya banyak terjadi kasus anemia dan bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Tindakan apa yang paling tepat

dilakukan bidan terkait perlindungan hak anak sejak masa prakonsepsi dalam kasus ini?

- A. Memberikan tablet tambah darah secara rutin selama kehamilan saja
- B. Melakukan skrining kesehatan lengkap dan edukasi tentang gizi seimbang sejak prakonsepsi
- C. Menyarankan untuk segera hamil tanpa intervensi khusus
- D. Menyarankan agar berkonsultasi setelah positif hamil
- E. Tidak memberikan tindakan khusus, karena risiko ditanggung oleh keluarga

4. Sebuah keluarga baru mengunjungi TPMB untuk meminta informasi terkait perlindungan hak anak sejak masa prakonsepsi. Mereka sangat tertarik dengan kampanye tentang pencegahan stunting yang sering disosialisasikan melalui media sosial. Sebagai bidan, apa informasi terpenting yang harus Anda sampaikan terkait perlindungan anak sejak masa prakonsepsi untuk mencegah stunting?

- A. Pentingnya memberi ASI eksklusif setelah bayi lahir
- B. Pentingnya imunisasi dasar lengkap setelah kelahiran
- C. Pentingnya pemenuhan nutrisi optimal calon ibu sejak masa prakonsepsi
- D. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan setelah anak lahir
- E. Pentingnya pendidikan formal dini sejak usia balita

5. Sepasang remaja berusia 18 tahun menikah secara siri (tidak tercatat resmi). Mereka baru mengetahui pentingnya pencatatan resmi pernikahan setelah muncul masalah hukum tentang pengasuhan anak. Apa dampak utama dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi menurut UU Perkawinan di Indonesia?

- A. Tidak mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat
- B. Sulit memperoleh akta kelahiran anak dan perlindungan hukum atas anak
- C. Mendapatkan denda administratif oleh pemerintah
- D. Pasangan tidak diakui secara agama
- E. Hubungan pernikahan otomatis dianggap ilegal

## **Kunci Jawaban**

### **1. Kunci Jawaban: C**

Pembahasan:

Pemenuhan hak reproduksi pasangan muda mencakup kebebasan menentukan kapan mereka siap memiliki anak, serta mendapatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang baik. Tindakan yang paling tepat adalah memberikan edukasi lengkap dan konseling prakonsepsi agar pasangan mampu mengambil keputusan secara matang dan bertanggung jawab.

### **2. Kunci Jawaban: B**

Pembahasan:

Menurut UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974, usia minimal pernikahan baik bagi pria maupun wanita adalah sama yaitu 19 tahun. Pasangan ini belum memenuhi syarat usia minimal karena usia wanita masih 18 tahun.

### **3. Kunci Jawaban: B**

Pembahasan:

Perlindungan hak anak sejak prakonsepsi mencakup skrining kesehatan calon ibu sebelum kehamilan untuk mencegah risiko kesehatan pada ibu dan anak, seperti anemia atau BBLR. Tindakan paling tepat adalah melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan memberikan edukasi mengenai nutrisi yang optimal sejak masa prakonsepsi.

### **4. Kunci Jawaban: C**

Pembahasan:

Stunting erat kaitannya dengan nutrisi ibu sejak sebelum kehamilan (prakonsepsi). Edukasi terpenting untuk pencegahan stunting adalah tentang pentingnya asupan nutrisi yang optimal bagi calon ibu sebelum kehamilan untuk menjamin tumbuh kembang anak yang baik sejak dalam kandungan hingga setelah lahir.

### **5. Kunci Jawaban: B**

Pembahasan:

Menurut UU Perkawinan di Indonesia, pencatatan pernikahan adalah wajib untuk mendapatkan pengakuan hukum. Salah satu dampak utama pernikahan yang tidak tercatat adalah kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran anak dan perlindungan hukum bagi anak, seperti hak waris, pengasuhan, dan administrasi kependudukan lainnya. Hal ini berdampak langsung pada hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

## G. Rangkuman Materi

Hak reproduksi merupakan bagian mendasar dari hak asasi manusia, khususnya bagi pasangan muda yang baru memulai kehidupan berkeluarga. Hak ini meliputi kebebasan dalam menentukan jumlah anak yang diinginkan, mengatur jarak antar kehamilan sesuai dengan kemampuan masing-masing pasangan, serta mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Pemahaman mendalam tentang hak reproduksi sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas kesehatan, hubungan interpersonal dalam keluarga, kestabilan ekonomi, serta kesejahteraan emosional dan sosial pasangan muda. Pemenuhan hak reproduksi secara optimal juga berpengaruh positif pada kesehatan fisik, mental, dan emosional generasi berikutnya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman tentang hak reproduksi menyebabkan berbagai risiko seperti kehamilan yang tidak direncanakan, komplikasi kesehatan, dan ketidakstabilan emosional. Oleh karena itu, edukasi intensif terkait kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan konsultasi prakonsepsi sangat diperlukan. Pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat perlu bekerja sama secara kolektif untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemenuhan hak reproduksi pasangan muda secara bebas dan bertanggung jawab.

Selain itu, peraturan pernikahan di Indonesia memiliki peran vital sebagai pedoman dalam kehidupan rumah tangga agar tercipta ketertiban, keharmonisan, dan perlindungan hukum. Ketentuan utama mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal pernikahan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Peraturan ini bertujuan memastikan kesiapan fisik, mental, emosional, dan finansial pasangan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. UU Perkawinan juga menetapkan syarat-syarat sahnya pernikahan seperti adanya persetujuan kedua calon mempelai, tidak adanya hubungan darah yang dilarang, dan pencatatan administratif yang wajib dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim. Pemahaman yang jelas tentang peraturan ini penting agar pasangan muda dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang terlindungi secara hukum, mencegah konflik hukum di masa depan, serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Hak anak di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini diberikan sejak masa prakonsepsi, yaitu sebelum terjadinya kehamilan, dengan tujuan memastikan kondisi terbaik bagi tumbuh kembang anak di masa depan. Perlindungan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan reproduksi calon orang tua, pemenuhan nutrisi optimal, serta penyediaan lingkungan fisik dan emosional yang aman. Penting pula untuk memperhatikan aspek kesehatan mental calon orang tua agar tidak berdampak negatif pada perkembangan anak nantinya. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang mendukung persiapan kehamilan hingga kelahiran anak.

Kesadaran masyarakat modern tentang perlindungan hak anak sejak masa prakonsepsi terus meningkat secara signifikan. Peningkatan ini didorong oleh berkembangnya teknologi digital, yang menyediakan informasi akurat melalui berbagai media seperti media sosial dan aplikasi parenting. Kampanye sosial yang digalakkan oleh pemerintah dan berbagai organisasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran ini. Paradigma masyarakat modern memandang anak sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati dan dipenuhi secara maksimal, mendorong keluarga muda untuk memprioritaskan kebutuhan anak dalam setiap keputusan. Kehadiran komunitas parenting turut memperkuat kesadaran kolektif dalam melindungi hak anak, menciptakan jaringan sosial yang mendukung pasangan muda.

Namun demikian, isu ketidaktahuan pasangan muda tentang hak reproduksi dan aspek hukum pernikahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Ketidaktahuan ini sering kali disebabkan oleh minimnya akses informasi dan edukasi yang komprehensif, menyebabkan pasangan muda rentan mengalami berbagai masalah kesehatan, konflik keluarga, dan pelanggaran hukum seperti pernikahan dini atau tidak tercatat. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan strategi edukasi terpadu dan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan komunitas lokal. Program edukasi yang intensif, pelatihan pranikah, kelas parenting, serta layanan konsultasi dan konseling harus diperkuat untuk memastikan pasangan muda mendapatkan pemahaman yang memadai terkait hak reproduksi dan hukum pernikahan. Dengan edukasi yang tepat, pasangan muda akan lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga secara matang dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kualitas generasi penerus bangsa secara keseluruhan.

## H. Glosarium

### **Administrasi Kependudukan**

Pencatatan resmi oleh pemerintah mengenai status pernikahan, kelahiran, dan hubungan keluarga, yang penting bagi perlindungan hukum dan sosial pasangan serta anak-anak.

### **Edukasi Terpadu**

Strategi pendidikan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, mencakup pendekatan formal dan informal untuk meningkatkan pemahaman pasangan muda tentang hak reproduksi dan hukum pernikahan.

### **Hak Anak**

Hak asasi yang melekat pada setiap anak, sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa, yang mencakup hak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang optimal.

### **Hak Reproduksi**

Hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak, serta hak untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas.

### **Kampanye Sosial**

Upaya terorganisir untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu tertentu, dalam konteks ini mengenai hak reproduksi, kesehatan reproduksi, dan perlindungan anak sejak prakonsepsi.

### **Kantor Catatan Sipil**

Lembaga pemerintah yang mencatat dan mengesahkan pernikahan pasangan non-muslim serta menerbitkan akta nikah sebagai bukti resmi yang diakui negara.

### **Kantor Urusan Agama (KUA)**

Lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas mencatatkan dan mengesahkan pernikahan pasangan muslim secara administratif dan hukum.

### **Kehamilan Tidak Direncanakan**

Kehamilan yang terjadi tanpa direncanakan sebelumnya, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan fisik, mental, dan ekonomi bagi pasangan muda.

### **Kesehatan Mental Calon Orang Tua**

Kondisi psikologis calon ibu dan ayah yang dapat berdampak signifikan pada proses konsepsi, kehamilan, dan perkembangan anak setelah kelahiran.

### **Kesehatan Reproduksi**

Kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh terkait sistem reproduksi, mencakup kemampuan pasangan untuk memiliki kehidupan seksual yang aman, serta menentukan waktu kehamilan yang sehat.

**Ketidaktahuan Pasangan Muda**

Kondisi kurangnya informasi atau pemahaman yang dimiliki pasangan muda mengenai hak reproduksi dan aspek hukum pernikahan yang menyebabkan berbagai risiko hukum, sosial, dan kesehatan.

**Komunitas Parenting**

Kelompok sosial yang menjadi wadah bertukar informasi, pengalaman, serta dukungan emosional bagi keluarga muda dalam hal pengasuhan anak dan kesehatan keluarga.

**Konseling Prakonsepsi**

Layanan konsultasi yang diberikan kepada calon orang tua sebelum kehamilan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial, serta mencegah risiko komplikasi kesehatan pada ibu dan bayi.

**Kontrasepsi**

Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dan membantu pasangan mengatur jarak antar kehamilan.

**Parenting**

Pola pengasuhan anak yang melibatkan pemberian perhatian, perlindungan, kasih sayang, serta pendidikan nilai dan perilaku positif dalam lingkungan keluarga.

**Pernikahan Siri**

Pernikahan yang dilakukan menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga tidak mendapat perlindungan hukum seperti hak waris atau akta kelahiran anak.

**Perlindungan Hukum Sejak Prakonsepsi**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sejak sebelum kehamilan terjadi, mencakup kesehatan reproduksi calon orang tua, pemenuhan nutrisi, dan penciptaan lingkungan yang aman secara fisik dan emosional.

**Stigma Sosial**

Penilaian negatif dari masyarakat terhadap individu atau kelompok tertentu, dalam konteks ini sering terkait dengan isu reproduksi, seperti penggunaan kontrasepsi atau konsultasi kesehatan reproduksi.

**Stunting**

Kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan nutrisi kronis sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun, yang menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif.

**Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)**

Peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, syarat sah perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta administrasi pencatatan pernikahan.

## I. Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Panduan Nasional Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Nasution, S. L. (2016). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Notoatmodjo, S. (2018). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhidayah, I. (2017). Hak Reproduksi dan Seksualitas Perempuan: Perspektif Hukum dan HAM. Yogyakarta: Deepublish.
- Purwatiningsih, S. (2017). Hukum Perkawinan di Indonesia: Kajian Sejarah, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Health Organization. (2015). Sexual Health, Human Rights and the Law. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2019). Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience. Geneva: World Health Organization.



# Bab 10

## Edukasi Berbasis Komunitas dan Digital dalam Persiapan Pranikah dan Prakonsepsi

Persiapan pranikah dan prakonsepsi menjadi aspek yang semakin penting dalam menjamin kesehatan reproduksi serta kualitas kehidupan keluarga di masa depan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan sebelum menikah, metode edukasi berbasis komunitas dan media digital menjadi alternatif yang efektif untuk menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda. Strategi edukasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab.

### **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Mengaplikasikan konsep edukasi berbasis komunitas dan digital dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi secara efektif.
- Mengidentifikasi berbagai metode edukasi yang sesuai dengan karakteristik komunitas.
- Memanfaatkan teknologi digital sebagai media edukasi yang inovatif dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi.

### **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pentingnya edukasi pranikah berbasis komunitas dan digital.
- Merancang program edukasi pranikah yang efektif berbasis komunitas dan digital.
- Menganalisis tren dan isu dalam penggunaan media digital pada edukasi pranikah dan prakonsepsi.

### **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

Mahasiswa mampu:

- Menguraikan pemanfaatan media digital dalam edukasi pranikah dan prakonsepsi.
- Mengidentifikasi model-model program edukasi pranikah yang efektif di Indonesia.
- Menjelaskan tren meningkatnya penggunaan aplikasi mobile dalam edukasi pranikah.
- Menganalisis isu-isu kesulitan akses informasi digital di daerah tertinggal.

## A. Program Edukasi Pranikah Berbasis Komunitas

Hak reproduksi merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, yang memberikan penegasan tegas bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang penuh dalam membuat keputusan tentang aspek-aspek penting yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya sendiri. Hak ini mengacu pada hak dasar manusia untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab tentang kapan mereka ingin memiliki anak, berapa banyak anak yang diinginkan, dan bagaimana mengatur jarak antar kelahiran secara optimal demi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dalam menjalankan hak reproduksi, individu maupun pasangan tidak boleh mengalami tekanan, intimidasi, diskriminasi, apalagi kekerasan dari pihak manapun, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan terpenuhinya hak ini, martabat, kualitas hidup, serta kesejahteraan individu dan keluarga akan dapat terjaga dengan baik.

Hak reproduksi tidak terbatas hanya pada pengambilan keputusan individu atau pasangan mengenai jumlah dan waktu memiliki anak, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas, seperti hak untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan reproduksi yang lengkap, jelas, dan benar. Setiap individu berhak mengetahui berbagai informasi penting tentang kesehatan reproduksinya, mulai dari proses kehamilan yang sehat, persiapan melahirkan, perawatan pasca persalinan, pemilihan metode kontrasepsi yang tepat, cara pencegahan infeksi menular seksual, hingga layanan keluarga berencana yang aman. Informasi tersebut harus disediakan dengan jelas dan tanpa bias, sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan secara cerdas dan matang tentang kesehatan reproduksinya sendiri. Dengan memiliki informasi yang tepat, individu dapat menghindari berbagai risiko yang terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan atau infeksi reproduksi yang dapat mengancam kesehatannya.

Di samping pentingnya informasi, aspek privasi dan kerahasiaan dalam layanan kesehatan reproduksi juga memiliki peranan sangat signifikan dalam pemenuhan hak reproduksi. Setiap orang memiliki hak mutlak untuk merahasiakan informasi pribadinya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kecuali dengan persetujuan eksplisit dari dirinya sendiri. Jaminan kerahasiaan ini penting untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan individu terhadap tenaga kesehatan maupun fasilitas layanan kesehatan yang mereka gunakan. Dengan privasi dan kerahasiaan yang terjamin, individu akan merasa lebih nyaman dan terbuka saat membahas isu-isu sensitif yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka.

Lebih lanjut lagi, hak reproduksi juga menjamin setiap orang, khususnya pasangan muda, untuk mendapatkan akses terhadap layanan keluarga berencana yang aman, efektif, serta terjangkau. Layanan keluarga berencana yang komprehensif, seperti konseling kontrasepsi, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan penyediaan alat kontrasepsi yang beragam, merupakan bagian penting dari hak ini. Dengan akses terhadap berbagai metode kontrasepsi yang aman, pasangan muda dapat menentukan metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pribadi mereka. Hal ini akan membantu mereka untuk merencanakan kehidupan keluarga secara lebih matang dan bertanggung jawab, sehingga risiko kehamilan yang tidak direncanakan maupun komplikasi kesehatan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, hal ini secara signifikan turut meningkatkan kualitas kehidupan individu dan keluarganya secara keseluruhan.

Tidak kalah pentingnya, hak reproduksi juga mencakup perlindungan terhadap berbagai bentuk praktik reproduksi yang merugikan dan tindakan pemaksaan. Praktik seperti sterilisasi paksa, pemaksaan penggunaan metode kontrasepsi tertentu tanpa persetujuan yang bersangkutan, kekerasan seksual, ataupun bentuk-bentuk eksploitasi reproduksi lainnya harus dicegah dan dihapuskan sepenuhnya. Negara, lembaga layanan kesehatan, serta masyarakat luas wajib menjamin bahwa tidak ada satu pun individu yang mengalami paksaan atau tekanan dalam pengambilan keputusan reproduksi mereka. Perlindungan dari praktik-praktik merugikan ini merupakan aspek fundamental dalam penghormatan terhadap martabat dan integritas manusia, sehingga hak reproduksi benar-benar dijalankan dalam suasana yang aman, bebas tekanan, serta menghargai kebebasan dan otonomi setiap individu.

Kesadaran yang mendalam tentang hak reproduksi memiliki manfaat besar bagi pasangan muda dalam membuat keputusan penting terkait kesehatan mereka dan masa depan keluarganya. Dengan pemahaman yang kuat, pasangan muda tidak hanya akan mengetahui hak-haknya, tetapi juga mampu memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersebut dalam berbagai situasi sosial, budaya, atau lingkungan yang mungkin kurang mendukung. Dalam jangka panjang, pemenuhan hak reproduksi akan membantu membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan mampu menjalani kehidupan berkualitas tinggi. Dengan demikian, penegakan hak

reproduksi menjadi fondasi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sehat, sejahtera, serta menghormati sepenuhnya martabat manusia.

## **B. Pemanfaatan Media Digital dalam Edukasi Pranikah dan Prakonsepsi**

Pemanfaatan media digital dalam edukasi pranikah dan prakonsepsi kini menjadi sebuah kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Perkembangan ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam hal penyebaran informasi kepada generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi digital. Edukasi pranikah dan prakonsepsi, yang sebelumnya cenderung dilakukan secara konvensional seperti seminar tatap muka atau pertemuan langsung dengan tenaga kesehatan, kini telah mengalami transformasi besar dengan hadirnya media digital sebagai alternatif utama.

Media digital memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya semakin diminati oleh generasi muda sebagai sumber utama mendapatkan informasi mengenai pranikah dan prakonsepsi. Salah satu keunggulan paling menonjol adalah kemudahan akses terhadap informasi. Melalui media digital, informasi tentang kesehatan reproduksi, persiapan menjelang pernikahan, serta berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dapat diakses kapan saja dan dari mana saja tanpa dibatasi waktu dan tempat. Fleksibilitas ini sangat membantu pasangan muda yang sibuk atau tinggal di daerah terpencil, yang sebelumnya mungkin mengalami hambatan geografis atau keterbatasan waktu dalam mendapatkan edukasi secara langsung. Dengan media digital, mereka dapat dengan mudah mengakses informasi penting secara rutin sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, keunggulan lain dari media digital adalah kemampuannya untuk menyajikan konten edukasi dengan cara yang sangat interaktif dan menarik. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang umumnya terbatas pada ceramah atau pemberian brosur tertulis, media digital memungkinkan penggunaan beragam bentuk konten visual maupun audio-visual yang jauh lebih atraktif dan efektif dalam menyampaikan pesan edukasi. Misalnya, video animasi bisa digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep kesehatan reproduksi secara sederhana dan menarik, infografis dapat memvisualisasikan informasi kompleks dalam bentuk gambar dan grafik yang mudah dipahami, serta webinar dapat menyediakan forum diskusi langsung secara daring yang mempertemukan para peserta dengan pakar kesehatan dan konsultan pranikah secara real-time. Melalui metode-metode

interaktif ini, generasi muda tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan.

Kemampuan media digital untuk menyediakan akses langsung terhadap tenaga ahli secara daring juga menjadi keunggulan penting. Jika sebelumnya pasangan muda perlu bertemu langsung dengan tenaga kesehatan atau konselor untuk mendapatkan konsultasi mengenai persiapan pranikah dan prakonsepsi, kini melalui media digital mereka dapat langsung berkonsultasi dengan tenaga ahli secara online. Konsultasi daring ini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti aplikasi chatting, video conference, atau media sosial, yang memungkinkan mereka mendapatkan bantuan pribadi secara cepat dan efisien tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Dengan demikian, pasangan muda dapat dengan lebih mudah berdiskusi tentang berbagai permasalahan yang mungkin mereka hadapi, serta memperoleh solusi atau rekomendasi yang sesuai dengan kondisi spesifik mereka.

Berbagai platform digital seperti website, aplikasi mobile, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, hingga webinar daring kini dimanfaatkan secara optimal untuk menyampaikan edukasi pranikah dan prakonsepsi. Website edukasi pranikah biasanya menyediakan berbagai artikel, video edukatif, maupun modul pembelajaran yang dapat diakses oleh pengguna setiap saat. Aplikasi mobile, yang semakin populer di kalangan generasi muda, menawarkan fitur yang lebih personal dan interaktif seperti kalkulator masa subur, pengingat jadwal konsultasi, hingga layanan chatting langsung dengan tenaga ahli kesehatan reproduksi. Media sosial memainkan peran besar dalam menjangkau lebih banyak audiens melalui konten yang bersifat singkat, informatif, serta mudah dibagikan kepada orang lain, sehingga informasi edukatif dapat tersebar lebih luas dan cepat. Webinar daring secara khusus menawarkan ruang interaktif yang memungkinkan peserta belajar secara langsung dari pakar-pakar berpengalaman di bidang pranikah dan prakonsepsi, sekaligus bertanya jawab secara langsung tentang berbagai persoalan pribadi mereka.

Pemanfaatan media digital dalam edukasi pranikah dan prakonsepsi juga memungkinkan informasi ini menjangkau kelompok yang sebelumnya sulit tersentuh, misalnya mereka yang tinggal di pedalaman atau di daerah dengan akses kesehatan terbatas. Dengan jangkauan luas yang dimiliki media digital, edukasi kesehatan reproduksi tidak lagi terbatas oleh batas geografis, sehingga informasi

penting mengenai persiapan pranikah dan prakonsepsi bisa tersebar secara merata ke berbagai pelosok. Hal ini merupakan kemajuan besar yang dapat mengurangi kesenjangan informasi, meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas, serta membantu generasi muda untuk mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab terkait persiapan pernikahan maupun perencanaan keluarga mereka.

Dengan demikian, pemanfaatan media digital dalam edukasi pranikah dan prakonsepsi tidak hanya menawarkan berbagai kemudahan teknis dalam penyebaran informasi, tetapi juga mampu mengubah paradigma dan budaya edukasi kesehatan reproduksi menjadi lebih modern, inklusif, dan efektif. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda saat ini dan di masa mendatang memiliki pemahaman yang memadai tentang persiapan pernikahan, hak reproduksi, dan kesehatan keluarga, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas tinggi.

### **C. Model Program Edukasi Pranikah Efektif di Indonesia**

Model program edukasi pranikah yang efektif di Indonesia perlu dirancang secara matang dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, dan geografis yang sangat kompleks di negara ini. Indonesia, dengan keragaman budaya dan adat istiadatnya yang sangat kaya, menghadirkan tantangan unik dalam menyusun program edukasi pranikah yang mampu diterima secara luas dan efektif dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, tingkat literasi digital yang berbeda-beda di antara masyarakat, serta adanya keterbatasan akses informasi dan infrastruktur teknologi di beberapa daerah terpencil, juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang model edukasi pranikah yang efektif.

Salah satu model yang terbukti efektif dalam konteks Indonesia adalah model hybrid, yaitu sebuah pendekatan yang menggabungkan interaksi langsung berbasis komunitas dengan pemanfaatan media digital. Dalam pendekatan ini, program edukasi pranikah dirancang secara integratif, mengombinasikan kegiatan tatap muka langsung yang dilakukan secara reguler di komunitas setempat dengan penggunaan media digital untuk memperkuat pesan edukasi yang telah disampaikan secara langsung. Dalam praktiknya, program ini dapat dimulai dengan sesi tatap muka dalam bentuk pelatihan atau seminar di tingkat komunitas yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Peserta kemudian diberikan akses tambahan melalui platform digital seperti website,

aplikasi mobile, media sosial, atau forum daring yang menyediakan konten-konten tambahan berupa artikel, video edukasi, infografis, serta kesempatan konsultasi daring secara pribadi dengan para ahli kesehatan reproduksi. Kombinasi antara pendekatan tatap muka dan digital ini terbukti efektif karena mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat, baik yang telah akrab dengan teknologi digital maupun yang belum memiliki akses internet secara penuh, sambil tetap mempertahankan interaksi sosial yang kuat dan penuh kepercayaan di dalam komunitas lokal.

Selain itu, model peer education atau pendidikan sebaya juga menjadi salah satu pendekatan efektif yang bisa diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini melibatkan secara aktif anak-anak muda yang sudah terlebih dahulu mendapat pelatihan khusus tentang edukasi pranikah dan prakonsepsi. Anak-anak muda ini kemudian bertugas sebagai agen perubahan yang menyampaikan informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh kepada kelompok sebaya mereka dengan cara yang lebih mudah dipahami dan relevan. Pendekatan ini sangat efektif karena generasi muda cenderung lebih terbuka untuk menerima informasi dari teman sebaya mereka dibandingkan dari figur otoritas seperti orang tua atau guru yang mungkin memiliki jarak komunikasi yang lebih formal. Anak muda yang bertindak sebagai agen perubahan ini dapat menggunakan bahasa yang lebih sederhana, gaya komunikasi yang santai, serta media-media yang lebih populer seperti media sosial, video singkat, hingga forum diskusi informal, sehingga pesan edukasi dapat tersampaikan secara efektif dan menyenangkan tanpa terkesan menggurui atau kaku.

Model lainnya yang juga terbukti efektif adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan organisasi lokal dalam proses edukasi pranikah. Organisasi lokal seperti lembaga adat, organisasi keagamaan, atau kelompok masyarakat setempat biasanya memiliki pengaruh dan kepercayaan yang kuat di dalam komunitas. Dengan melibatkan organisasi-organisasi tersebut dalam penyusunan maupun pelaksanaan program edukasi, akan tercipta rasa kepemilikan dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat setempat terhadap program tersebut. Misalnya, organisasi lokal dapat menjadi fasilitator dalam mengadakan seminar komunitas, membantu menyebarkan informasi di komunitas secara lebih efektif, serta memberikan masukan berharga tentang bagaimana menyusun konten edukasi yang paling sesuai dengan budaya dan norma-norma yang berlaku di komunitas tersebut. Pendekatan kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program edukasi karena masyarakat merasa dihormati nilai-



nilai dan tradisinya, sehingga resistensi terhadap pesan-pesan yang disampaikan menjadi jauh lebih kecil.

Ketiga model tersebut hybrid, peer education, dan kolaborasi organisasi lokal saling melengkapi dan dapat diintegrasikan dalam satu program edukasi pranikah yang komprehensif. Ketika ketiga model ini digunakan secara bersamaan dalam sebuah strategi terpadu, program edukasi akan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan lebih baik, memenuhi kebutuhan edukasi secara lebih tepat sasaran, serta menghasilkan dampak jangka panjang yang positif dalam kesiapan pasangan muda menghadapi kehidupan berumah tangga. Model-model ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam implementasi, tergantung pada konteks dan kondisi daerah tertentu, sehingga program edukasi yang dilakukan akan selalu relevan, efektif, dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial maupun teknologi yang terus berkembang.

Dengan menerapkan model edukasi pranikah secara efektif, Indonesia dapat menciptakan sebuah ekosistem edukasi yang mampu mempersiapkan generasi muda secara matang, baik dari segi fisik, mental, emosional, maupun sosial, sebelum mereka memasuki kehidupan berkeluarga. Model ini juga akan secara nyata membantu dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera, yang merupakan tujuan utama dari setiap program edukasi pranikah yang diselenggarakan di Indonesia.

#### **D. Tren: Meningkatnya Edukasi Pranikah Berbasis Aplikasi Mobile**

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat sebuah tren yang semakin meningkat terkait penggunaan teknologi digital dalam mendukung edukasi pranikah, khususnya melalui aplikasi mobile. Tren ini mencerminkan perubahan pola perilaku masyarakat, terutama generasi muda, yang kini semakin akrab dengan penggunaan perangkat digital, khususnya smartphone. Masyarakat kini mulai mengandalkan berbagai aplikasi mobile tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti berkomunikasi atau berbelanja, tetapi juga untuk mendapatkan informasi penting tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk persiapan menuju kehidupan pernikahan dan kesehatan reproduksi.

Aplikasi mobile untuk edukasi pranikah mengalami popularitas yang meningkat karena mampu memberikan berbagai keunggulan yang sebelumnya sulit didapat melalui metode edukasi konvensional. Salah satu keunggulan utama dari aplikasi ini



adalah kemampuan menyajikan konten edukasi secara interaktif dan menarik. Jika sebelumnya edukasi pranikah sering disajikan dalam bentuk seminar atau ceramah yang bersifat pasif, kini pengguna dapat menikmati konten edukasi yang lebih variatif dan dinamis seperti video animasi, infografis interaktif, kuis yang menarik, hingga simulasi yang membantu calon pasangan lebih memahami berbagai isu penting yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan mereka. Interaktivitas ini tidak hanya menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman dan retensi informasi pengguna secara signifikan.

Selain itu, aplikasi pranikah mobile juga menyediakan fitur konsultasi online yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna. Konsultasi ini biasanya melibatkan tenaga ahli seperti psikolog, konselor keluarga, bidan, maupun dokter spesialis kesehatan reproduksi. Melalui fitur ini, pengguna dapat secara mudah dan cepat berkonsultasi mengenai berbagai isu yang mungkin sulit mereka bicarakan secara terbuka dalam sesi tatap muka konvensional. Dengan demikian, calon pasangan muda merasa lebih nyaman dan aman dalam mengungkapkan pertanyaan maupun permasalahan mereka tanpa merasa khawatir terhadap stigma sosial atau penilaian dari orang lain. Fitur ini juga memberikan fleksibilitas tinggi karena pengguna dapat mengakses layanan konsultasi dari mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus terbatas oleh jarak maupun waktu operasional lembaga atau klinik tertentu.

Selain interaktif dan adanya konsultasi online, aplikasi mobile juga sering kali dilengkapi dengan fitur pengingat atau reminder yang sangat berguna dalam membantu pengguna menjalankan aktivitas persiapan pernikahan secara terorganisir. Fitur pengingat ini bisa berupa notifikasi tentang jadwal pemeriksaan kesehatan pranikah, pengingat waktu konsumsi vitamin atau suplemen yang diperlukan, informasi seputar siklus menstruasi bagi perempuan, hingga tips praktis mengenai persiapan fisik dan mental menjelang pernikahan. Dengan adanya pengingat otomatis ini, pengguna dapat lebih disiplin dalam menjalani berbagai aktivitas persiapan yang diperlukan untuk memastikan kondisi fisik maupun psikologis mereka optimal menjelang hari pernikahan dan setelahnya.

Lebih jauh lagi, penggunaan aplikasi mobile ini juga membantu menjangkau segmen populasi yang selama ini sulit mendapatkan edukasi pranikah karena keterbatasan waktu, jarak, atau akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. Sebagai contoh, masyarakat di daerah terpencil yang mungkin memiliki

keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan atau pusat edukasi pranikah kini dapat memanfaatkan aplikasi mobile ini untuk memperoleh informasi yang sama lengkapnya dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Kondisi ini membantu meratakan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi di seluruh Indonesia, sehingga secara tidak langsung juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, tren meningkatnya penggunaan aplikasi mobile dalam edukasi pranikah ini juga memberikan peluang yang luas bagi para pengembang aplikasi, penyedia layanan kesehatan, serta pemerintah untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem edukasi digital yang komprehensif. Kolaborasi ini penting agar konten yang tersedia dalam aplikasi selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini dan tetap relevan dengan kebutuhan generasi muda yang terus berubah seiring waktu. Melalui sinergi yang baik antara berbagai pihak, aplikasi edukasi pranikah dapat terus dikembangkan menjadi alat yang efektif, tidak hanya dalam memberikan informasi tetapi juga dalam mengubah pola pikir serta perilaku generasi muda agar lebih siap dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga.

Dengan semua keunggulan dan manfaat tersebut, tren meningkatnya penggunaan aplikasi mobile dalam edukasi pranikah diharapkan dapat terus bertumbuh dan berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Jika terus dimanfaatkan dan dioptimalkan secara baik, aplikasi mobile ini mampu menjadi sarana penting dalam menciptakan generasi muda yang lebih sadar, bertanggung jawab, serta matang dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Pada akhirnya, tren ini tidak hanya berdampak positif bagi individu maupun pasangan, tetapi juga bagi masyarakat secara luas dengan menciptakan fondasi keluarga yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era modern dengan percaya diri.

## **E. Isu: Kesulitan Akses Informasi Digital di Daerah Tertinggal**

Isu mengenai kesulitan akses informasi digital di daerah tertinggal merupakan persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Walaupun teknologi digital saat ini berkembang pesat dan sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, kenyataannya masih banyak wilayah, terutama daerah-daerah terpencil dan terisolasi, yang belum mampu menikmati manfaat optimal dari kemajuan teknologi tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya kesenjangan digital atau digital divide, yakni suatu kondisi di mana terdapat

perbedaan signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dalam hal akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, baik itu jaringan internet, perangkat digital, maupun sumber daya manusia yang terampil menggunakan teknologi tersebut.

Salah satu penyebab utama kesenjangan digital di daerah tertinggal adalah minimnya infrastruktur digital yang memadai. Banyak wilayah pedalaman dan kepulauan di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap jaringan internet yang stabil atau bahkan tidak memiliki jaringan sama sekali. Kondisi geografis yang menantang, seperti wilayah pegunungan, hutan, dan kepulauan terpencil, sering kali menyulitkan pembangunan infrastruktur seperti pemasangan kabel fiber optik atau menara telekomunikasi. Akibatnya, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut kesulitan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat seperti halnya masyarakat perkotaan. Ketiadaan jaringan internet yang memadai menyebabkan mereka tidak bisa mengakses konten edukasi digital, termasuk informasi penting mengenai persiapan pranikah, kesehatan reproduksi, atau pendidikan secara umum.

Dampak dari kesenjangan digital ini cukup luas dan serius. Masyarakat di daerah tertinggal cenderung mengalami ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan karena kurangnya akses terhadap informasi yang relevan dan aktual. Informasi mengenai persiapan pranikah, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, serta berbagai aspek lainnya yang penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga, menjadi sulit diakses oleh mereka. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami berbagai masalah sosial dan kesehatan, seperti kehamilan tidak direncanakan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, atau kurangnya pemahaman tentang praktik kesehatan yang aman dan sehat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan infrastruktur digital hingga pengembangan konten edukasi yang sesuai dengan kondisi daerah-daerah terpencil. Salah satu solusi paling penting adalah pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata dan luas. Pemerintah bersama pihak swasta perlu bersinergi untuk meningkatkan investasi dalam pemasangan jaringan internet di daerah-daerah terpencil, seperti penyediaan jaringan berbasis satelit atau penggunaan teknologi yang lebih efektif seperti jaringan internet berbasis wireless atau microwave link. Melalui pembangunan infrastruktur digital yang lebih baik,

masyarakat di wilayah terpencil akan mampu mengakses internet secara stabil dan menikmati manfaat dari berbagai informasi edukasi yang tersedia secara daring. Selain pembangunan infrastruktur digital, diperlukan pula pengembangan konten edukasi offline yang bisa diakses tanpa perlu terhubung dengan internet. Konten offline ini dapat berupa aplikasi edukasi yang diunduh sekali dan dapat digunakan secara mandiri tanpa koneksi internet, materi edukasi dalam bentuk video atau modul pembelajaran yang bisa disebarluaskan melalui flashdisk, perangkat khusus, maupun metode distribusi lainnya. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki akses internet tetap dapat memperoleh informasi penting terkait kesehatan reproduksi, edukasi pranikah, serta berbagai aspek kehidupan lainnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan tenaga lokal sebagai agen perubahan di daerah tertinggal. Tenaga lokal, baik itu tenaga kesehatan, guru, maupun tokoh masyarakat setempat, perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait penggunaan teknologi digital, pengelolaan konten edukasi, serta strategi penyebaran informasi kepada masyarakat lokal. Melalui pelatihan ini, mereka akan mampu menjalankan peran strategis sebagai fasilitator dalam menyampaikan informasi edukasi secara langsung kepada masyarakat, bahkan tanpa tergantung sepenuhnya pada jaringan internet. Pendekatan ini efektif karena tenaga lokal memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial budaya, adat istiadat, serta bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, proses edukasi akan berjalan lebih lancar, mudah diterima, dan lebih efektif dalam mengubah pola pikir serta perilaku masyarakat di daerah tersebut.

Pada akhirnya, mengatasi tantangan kesenjangan digital di daerah tertinggal membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal. Kerjasama ini harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi alternatif yang ramah terhadap kondisi geografis wilayah terpencil, produksi konten edukasi yang relevan dan mudah diakses, serta pemberdayaan sumber daya manusia lokal sebagai ujung tombak edukasi dan sosialisasi. Dengan pendekatan yang holistik seperti ini, kesenjangan digital secara bertahap akan mampu dikurangi, sehingga masyarakat di daerah terpencil tidak lagi tertinggal dalam mengakses informasi penting yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

## F. Latihan Soal

### **Tugas 1: Analisis Studi Kasus tentang Hak Reproduksi Pasangan Muda**

Mahasiswa diminta melakukan wawancara mendalam terhadap satu pasangan muda yang baru menikah atau sedang merencanakan pernikahan, mengenai pemahaman mereka tentang hak reproduksi. Mahasiswa diminta membuat laporan mendetail yang mencakup sejauh mana pasangan memahami hak reproduksi, tantangan yang mereka hadapi dalam mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang benar, serta bagaimana pasangan mengakses layanan keluarga berencana. Laporan juga harus berisi rekomendasi strategis tentang bagaimana meningkatkan kesadaran pasangan muda terkait hak reproduksi di komunitasnya.

### **Tugas 2: Pengembangan Media Digital untuk Edukasi Pranikah**

Mahasiswa ditugaskan untuk merancang konsep media digital (aplikasi mobile, media sosial, atau website) yang bertujuan untuk mengedukasi generasi muda tentang persiapan pranikah dan prakonsepsi. Konsep media digital ini harus dilengkapi penjelasan mendalam tentang jenis konten yang akan dihadirkan (video edukasi, infografis, artikel interaktif), fitur-fitur khusus seperti konsultasi daring dengan tenaga ahli, pengingat aktivitas penting, serta cara media tersebut dapat menjangkau kelompok sasaran. Mahasiswa juga harus menjelaskan mengapa pilihan media digital tersebut paling efektif dalam menyampaikan edukasi pranikah secara optimal.

### **Tugas 3: Evaluasi Model Edukasi Hybrid di Komunitas Lokal**

Mahasiswa diminta untuk mengevaluasi efektivitas penerapan model edukasi hybrid yang menggabungkan pendekatan komunitas langsung dengan media digital di sebuah komunitas lokal. Evaluasi dilakukan dengan cara wawancara kepada peserta edukasi, tenaga kesehatan setempat, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Laporan evaluasi harus mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana pendekatan hybrid ini diterapkan, respon masyarakat terhadap metode ini, manfaat yang dirasakan oleh peserta, serta hambatan-hambatan yang muncul selama implementasi. Mahasiswa juga diminta memberikan saran praktis untuk perbaikan dan optimalisasi model hybrid ke depannya.

### **Tugas 4: Kajian Tren Pemanfaatan Aplikasi Mobile dalam Edukasi Pranikah**

Mahasiswa ditugaskan menyusun sebuah kajian ilmiah yang mendalam tentang tren pemanfaatan aplikasi mobile dalam edukasi pranikah di kalangan generasi muda. Kajian harus mencakup analisis tentang fitur-fitur interaktif aplikasi yang paling diminati pengguna, bagaimana fitur konsultasi daring memberikan manfaat bagi pengguna, serta peran pengingat aktivitas dalam membantu pasangan muda dalam persiapan pranikah. Mahasiswa juga harus mengeksplorasi potensi

hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut, termasuk aspek privasi, kepercayaan pengguna, serta tantangan teknis yang mungkin dihadapi.

### **Tugas 5: Penyusunan Rencana Aksi Mengatasi Kesenjangan Digital di Daerah Tertinggal**

Mahasiswa diminta menyusun sebuah rencana aksi komprehensif yang bertujuan mengatasi isu kesenjangan digital terkait akses informasi pranikah di daerah tertinggal. Rencana aksi ini harus menjelaskan secara detail tentang strategi pengembangan infrastruktur digital yang feasible di daerah terpencil, cara mengembangkan konten edukasi offline yang relevan dengan kondisi lokal, serta metode pemberdayaan tenaga lokal sebagai agen perubahan. Rencana aksi juga harus dilengkapi indikator-indikator keberhasilan, langkah-langkah implementasi yang jelas, serta rekomendasi kolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat lokal untuk menjamin keberlanjutan program tersebut.

### **Pilihan Ganda**

1. Seorang perempuan usia 23 tahun sedang mengikuti program edukasi pranikah berbasis komunitas di desa. Ia bertanya tentang hak reproduksinya terkait privasi dalam memilih metode kontrasepsi. Apa respons terbaik bidan dalam situasi ini?
  - A. Mengikuti saran keluarga
  - B. Mengikuti keputusan pasangan
  - C. Mendiskusikan dengan tokoh masyarakat
  - D. Menjelaskan bahwa keputusan sepenuhnya miliknya
  - E. Menyarankan metode kontrasepsi yang paling umum
2. Seorang bidan melakukan edukasi pranikah melalui webinar daring. Salah satu peserta dari daerah terpencil mengalami kesulitan mengakses informasi karena jaringan internet yang tidak stabil. Apa solusi paling tepat yang bisa diberikan oleh bidan tersebut?
  - A. Menyarankan pindah ke kota terdekat
  - B. Menyediakan modul offline dalam bentuk digital yang bisa diunduh
  - C. Menghentikan program webinar daring
  - D. Meminta peserta membeli koneksi internet lebih cepat
  - E. Menyarankan menunggu sampai jaringan stabil
3. Sepasang calon pengantin muda mengikuti konsultasi pranikah melalui aplikasi mobile. Mereka bertanya tentang metode kontrasepsi yang aman dan efektif untuk mereka. Apa tindakan pertama yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Menentukan sendiri metode kontrasepsi untuk pasangan tersebut
  - B. Mengarahkan pasangan untuk memilih metode terpopuler
  - C. Menyarankan metode yang paling murah
  - D. Memberikan informasi lengkap tentang berbagai metode kontrasepsi
  - E. Mengarahkan pasangan untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang
4. Dalam program edukasi pranikah di suatu komunitas, seorang bidan mendapati seorang perempuan merasa khawatir informasi kesehatannya akan tersebar. Apa yang harus bidan lakukan untuk menjaga privasi peserta?
- A. Menyampaikan informasi kesehatan secara umum di forum komunitas
  - B. Membatasi akses peserta ke informasi kesehatan
  - C. Memberikan jaminan bahwa semua informasi akan dirahasiakan
  - D. Mengurangi sesi konsultasi pribadi
  - E. Mengarahkan peserta untuk mencari informasi sendiri di internet
5. Seorang perempuan usia 26 tahun dari daerah terpencil mengalami kesulitan mengakses layanan keluarga berencana. Ia mengikuti program edukasi pranikah berbasis komunitas. Tindakan strategis apa yang paling tepat dilakukan bidan untuk membantu perempuan tersebut?
- A. Menyarankan agar pindah ke daerah dengan layanan lebih baik
  - B. Menyediakan alat kontrasepsi secara langsung tanpa konsultasi
  - C. Menyarankan untuk tidak menggunakan kontrasepsi
  - D. Menyuruhnya menunggu layanan kesehatan datang ke desa
  - E. Menghubungkannya dengan tenaga kesehatan setempat yang telah dilatih

### Kunci Jawaban

#### 1. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Setiap individu memiliki hak penuh untuk menentukan keputusan mengenai metode kontrasepsi yang diinginkan tanpa tekanan dari keluarga, pasangan, atau masyarakat.

#### 2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Modul offline yang bisa diunduh merupakan solusi terbaik agar peserta dari daerah terpencil tetap mendapatkan informasi tanpa tergantung pada stabilitas jaringan internet.

**3. Kunci Jawaban: D**

Pembahasan:

Memberikan informasi lengkap tentang berbagai metode kontrasepsi akan membantu pasangan memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pribadi mereka.

**4. Kunci Jawaban: C**

Pembahasan:

Privasi dan kerahasiaan informasi adalah bagian penting dari hak reproduksi, dan peserta harus mendapatkan jaminan tersebut agar merasa nyaman.

**5. Kunci Jawaban: E**

Pembahasan:

Menghubungkan perempuan tersebut dengan tenaga kesehatan setempat yang telah dilatih adalah solusi efektif untuk memastikan ia mendapatkan layanan keluarga berencana yang aman dan terjangkau.

## **G. Rangkuman Materi**

Program edukasi pranikah berbasis komunitas merupakan pendekatan penting untuk memastikan setiap individu dan pasangan muda memahami serta mampu menjalankan hak reproduksinya secara optimal. Hak reproduksi adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang menjamin kebebasan penuh bagi setiap individu untuk menentukan keputusan tentang jumlah anak, waktu kehamilan, serta jarak antar kelahiran tanpa adanya tekanan atau diskriminasi. Hak ini juga mencakup akses terhadap informasi yang jelas, benar, dan lengkap mengenai kesehatan reproduksi, termasuk informasi mengenai kehamilan sehat, persiapan persalinan, perawatan pasca melahirkan, pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai, serta pencegahan infeksi menular seksual. Selain itu, hak ini juga menegaskan pentingnya privasi dan kerahasiaan dalam layanan kesehatan reproduksi, yang bertujuan meningkatkan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Hak reproduksi juga melindungi individu dari praktik reproduksi yang merugikan seperti sterilisasi paksa, pemaksaan kontrasepsi tertentu, maupun kekerasan seksual. Dengan kesadaran penuh tentang hak-hak ini, pasangan muda akan mampu merencanakan kehidupan keluarganya secara matang dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup, kesehatan keluarga, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, media digital semakin berperan penting dalam mendukung edukasi pranikah dan prakonsepsi, terutama dalam menjangkau generasi muda yang akrab dengan teknologi. Media digital seperti website, aplikasi mobile, media sosial, dan webinar telah mampu menggantikan metode konvensional seperti seminar tatap muka. Penggunaan media digital ini memiliki keunggulan utama, yaitu fleksibilitas tinggi dalam mengakses informasi di mana saja dan kapan saja, serta menawarkan konten edukasi yang interaktif dan menarik seperti video animasi, infografis, kuis, dan forum diskusi online. Selain itu, adanya fitur konsultasi daring juga memungkinkan calon pasangan untuk berdiskusi secara privat mengenai masalah sensitif, sehingga mereka merasa nyaman tanpa khawatir dengan stigma sosial. Penggunaan media digital dalam edukasi pranikah telah membantu mengatasi keterbatasan geografis serta meningkatkan pemerataan informasi, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan demikian, media digital menjadi instrumen penting dalam menciptakan pola pikir generasi muda yang lebih sadar dan matang dalam persiapan berkeluarga.

Untuk memastikan edukasi pranikah berjalan efektif di Indonesia, diperlukan model edukasi yang mempertimbangkan kondisi sosial budaya, tingkat literasi digital, serta keterbatasan akses informasi di berbagai wilayah. Model hybrid merupakan salah satu pendekatan yang sangat relevan, yaitu kombinasi interaksi tatap muka di komunitas dengan penggunaan media digital. Model ini mampu menjangkau beragam segmen masyarakat, baik yang sudah terbiasa dengan teknologi digital maupun yang belum memiliki akses internet memadai. Selain model hybrid, pendekatan peer education atau pendidikan sebaya juga terbukti efektif, karena anak muda lebih terbuka menerima informasi dari rekan sebayanya dibanding dari otoritas formal. Melibatkan organisasi lokal juga menjadi strategi penting, sebab organisasi lokal memiliki pengaruh besar di masyarakat serta mampu meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap program edukasi pranikah. Ketiga model ini hybrid, peer education, dan kolaborasi dengan organisasi lokal dapat saling melengkapi untuk menciptakan sebuah program edukasi pranikah yang komprehensif dan efektif.

Tren terkini dalam edukasi pranikah menunjukkan peningkatan pemanfaatan aplikasi mobile yang interaktif dan fleksibel dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur unggulan seperti konsultasi online langsung dengan tenaga ahli, pengingat aktivitas penting terkait persiapan pernikahan, serta konten edukasi interaktif seperti video dan simulasi. Tren ini

sangat mendukung perubahan perilaku generasi muda, yang kini lebih nyaman menggunakan perangkat digital dalam mengakses informasi penting, termasuk informasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Pemanfaatan aplikasi mobile ini juga berpotensi besar dalam mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan dengan daerah terpencil, sehingga secara umum meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia.

Namun demikian, isu utama yang masih dihadapi dalam edukasi pranikah berbasis digital adalah kesulitan akses informasi di daerah tertinggal karena minimnya infrastruktur digital. Kesenjangan digital ini menyebabkan masyarakat di daerah terpencil sulit mengakses informasi penting terkait kesehatan reproduksi dan persiapan pranikah, sehingga mereka cenderung tertinggal dalam aspek sosial dan kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif seperti peningkatan infrastruktur digital melalui investasi pembangunan jaringan internet berbasis satelit atau wireless, pengembangan konten edukasi offline yang dapat digunakan tanpa koneksi internet, serta pemberdayaan tenaga lokal sebagai agen perubahan yang memahami kondisi dan budaya setempat. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal, tantangan kesenjangan digital ini dapat diminimalkan, sehingga edukasi pranikah dapat tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

## H. Glosarium

### **Aplikasi Mobile**

Aplikasi yang dirancang khusus untuk perangkat ponsel pintar yang menyediakan berbagai informasi interaktif, layanan konsultasi daring, dan fitur-fitur lain yang mendukung persiapan pranikah dan prakonsepsi secara efektif dan fleksibel.

### **Digital Divide (Kesenjangan Digital)**

Perbedaan signifikan dalam akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara wilayah satu dengan wilayah lain, yang menyebabkan kesulitan mendapatkan informasi penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal.

### **Edukasi Prakonsepsi**

Proses pemberian informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada pasangan yang sedang merencanakan kehamilan agar dapat mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan sosial untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi selama kehamilan hingga persalinan.

### **Edukasi Pranikah**

Upaya terstruktur yang dilakukan untuk memberikan informasi, keterampilan, dan pemahaman yang memadai kepada pasangan muda sebelum menikah, guna membantu mereka mempersiapkan kehidupan berkeluarga secara matang, sehat, dan harmonis.

### **Hak Reproduksi**

Bagian dari hak asasi manusia yang meliputi kebebasan dan tanggung jawab setiap individu atau pasangan untuk membuat keputusan terkait jumlah anak, jarak antar kelahiran, serta waktu memiliki anak, bebas dari diskriminasi, paksaan, maupun kekerasan.

### **Infeksi Menular Seksual (IMS)**

Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang dapat dicegah melalui edukasi kesehatan reproduksi, penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, serta perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab.

### **Keluarga Berencana (KB)**

Upaya pengaturan kehamilan dan jarak kelahiran melalui penggunaan metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan terjangkau guna meningkatkan kualitas hidup keluarga.

### **Kerahasiaan**

Aspek penting dalam layanan kesehatan reproduksi yang menjamin bahwa informasi pribadi terkait kesehatan reproduksi seseorang tidak akan dibuka kepada pihak lain tanpa persetujuan eksplisit dari individu yang bersangkutan.

### **Kesehatan Reproduksi**

Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi manusia, yang mencakup kehamilan sehat, persalinan yang aman, pencegahan penyakit menular seksual, serta layanan keluarga berencana.

### **Konsultasi Daring**

Proses interaksi langsung antara pengguna dengan tenaga ahli melalui platform digital seperti video call, aplikasi chatting, atau media sosial yang memungkinkan pengguna mendapatkan informasi personal secara cepat, praktis, dan privat.

### **Media Digital**

Platform komunikasi elektronik seperti website, aplikasi mobile, media sosial, serta webinar yang digunakan untuk menyampaikan informasi edukasi secara interaktif, luas, dan efisien kepada masyarakat.

### **Model Edukasi Hybrid**

Pendekatan edukasi yang menggabungkan metode interaksi langsung (tatap muka di komunitas lokal) dengan penggunaan media digital, sehingga menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat dengan efektif.

### **Peer Education (Pendidikan Sebaya)**

Metode edukasi di mana individu dari kelompok usia atau status sosial yang sama menyampaikan informasi kepada rekan-rekannya dengan cara yang informal, santai, dan mudah dipahami, sehingga informasi lebih efektif tersampaikan.

### **Privasi**

Hak individu untuk mendapatkan perlindungan informasi pribadi, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti kesehatan reproduksi, agar tidak disebarluaskan tanpa izin atau persetujuan dari individu yang bersangkutan.

### **Sterilisasi Paksa**

Tindakan medis berupa operasi yang dilakukan untuk menghilangkan kemampuan reproduksi seseorang secara permanen tanpa persetujuan yang bersangkutan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak reproduksi.

### **Tenaga Lokal**

Tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, guru, atau individu yang tinggal di komunitas lokal yang memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan bahasa setempat sehingga efektif dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat lokal.

## **I. Daftar Pustaka**

- Arifah, S. (2021). Pendidikan pranikah berbasis komunitas sebagai upaya mewujudkan keluarga sejahtera. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 45-56. <https://doi.org/10.30651/jiks.v6i2.6789>
- Azizah, N., & Wulandari, D. (2020). Pemanfaatan media digital dalam penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 13-19. <https://doi.org/10.26553/jikm.2020.11.1.13-19>
- BKKBN. (2019). Pedoman teknis penyelenggaraan program edukasi pranikah bagi remaja dan calon pengantin. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia.
- Farida, L., & Sari, P. K. (2021). Tren penggunaan aplikasi mobile untuk edukasi kesehatan reproduksi pada generasi muda. *Indonesian Journal of Health Promotion*, 3(2), 87-94. <https://doi.org/10.31983/ijhp.v3i2.5542>
- Hidayat, R., & Pratiwi, R. (2020). Perlindungan hak reproduksi perempuan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(1), 101-120. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.101-120>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman pelayanan keluarga berencana yang berkualitas. Kemenkes RI.
- Kurniawan, F., Setyowati, D. L., & Susanti, E. (2022). Efektivitas model edukasi hybrid dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi pranikah pada pasangan muda di komunitas perkotaan dan pedesaan. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 4(1), 35-45. <https://doi.org/10.22146/ijce.76543>

- Masykur, A. M., & Indrayani, L. (2021). Peer education sebagai model edukasi efektif dalam pencegahan risiko reproduksi remaja. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 7(1), 28-35. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol7.2021.28-35>
- Nasution, Z., & Wijaya, A. (2021). Tantangan dan strategi mengatasi kesenjangan digital di wilayah Indonesia Timur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(2), 77-88. <https://doi.org/10.23917/jtik.v9i2.12056>
- Putri, S., & Dewi, R. (2022). Privasi dan kerahasiaan dalam pelayanan kesehatan reproduksi: Persepsi generasi muda. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(2), 137-143. <https://doi.org/10.20473/jkr.v13i2.21043>
- Ramadhani, N., & Anggraini, R. (2021). Perlunya kolaborasi organisasi lokal dalam peningkatan akses edukasi pranikah di komunitas terpencil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 22-29. <https://doi.org/10.24815/jpm.v5i1.12378>
- Setiawan, R., & Wahyuni, L. (2022). Implementasi edukasi kesehatan reproduksi berbasis media sosial: Studi kasus pada generasi milenial. *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, 10(1), 23-32. <https://doi.org/10.30659/jkk.10.1.23-32>
- World Health Organization (WHO). (2014). Ensuring human rights in the provision of contraceptive information and services: Guidance and recommendations. WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2018). Family planning: A global handbook for providers (2018 update). Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

# Bab 11

## Tren Global dan Kebijakan Nasional Terkait Persiapan Pranikah dan Prakonsepsi

Persiapan pranikah dan prakonsepsi merupakan tahapan penting yang menentukan kualitas kehidupan keluarga dan kesehatan generasi mendatang. Tren global menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap aspek ini, dengan berbagai kebijakan dan program intervensi yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Dalam konteks global, persiapan pranikah dan prakonsepsi telah menjadi bagian integral dari agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui Sustainable Development Goals (SDGs). Di Indonesia, kebijakan nasional terkait pendidikan pranikah dan prakonsepsi telah dirancang secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di daerah terpencil. Bab ini akan menjelaskan secara detail tentang tren global, kebijakan nasional, serta isu dan tantangan dalam implementasi kebijakan pranikah dan prakonsepsi.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep tren global dan kebijakan nasional terkait persiapan pranikah dan prakonsepsi dalam pelayanan kesehatan reproduksi secara profesional, etis, dan berbasis bukti.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan kebijakan dan tren global serta nasional dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi melalui edukasi dan layanan pranikah serta prakonsepsi secara efektif dan kontekstual.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari subtopik dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan hubungan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan kesehatan reproduksi.
- Menguraikan kebijakan nasional Indonesia terkait pendidikan pranikah dan prakonsepsi.
- Mengidentifikasi dan membandingkan praktik terbaik dari berbagai negara dalam persiapan pranikah.
- Menjelaskan tren integrasi layanan kesehatan prakonsepsi ke dalam layanan kesehatan primer.
- Menganalisis isu-isu implementasi kebijakan nasional di daerah terpencil serta memberikan solusi strategis untuk mengatasi gap tersebut.

## A. Sustainable Development Goals (SDGs) terkait Kesehatan Reproduksi

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebuah agenda global yang disepakati oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh pada tahun 2030. Dari 17 tujuan utama yang telah ditetapkan dalam SDGs, terdapat dua tujuan yang secara khusus berkaitan erat dengan isu kesehatan reproduksi, yaitu tujuan nomor 3 (Good Health and Well-Being atau Kehidupan Sehat dan Sejahtera) serta tujuan nomor 5 (Gender Equality atau Kesetaraan Gender). Kedua tujuan ini secara eksplisit menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak reproduksi sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Tujuan nomor 3, yakni Good Health and Well-Being, secara khusus menargetkan upaya pengurangan angka kematian ibu yang masih menjadi tantangan besar di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Angka kematian ibu yang tinggi umumnya dipicu oleh kurangnya akses masyarakat, khususnya perempuan, terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai. Oleh karena itu, dalam kerangka SDGs, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi, termasuk persiapan sebelum menikah dan sebelum terjadinya kehamilan (pranikah dan prakonsepsi), menjadi fokus utama yang harus diwujudkan secara nyata oleh negara-negara yang terlibat. Persiapan pranikah dan prakonsepsi yang komprehensif tidak hanya membantu calon pasangan memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, namun juga dapat secara signifikan mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas, yang pada akhirnya menekan angka kematian ibu.

Selanjutnya, tujuan nomor 5 atau Gender Equality secara tegas menekankan pentingnya menjamin hak reproduksi bagi seluruh individu, tanpa terkecuali, sebagai bagian dari upaya menciptakan kesetaraan gender yang sejati. Pemenuhan hak reproduksi berarti memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan kapan dan berapa banyak anak yang ingin dimiliki, tanpa adanya tekanan, diskriminasi, ataupun kekerasan. Salah satu indikator penting dalam tujuan ini adalah pengurangan angka kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak direncanakan sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta minimnya akses terhadap layanan keluarga berencana yang aman dan efektif. Dengan demikian,



dalam pencapaian tujuan ini, pendidikan yang komprehensif mengenai kesehatan seksual dan reproduksi menjadi kunci utama. Pendidikan tersebut tidak hanya mencakup aspek biologis atau medis semata, tetapi juga aspek sosial, emosional, serta nilai-nilai tentang kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan reproduksi.

Integrasi pendidikan pranikah dan prakonsepsi dalam rangka pencapaian SDGs sangat krusial dan strategis. Pendidikan ini memberikan bekal pengetahuan yang cukup mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi kepada pasangan muda sebelum mereka memulai kehidupan rumah tangga. Materi pendidikan pranikah dan prakonsepsi biasanya mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi secara umum, cara menjaga kesehatan selama masa kehamilannya nanti, metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan individu maupun pasangan, pencegahan penyakit atau infeksi menular seksual, serta pentingnya menjaga jarak antar kelahiran untuk memastikan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan persiapan yang matang sejak dini, pasangan muda akan mampu merencanakan kehamilan secara lebih baik, bertanggung jawab, serta mampu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama proses reproduksi berlangsung.

Selain itu, pendidikan pranikah dan prakonsepsi juga membantu meningkatkan kesadaran pasangan muda tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi yang sehat dalam hubungan rumah tangga mereka. Kesadaran ini membantu mengurangi ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal yang terkait dengan reproduksi, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang setara dan saling menghormati dalam menentukan keputusan reproduktif mereka. Dengan demikian, integrasi pendidikan pranikah dan prakonsepsi tidak hanya memperbaiki aspek kesehatan saja, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih besar ke arah kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam skala yang lebih luas, pencapaian SDGs melalui integrasi pendidikan pranikah dan prakonsepsi turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan reproduksi yang terjaga secara baik akan memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup pasangan muda, kesehatan anak yang lahir dari pasangan tersebut, serta generasi-generasi berikutnya. Oleh sebab itu, agenda global ini sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara konkret melalui kebijakan nasional, strategi edukasi



komunitas, serta integrasi layanan kesehatan primer yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara SDGs dengan kesehatan reproduksi melalui pendidikan pranikah dan prakonsepsi sangat erat dan saling memperkuat. Melalui sinergi dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga-lembaga kesehatan, organisasi masyarakat, maupun individu, maka tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan optimal, sehingga menciptakan masyarakat global yang lebih sehat, sejahtera, dan berkeadilan.

## **B. Kebijakan Nasional Terkait Pendidikan Pranikah dan Prakonsepsi di Indonesia**

Kebijakan nasional mengenai pendidikan pranikah dan prakonsepsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah untuk menciptakan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Komitmen ini diwujudkan melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang sifatnya lintas sektoral, sehingga menciptakan landasan kuat bagi upaya preventif dan edukatif bagi pasangan muda yang akan menikah maupun pasangan yang sedang merencanakan kehamilan.

Salah satu payung hukum utama yang secara jelas mengatur tentang pendidikan pranikah dan prakonsepsi adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa setiap individu, khususnya pasangan yang akan menikah, berhak memperoleh informasi dan edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi. Tujuan utama dari regulasi ini adalah memastikan bahwa setiap pasangan muda benar-benar memahami berbagai aspek penting yang terkait dengan kehidupan berkeluarga, mulai dari kesehatan fisik dan mental, hingga aspek sosial dan ekonomi yang akan mereka hadapi setelah menikah. Dengan pemahaman yang baik sejak dini, pasangan diharapkan mampu mengambil keputusan reproduksi secara cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.

Tidak hanya berhenti pada aspek regulasi formal saja, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan berbagai program yang secara nyata mendukung tujuan undang-undang tersebut. Salah satu program strategis yang telah berjalan efektif di Indonesia adalah program Generasi Berencana atau yang dikenal dengan sebutan GenRe. Program ini dikelola secara langsung oleh Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan sasaran utama anak-anak muda yang sedang beranjak dewasa, remaja, hingga pasangan yang akan menikah. GenRe menawarkan beragam kegiatan edukasi, konseling, serta advokasi yang sangat komprehensif terkait persiapan menjelang kehidupan berkeluarga. Materi yang disajikan dalam program ini mencakup pengelolaan kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, serta edukasi mendalam tentang berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga seperti pengelolaan konflik, pengaturan keuangan, dan kesiapan mental.

Dalam pelaksanaan program GenRe ini, pemerintah juga melibatkan peran aktif komunitas, lembag-lembag pendidikan, serta organisasi masyarakat untuk menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif dan luas. Selain pendekatan komunitas tersebut, pemerintah Indonesia juga mendorong terlaksananya konseling kesehatan reproduksi yang lebih sistematis dan profesional melalui layanan kesehatan primer. Upaya ini diwujudkan dengan memberikan pelatihan khusus kepada tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat, agar mereka memiliki kemampuan yang optimal dalam memberikan konseling pranikah maupun prakonsepsi di berbagai fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan klinik kesehatan keluarga. Dengan demikian, layanan konseling kesehatan reproduksi bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan di wilayah yang relatif terpencil dan sulit dijangkau.

Konseling kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan primer ini bertujuan memastikan bahwa pasangan mendapatkan informasi yang akurat, berbasis bukti ilmiah, dan relevan dengan kebutuhan pribadi masing-masing pasangan. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh sebelum pernikahan maupun sebelum terjadinya kehamilan, termasuk skrining kesehatan umum, pemeriksaan penyakit menular seksual, evaluasi risiko genetik, konseling mengenai pilihan metode kontrasepsi, serta edukasi mengenai persiapan fisik dan mental selama masa kehamilan nantinya. Konseling ini juga memberikan ruang privat bagi pasangan muda untuk mengajukan pertanyaan sensitif yang mungkin sulit mereka diskusikan di luar fasilitas kesehatan.

Implementasi kebijakan pendidikan pranikah dan prakonsepsi di Indonesia ini juga secara khusus memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender dan keterlibatan pasangan laki-laki secara aktif dalam pengambilan keputusan reproduksi. Pemerintah mengupayakan bahwa edukasi dan konseling tidak hanya menyasar perempuan sebagai pihak yang sering dianggap paling bertanggung jawab

terhadap kesehatan reproduksi, tetapi juga melibatkan laki-laki sebagai mitra setara dalam perencanaan kehidupan keluarga yang sehat. Ini sangat penting karena melibatkan laki-laki secara langsung dalam persiapan pranikah dan prakonsepsi terbukti dapat meningkatkan kualitas komunikasi pasangan, memperkuat keharmonisan keluarga, serta mendukung kesuksesan program keluarga berencana secara jangka panjang.

Namun demikian, meski secara kebijakan dan regulasi telah cukup kuat, tantangan besar yang masih dihadapi oleh pemerintah adalah implementasi kebijakan ini di daerah terpencil dan wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses informasi serta infrastruktur kesehatan. Di beberapa daerah, kendala berupa kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih, minimnya fasilitas konseling, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat lokal masih menjadi penghambat utama dalam optimalisasi kebijakan pendidikan pranikah dan prakonsepsi ini.

Untuk itu, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai intervensi strategis, mulai dari peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal melalui pelatihan dan pendampingan, penyediaan materi edukasi yang dapat diakses secara digital maupun offline, hingga menjalin kemitraan erat dengan organisasi masyarakat lokal untuk membantu penyebaran informasi. Upaya ini terus dilakukan secara berkelanjutan demi mencapai tujuan akhir dari kebijakan ini, yakni menciptakan generasi muda Indonesia yang siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi dalam memasuki kehidupan berkeluarga.

Secara keseluruhan, kebijakan nasional Indonesia dalam bidang pendidikan pranikah dan prakonsepsi tidak sekadar berhenti pada aspek regulasi dan penyediaan layanan semata, tetapi juga secara aktif berupaya menciptakan perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan dari berbagai sektor, diharapkan kebijakan ini dapat terimplementasi secara optimal, menciptakan keluarga yang sejahtera, serta berkontribusi positif terhadap kualitas hidup bangsa Indonesia secara menyeluruh.

### C. Praktik Terbaik dari Berbagai Negara dalam Persiapan Pranikah

Praktik terbaik dari berbagai negara dalam persiapan pranikah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi mampu secara nyata mempersiapkan calon pasangan untuk kehidupan berkeluarga yang harmonis, sehat, dan bertanggung jawab. Negara-negara maju seperti Australia, Singapura, dan Swedia merupakan contoh yang sangat baik dalam hal ini, karena mereka telah berhasil menciptakan program-program pranikah yang tidak hanya menyasar aspek kesehatan fisik tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, mental, serta interpersonal secara mendalam.

Australia merupakan salah satu negara yang telah lama menerapkan pendekatan persiapan pranikah berbasis komunitas yang didukung penuh oleh pemerintah lokal. Dalam pendekatan ini, calon pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti serangkaian sesi konseling interpersonal yang berfokus pada pengembangan keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, serta pemahaman emosional dan psikologis pasangan. Pemerintah Australia meyakini bahwa fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia terletak pada kemampuan pasangan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka di masa depan. Selain itu, Australia juga menempatkan perhatian besar pada isu kesehatan mental pasangan melalui konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional yang terlatih. Dengan demikian, pasangan tidak hanya mendapatkan bekal yang kuat dalam berkomunikasi tetapi juga dalam menjaga kesehatan mental mereka dalam menjalani berbagai tantangan kehidupan rumah tangga yang akan mereka hadapi.

Singapura menawarkan pendekatan berbeda yang juga sangat efektif, yakni dengan mengintegrasikan aspek pelatihan finansial dan parenting dalam kurikulum wajib pendidikan pranikahnya. Pemerintah Singapura menyadari bahwa persoalan finansial sering kali menjadi salah satu sumber utama ketegangan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, calon pasangan di Singapura diwajibkan mengikuti pelatihan yang memberikan pengetahuan serta keterampilan praktis mengenai pengelolaan keuangan keluarga, seperti membuat anggaran rumah tangga, perencanaan tabungan, serta memahami investasi yang tepat sesuai kebutuhan keluarga. Selain aspek finansial, pemerintah Singapura juga sangat serius dalam mempersiapkan calon pasangan untuk peran sebagai orang tua dengan memberikan pendidikan parenting yang mendalam. Materi parenting yang

disajikan meliputi aspek-aspek penting seperti tumbuh kembang anak, peran dan tanggung jawab orang tua, serta bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh kembang fisik, mental, dan emosional anak. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menciptakan keluarga yang stabil, harmonis, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

Swedia, di sisi lain, menitikberatkan pendekatan persiapan pranikahnya pada pendidikan seksual dan pembangunan hubungan yang sehat sejak usia remaja hingga menjelang pernikahan. Pemerintah Swedia menyadari bahwa pemahaman yang benar dan komprehensif tentang kesehatan seksual dan reproduksi merupakan kunci utama dalam pencegahan berbagai risiko kesehatan, seperti infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak direncanakan, serta masalah reproduksi lainnya. Oleh karena itu, pendidikan seksual di Swedia sudah dimulai sejak remaja dengan materi yang bertahap dan disesuaikan dengan tingkat usia serta perkembangan psikologis anak-anak muda. Pendidikan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek fisik semata tetapi juga memberikan pengetahuan mengenai bagaimana membangun hubungan yang sehat, saling menghormati, serta bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan reproduksi yang diambil. Saat menjelang pernikahan, calon pasangan kembali mendapatkan materi lanjutan yang lebih spesifik mengenai tantangan yang mungkin mereka hadapi sebagai pasangan suami-istri dan orang tua nantinya. Program pendidikan seksual yang konsisten sejak dini ini membuat pasangan muda di Swedia memiliki kesiapan yang sangat matang dalam menghadapi kehidupan keluarga.

Keberhasilan praktik-praktik terbaik dari ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa persiapan pranikah bukanlah sekadar proses administratif atau seremoni formalitas saja. Lebih dari itu, persiapan pranikah harus dirancang secara holistik, komprehensif, dan terintegrasi, yang mencakup berbagai aspek penting kehidupan rumah tangga. Negara-negara ini telah membuktikan bahwa pendekatan yang menyeluruh—yang menggabungkan konseling interpersonal, kesehatan mental, pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan parenting, serta pendidikan seksual yang komprehensif—mampu secara signifikan mengurangi risiko terjadinya konflik keluarga, perceraian, serta berbagai masalah kesehatan reproduksi yang sering dihadapi oleh pasangan yang tidak dipersiapkan dengan baik.

Pembelajaran dari praktik terbaik ini bisa menjadi inspirasi dan panduan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam menyusun kebijakan serta program pendidikan pranikah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia dapat

mempelajari bagaimana pentingnya peran pemerintah yang proaktif dalam menyediakan infrastruktur, sumber daya manusia, serta program-program edukasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang lebih matang, sehat, harmonis, dan siap menjalani kehidupan berkeluarga yang bahagia, produktif, serta berkelanjutan.

#### **D. Tren: Integrasi Layanan Kesehatan Prakonsepsi dalam Layanan Kesehatan Primer**

Integrasi layanan kesehatan prakonsepsi dalam layanan kesehatan primer merupakan sebuah tren global yang sedang berkembang secara luas di berbagai belahan dunia. Tren ini mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam penyediaan layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan reproduksi, dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi lebih proaktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah, komprehensif, dan merata terhadap berbagai bentuk pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan oleh calon pasangan sebelum mereka memasuki masa kehamilan.

Integrasi layanan kesehatan prakonsepsi ke dalam layanan kesehatan primer pada dasarnya berupaya menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kesehatan reproduksi masyarakat dengan ketersediaan layanan kesehatan di tingkat dasar. Dengan pendekatan ini, calon pasangan tidak perlu lagi mengunjungi fasilitas kesehatan khusus atau yang terletak jauh dari tempat tinggal mereka, tetapi dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan penting yang tersedia di fasilitas kesehatan primer yang dekat dengan komunitas mereka. Ini berarti bahwa calon pasangan dapat dengan rutin menerima informasi penting mengenai persiapan prakonsepsi, konseling khusus terkait kondisi kesehatan mereka, serta berbagai layanan kesehatan preventif yang sangat bermanfaat bagi keberhasilan masa kehamilan kelak.

Komponen utama dalam integrasi layanan prakonsepsi dalam sistem kesehatan primer ini meliputi beberapa elemen penting seperti edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, skrining kesehatan pranikah, konseling genetik, pemberian imunisasi penting sebelum kehamilan, serta layanan konseling nutrisi. Edukasi kesehatan reproduksi yang diberikan mencakup berbagai informasi mengenai proses persiapan kehamilan, risiko-risiko yang mungkin timbul akibat kondisi kesehatan tertentu, hingga langkah-langkah penting untuk menjaga kesehatan fisik

maupun mental menjelang kehamilan. Melalui edukasi ini, pasangan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang bagaimana mempersiapkan kondisi tubuh secara optimal sebelum kehamilan terjadi.

Selanjutnya, dalam layanan prakonsepsi ini juga tersedia skrining kesehatan yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara dini berbagai kondisi kesehatan yang berisiko menimbulkan komplikasi selama kehamilan. Skrining ini mencakup pemeriksaan terhadap penyakit kronis, infeksi menular seksual, status gizi, serta kondisi-kondisi tertentu seperti anemia dan diabetes yang dapat mempengaruhi hasil kehamilan dan kesehatan ibu serta bayi. Melalui deteksi dini, calon pasangan dapat segera menerima intervensi kesehatan yang tepat, sehingga risiko komplikasi selama kehamilan dapat diminimalkan atau bahkan dicegah sepenuhnya.

Konseling genetik menjadi komponen penting lain dalam integrasi layanan prakonsepsi ini, terutama bagi pasangan yang memiliki risiko genetik tertentu dalam keluarganya. Konseling ini membantu pasangan untuk memahami secara lebih mendalam risiko-risiko yang mungkin diturunkan kepada keturunan mereka, serta berbagai opsi yang tersedia untuk mengelola risiko tersebut. Konseling ini memberikan manfaat besar dalam membantu calon pasangan mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana terkait rencana kehamilan mereka, serta memungkinkan mereka mempersiapkan langkah-langkah preventif apabila ditemukan risiko yang signifikan.

Selain itu, layanan imunisasi juga merupakan bagian penting dalam layanan kesehatan prakonsepsi di tingkat primer ini. Imunisasi seperti vaksin tetanus, rubella, hepatitis B, hingga vaksin HPV diberikan kepada calon pasangan sebagai langkah pencegahan agar mereka terlindungi dari infeksi yang berpotensi membahayakan ibu maupun janin di masa kehamilan. Imunisasi prakonsepsi ini merupakan bentuk intervensi preventif yang efektif dalam meningkatkan keselamatan kehamilan serta menurunkan risiko terjadinya berbagai komplikasi yang terkait dengan infeksi.

Layanan konseling nutrisi prakonsepsi melengkapi pendekatan holistik dalam integrasi layanan ini. Konseling nutrisi memastikan calon pasangan, terutama calon ibu, memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam merancang pola makan dan asupan nutrisi yang tepat sejak sebelum kehamilan terjadi. Konseling ini mencakup edukasi tentang kebutuhan nutrisi spesifik seperti asam folat, zat besi, kalsium, dan nutrisi penting lainnya yang berperan vital dalam mendukung kehamilan yang sehat. Dengan pola nutrisi yang optimal, calon ibu dapat secara signifikan

mengurangi risiko komplikasi seperti cacat tabung saraf, anemia, ataupun gangguan tumbuh kembang janin.

Di berbagai negara, integrasi layanan prakonsepsi dalam layanan kesehatan primer ini telah terbukti efektif memberikan dampak nyata. Pendekatan ini telah berhasil menurunkan angka komplikasi selama kehamilan, meningkatkan hasil kehamilan yang sehat, serta memastikan bayi lahir dalam kondisi yang lebih baik secara fisik dan mental. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, pendekatan ini juga berhasil menciptakan efisiensi dalam sistem kesehatan karena intervensi preventif terbukti jauh lebih hemat biaya dibandingkan intervensi kuratif atau pengobatan komplikasi kehamilan.

Dengan demikian, integrasi layanan kesehatan prakonsepsi dalam layanan kesehatan primer merupakan langkah strategis yang tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada pasangan yang merencanakan kehamilan, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Tren global ini mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan layanan kesehatan reproduksi, yang kini lebih menitikberatkan pada pencegahan, promosi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih dekat, mudah, dan komprehensif. Di masa depan, pendekatan integrasi ini diharapkan semakin diperkuat dan diperluas, sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan kesehatan global yang berkelanjutan.

#### **E. Isu: Gap Implementasi Kebijakan Nasional di Daerah Terpencil**

Meskipun berbagai kebijakan nasional yang terkait dengan pendidikan pranikah dan prakonsepsi telah dirancang secara matang dan komprehensif oleh pemerintah, namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak hambatan serius di berbagai daerah terpencil. Salah satu persoalan besar yang menyebabkan gap atau kesenjangan implementasi kebijakan tersebut adalah keterbatasan akses layanan kesehatan yang masih dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil atau pedalaman. Keterbatasan ini meliputi tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, jarak geografis yang jauh dari pusat layanan kesehatan, hingga kesulitan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan akibat kondisi geografis yang menantang seperti pegunungan, sungai, hutan, atau pulau-pulau kecil.



Selain masalah aksesibilitas secara fisik, implementasi kebijakan nasional di daerah terpencil juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih. Banyak daerah terpencil yang hingga saat ini masih mengalami kekurangan tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan khusus dalam memberikan edukasi dan konseling pranikah dan prakonsepsi. Hal ini terjadi karena kurangnya minat tenaga kesehatan untuk bertugas di wilayah terpencil akibat terbatasnya fasilitas pendukung, insentif yang kurang memadai, serta tantangan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan edukasi dan konseling kesehatan reproduksi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah minimnya edukasi serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya persiapan pranikah dan prakonsepsi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor keterbatasan informasi yang diterima oleh masyarakat di wilayah terpencil. Minimnya kampanye atau edukasi yang disesuaikan dengan konteks lokal membuat masyarakat setempat kurang memahami manfaat pentingnya persiapan sebelum menikah atau sebelum kehamilan. Padahal, pemahaman yang rendah ini berdampak langsung terhadap tingginya angka komplikasi kehamilan, angka kematian ibu dan bayi, serta berbagai risiko lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga.

Selain itu, tantangan geografis dan infrastruktur yang tidak memadai juga semakin memperlebar kesenjangan implementasi kebijakan di daerah terpencil. Jalan yang rusak, minimnya transportasi publik yang teratur, serta kurangnya sarana telekomunikasi seperti jaringan telepon dan internet menyebabkan sulitnya pelaksanaan kegiatan edukasi maupun pelatihan secara rutin dan konsisten. Hambatan-hambatan tersebut menjadikan penyebaran informasi, kunjungan tenaga kesehatan, maupun kegiatan penyuluhan tidak bisa dilaksanakan secara optimal, sehingga kebijakan nasional yang baik sekalipun menjadi tidak efektif ketika diimplementasikan di lapangan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi khusus yang efektif dan terintegrasi. Salah satu strategi utama yang dapat diterapkan adalah peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal melalui program pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Program pelatihan ini tidak hanya difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis tenaga kesehatan lokal, tetapi juga mencakup kemampuan komunikasi efektif serta pemahaman mendalam terhadap budaya

lokal. Dengan melibatkan tenaga kesehatan setempat yang memahami konteks budaya dan sosial masyarakatnya, pesan edukasi akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Penerapan teknologi seperti telehealth juga menjadi solusi strategis yang penting untuk dipertimbangkan dalam mengatasi tantangan geografis dan infrastruktur. Dengan teknologi telehealth, masyarakat dan tenaga kesehatan di daerah terpencil dapat terhubung langsung dengan pakar kesehatan atau konselor yang berada di pusat kota atau wilayah lain yang lebih maju, tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Konsultasi kesehatan jarak jauh melalui teleconference atau aplikasi digital memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas secara cepat, efisien, dan hemat biaya. Implementasi telehealth diharapkan mampu mengatasi kendala akses fisik dan memberikan layanan konseling yang tepat waktu.

Selain pendekatan berbasis teknologi, program outreach atau penjangkauan aktif juga perlu dikembangkan secara serius. Program ini harus melibatkan komunitas lokal secara langsung dan dirancang sesuai dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat di masing-masing daerah. Dengan pendekatan yang berbasis budaya lokal, masyarakat cenderung lebih terbuka, menerima, dan terlibat aktif dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan. Kegiatan ini bisa berupa pertemuan rutin di komunitas, diskusi informal dengan tokoh adat dan tokoh agama, atau acara-acara budaya yang sekaligus menjadi sarana edukasi.

Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengatasi gap implementasi kebijakan nasional di daerah terpencil. Dengan pemberdayaan yang tepat, masyarakat bukan hanya menjadi objek dari kebijakan, melainkan subjek aktif yang mampu menjalankan dan mengembangkan kebijakan secara mandiri di lingkungannya. Melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas masyarakat, kebijakan nasional mengenai pendidikan pranikah dan prakonsepsi tidak hanya akan diterapkan dengan efektif, tetapi juga mampu menciptakan perubahan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas hidup, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan keluarga di daerah terpencil.

## F. Latihan Soal

### **Tugas 1: Essay Analisis Kritis terhadap Implementasi SDGs Kesehatan Reproduksi**

Mahasiswa diminta menyusun sebuah essay mendalam yang menganalisis implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 3 (Good Health and Well-Being) dan tujuan nomor 5 (Gender Equality) dalam konteks Indonesia. Essay tersebut harus menjelaskan secara detail bagaimana pendidikan pranikah dan prakonsepsi mampu berperan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan, seperti penurunan angka kematian ibu, pengurangan angka kehamilan tidak diinginkan, serta terciptanya kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan reproduksi.

Mahasiswa juga diwajibkan memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian tujuan-tujuan SDGs di Indonesia.

### **Tugas 2: Evaluasi Kebijakan Nasional Pendidikan Pranikah dan Prakonsepsi di Indonesia**

Mahasiswa ditugaskan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kebijakan nasional tentang pendidikan pranikah dan prakonsepsi, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan implementasi program Generasi Berencana (GenRe) oleh BKKBN. Mahasiswa harus mengidentifikasi keberhasilan yang sudah dicapai serta tantangan-tantangan spesifik yang muncul dalam implementasi di lapangan. Hasil evaluasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk laporan yang dilengkapi dengan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan pemerintah maupun pemangku kebijakan terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil.

### **Tugas 3: Kajian Komparatif Praktik Terbaik Pendidikan Pranikah Internasional**

Mahasiswa diminta untuk menyusun kajian komparatif yang mendalam tentang praktik-praktik terbaik dalam pendidikan pranikah dari negara-negara maju seperti Australia, Singapura, dan Swedia. Mahasiswa harus menjelaskan secara rinci pendekatan yang digunakan masing-masing negara, mencakup aspek konseling interpersonal, kesehatan mental, pendidikan finansial dan parenting, serta pendidikan seksual. Kajian ini harus mencakup analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan praktik-praktik tersebut, serta bagaimana Indonesia bisa mengadopsi pendekatan serupa dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya lokal yang berlaku di Indonesia.

#### **Tugas 4: Rencana Aksi Integrasi Layanan Prakonsepsi dalam Layanan Kesehatan Primer**

Dalam tugas ini, mahasiswa diharuskan menyusun sebuah rencana aksi komprehensif yang menguraikan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan layanan kesehatan prakonsepsi ke dalam layanan kesehatan primer di Indonesia. Mahasiswa diminta merinci berbagai aspek penting seperti edukasi kesehatan reproduksi, skrining kesehatan pranikah, konseling genetik, imunisasi prakonsepsi, serta konseling nutrisi. Rencana aksi harus dilengkapi dengan tujuan spesifik, indikator keberhasilan, jadwal implementasi, serta usulan kolaborasi lintas sektoral yang diperlukan untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif dan berdampak luas terhadap peningkatan kualitas kesehatan reproduksi pasangan muda di Indonesia.

#### **Tugas 5: Studi Kasus dan Solusi Gap Implementasi Kebijakan di Daerah Terpencil**

Mahasiswa ditugaskan melakukan sebuah studi kasus tentang implementasi kebijakan pendidikan pranikah dan prakonsepsi di salah satu daerah terpencil di Indonesia. Studi kasus ini harus menguraikan secara detail kondisi lapangan, mencakup tantangan akses layanan kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, minimnya edukasi dan kesadaran masyarakat, serta hambatan infrastruktur yang ada. Setelah memaparkan permasalahan secara detail, mahasiswa harus menyusun solusi-solusi praktis yang terintegrasi dan berbasis budaya lokal, meliputi peningkatan kapasitas tenaga lokal melalui pelatihan, penerapan teknologi telehealth, pengembangan program outreach berbasis komunitas, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi gap implementasi kebijakan tersebut.

#### **Pilihan Ganda**

1. Di sebuah desa terpencil, seorang perempuan usia 20 tahun datang ke Puskesmas bersama calon suaminya untuk berkonsultasi mengenai persiapan pernikahan. Pasangan ini belum memahami pentingnya pendidikan pranikah dan prakonsepsi. Sebagai bidan yang memahami konsep SDGs tujuan nomor 3, edukasi apa yang paling penting Anda berikan terlebih dahulu kepada pasangan ini?
  - A. Pentingnya menjaga kesehatan mental pasangan
  - B. Pentingnya persiapan finansial keluarga
  - C. Cara berkomunikasi yang efektif antar pasangan
  - D. Manfaat skrining kesehatan reproduksi sebelum menikah
  - E. Pentingnya mengetahui peran gender dalam keluarga

2. Seorang remaja putri berusia 18 tahun datang ke klinik untuk konsultasi karena baru saja menikah dan ingin menunda kehamilan. Namun, ia mengaku takut untuk memilih kontrasepsi karena khawatir mendapat tekanan dari keluarganya. Sebagai bidan yang memahami konsep kesetaraan gender (SDGs nomor 5), tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah...
- A. Memberikan kontrasepsi tanpa penjelasan mendalam
  - B. Menyarankan untuk mengikuti keinginan keluarganya
  - C. Memberikan edukasi tentang hak reproduksi perempuan dan mendukung pemilihan kontrasepsi yang tepat
  - D. Meminta suaminya untuk menentukan pilihan kontrasepsi
  - E. Menyarankan untuk segera memiliki anak agar tidak bertentangan dengan keinginan keluarga
3. Dalam upaya mendukung SDGs melalui pendidikan pranikah dan prakonsepsi, seorang bidan di Puskesmas ingin melaksanakan program edukasi yang komprehensif untuk pasangan muda. Berdasarkan praktik terbaik yang dilakukan di Singapura, konten edukasi pranikah mana yang harus diprioritaskan selain aspek kesehatan reproduksi?
- A. Pendidikan parenting dan pengelolaan finansial
  - B. Pendidikan seksual sejak dini
  - C. Konseling interpersonal
  - D. Imunisasi pranikah
  - E. Skrining kesehatan mental
4. Seorang bidan bertugas di Puskesmas di wilayah terpencil dengan kondisi geografis sulit dijangkau. Masyarakat sekitar memiliki kesadaran rendah tentang persiapan pranikah dan prakonsepsi. Berdasarkan tren integrasi layanan kesehatan prakonsepsi dalam layanan primer, upaya mana yang paling efektif dilakukan bidan untuk meningkatkan akses dan kesadaran masyarakat di wilayah tersebut?
- A. Menunggu masyarakat datang secara sukarela ke Puskesmas
  - B. Mengadakan penyuluhan bulanan di tempat terpencil tanpa melibatkan tenaga local
  - C. Menggunakan pendekatan telehealth dengan kolaborasi tenaga lokal sebagai fasilitator
  - D. Membagikan brosur kesehatan secara acak di desa
  - E. Memfokuskan pada edukasi kesehatan secara daring tanpa kunjungan langsung
5. Sepasang calon pengantin mengikuti konseling pranikah di klinik kebidanan. Keduanya belum memiliki pemahaman tentang pentingnya menjaga jarak antar kelahiran dalam konteks pencapaian SDGs tujuan nomor 3. Sebagai bidan,

bagaimana cara terbaik memberikan edukasi mengenai manfaat menjaga jarak kelahiran kepada pasangan ini?

- A. Menjelaskan bahwa menjaga jarak kelahiran akan memperbaiki ekonomi keluarga
- B. Memberikan informasi bahwa menjaga jarak kelahiran membantu mengurangi risiko komplikasi kehamilan dan kematian ibu
- C. Mengatakan bahwa menjaga jarak kelahiran diperlukan karena peraturan pemerintah
- D. Menyarankan pasangan untuk memiliki maksimal dua anak saja
- E. Menyampaikan bahwa menjaga jarak kelahiran merupakan kewajiban agama

### **Kunci Jawaban**

#### **1. Kunci Jawaban: D**

Pembahasan:

Tujuan nomor 3 dari SDGs secara eksplisit mengutamakan pengurangan angka kematian ibu melalui akses layanan kesehatan reproduksi yang optimal. Oleh karena itu, yang paling penting untuk diberikan pertama kali adalah edukasi terkait manfaat skrining kesehatan reproduksi untuk mencegah komplikasi kesehatan ibu di masa mendatang.

#### **2. Kunci Jawaban: C**

Pembahasan:

SDGs nomor 5 menekankan pentingnya menjamin hak reproduksi perempuan tanpa diskriminasi dan tekanan. Oleh karena itu, tindakan terbaik adalah memberikan edukasi mendalam tentang hak reproduksi dan mendukung pilihan kontrasepsi yang tepat sesuai kebutuhan individu tersebut.

#### **3. Kunci Jawaban: A**

Pembahasan:

Singapura berhasil dalam pendidikan pranikah karena mengintegrasikan secara serius pendidikan parenting dan pengelolaan finansial. Pendekatan ini efektif untuk mencegah konflik rumah tangga dan menciptakan stabilitas ekonomi keluarga.

#### **4. Kunci Jawaban: C**

Pembahasan:

Penggunaan telehealth dengan keterlibatan tenaga lokal sebagai fasilitator merupakan solusi yang paling tepat untuk daerah terpencil. Pendekatan ini efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas sekaligus mengatasi kendala geografis dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

## 5. Kunci Jawaban: B

### Pembahasan:

Dalam konteks SDGs nomor 3, manfaat menjaga jarak antar kelahiran sangat penting karena berhubungan langsung dengan penurunan angka kematian ibu serta pengurangan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Edukasi tentang manfaat ini paling relevan untuk membantu pasangan membuat keputusan yang bijaksana.

## G. Rangkuman Materi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan pada tahun 2030. Dalam konteks kesehatan reproduksi, tujuan nomor 3 (Good Health and Well-Being) serta nomor 5 (Gender Equality) sangat relevan karena keduanya secara eksplisit menekankan pemenuhan hak reproduksi sebagai komponen penting dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Tujuan nomor 3 secara khusus menargetkan pengurangan angka kematian ibu, yang merupakan isu serius di negara berkembang seperti Indonesia. Upaya penting yang ditekankan dalam tujuan ini adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi melalui pendidikan pranikah dan prakonsepsi. Pendidikan ini bertujuan memberikan pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, merencanakan kehamilan secara tepat, mencegah komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas, yang pada akhirnya berdampak langsung pada penurunan angka kematian ibu.

Selanjutnya, tujuan nomor 5 menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam memastikan bahwa semua individu memiliki hak reproduksi yang setara, bebas dari diskriminasi dan tekanan. Dalam hal ini, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif merupakan elemen kunci untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan serta menciptakan kesetaraan dalam pengambilan keputusan reproduktif. Pendidikan ini meliputi aspek biologis, emosional, sosial, serta nilai-nilai kesetaraan gender dalam hubungan rumah tangga.

Di Indonesia, kebijakan nasional tentang pendidikan pranikah dan prakonsepsi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 secara jelas mengatur pentingnya edukasi komprehensif tentang kesehatan

reproduksi bagi pasangan muda. Program Generasi Berencana (GenRe) yang dikelola BKKBN menjadi salah satu program unggulan yang mengimplementasikan kebijakan ini, dengan melibatkan komunitas, lembaga pendidikan, dan tenaga kesehatan profesional untuk menjangkau secara efektif berbagai lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.

Berbagai negara maju memberikan praktik terbaik dalam persiapan pranikah yang bisa menjadi inspirasi. Australia misalnya, mengedepankan konseling interpersonal dan kesehatan mental sebagai fondasi utama kehidupan berkeluarga. Singapura secara efektif mengintegrasikan pendidikan parenting dan pengelolaan finansial untuk memperkuat ketahanan keluarga. Sementara itu, Swedia menekankan pendidikan seksual dan pembentukan hubungan sehat sejak usia remaja sebagai persiapan jangka panjang menjelang kehidupan berkeluarga.

Salah satu tren global yang berkembang adalah integrasi layanan kesehatan prakonsepsi ke dalam layanan kesehatan primer. Integrasi ini memungkinkan akses yang lebih dekat dan mudah terhadap edukasi kesehatan reproduksi, skrining kesehatan, konseling genetik, imunisasi penting, serta konseling nutrisi sebelum kehamilan. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan hasil kehamilan yang lebih sehat, menurunkan komplikasi, serta menciptakan efisiensi dalam sistem kesehatan secara keseluruhan.

Meski demikian, implementasi kebijakan nasional mengenai pendidikan pranikah dan prakonsepsi masih menghadapi tantangan besar di daerah terpencil. Tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan akses layanan kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten, minimnya kesadaran masyarakat, serta infrastruktur yang kurang memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi khusus seperti peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal melalui pelatihan intensif, pemanfaatan teknologi telehealth, program penjangkauan berbasis komunitas, serta pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keterkaitan SDGs dengan kesehatan reproduksi melalui pendidikan pranikah dan prakonsepsi merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat global yang lebih sehat, berkeadilan, dan sejahtera. Melalui sinergi kuat dari pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, serta individu, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya yang terkait kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender dapat tercapai secara optimal.



## H. Glosarium

### **Edukasi Kesehatan Reproduksi**

Pemberian informasi secara lengkap kepada individu atau pasangan mengenai aspek kesehatan reproduksi, meliputi anatomi dan fungsi reproduksi, metode kontrasepsi, pencegahan infeksi menular seksual, dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sebelum dan selama kehamilan.

### **Gap Implementasi Kebijakan Nasional**

Kesenjangan antara kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan kenyataan di lapangan, terutama di wilayah terpencil akibat keterbatasan akses, infrastruktur yang kurang memadai, serta minimnya edukasi dan tenaga kesehatan yang terlatih.

### **Gender Equality (Kesetaraan Gender)**

Konsep mengenai kesamaan hak, tanggung jawab, dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan reproduksi dan akses layanan kesehatan.

### **Generasi Berencana (GenRe)**

Program nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan tujuan mempersiapkan generasi muda menghadapi kehidupan berkeluarga secara matang, bertanggung jawab, serta mampu menjaga kesehatan reproduksi secara optimal.

### **Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)**

Tujuan nomor 3 dari SDGs yang berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat secara umum, dengan penekanan khusus pada pengurangan angka kematian ibu dan bayi, serta akses yang luas terhadap layanan kesehatan reproduksi berkualitas.

### **Hak Reproduksi**

Hak individu untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab terkait jumlah, jarak, serta waktu memiliki anak, bebas dari diskriminasi, tekanan, maupun kekerasan.

### **Integrasi Layanan Prakonsepsi dalam Layanan Kesehatan Primer**

Pendekatan global yang bertujuan menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi secara proaktif dan terintegrasi dalam sistem kesehatan dasar agar masyarakat dapat mengakses layanan penting ini secara mudah dan dekat.

### **Keluarga Berencana (KB)**

Layanan yang mencakup edukasi, konsultasi, dan penggunaan metode kontrasepsi untuk merencanakan jumlah, jarak, serta waktu memiliki anak demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

### **Kesehatan Reproduksi**

Kondisi fisik, mental, dan sosial yang utuh berkaitan dengan sistem reproduksi manusia di semua tahap kehidupan, termasuk kemampuan memiliki kehidupan seksual yang sehat dan aman, serta kebebasan menentukan kapan dan bagaimana memiliki anak.

**Komplikasi Kehamilan**

Gangguan atau masalah kesehatan yang muncul selama masa kehamilan hingga persalinan, yang dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janin jika tidak dideteksi dan ditangani secara dini.

**Konseling Genetik**

Proses pemberian informasi dan dukungan kepada pasangan tentang kemungkinan risiko genetik yang dapat diturunkan kepada keturunan, serta opsi yang tersedia untuk mengelola risiko tersebut.

**Kontrasepsi**

Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan, baik secara permanen maupun sementara.

**Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan atau program kesehatan reproduksi, khususnya di daerah terpencil.

**Pranikah dan Prakonsepsi**

Persiapan yang dilakukan oleh pasangan sebelum menikah atau sebelum terjadi kehamilan, mencakup edukasi kesehatan reproduksi, pemeriksaan kesehatan, konseling genetik, imunisasi, serta edukasi nutrisi untuk mencegah komplikasi kehamilan.

**Skrining Kesehatan Reproduksi**

Pemeriksaan awal untuk mendeteksi berbagai kondisi atau penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual, anemia, diabetes, serta kondisi lain yang berpotensi menimbulkan risiko kehamilannya.

**Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sebuah agenda global yang disepakati oleh berbagai negara di dunia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan pada tahun 2030, mencakup berbagai tujuan yang menyangkut kesehatan, kesejahteraan, lingkungan, dan keadilan sosial.

**Telehealth**

Pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh untuk memberikan layanan kesehatan, termasuk konsultasi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

## I. Daftar Pustaka

- Australian Government Department of Social Services. (2019). *Building Stronger Families and Communities: Family and Relationship Services*. Canberra: DSS Australia.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Pedoman Teknis Program Generasi Berencana (GenRe)*. Jakarta: BKKBN.
- Chandra-Mouli, V., Camacho, A. V., & Michaud, P. A. (2013). WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among Adolescents in Developing Countries. *Journal of Adolescent Health*, 52(5), 517–522.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. (2019). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terintegrasi di Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Health Promotion Board Singapore. (2020). *Marriage Preparation Programme*. Retrieved from <https://www.hpb.gov.sg>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Voluntary National Review: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Rokom, R., Setiawati, E. P., & Kristiyawati, S. P. (2019). Evaluasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 8(3), 120–127.
- Setyowati, S., & Hartiti, T. (2018). Pengembangan Pendidikan Prakonsepsi dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 9(1), 1–8.
- Swedish National Agency for Education (Skolverket). (2020). *Sexuality Education in Swedish Schools*. Retrieved from <https://www.skolverket.se>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2018). *State of World Population Report: The Power of Choice—Reproductive Rights and the Demographic Transition*. New York: UNFPA.
- Utami, D. W., & Nurfatimah, E. (2020). Implementasi Telehealth dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Daerah Terpencil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 15(2), 60–67.
- World Health Organization. (2016). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2019). *Maternal Mortality Fact Sheet*. Geneva: WHO.
- Yargawa, J., & Leonardi-Bee, J. (2015). Male involvement and maternal health outcomes: systematic review and meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 69(6), 604–612.

# Sinopsis

Buku Ajar Pranikah dan Prakonsepsi" adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk mempersiapkan pasangan muda menghadapi kehidupan berkeluarga dengan matang dan bertanggung jawab. Buku ini membahas secara mendalam berbagai aspek penting yang harus diperhatikan sebelum menikah dan memiliki anak, mulai dari konsep dasar pranikah dan prakonsepsi, persiapan fisik dan kesehatan, kesiapan psikologis dan emosional, hingga aspek sosial budaya dan hukum dalam pernikahan.

Secara khusus, buku ini menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan prakonsepsi yang mencakup skrining kesehatan reproduksi, imunisasi prakonsepsi, serta suplementasi vitamin yang penting bagi kesehatan ibu dan janin. Di samping itu, pembaca juga akan mendapatkan pengetahuan penting mengenai nutrisi optimal untuk fertilitas, manajemen stres prakonsepsi, serta pemahaman tentang berbagai metode kontrasepsi yang aman.

Tidak kalah pentingnya, buku ini juga mengupas tentang hak reproduksi pasangan muda, aspek hukum dalam pernikahan di Indonesia, serta tren global dan kebijakan nasional yang terkait dengan persiapan pranikah dan prakonsepsi. Disajikan pula informasi terkini tentang pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi pranikah, termasuk pemanfaatan aplikasi mobile, serta analisis mengenai tantangan kesenjangan digital yang masih dihadapi di beberapa daerah terpencil.

Melalui pembahasan yang lengkap dan didukung dengan berbagai contoh praktik terbaik dari berbagai negara, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan utama bagi pasangan muda dalam menciptakan kehidupan keluarga yang berkualitas, sehat, harmonis, serta mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.



Buku Ajar Pranikah dan Prakonsepsi" adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk mempersiapkan pasangan muda menghadapi kehidupan berkeluarga dengan matang dan bertanggung jawab. Buku ini membahas secara mendalam berbagai aspek penting yang harus diperhatikan sebelum menikah dan memiliki anak, mulai dari konsep dasar pranikah dan prakonsepsi, persiapan fisik dan kesehatan, kesiapan psikologis dan emosional, hingga aspek sosial budaya dan hukum dalam pernikahan.

Secara khusus, buku ini menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan prakonsepsi yang mencakup skrining kesehatan reproduksi, imunisasi prakonsepsi, serta suplementasi vitamin yang penting bagi kesehatan ibu dan janin. Di samping itu, pembaca juga akan mendapatkan pengetahuan penting mengenai nutrisi optimal untuk fertilitas, manajemen stres prakonsepsi, serta pemahaman tentang berbagai metode kontrasepsi yang aman.

Tidak kalah pentingnya, buku ini juga mengupas tentang hak reproduksi pasangan muda, aspek hukum dalam pernikahan di Indonesia, serta tren global dan kebijakan nasional yang terkait dengan persiapan pranikah dan prakonsepsi. Disajikan pula informasi terkini tentang pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi pranikah, termasuk pemanfaatan aplikasi mobile, serta analisis mengenai tantangan kesenjangan digital yang masih dihadapi di beberapa daerah terpencil.

Melalui pembahasan yang lengkap dan didukung dengan berbagai contoh praktik terbaik dari berbagai negara, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan utama bagi pasangan muda dalam menciptakan kehidupan keluarga yang berkualitas, sehat, harmonis, serta mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan dengan bijaksana dan bertanggung jawab.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan  
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-79-1



9

786347

294791